PODROČJE 01 / ČRNOMELJ

Pregled

Kako zdravi smo, kaj je na voljo in kaj lahko izboljšamo? Začnite s povzetkom ali izberite področje spodaj.

JAVNO ZDRAVJE · OBČINA ČRNOMELJ · PREGLED 2026

Zdravje v občini Črnomelj

Od podatkov do ukrepov

Podatki o zdravju, pregled preventive in možnosti za dejavno življenje v Beli krajini. Povezane analize, lokalni zemljevidi in vprašanja za boljše odločitve.

Osnova: 19. september 2026; kader in šport: 21. september 2026 Izdaje NIJZ 2016–2026

Uradni viri · raziskave · lokalne objave Voda, zrak in življenjske razmere: 24. september 2026

Dostop do oskrbe, nove teme in povzetek za prebivalce: 25.–26. september 2026

Samopregledi in presejanje: 27. september 2026 Oblikovna prenova in raziskave spanja: 25. september 2026

PREHRANJENOST OTROK

28,3 %

Slovenija 24,18 %. Podatek za 2024, izdaja NIJZ 2026. [1]

PRESEJANOST DORA

82,08 %

Slovenija 77,93 %. Obdobje januar 2024–oktober 2025. [1]

NESREČE IN ALKOHOL

12,94 %

Slovenija 8,22 %. Povprečje 2020–2024. [1]

DOKUMENTIRANO DELO CKZ

3,4 / 5

Analitična ocena petih javno preverljivih meril. Učinkovitost ostaja neocenjena. Metoda ocenjevanja ↓

Na kratko za prebivalce

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

To poročilo je dolgo, ker mora vsako trditev podpreti z viri. Tukaj je bistvo v preprostem jeziku. Vsaka točka vodi do poglavja, kjer so podatki in viri. Številke so ocene iz javnih virov, ne diagnoza posameznika. Za nasvet o svojem zdravju se vedno obrnite na svojega zdravnika.

Kaj je dobro

KAJ	VEČ
Ženske se v Črnomlju pogosto udeležijo presejanja za raka dojk, več ljudi kot drugod v Sloveniji pa se odzove na presejanje za raka debelega črevesa.	Presejanje
Referenčne ambulante vsako leto pregledajo več kot tisoč ljudi in odkrijejo veliko bolezni zgodaj.	Referenčne ambulante
Nujna medicinska pomoč deluje 24 ur na dan, zdravstveni dom pa je začel s prvimi posredovalci.	Nujna pomoč
V okolici so urejene poti za hojo in kolo, tudi Srčna pot in trim steza.	Poti
Pitna voda je redno nadzorovana, izvidi so javni.	Pitna voda

Kje so težave

KAJ	VEČ
Veliko ljudi nima izbranega osebnega zdravnika. Nove paciente sprejema le malo ambulant.	Neopredeljeni pacienti
Na nekatere specialistične preglede v Novem mestu se čaka dolgo.	Čakalne dobe
Po modelski oceni lahko reševalci do oddaljenih vasi potrebujejo več kot 15 minut.	Zemljevid dostopnosti
Starejši redkeje dobijo pomoč na domu kot drugod, pomoč pa je dražja.	Dolgotrajna oskrba
Več otrok kot drugod v Sloveniji ima preveč kilogramov.	Debelost otrok
Večji delež prometnih nesreč kot drugod v Sloveniji povzročijo vozniki pod vplivom alkohola.	Promet in alkohol
Poleti je veliko vročih dni, kar je nevarno za starejše.	Vročina
V Črnomlju nismo našli demenci prijazne točke za ljudi z demenco in njihove svojce.	Demenca

Kaj lahko storite sami

KAJ	ZAKAJ
Če ste stari 30 let ali več, se vsakih pet let naročite na preventivni pregled pri svojem zdravniku.	Zgodaj odkrit povišan krvni tlak, sladkorno bolezen ali depresijo je lažje zdraviti. Več
Poglejte, kateri pregledi veljajo za vašo starost, in si pravilno izmerite krvni tlak doma.	Zvišan tlak in sladkorna bolezen dolgo ne bolita. Vodnik po samopregledih

KAJ	ZAKAJ
Odzovite se vabilom na presejanje (Svit, Zora, Dora).	Presejanje odkrije raka, preden se pojavijo težave. Več
Uredite si zVEM ali pooblastilo za svojca. Če ne znate, prosite za pomoč.	Lažje pridete do izvidov, receptov in terminov. Več
Naučite se oživljanja in poiščite najbližji AED.	Prve minute pri srčnem zastoju odločajo. Več
V vročih dneh pokličite starejšega soseda ali sorodnika.	Vročina je najbolj nevarna za starejše, ki živijo sami. Več
Po zabavi ne vozite, če ste pili.	Alkohol poveča tveganje za nesrečo. Več

Kaj predlagamo odločevalcem

Poročilo predlaga predvsem ukrepe, ki niso dragi: javno objavo časov nujne pomoči, demenci prijazno točko in pomoč pri zVEM v Črnomlju, načrt ob vročini, pomoč pri vlogah za dolgotrajno oskrbo v Črnomlju, več gibanja v šolah in paket za pridobitev zdravnikov. Podrobnosti so v zavihku Ukrepi in odprta vprašanja.

---

01 Ključne ugotovitve in prednostne naloge

> Pomembno o dokazih: lokalne kopije starejših virov, ki so bile ob prenosu izpraznjene, so bile 25. 9. 2026 obnovljene iz prve različice projekta in preverjene s kontrolnimi vsotami. To potrjuje, da so kopije izvirne, ne pa, da so starejše ugotovitve še aktualne; te v prenovi niso ponovno v celoti preverjene. Pri štirih raziskavah o spanju je prebran samo povzetek. Stanje virov je označeno v literaturi.

Najnovejši občinski profil potrjuje višjo prekomerno prehranjenost otrok, nadpovprečen delež nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji in dobro vključevanje v Svit ter DORO. Pri večini drugih razlik je treba upoštevati statistično negotovost. **[2]**

UGOTOVITEV	KAJ POMENI ZA ODLOČANJE
Otroci: izboljšanje ob vztrajni vrzeli. Delež je med izdajama 2016 in 2026 padel z 31,1 na 28,3 %, v vseh enajstih izdajah pa ostaja nad slovenskim povprečjem. **[3]**	Ohraniti družinsko obravnavo, razširiti redno gibanje in izboljšati prehransko okolje. Trditev starega poročila, da izboljšanja sploh ni, je napačna.
Srčna kap je številčno pod povprečjem, možganska kap mu je blizu. Zadnji stopnji sta 1,66 proti 1,86 in 2,26 proti 2,21 na 1.000. **[3]**	Gre za bolnišnične obravnave in večletna povprečja. To ni dokaz uspeha posameznega programa; profil pri obeh zadnjih vrednostih ne označuje statistično značilne razlike. **[2]**
CKZ ima javno imenovano vodjo in raznoliko dejavnost. Uradna stran imenuje Tatjano Gregorič in strokovne sodelavce. **[4]** Letno poročilo navaja izvedbo načrtovanih ur. **[5]**	Prejšnji očitek o neznanem vodstvu se umakne. Naslednja naloga je pregledno poročanje o številu različnih uporabnikov, stroških in izidih.
Dodane prezrte potrebe. Precepljenost proti pnevmokokom je 44,4 proti 55,2 %, pomoč na domu 1,0 proti 1,8 %. **[2]**	Preventiva vključuje tudi cepljenje, podporo starejšim in dostopnost oskrbe. CKZ teh vrzeli ne more odpraviti sam.
Voda in zrak potrebujeta ločeno presojo. Poročilo o vodi za 2025 izpostavlja parazite v Adlešičih; zrak 2024 pri ZD je imel benzo(a)piren 2,6 ng/m³. **[6][7]**	Preveriti trajno odpravo vzrokov v vodi, izboljšati nadzor omrežja in zmanjševati zimske izpuste. Letni pregled zraka 2025 navaja PM10 19 in PM2,5 15 µg/m³; selitev postaje omejuje trend. **[8][9]** Podrobni podatki.

UGOTOVITEV	KAJ POMENI ZA ODLOČANJE
Dostop do oskrbe je najšibkejši člen. 3.142 ljudi je registriranih v ambulantah za neopredeljene, nove paciente sprejema 1 od 9 ambulant, v SB Novo mesto 47,3 % čakajočih na prvi pregled čaka dlje od dopustne dobe. V pomoč na domu je vključen 1,0 % starejših (Slovenija 1,8 %), delež prometnih nezgod z alkoholom je 12,9 % (Slovenija 8,2 %).	Objaviti dostopne čase NMP in obseg mreže prvih posredovalcev, pripraviti načrt ob vročini in pomoč pri vlogah za dolgotrajno oskrbo v Črnomlju. Podrobnosti.

Kam po pomoč

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Kontakti so zbrani iz uradnih spletnih strani ustanov, stanje 26. septembra 2026. Po telefonu jih nismo preverjali. Urniki se lahko spremenijo, zato pred obiskom preverite na strani ustanove.

Ob nevarnosti za življenje vedno pokličite 112. [10]

Zdravje in zdravnik

KDAJ	KAM	KONTAKT
Nujno stanje, nesreča, srčni zastoj	Nujna medicinska pomoč	**112** [11]
Naročanje pri zdravniku, splošne informacije	ZD Črnomelj, Delavska pot 4	07 30 61 700, info@zd-crnomelj.si [10]
Zdravnik v Vinici	Zdravstvena postaja Vinica	07 36 46 700 [12]
Nimate izbranega osebnega zdravnika	Ambulanta za neopredeljene v ZD Črnomelj	prek centrale ZD [13]
Naročanje z e-napotnico	Nacionalna številka za naročanje	080 24 45 (potrebujete številko kartice zdravstvenega zavarovanja in e-napotnice) [14]
Pomoč pri zVEM (izvidi, recepti, pooblastila)	Klicni center eZdravja	080 72 99, vsak dan 7–22 [14]
Preventivni pregled (od 30. leta, vsakih 5 let)	Ambulanta vašega osebnega zdravnika (referenčna ambulanta)	pri osebnem zdravniku [15] [16]
Delavnice za zdrav življenjski slog, vadba	Center za krepitev zdravja (CKZ)	07 62 05 755 [17]
Nega na domu, obisk novorojenčka	Patronažna služba ZD	07 30 61 714, med 7. in 8. uro [18]

Duševno zdravje

KDAJ	KAM	KONTAKT
Otrok ali mladostnik (do 21 let) potrebuje psihologa	Psihološka ambulanta ZD Črnomelj	07 62 05 756, psiholog@zd-crnomelj.si [19]
Zahtevnejša pomoč otrokom in mladostnikom	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Novo mesto	07 39 16 819 [20]

KDAJ	KAM	KONTAKT
Otrok ali mladostnik želi anonimen pogovor	TOM telefon	116 111 [21]
Odrasla oseba v duševni stiski	Klic v duševni stiski	01 520 99 00 [21]
Anonimen pogovor kadarkoli	Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik	116 123 [21]

Starejši, oskrba in demenca

KDAJ	KAM	KONTAKT
Pomoč na domu	Dom starejših občanov Črnomelj	07 30 56 260 [22]
Vloga za dolgotrajno oskrbo	Vstopna točka CSD Dolenjska in Bela krajina, Novo mesto	07 393 26 78, dolgotrajna.csddolbk@gov.si [23]
Socialna pomoč, svetovanje	CSD, Enota Črnomelj	07 306 23 60 [24]
Demenca: informacije za svojce	Spominčica, svetovalni telefon	059 305 555 [25]
Demenci prijazna točka	DSO Metlika	ponedeljek–petek, 8–14 [25]

Kje je najbližji AED

Seznam in zemljevid defibrilatorjev sta v zavihku AED-ji. Ob srčnem zastoju najprej pokličite 112. Javno dostopni AED so vključeni v evidenco dispečerske službe zdravstva. [26]

PODROČJE 02 / ČRNOMELJ

Samopregledi in presejanje

Kaj lahko preverite sami, na katere preglede vas vabijo in ob katerih znakih ne smete čakati.
Povzetek uradnih navodil in dokazov; ne nadomešča posveta z zdravnikom.

Vodnik: kateri pregledi so za vas

Dopolnitev 27. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Nekatere pogoste bolezni dolgo ne bolijo. Zvišan krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2 ter predrakave spremembe na debelem črevesu in maternicnem vratu lahko leta napredujejo brez težav. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da 44 % odraslih z zvišanim krvnim tlakom za to ne ve. [27] Tudi v Črnomlju je tako: preventivni pregledi v ambulantah družinske medicine ZD Črnomelj so leta 2025 med 1.366 pregledanimi na novo odkrili 236 oseb z zvišanim krvnim tlakom in 144 s sladkorno boleznijo. [5]

Ta zavihek zbira uradna navodila za preglede, ki jih lahko opravite sami, in za preglede, na katere vas povabijo. Pove tudi, kaj kažejo raziskave o njihovi koristi. Vodnik ne nadomešča posveta z zdravnikom. Če se že zdravite, veljajo navodila vašega zdravnika.

> Če imate nenadne težave, kot so bolečina v prsih, povešen ustni kot, šibka roka ali nerazumljiv govor, ne merite in ne čakajte: pokličite 112. Znaki so opisani v poglavju Znaki, ob katerih ne čakajte.

Štirje načini, kako pravočasno odkriti težavo

NAČIN	KAJ POMENI	PRIMERI
Meritev ali samopregled doma	Sami opazujete in merite. Sprememba je razlog za obisk pri zdravniku, ne diagnoza.	Krvni tlak, obseg pasu in vprašalnik o sladkorni bolezni, dojke, moda in koža
Državni presejalni program	Po pošti prejmete vabilo. Pregled je za zavarovane osebe brezplačen.	Svit, Zora in Dora
Preventivni pregled v ambulanti družinske medicine	Diplomirana medicinska sestra povabi odrasle od 30. leta dalje vsakih pet let: krvne preiskave, meritve, pogovor o navadah in vprašalnik o počutju. [15]	Odkrije zvišan tlak, sladkor in maščobe v krvi, depresijo. Več o rezultatih v Črnomlju
Znaki, ob katerih ne čakate	Nekatere težave zahtevajo takojšnjo pomoč.	Možganska kap, srčni infarkt, nepravilen utrip

Poiščite preglede za svojo starost

Vpišite starost in izberite spol. Preglednica pokaže, kaj velja za vas. Brez izbire so prikazani vsi pregledi. Podatki veljajo za septembra 2026; spremembe programa Zora začnejo veljati 1. 1. 2027.

PREGLED	KOMU	KAKO POGOSTO	KAKO IN KJE
Krvni tlak	Vsi odrasli	Pri normalnem tlaku brez zdravil zadošča enkrat na leto. Pri zdravljenju po dogovoru z zdravnikom. [28]	Doma z validiranim merilnikom na nadlakti ali v ambulanti.
Obseg pasu	Vsi odrasli	Občasno; pomembno je, da se obseg ne povečuje. [29]	Doma s šiviljskim metrom v višini popka.
Vprašalnik o tveganju za sladkorno bolezen (FINDRISK)	Vsi odrasli	Kadar koli. Pri 15 točkah ali več obiščite zdravnika. [30]	Na papirju ali v spletni različici NIJZ; izračun je tudi v tem poročilu.
Preventivni pregled v ambulanti družinske medicine	Odrasli od 30. leta	Vsakih pet let; ob večjem tveganju prej. [15]	Pri diplomirani medicinski sestri v ambulanti vašega izbranega zdravnika.
Zora: rak maternicnega vratu	Ženske 20–64 let; od 1. 1. 2027 25–64 let	Na tri leta; po negativnem testu HPV na pet let. [31]	Pri izbranem ginekologu.
Dora: rak dojk	Ženske 50–69 let	Vsaki dve leti na vabilo. [32]	Slikanje v ZD Novo mesto, Kandijska cesta 4; naročanje 080 27 28. [33]
Svit: rak debelega črevesa in danke	Moški in ženske 50–74 let	Vsaki dve leti na vabilo. [34]	Test blata doma, vzorec pošljete po pošti.
Dojke: pozornost na spremembe	Vse odrasle ženske	Redno; program Dora svetuje enkrat mesečno, tudi med dvema slikanjema. [35] [32]	Ogled in otip doma; spremembo pokažite osebnemu zdravniku ali ginekologu.
Moda	Moški, zlasti mlajši (rak mod je najpogostejši rak moških, starih 20–40 let)	Društvo onkoloških bolnikov svetuje enkrat mesečno. [36] [37]	Otip med kopanjem ali po njem.
Koža in znamenja	Vsi	Društvo onkoloških bolnikov svetuje enkrat mesečno. [38]	Pred velikim ogledalom v dobro osvetljeni sobi.
Test PSA (prostata)	Moški 50–69 let	Državnega programa ni. Raziskava PRO-PETER vabi naključno izbrane moške. [39]	Odločitev po pogovoru z osebnim zdravnikom o koristih in slabostih.
Pljuča	Kadilci in nekdanji kadilci	Presejalnega programa še ni; projekt LUKA pripravlja strokovne podlage. [40]	Najbolj učinkovit korak je opustitev kajenja; CKZ Črnomelj navaja delavnico svetovanja za opuščanje kajenja. [41]

Brez JavaScripta in v PDF so prikazani vsi pregledi. Starostne meje v stolpcu »Komu« so iz navedenih virov; pri samopregledih brez uradne starostne meje preglednica uporablja 15 ali 18 let le za prikaz.

Krvni tlak: kako ga pravilno izmeriti doma

Dopolnitev 27. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Zvišan krvni tlak običajno ne boli, zato ga odkrijemo le z merjenjem. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije ima zvišan tlak 1,4 milijarde odraslih, starih 30–79 let (2024), 44 % jih za to ne ve in le 23 % ima

tlak urejen. [27]

V Občini Črnomelj je prejemnikov zdravil za zvišan krvni tlak 25,38 na 100 prebivalcev, v Sloveniji 22,51 (starostno standardizirano, izdaja NIJZ 2026, podatki za leto 2024). [3] To ni delež ljudi z zvišanim tlakom: nekateri se ne zdravijo, drugi zanj ne vedo. Preventivni pregledi ZD Črnomelj so leta 2025 na novo odkrili zvišan tlak pri 236 od 1.366 pregledanih (17,3 %). [5] Pregledani niso naključni vzorec prebivalcev, zato tega deleža ne smemo prenesti na vso občino.

Domače meritve so koristne, če so pravilno izvedene. Pri domačih meritvah so meje nižje kot v ambulanti: povprečje 135/85 mm Hg doma ustreza 140/90 mm Hg v ambulanti. [42]

Pred meritvijo in med njo

KORAK	NAVODILO
Pol ure prej	Ne jejte, ne pijte kave, ne kadite in ne pijte alkohola. Ne merite takoj po naporu. [28]
Tik pred meritvijo	Izpraznite mehur. Vsaj pet minut mirno sedite. [28]
Položaj	Sedite na stolu z naslonjenim hrbtom, stopala na tleh, noge niso prekrižane. Roka udobno leži, manšeta je v višini srca. [28]
Manšeta	Na nadlakti. Cevka poteka po notranji strani komolca. Pod manšeto mora iti en prst. Velikost manšete mora ustrezati obsegu nadlakti. [28] [42]
Med meritvijo	Bodite sproščeni, ne govorite, ne poslušajte radia in ne glejte televizije. [28] [42]
Število meritev	Dve meritvi zaporedoma z eno do dve minuti presledka. Zapišite obe. [28] [42]

Kdaj in kako pogosto meriti

POLOŽAJ	PRIPOROČILO
Normalen tlak, brez zdravil	Meritev enkrat na leto zadošča. [28]
Preverjanje, ali je tlak zvišan (pred obiskom pri zdravniku ali ob sumu)	Sedem dni (najmanj tri) zjutraj in zvečer, vsakič dve meritvi. Zjutraj merite pred jemanjem zdravil. [42]
Urejen tlak ob zdravljenju	Enkrat tedensko do enkrat mesečno oziroma po dogovoru z zdravnikom. Vsakodnevno merjenje ni priporočeno. [28] [42]

Kako razumeti rezultat

POVPREČJE DOMAČIH MERITEV	POMEN IN NASLEDNJI KORAK
Pod 135/85 mm Hg	Za domače meritve normalno. [28]
135/85 mm Hg ali več (zgornja ali spodnja vrednost)	Meja za zvišan tlak pri domačih meritvah. Zapiske prinesite osebnemu zdravniku. [42] [28]
Sladkorna ali ledvična bolezen	Zdravnik lahko določi nižje ciljne vrednosti. [28]
Vrednost ob hkratni bolečini v prsih, šibkosti roke ali noge, motnjah govora	Ne merite znova: pokličite 112. Glejte Znaki, ob katerih ne čakajte.

Zdravil ne spreminjajte sami na podlagi domačih meritev; zdravnik takšno ravnanje odsvetuje. [28] Upoštevajte povprečje več dni, ne posamezne meritve. Ena visoka vrednost po kavi ali v stresu še ne pomeni bolezni; ena normalna vrednost pa ne izključi zvišanega tlaka.

Izbira merilnika

VRSTA	PRIPOROČILO
Samodejni merilnik z manšeto na nadlakti	Priporočen, če je klinično validiran. Seznam validiranih merilnikov je na mednarodni strani STRIDE BP (stridebp.org). [28] [42]
Merilnik na zapestju	Na splošno ni priporočen, ker je manj natančen. [42]
Pametne ure in naprave brez manšete	Evropsko združenje za hipertenzijo jih ne priporoča za postavitev diagnoze ali vodenje zdravljenja, ker natančnost še ni ustrezno preverjena. [43]
Po nakupu	Merilnik naj pregleda zdravnik ali medicinska sestra, ki vam pokaže tudi pravilno merjenje. [28]

Pomoč v Črnomlju

KJE	KAJ PONUJAJO PO OBJAVLJENIH VIRIH
Ambulante družinske medicine (referenčne ambulante) ZD Črnomelj	Preventivni pregledi, tudi v popoldanskih terminih. [16]
CKZ Črnomelj	Delavnica »Zvišan krvni tlak«, delavnice »Zdravo jem«, »Gibam se« in »Zdravo hujšanje«. Termini niso preverjeni. [41]
Lekarna Črnomelj	Pregled uporabe zdravil. Merjenje tlaka na njeni spletni strani ni navedeno. [44]

Sladkorna bolezen tipa 2 in obseg pasu: ocenite tveganje

Dopolnitev 27. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Sladkorna bolezen tipa 2 pride tiho. Značilni znaki, kot so huda žeja, pogosto uriniranje, utrujenost, nepojasnjeno hujšanje in zamegljen vid, se pogosto pojavijo šele pozno. [30] Preventivni pregledi ZD Črnomelj so leta 2025 na novo odkrili sladkorno bolezen pri 144 od 1.366 pregledanih. [5] Prejemnikov zdravil za sladkorno bolezen je v občini 5,72 na 100 prebivalcev, v Sloveniji 5,47 (standardizirano, izdaja NIJZ 2026). [3] Tudi to ni celotna razširjenost bolezni.

Tveganje lahko ocenite sami z vprašalnikom FINDRISK, ki ga priporoča NIJZ. Pri 15 točkah ali več obiščite osebnega zdravnika, ki bo naročil laboratorijsko meritev krvnega sladkorja. [30] [45]

Vprašalnik FINDRISK

Za vsako vprašanje izberite odgovor, ki velja za vas, in seštejte točke. Indeks telesne mase (ITM) izračunate tako, da telesno težo v kilogramih delite s kvadratom višine v metrih (npr. 80 kg / (1,75 m × 1,75 m) = 26,1). [45]

VPRAŠANJE	ODGOVORI IN TOČKE
1. Starost	Manj kot 45 let: 0 · 45–54 let: 2 · 55–64 let: 3 · več kot 64 let: 4
2. Indeks telesne mase	Manj kot 25: 0 · 25–30: 1 · več kot 30: 3
3. Obseg pasu v višini popka	Moški: manj kot 94 cm: 0 · 94–102 cm: 3 · več kot 102 cm: 4. Ženske: manj kot 80 cm: 0 · 80–88 cm: 3 · več kot 88 cm: 4
4. Ali ste vsak dan vsaj 30 minut telesno dejavni v službi ali doma?	Da: 0 · ne: 2
5. Kako pogosto jeste zelenjavo ali sadje?	Vsak dan: 0 · ne vsak dan: 1
6. Ali ste kdaj redno jemali zdravila za znižanje krvnega tlaka?	Ne: 0 · da: 2
7. Ali so vam kdaj izmerili zvišan krvni sladkor (pri pregledu, ob bolezni, med nosečnostjo)?	Ne: 0 · da: 5
8. Ali ima ali je imel kdo od krvnih sorodnikov sladkorno bolezen (tip 1 ali 2)?	Ne: 0 · da, stari starši, tete, strici, bratranci ali sestrične: 3 · da, starši, bratje, sestre ali otroci: 5

Vir: vprašalnik NIJZ, 2026. [45]

Kaj pomeni seštevek

TOČKE	OCENA TVEGANJA V NASLEDNJIH 10 LETIH	KAJ STORITI
Manj kot 7	Nizko: zboli približno 1 od 100	Vprašalnik posebnega ukrepa ne navaja.
7–11	Povečano: približno 1 od 25	Vprašalnik posebnega ukrepa ne navaja; zdrav način življenja lahko bolezen prepreči ali odloži.
12–14	Zmerno: približno 1 od 6	Resno presodite gibanje, prehrano in telesno težo; več informacij pri zdravniku ali medicinski sestri.
15–20	Visoko: približno 1 od 3	Obiščite osebnega zdravnika; potrebna je laboratorijska meritev krvnega sladkorja. Sladkorno bolezen morda že imate, čeprav ne čutite težav.
Več kot 20	Zelo visoko: približno 1 od 2	Obiščite osebnega zdravnika.

Vir: NIJZ, 2026. [45] Vprašalnik oceni tveganje, ne postavi diagnoze.

Ali naj si sladkor merim doma?

Slovenske smernice za obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 odsvetujejo merjenje krvnega sladkorja za ugotavljanje sladkorne bolezni zunaj zdravstvenega sistema. [46] Diagnozo postavi zdravnik na podlagi laboratorijskih preiskav, pri ljudeh brez znakov bolezni praviloma z dvema pozitivnima izvidoma. [46] Merilnik sladkorja (glukometer) je pripomoček za ljudi, ki že imajo sladkorno bolezen, po dogovoru z zdravstvenim timom.

LABORATORIJSKA PREISKAVA	MEJA ZA DIAGNOZO SLADKORNE BOLEZNI
Glukoza v plazmi na tešče (vsaj 8 ur brez hrane)	7,0 mmol/l ali več [46]

LABORATORIJSKA PREISKAVA	MEJA ZA DIAGNOZO SLADKORNE BOLEZNI
Glikirani hemoglobin HbA1c	6,5 % (48 mmol/mol) ali več [46]
Naključna glukoza ob značilnih znakih	11,1 mmol/l ali več [46]
Preventivni pregled: glukoza na tešče pod 6,1 mmol/l	Uvrstitev med osebe brez motene glukoze; ob dejavnikih tveganja svetovanje in usmeritev v CKZ. [46]

Številke so namenjene razumevanju izvida, ne samodiagnozi.

Obseg pasu

Obseg pasu izmerite s šiviljskim metrom v višini popka. [29] Maščoba okrog pasu je bolj tvegana kot maščoba na bokih in zadnjici. [29]

OBSEG PASU	ŽENSKE	MOŠKI
Ogroža zdravje	več kot 80 cm	več kot 94 cm
Zelo ogroža zdravje	več kot 88 cm	več kot 102 cm

Vir: NIJZ. [29] Z zmanjšanjem obsega pasu za 5–10 cm (5–10 % telesne mase) se ogroženost bistveno zmanjša; hitre shujševalne diete dolgoročno niso učinkovite. [29]

Pomoč v Črnomlju

KJE	KAJ PONUJAJO PO OBJAVLJENIH VIRIH
Ambulanta vašega izbranega zdravnika	Preventivni pregled od 30. leta, vsakih pet let, vključno s krvnim sladkorjem. [15]
CKZ Črnomelj	Delavnice »Zvišan krvni sladkor«, »Sladkorna bolezen tipa 2«, »S sladkorno boleznijo skozi življenje«, »Zdravo hujšanje«, »Zdravo jem« in »Gibam se«. Termini niso preverjeni. [41]

Dojke, moda in koža: poznajte svoje telo

Dopolnitev 27. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Slovenske ustanove svetujejo redno samopregledovanje dojk, mod in kože. [35] [36] [38] Pošteno pa je povedati tudi, kaj kažejo raziskave. Pregled dveh velikih raziskav z 388.535 ženskami ni pokazal, da bi sistematično samopregledovanje dojk zmanjšalo umrljivost za rakom dojk; ženske, ki so se samopregledovale, so imele skoraj dvakrat več biopsij (3.406 proti 1.856). [47] Ameriški neodvisni strokovni odbor ne priporoča presejanja za raka mod pri moških brez težav in ocenjuje, da dokazi o pregledovanju kože pri ljudeh brez znakov ne zadoščajo. [48] [49]

Kaj to pomeni za vas? Samopregled ne nadomesti presejalnega programa in ni zagotovilo, da bolezni ni. Njegov smisel je, da spoznate, kaj je za vaše telo normalno, in spremembo hitro pokažete zdravniku. Ameriški odbor v obeh priporočilih izrecno poudarja, da oceni ne veljata za ljudi, ki spremembo že opazijo: ti naj gredo

k zdravniku. [48] [49] Tudi Cochranov pregled svetuje, naj ženske ob vsaki spremembi v dojki poiščejo zdravniški nasvet. [47]

Dojke

Onkološki inštitut za ženske s povprečno ogroženostjo priporoča redno samopregledovanje dojk oziroma pozornost na spremembe ter udeležbo v programu Dora. [35] Program Dora svetuje samopregled enkrat mesečno, tudi med dvema slikanjema, saj se rak lahko pojavi med njima. [32]

KORAK	KAKO (PO NAVODILIH EUROPA DONNA SLOVENIJA)
Kdaj	Do menopavze deseti dan po začetku menstruacije, pozneje na izbrani dan v mesecu. [50]
Ogled	Pred ogledalom z rokama ob telesu, nato z rokama na bokih in z dvignjenima rokama. Iščite vidne spremembe dojk in bradavic. [50]
Otip dojk	Dvignite roko in z drugo roko pretipajte vso dojko s krožnimi gibi, od robov proti bradavici. Ponovite na drugi strani. [50]
Bradavici	S palcem in sredincem nežno stisnite vsako bradavico in preverite, ali je izcedek. [50]
Pazduhi	Pretipajte obe pazduhi, najprej s stisnjenimi in nato z razprtimi prsti. [50]
Leže	Pregled lahko končate leže, z vzglavnikom pod ramo. [50]

NA KAJ BODITE POZORNI	KAJ STORITI
Zatrdlina v dojki ali pazduhi, sprememba velikosti ali oblike, sprememba barve kože, uvlečena bradavica, izcedek [50]	Obrnite se na osebnega zdravnika ali ginekologa, ki vas napoti v center za bolezni dojk. Ne čakajte na naslednje vabilo Dora. [32]
Več primerov raka dojk ali jajčnikov v družini	Povejte zdravniku. Za ženske z večjo ogroženostjo veljajo drugačni pregledi, na primer klinični pregled in mamografija pred 50. letom. [35]

Moda

Rak mod je redek, a je najpogostejši rak mladih odraslih moških, starih 20–40 let. Leta 2022 je v Sloveniji zbolelo 126 moških. Bolezen je večinoma ozdravljiva. [37] Društvo onkoloških bolnikov Slovenije svetuje samopregled enkrat mesečno. [36]

KORAK	KAKO (PO NAVODILIH DRUŠTVA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV)
Kdaj	Med kopanjem ali po njem, ko je mošnja mehka. Otip naj bo nežen. [36]
Kako	Vsako modo pregledajte posebej, s palcem, kazalcem in sredincem obeh rok. [36]
Kaj je normalno	Nadmodek se tipa kot mehka, nekoliko vozličasta vrvica nad modom in ob njem; semenovod kot trša gladka cevka. Zdravo modo je ovalno, prožno in gladko. Majhna zatrdlina v velikosti prosenega zrna na površini ni sumljiva. [36]
Kdaj k zdravniku	Vsaka zatrdlina v globini moda, ne glede na velikost; boleče ali neboleče povečanje moda; hitra sprememba velikosti, občutek teže ali neugodja. [36] [37]

Koža in znamenja

Najpomembnejši dejavnik tveganja za kožnega melanoma je ultravijolično sevanje sonca in solarijev. Bolj ogroženi so ljudje s svetlo poltjo, veliko znamenji, melanomom v družini ali že prebolelim melanomom. [38] Društvo onkoloških bolnikov svetuje mesečni pregled kože v dobro osvetljeni sobi z velikim ogledalom, tudi lasišča in kože med prsti rok in nog. Pozorni bodite na nove spremembe, ki se večajo ali se ne zacelijo v mesecu ali dveh. [38]

ČRKA	NA KAJ POMISLITI PRI ZNAMENJU [38]
A – asimetrija	Polovici znamenja nista enaki.
B – rob	Rob je nazobčan ali nepravilen.
C – barva	Znamenje spreminja barvo, temni ali ima več odtenkov.
D – premer	Večji od 5 mm.
E – spreminjanje	Znamenje raste v višino ali širino.

Pravilo ABCDE je pripomoček, ne diagnoza. Znamenje, ki vas skrbi, pokažite osebnemu zdravniku. Zaščita pred soncem med 10. in 16. uro, zaščitna krema s faktorjem SPF 30, zaščitna oblačila in izogibanje solarijem so priporočeni ukrepi. [38]

Presejalni programi Svit, Zora in Dora ter kaj prihaja

Dopolnitev 27. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Presejanje pomeni, da pri ljudeh brez težav s preprostim testom iščemo tiste, ki morda že imajo raka ali njegove predstopnje. [34] V Sloveniji delujejo trije organizirani državni programi: Zora za raka materničnega vratu, Dora za raka dojk in Svit za raka debelega črevesa in danke. [51] Za zavarovane osebe so brezplačni; vabilo pride po pošti. Evropski kodeks proti raku (5. izdaja, 2026) posameznikom priporoča udeležbo v organiziranih presejalnih programih, kot jih priporoča njihova država. [52]

Prebivalci Črnomlja se na vabila odzivajo dobro. Pri Svitu in Dori je odziv nad slovenskim povprečjem, pri Zori mu je blizu. [3]

PROGRAM	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	POJASNILO
Svit, odzivnost	68,14 %	64,94 %	Izdaja NIJZ 2026; NIJZ razliko označuje kot ugodno. [3]
Zora, pregledanost	71,96 %	72,48 %	Izdaja 2026; razlika ni statistično značilna. [3]
Dora, presejanost	82,08 %	77,93 %	Izdaja 2026 (obdobje januar 2024–oktober 2025). [3]

Več o časovnih nizih je v poglavju Presejanje in preventiva.

Trije državni programi

PROGRAM	KOMU	KAKO POGOSTO	KAKO POTEKA
Svit	Moški in ženske, stari 50–74 let, z obveznim zdravstvenim zavarovanjem	Vsaki dve leti	Po pošti prejmete komplet za odvzem vzorca blata doma in ga pošljete v analizo. Pri pozitivnem testu sledi kolonoskopija. [34] V Črnomlju CKZ navaja stran »Svit podpora«. [41]
Zora	Ženske, stare 20–64 let; od 1. 1. 2027 stare 25–64 let	Na tri leta; po negativnem testu HPV na pet let	Bris maternične vratu pri izbranem ginekologu. [31]
Dora	Ženske, stare 50–69 let, brez prej ugotovljenega raka dojk	Vsaki dve leti	Presejalna mamografija. Ženske iz Črnomlja, Metlike in Semiča so vabljene v presejalni center v ZD Novo mesto, Kandijska cesta 4. Naročanje in sprememba termina: 080 27 28, ob delavnikih 9.–12. ure. [33] [32]

Novosti 2026–2027

KAJ	STANJE PO URADNIH VIRIH
Zora prehaja na test HPV	Od 1. 1. 2027 ciljna skupina 25–64 let. Test HPV se bo uvajal postopno v petih letih; iz istega vzorca se test PAP opravi le ob pozitivnem testu HPV. Po negativnem testu HPV je naslednji pregled čez pet let, do prvega testa HPV pa ostaja triletni interval. Ženske po 64. letu niso več aktivno vabljene; če ob izstopu nimajo negativnega testa HPV, se lahko same naročijo pri izbranem ginekologu. [31]
Dora za starost 45–74 let	Program se pripravlja na načrtovano širitev. Raziskava do konca leta 2026 vključuje 2.150 žensk iz sedmih občin ljubljanske enote ZZZS; za Belo krajino še ne velja. [53]
Rak prostate (PSA)	Državnega programa ni. Raziskava PRO-PETER vabi naključno izbrane moške, stare 50–69 let; kri odvzamejo na Onkološkem inštitutu ali v UKC Ljubljana. [39] Evropski kodeks proti raku ocenjuje, da je za splošno priporočilo presejanja še prezgodaj, ker koristi spremlja tudi pretirano diagnosticiranje. [52] Moški, ki razmišlja o testu PSA, naj se o koristih in slabostih pogovori z osebnim zdravnikom.
Rak pljuč	Presejalnega programa še ni. Projekt LUKA pripravlja strokovne podlage za morebitno presejanje z nizkodozno računalniško tomografijo pri ljudeh z visokim tveganjem. [40] Evropski kodeks tako presejanje priporoča le za ljudi z večjim tveganjem in v povezavi s pomočjo pri opuščanju kajenja. [52]

Negativen izvid ni garancija

Noben presejalni test ni stoodstotno zanesljiv, zato je treba biti pozoren na znake bolezni tudi po negativnem izvidu. [51] Spremembe na steni črevesa ne krvavijo ob vsakem odvajanju, zato je pomembno, da se na vabilo Svit odzovete vsaki dve leti. [34] Rak dojk se lahko pojavi tudi pred 50. letom, med dvema slikanjema ali po 70. letu. [32]

KAJ SE ZGODI	KAJ STORITI
Opazite spremembo v dojki med dvema vabiloma	K osebnemu zdravniku ali ginekologu, ne na presejalno slikanje. [32]

KAJ SE ZGODI	KAJ STORITI
Imate težave (na primer kri v blatu)	Presejanje je namenjeno ljudem brez težav. S težavami pojdite k osebnemu zdravniku. [51]
Vabila niste prejeli ali ste ga izgubili	Za Doro pokličite 080 27 28. [32] Za Svit in Zoro se obrnite na program oziroma izbranega ginekologa.

Znaki, ob katerih ne čakajte

Dopolnitev 27. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Samopregledi so namenjeni počasnim spremembam. Nekatera stanja pa zahtevajo takojšnjo pomoč: pri možganski kapi šteje vsaka minuta, saj se z vsakim odlašanjem povečuje možnost trajne okvare možganov. [54] Tudi srčni infarkt lahko povzroči smrt, zato z ukrepanjem ne smemo odlašati. [55] Pri teh znakih ne merite tlaka in ne čakajte, da mine: pokličite 112.

Možganska kap: GROM

ČRKA	ZNAK
G – govor	Neustrezen, zatikajoč ali slabo razumljiv govor. Človek lahko popolnoma molči ali govori nepovezano. [54]
R – roka	Nenadna šibkost roke ali noge, običajno na eni strani telesa. Ko ga prosite, naj dvigne obe roki, dvigne le eno. [54]
O – obraz	Povešen ustni kot na eni strani, običajno na isti strani kot šibkost roke ali noge. [54]
M – minuta	Vsaka minuta šteje. Takoj pokličite 112 in povejte, da ste ob človeku, ki je verjetno doživel možgansko kap. [54]

Srčni infarkt

KAJ OPAZITE	KAJ STORITI
Stiskajoča ali pekoča bolečina v prsnem košu, ki nastane v mirovanju ali ob najmanjšem naporu in se ne spreminja z dihanjem ali položajem telesa. Pogosto se širi v vrat, v eno ali obe roki ali v žličko. Pridružijo se lahko slabost, bruhanje, bledica, potenje in občutek dušenja. [55]	Če bolečina v mirovanju v nekaj minutah ne popusti, pokličite 112. Do prihoda reševalcev naj bolnik počiva. [55]
Pri manj kot petini bolnikov je bolečina neznačilna ali je sploh ni, predvsem pri starejših in pri ljudeh s sladkorno boleznijo. [55]	Ob nenavadni slabosti, dušenju ali potenju brez razlage ne odlašajte s klicem.

Če človek izgubi zavest, takoj pokličite 112. Lokacije AED-jev iz ohranjenega registra so v zavihku AED-ji, o dostopu do nujne pomoči pa v poglavju Nujna pomoč.

Drugi znaki, zaradi katerih pojdite k zdravniku

ZNAK	ZAKAJ JE POMEMBEN IN KAM
Hitro in nepravilno bitje srca, pogosto s tiščanjem v prsih, pomanjkanjem sape, omotico ali slabšo zmogljivostjo; napadi trajajo najmanj uro ali več dni	Lahko gre za atrijsko fibrilacijo, ki do petkrat poveča možnost možganske kapi. Nekateri je sploh ne zaznajo. K osebnemu zdravniku; ob znakih kapi 112. [56]
Huda žeja, pogosto uriniranje, utrujenost, nepojasnjeno hujšanje, zamegljen vid	Lahko so znaki zvišanega krvnega sladkorja. K osebnemu zdravniku. [30]
Zatrdlina v dojki ali pazduhi, uvlečena bradavica, izcedek	K osebnemu zdravniku ali ginekologu, tudi če ste bili nedavno na slikanju Dora. [32] [50]
Neboleča zatrdlina v modu, hitra sprememba velikosti ali občutek teže	K osebnemu zdravniku. [37]
Znamenje, ki raste, spreminja barvo ali obliko, ali rana, ki se ne zaceli v mesecu ali dveh	K osebnemu zdravniku. [38]
Kakršni koli sumljivi znaki kljub negativnemu presejalnemu testu	Noben presejalni test ni stoodstotno zanesljiv. Ne odlašajte z obiskom pri osebnem zdravniku. [51]
Duševna stiska	Telefonske številke za pomoč so v poglavju Kam po pomoč.

Samopregledi in presejanje v Črnomlju: vrzeli, vprašanja in predlogi

Dopolnitev 27. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Prebivalci Črnomlja se dobro odzivajo na državna presejalna programa Svit in Dora, pri Zori so blizu slovenskega povprečja. [3] Preventivni pregledi ZD pa kažejo veliko še neodkritih bolezni: leta 2025 so pri 1.366 pregledanih na novo odkrili 236 primerov zvišanega krvnega tlaka in 144 sladkorne bolezni. [5] Prebivalci zato potrebujejo jasna, lokalna in preverjena navodila, kaj lahko preverijo sami in kam se obrnejo. Na spletnih straneh ZD Črnomelj, CKZ in Lekarne Črnomelj, ki smo jih pregledali, takega vodnika nismo našli; CKZ navaja delavnice o zvišanem tlaku, sladkorju in opuščanju kajenja ter stran »Svit podpora«. [41] [44]

Dokazi o koristi samopregledov so različni. Pravilno merjenje tlaka doma je v smernicah dobro podprto, [42] sistematični samopregled dojk pa v raziskavah ni zmanjšal umrljivosti in je povečal število biopsij. [47] Obveščanje mora zato poudarjati poznavanje lastnega telesa in hiter obisk ob spremembi, ne lažne gotovosti.

Trenutno stanje

Zavihek »Samopregledi in presejanje« v tem poročilu povzema uradna navodila za prebivalce: vodnik po starosti, krvni tlak, sladkorno bolezen in obseg pasu, dojke, moda in kožo, presejalne programe in nujne znake. Vsebina je pripravljena iz javnih virov 27. 9. 2026 in je ni pregledal zdravnik ZD Črnomelj.

Ključna dejstva

DEJSTVO	VIR
Svit: odzivnost 68,14 % (Slovenija 64,94 %, ugodna razlika); Zora 71,96 % (72,48 %, neznačilno); Dora 82,08 % (77,93 %); izdaja NIJZ 2026.	[3]
Prejemniki zdravil za zvišan tlak 25,38 na 100 (Slovenija 22,51), za sladkorno bolezen 5,72 (5,47); izdaja 2026, standardizirano; ni razširjenost bolezni.	[3]
Preventivni pregledi ZD 2025: 1.366 pregledanih, na novo 236 zvišanega tlaka, 165 depresije, 144 sladkorne bolezni.	[5]
Doma velja meja 135/85 mm Hg; priporočeni so validirani merilniki na nadlakti, zapestni na splošno ne; naprave brez manšete niso priporočene za diagnozo.	[42] [43]
Slovenske smernice odsvetujejo merjenje glukoze za diagnozo zunaj zdravstvenega sistema; NIJZ priporoča vprašalnik FINDRISK (15+ točk: k zdravniku).	[46] [30]
Zora od 1. 1. 2027: 25–64 let, postopno test HPV, interval pet let po negativnem testu.	[31]
Ženske iz Črnomlja so vabljene na Doro v ZD Novo mesto; mobilna enota v Beli krajini je bila leta 2016 napovedana za leto 2018, sedanja stran programa je ne navaja.	[33] [57]
Za raka prostate in pljuč ni državnega programa; potekata raziskava PRO-PETER in projekt LUKA. Evropski kodeks proti raku (2026) presejanja raka prostate še ne priporoča.	[39] [40] [52]
Samopregled dojk: brez vpliva na umrljivost v dveh velikih raziskavah, skoraj dvakrat več biopsij; OI kljub temu priporoča pozornost na spremembe.	[47] [35]
USPSTF: presejanje za raka mod pri moških brez težav ni priporočeno; za pregled kože dokazi ne zadoščajo. Ne velja za ljudi z znaki.	[48] [49]

Viri

Uradni slovenski viri (NIJZ, Onkološki inštitut, programi Svit, Zora in Dora, Diabetološko združenje) imajo visoko zanesljivost. Mednarodni viri (ESH, WHO, Cochrane, USPSTF, Evropski kodeks proti raku) so prebrani v povzetkih ali priporočilnih delih; ameriški odbor USPSTF ocenjuje drug zdravstveni sistem. Bolniška združenja (DOBS, Europa Donna, GROM) so uporabljena za praktična navodila, ne za dokaz učinka. Knjižica o srčnem infarktu je strokovna, a jo je izdalo farmacevtsko podjetje in nima datuma. Stran rakdojk.si, ki jo izdaja farmacevtsko podjetje, ni uporabljena. Priporočila ESC 2024 za atrijsko fibrilacijo niso bila dostopna (403) in niso navedena.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Veliko neodkritega zvišanega tlaka in sladkorne bolezni	236 in 144 novih primerov v enem letu pri pregledanih. [5]
Ni lokalnega vodnika za samopreglede	Na pregledanih straneh ZD, CKZ in lekarne ga nismo našli.

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Meritve v lekarni niso navedene	Stran Lekarne Črnomelj navaja pregled uporabe zdravil, ne meritev. [44]
Dora zahteva pot v Novo mesto	Napovedana mobilna enota v Beli krajini ni navedena na sedanji strani. [33] [57]
Sprememba Zore 2027	Ženske, stare 20–24 let, ne bodo več vabljene; interval se podaljša. Potrebno je razumljivo obveščanje. [31]
Zora nekoliko pod povprečjem	71,96 % proti 72,48 %, razlika neznačilna. [3]
Naprave brez manšete in pametne ure	Niso priporočene za diagnozo; ljudje jih lahko napačno razumejo kot zanesljive. [43]
Šibki dokazi za samopregled dojk, mod in kože	Tveganje lažnega pomirjanja ali nepotrebnih preiskav. [47] [48]

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Vodstvo ZD Črnomelj	Koliko od 236 oseb z na novo odkritim zvišanim tlakom in 144 s sladkorno boleznijo je v šestih mesecih začelo zdravljenje ali obravnavo v CKZ? Agregirani podatki za leto 2025.
Vodstvo ZD Črnomelj	Ali ZD pacientom posoja ali priporoča validirane merilnike tlaka in jih uči pravilnega merjenja? Opis prakse in število usposobljenih.
CKZ Črnomelj	Koliko delavnic »Zvišan krvni tlak«, »Zvišan krvni sladkor« in »Svetovanje za opuščanje kajenja« je bilo izvedenih v letih 2025 in 2026 in s koliko udeleženci? Evidenca izvedb.
CKZ Črnomelj	Kaj obsega »Svit podpora« in koliko ljudi je dosegla? Opis in število stikov.
Ginekologija ZD Črnomelj	Kako bodo ženske obveščene o spremembah Zore 2027 in koliko jih ima zamujen bris? Načrt obveščanja, delež zamud.
Program Dora (Onkološki inštitut)	Ali ženske iz Bele krajine slika mobilna enota ali samo center v Novem mestu, in kakšen je odziv po krajih? Urnik mobilne enote, odzivnost po občinah.
Program Svit (NIJZ)	Katere skupine v Črnomlju se najredkeje odzovejo (starost, spol, kraj)? Agregirani podatki.
Lekarna Črnomelj	Ali lekarna izvaja meritve tlaka, sladkorja ali holesterola in ob katerih pogojih? Cenik in urnik storitev.
Občina Črnomelj	Ali bo občina podprla preventivne dneve z meritvami v krajevnih skupnostih, skupaj z ZD in društvi? Sklep in proračunska postavka.
Društva upokojencev in KS	Ali bi gostili meritve tlaka in predstavitev vprašalnika FINDRISK? Pisni dogovor.
NIJZ	Kolikšen delež odraslih v JV regiji si doma meri tlak in pozna svoje vrednosti? Podatki ankete EHIS ali CINDI.
Osnovne in srednje šole	Ali pri zdravstveni vzgoji mladih vključujejo prepoznavanje znakov kapi (GROM) in samopregled mod in dojk? Učni načrt ali program ZD.

Tveganja

Samopregled lahko lažno pomiri ali povzroči nepotrebno skrb in preiskave. Domače meritve z nevalidiranimi napravami dajejo napačne vrednosti. Ljudje lahko na podlagi domačih meritev sami spreminjajo zdravljenje, kar strokovnjaki odsvetujejo. [28] Starejši brez prevoza težje pridejo na Doro v Novo mesto. Navodila v tem poročilu niso nadomestilo za obravnavo pri zdravniku.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	ZD in CKZ na spletni strani objavita kratek lokalni vodnik po samopregledih in presejanju (lahko na podlagi tega zavihka, po strokovnem pregledu).	10–20 ur dela; obstoječi kadri.	Več ljudi ve, kam iti; tveganje zastarelih podatkov. Objava in letna posodobitev.
0–12 mesecev	Dnevi meritev tlaka in izpolnjevanja vprašalnika FINDRISK v krajevnih skupnostih (ZD, CKZ, društva, občina).	2–4 dogodki na leto; pogodbe o sodelovanju, morebitna občinska sredstva.	Odkrivanje v oddaljenih krajih; tveganje enkratnega dogodka brez nadaljnje obravnave. Število izmerjenih in delež napotenih, ki so prišli k zdravniku v treh mesecih.
0–12 mesecev	Obveščanje žensk o spremembah Zore 2027 prek ambulant, lekarne in lokalnih medijev.	Obstoječa gradiva programa Zora.	Manj zmede; tveganje, da mlajše ženske razumejo spremembo kot »pregled ni potreben«. Pregledanost Zora v izdaji NIJZ 2028.
1–3 leta	Učenje pravilnega merjenja tlaka in posoja validiranih merilnikov za tedensko merjenje pred obiskom (ZD, CKZ).	20–40 merilnikov, načrtovalna ocena nekaj tisoč evrov; ZD, donacije, občinski razpisi.	Natančnejša diagnoza; tveganje izgube merilnikov. Delež pacientov z domačimi meritvami pred odločitvijo o zdravljenju.
1–3 leta	ZD v letnem poročilu objavi izide po preventivnih pregledih (začetek zdravljenja, vključitev v CKZ).	Obstoječi podatki.	Presoja koristi pregledov; tveganje dodatnega administrativnega dela. Objava v letnem poročilu.
1–3 leta	Dogovor z Onkološkim inštitutom o mobilni enoti Dora v Beli krajini ali o organiziranem prevozu.	Program Dora, občina.	Lažji dostop; tveganje stroškov in terminov. Odzivnost po občinah.
3–10 let	Priprava na morebitna nova programa (pljuča, prostata): seznam ogroženih kadilcev v ambulantah in krepitev programa opuščanja kajenja v CKZ.	Državni program, ko bo sprejet.	Hitra uvedba; tveganje, da programa ne bosta sprejeta. Delež kadilcev, vključenih v opuščanje.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril. Ocena presoja javno dokumentirano ponudbo in obveščanje, ne klinične kakovosti.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	3: ZD objavlja število pregledov in odkritih bolezni; lokalnega vodnika za samopreglede ni.
Dostop in razpoložljivost	3: preventivni pregledi in delavnice CKZ; Dora v Novem mestu; meritve v lekarni niso navedene.
Usklajenost s potrebami	4: ponudba CKZ naslavlja tlak, sladkor in kajenje, ki so v občini pogosti.
Dokazna podlaga in spremljanje	2: ni podatkov o izidih po pregledih in o domačih meritvah; dokazi za samopreglede so omejeni.
Pravičnost in doseg	3: odziv na Svit in Doro nad povprečjem; podatkov po krajih in skupinah ni.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	4: državni programi so stalni; lokalna ponudba je odvisna od kadrov CKZ.
Izvedljivost	4: obveščanje in dnevi meritev so poceni.

Izračun: (3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 4) / 7 = **3,29/5,** ⚠️.

Primerjave

Črnomelj je pri odzivu na Svit in Doro nad slovenskim povprečjem, pri Zori blizu njega (izdaja NIJZ 2026). **[3]** Podatkov o tem, koliko prebivalcev si doma meri tlak ali pozna svoje vrednosti, za občino in regijo nismo pridobili; brez njih primerjava ni mogoča.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Izidi po preventivnih pregledih	Zahteva ZD (vključiti v zahtevo IJZ).
Mobilna enota Dora v Beli krajini	Vprašanje programu Dora.
Meritve v Lekarni Črnomelj	Preveriti pri lekarni.
Poznavanje tlaka med prebivalci	Podatki NIJZ (EHIS) za JV regijo.
Strokovni pregled zavihka	Predlagati pregled zdravniku družinske medicine ZD ali CKZ.

Zdravje v številkah

Kazalniki in demografski kontekst. Letnica na drsniku NIJZ je leto izdaje; referenčna obdobja so navedena ob grafih in v metodologiji.

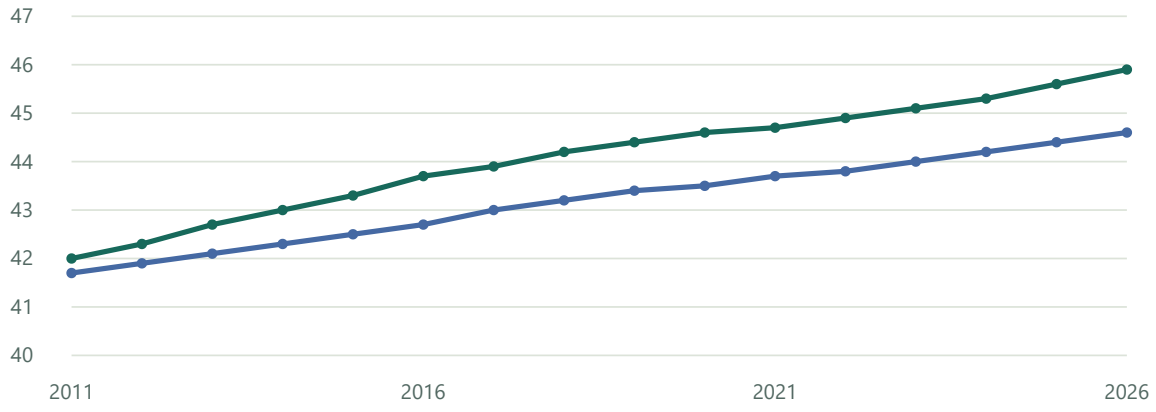
17 Starost prebivalcev in staranje občine

Na **1. januar 2026** ima občina **14 170 prebivalcev**. Povprečna starost je **45,9 leta**, kar je 1,3 leta nad slovenskim povprečjem (44,6). Delež starih 65 let ali več dosega **25,5 %**, v Sloveniji 22,5 %. **[58][59]**

> Od začetka 2011 do začetka 2026 se je število prebivalcev zmanjšalo za 547 (3,7 %), število starih 65+ pa povečalo z 2.420 na 3.616 (+49,4 %). Število starih 15–64 let je upadlo z 10.266 na 8.502 (−17,2 %). Otrok 0–14 let je bilo 2.031, zdaj jih je 2.052; po letu 2021 se je njihovo število zmanjšalo. To opisuje spremembo sestave, ne dokazuje posameznega vzroka selitev ali staranja. **[58]**

Povprečna starost, 2011–2026

Zelena: Črnomelj · modra: Slovenija · stanje na 1. januar · v letih



Vir: SURS; vse vrednosti so tudi v spodnji tabeli. **[59]**

Prebivalstvo in starostne skupine po letih

LETO (1. 1.)	SKUPAJ	0–14 LET	15–64 LET	65+ LET	80+ LET[1]	STAROST ČRNOMELJ	STAROST SLOVENIJA	INDEKS STARANJA
2011	14 717	2 031	10 266	2 420	676	42,0	41,7	119,2
2012	14 714	2 042	10 213	2 459	699	42,3	41,9	120,4

LETO (1. 1.)	SKUPAJ	0–14 LET	15–64 LET	65+ LET	80+ LET[1]	STAROST ČRNOMELJ	STAROST SLOVENIJA	INDEKS STARANJA
2013	14 629	2 058	10 054	2 517	747	42,7	42,1	122,3
2014	14 586	2 103	9 929	2 554	776	43,0	42,3	121,4
2015	14 591	2 104	9 837	2 650	811	43,3	42,5	126,0
2016	14 407	2 101	9 575	2 731	836	43,7	42,7	130,0
2017	14 365	2 071	9 473	2 821	867	43,9	43,0	136,2
2018	14 313	2 076	9 354	2 883	868	44,2	43,2	138,9
2019	14 299	2 078	9 254	2 967	859	44,4	43,4	142,8
2020	14 241	2 104	9 090	3 047	867	44,6	43,5	144,8
2021	14 308	2 159	8 995	3 154	828	44,7	43,7	146,1
2022	14 279	2 168	8 840	3 271	842	44,9	43,8	150,9
2023	14 236	2 122	8 759	3 355	849	45,1	44,0	158,1
2024	14 232	2 125	8 677	3 430	839	45,3	44,2	161,4
2025	14 213	2 079	8 621	3 513	835	45,6	44,4	169,0
2026	14 170	2 052	8 502	3 616	823	45,9	44,6	176,2

Oba spola skupaj; prebivalci celotne občine, ne samo mesta Črnomelj ali celotnega območja ZD. H1 pomeni stanje na 1. januar, ne letnega povprečja. Najnovejše stanje je 1. 1. 2026, objavljeno 18. 5. 2026. Povprečno starost uporabljamo neposredno iz SURS; ne izračunavamo je iz skupine 85+. Pri občinah SURS od 2011 uporablja enoletne starostne skupine, zato je glavni trend prikazan od 2011. Celotni prenos števil je za 2008–2026. [1] Skupina 80+ je že vključena v 65+; teh stolpcev se ne sešteva. **[60]**

Prenesi letno tabelo CSV · Vse starosti, 2008–2026, Črnomelj in Slovenija

Koliko ljudi je v posamezni starostni skupini?

Stanje na 1. januar 2026. Zadnja skupina je odprta (85 let in več). **[58]**

STAROST	PREBIVALCI	DELEŽ (%)
0–4 let	617	4,4
5–9 let	704	5,0
10–14 let	731	5,2
15–19 let	713	5,0
20–24 let	539	3,8
25–29 let	601	4,2
30–34 let	712	5,0
35–39 let	907	6,4

STAROST	PREBIVALCI	DELEŽ (%)
40–44 let	987	7,0
45–49 let	1 096	7,7
50–54 let	950	6,7
55–59 let	914	6,5
60–64 let	1 083	7,6
65–69 let	1 090	7,7
70–74 let	998	7,0
75–79 let	705	5,0
80–84 let	358	2,5
85 let in več	465	3,3

▼ Odpri celotno tabelo: posamezna leta starosti 0–84 in 85+

STAROST (LETA)	ŠTEVILO PREBIVALCEV
0	117
1	113
2	114
3	124
4	149
5	135
6	135
7	140
8	138
9	156
10	128
11	141
12	155
13	151
14	156
15	153
16	161
17	145
18	158

STAROST (LETA)	ŠTEVILO PREBIVALCEV
19	96
20	119
21	88
22	92
23	98
24	142
25	106
26	117
27	113
28	131
29	134
30	147
31	143
32	146
33	130
34	146
35	159
36	165
37	192
38	183
39	208
40	173
41	201
42	199
43	214
44	200
45	224
46	208
47	244
48	196
49	224
50	217

STAROST (LETA)	ŠTEVILO PREBIVALCEV
51	189
52	188
53	184
54	172
55	162
56	180
57	186
58	209
59	177
60	206
61	205
62	228
63	219
64	225
65	225
66	208
67	208
68	227
69	222
70	231
71	198
72	212
73	168
74	189
75	176
76	157
77	132
78	129
79	111
80	72
81	70
82	68

STAROST (LETA)	ŠTEVILO PREBIVALCEV
83	82
84	66
85 let in več	465

Prenesi tabelo po posameznih letih starosti

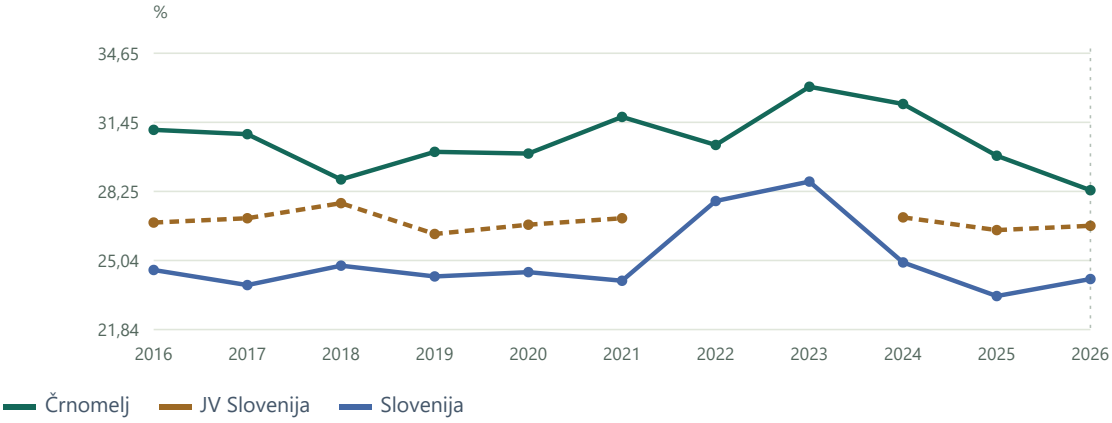
Kaj to pomeni za zdravstveno poročilo?

Več starejših pomeni večjo potrebo po dostopni obravnavi kroničnih bolezni, preprečevanju padcev, prevozih in pomoči na domu; to je načrtovalska interpretacija, ne izmerjena lokalna potreba po določenem številu mest. Delež 80+ je leta 2026 5,8 % v občini in 5,8 % v Sloveniji (pri objavi na eno decimalko). Podobnost pri najstarejših torej ne pomeni enake povprečne starosti ali deleža 65+. **[59]** Starostno standardiziranih zdravstvenih stopenj tudi po tej dopolnitvi ne pojasnjujemo zgolj s starejšim prebivalstvom. **[61]**

Otroci, prehrana in alkohol: kazalniki tveganja

Prekomerna prehranjenost otrok

K2.2 · leto objave podatkov



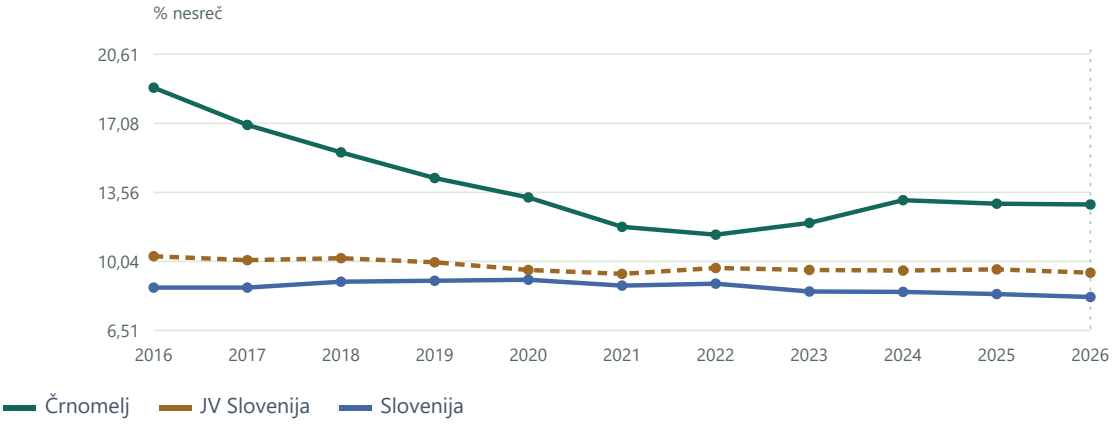
Izdaja 2026: meritve 2024. Preddebelost in debelost skupaj. [3]

▼ Odpri podatkovno tabelo

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	31,1	26,8	24,6
2017	30,9	27	23,9
2018	28,8	27,7	24,8
2019	30,08	26,27	24,3
2020	30	26,7	24,5
2021	31,7	27	24,1
2022	30,4	—	27,8
2023	33,1	—	28,7
2024	32,3	27,04	24,95
2025	29,9	26,45	23,39
2026	28,3	26,65	24,18

Nesreče z alkoholiziranimi povzročitelji

K2.6 · leto objave podatkov



Izdaja 2026: povprečje 2020–2024; ne število nesreč v 2026. [3]

▼ **Odpri podatkovno tabelo**

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	18,9	10,3	8,7
2017	17	10,1	8,7
2018	15,6	10,2	9
2019	14,29	9,99	9,05
2020	13,3	9,6	9,1
2021	11,8	9,4	8,8
2022	11,4	9,7	8,9
2023	12	9,6	8,5
2024	13,16	9,57	8,48
2025	12,98	9,63	8,37
2026	12,94	9,46	8,22

Prednostna naloga: okolje za zdravo odraščanje. Vrzel pri prekomerni prehranjenosti otrok je v zadnji izdaji 4,12 odstotne točke. V celotnem nizu se giblje med 2,6 in 7,6 točke. Otroci niso edini kazalnik z vztrajnim odstopanjem: nad povprečjem ostajajo tudi nesreče z alkoholom in prejemniki zdravil za tlak. [3]

DODATNI KAZALNIK	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	KAJ LAHKO SKLEPAMO
Kadilci, objava 2021	23,7 %	23,2 %	Starejši anketni kazalnik; ni neposredno primerljiv z dnevnim kajenjem v OECD.

DODATNI KAZALNIK	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	KAJ LAHKO SKLEPAMO
Visokotvegano opijanje, objava 2021	46,2 %	42,8 %	Opozorilni signal starejših anketnih podatkov, ne tekoča razširjenost v 2026.
Prekomerna prehranjenost odraslih, objava 2026	61,64 %	59,78 %	Vključuje preddebelost in debelost; meritev 2024. Razlika v profilu NIJZ ni označena kot statistično značilna.
Uporaba marihuane, objava 2026	14,04 %	21,96 %	Podatek 2023; definicija uporabe in anketna negotovost omejujeta interpretacijo.

Lokalni nizi in profil NIJZ. [3][2]

Delež nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji je med prvo in zadnjo izdajo nižji za približno 31,5 %, ne za polovico. Zadnja občinska vrednost je približno 57,4 % nad slovensko. Ta delež ne meri količine popitega alkohola in ne zajame vseh posledic pitja. [3][61]

Debelost in gibanje otrok

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Prekomerno prehranjenih je bilo po podatkih NIJZ (leto 2024) 28,3 % črnomaljskih otrok in mladostnikov, starih 6–14 let, (Slovenija 24,2 %, JV Slovenija 26,7 %). Razlika je **statistično značilna in za občino neugodna**. [2] Črnomelj je nad slovenskim povprečjem v vseh izdajah od 2016 do 2026, najvišjo vrednost (33,1 %) je dosegel v izdaji 2023. [3] Tudi telesni fitnes otrok je nižji od povprečja (45,1 proti 49,4 percentila), vendar ta razlika ni statistično značilna. [2]

Nacionalno spremljanje SLOfit opozarja, da indeks telesne mase podcenjuje težavo. V šolskem letu 2024/25 je debelina kožne gube narasla, čeprav je delež prekomerno prehranjenih po ITM nekoliko upadel; avtorji to imenujejo »presnovna debelost«. [62] Raziskave kažejo, da programi gibanja in prehrane pri otrocih, starih 0–12 let, pomagajo malo, a merljivo; pri mladostnikih učinka ni bilo. [63]

Trenutno stanje

Podatki izhajajo iz športnovzgojnega kartona SLOfit, ki meri okoli 96 % osnovnošolcev, zato sta kazalnika tudi za majhno občino razmeroma zanesljiva. [61] SLOfit ugotavlja, da sta 1. in 2. triletje osnovne šole kritični obdobji, v katerih gibalne sposobnosti upadajo. Ministrstvu priporoča več in kakovostnejše športne vzgoje ter dodatno športno ponudbo kot standard. [62]

Lokalno CKZ izvaja »Družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog«. V letu 2025 je pri 14 od 17 udeležencev narasla mišična masa, pri 13 od 17 se je zmanjšala maščobna masa. [5] Ker skupina nima primerjalne skupine in je majhna, to ne dokazuje učinka za vse otroke.

Ključna dejstva

Prekomerna prehranjenost osnovnošolcev, izdaje NIJZ

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	31,1 %	26,8 %	24,6 %
2019	30,1 %	26,3 %	24,3 %
2023	33,1 %	ni podatka	28,7 %
2024	32,3 %	27,0 %	25,0 %
2025	29,9 %	26,5 %	23,4 %
2026 (meritve 2024)	28,3 %	26,7 %	24,2 %

Vir: časovni nizi NIJZ. [3] Leto je leto izdaje; izdaja 2026 temelji na meritvah leta 2024 pri otrocih, starih 6–14 let (metodologija NIJZ navaja osnovnošolce, stare 6–15 let). [2] [61] Izboljšanje od izdaje 2023 je lahko tudi odziv na obdobje po epidemiji; SLOfit za vso Slovenijo poroča o upadu pod raven pred epidemijo, a hkrati o porastu kožne gube. [62]

Kaj kažejo raziskave o ukrepih

RAZISKAVA	UGOTOVITEV	OMEJITVE
Brown in sod., 2019 (Cochrane, 153 RCT) [63]	Programi prehrane in gibanja so zmanjšali zBMI pri otrocih 0–5 let za 0,07 in pri 6–12 let za 0,04 enote. Programi samo telesne dejavnosti so pri 6–12-letnikih zmanjšali tveganje debelosti. Pri 13–18-letnikih učinka ni bilo.	Majhen učinek na posameznika, pomemben na ravni populacije. Pravičnost učinkov med skupinami je slabo raziskana. Prebran povzetek.
SLOfit 2025 [62]	Upad gibalnih sposobnosti med 1. razredom in 3. triletjem; priporočilo več ur športne vzgoje in dodatne športne ponudbe.	Nacionalna ocena, ne lokalna meritev.

Viri

NIJZ in SLOfit sta uradna vira z visoko pokritostjo. Cochrane je prebran kot povzetek v preprostem jeziku. Podatkov po šolah v Črnomlju v tem pregledu nimamo; šole jih imajo v sistemu SLOfit.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Dolgotrajno višja prekomerna prehranjenost	V vseh izdajah 2016–2026 nad Slovenijo; 2026 značilno slabše. [3] [2]
Nižji telesni fitnes	45,1 proti 49,4; razlika ni značilna. [2]
ITM podcenjuje težavo	Kožna guba narašča ob padcu ITM. [62]
Lokalni programi niso ovrednoteni	Majhna skupina CKZ brez primerjave. [5]

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Osnovne šole	Kakšni so agregirani rezultati SLOfit po šolah in razredih v zadnjih petih letih? Anonimizirani povzetki šolskih poročil SLOfit.
Osnovne šole	Ali šole izvajajo dodatne ure športa ali gibalne odmore v 1. in 2. triletju? Urniki in obseg.
Osnovne šole	Kakšna je ponudba šolske prehrane (sladke pijače, sadje, voda)? Jedilniki in pravila.
Pediatri ZD	Koliko otrok s prekomerno prehranjenostjo je napotenih v obravnavo in kam? Agregirani podatki sistematskih pregledov.
CKZ	Koliko družin se letno vključi v družinsko obravnavo in kolikšen je osip? Letni podatki s spremljanjem po 6 in 12 mesecih.
Občina	Ali financira brezplačne ali cenejše športne programe za otroke iz družin z nižjimi dohodki? Seznam in obseg.
Občina	Ali so šolske poti varne za hojo in kolo? Popis nevarnih odsekov.
Športna društva	Koliko otrok je vključenih v redno vadbo in od kod prihajajo? Agregirani podatki.
Vrtci	Koliko gibanja na prostem imajo otroci dnevno? Program vrtca.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	Ali bo dodatna športna ponudba postala standard, kot priporoča SLOfit? Načrt.
NIJZ	Ali je mogoče objaviti podatke o debelosti (ne le prekomerni prehranjenosti) za občino? Podatki in intervali zaupanja.

Tveganja

Tehtanje in razvrščanje otrok lahko vodi v stigmo in motnje hranjenja. Ukrepi naj bodo usmerjeni v okolje (šola, prehrana, gibanje) in ne v posamezne otroke. Nižji dohodki družin lahko omejijo dostop do plačljivih športnih programov.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	Šole in CKZ uvedejo gibalne odmore in aktivne ure v 1. in 2. triletju.	Obstoječi kadri; usposabljanje učiteljev.	Več gibanja brez stroškov; tveganje izvedbe le na papirju. Delež razredov z dnevnim gibalnim odmorom.
0–12 mesecev	Šole preverijo prehransko okolje (voda namesto sladkih pijač, sadje).	Šolska prehrana.	Boljše prehranjevanje; tveganje odpora. Delež šol brez sladkih pijač.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
1–3 leta	Občina sofinancira brezplačne športne programe za otroke iz družin z nižjimi dohodki.	Načrtovalna ocena 10.000–30.000 EUR letno; občinski proračun.	Pravičnejši dostop; tveganje nizke udeležbe. Število vključenih otrok.
1–3 leta	Varne šolske poti za hojo in kolo.	Po projektu; občina.	Vsakodnevno gibanje; tveganje stroškov. Delež otrok, ki v šolo hodijo peš ali s kolesom.
3–10 let	Dodatna športna ponudba kot standard v vseh šolah (skupaj z MVI).	Državna sredstva.	Trajno več gibanja; tveganje kadrov. Kazalnika SLOfit in NIJZ po 5 letih.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	4: podatki SLOfit in NIJZ so javni in redni.
Dostop in razpoložljivost	3: šport in CKZ obstajata, stroški in prevoz niso pregledani.
Usklajenost s potrebami	2: kazalnik je dolgotrajno slabši, lokalni odziv je majhen.
Dokazna podlaga in spremljanje	4: dobro spremljanje populacije; programi niso ovrednoteni.
Pravičnost in doseg	2: dostop za otroke iz podeželja in družin z nižjimi dohodki ni znan.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	3: SLOfit je trajen, lokalni programi so majhni.
Izvedljivost	4: šole in CKZ lahko ukrepajo hitro.

Izračun: (4 + 3 + 2 + 4 + 2 + 3 + 4) / 7 = **3,14/5**; zaradi potrjeno in značilno slabšega kazalnika jo spustimo na ❌.

Primerjave

Črnomelj je nad JV Slovenijo in Slovenijo v vseh izdajah. [3] SLOfit ima podatke po regijah; najvišje deleže v šolskem letu 2024/25 navaja za pomursko, posavsko in zasavsko regijo. [62]

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Podatki po šolah	Agregirana poročila SLOfit šol v Črnomlju.

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Debelost ločeno od preddebelosti	Zahteva NIJZ ali SLOfit.

Prometna varnost in alkohol

Dopolnitev 25. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

V Občini Črnomelj so alkoholizirani udeleženci povzročili 12,9 % vseh prometnih nezgod (povprečje 2020–2024). V Sloveniji je ta delež 8,2 %, v JV Sloveniji pa 9,5 %. Razlika je statistično značilna in za občino neugodna. [2] Pri bolnišničnih obravnavah zaradi poškodb v transportnih nezgodah (1,2 proti 1,0 na 1.000 prebivalcev) razlika ni statistično značilna. [2]

Raziskave podpirajo dobro oglaševan in reden policijski nadzor alkoholiziranosti. V sistematičnem pregledu je bilo smrtnih nezgod z alkoholom po takih programih v mediani 8,9 % manj. [64] Podatkov o prometnih nezgodah po občinah policija javno ne objavlja, zato lokalnega vzroka razlike ne moremo določiti. [61]

Trenutno stanje

Kazalnik NIJZ se objavlja letno kot povprečje več zaporednih let, zato so vrednosti v sosednjih izdajah prekrivajoče. [61] V izdaji 2016 je bila vrednost za Črnomelj 18,9 %, v izdaji 2022 11,4 % in v izdaji 2026 12,9 %. [2] To ni letna vrsta, temveč zaporedje drsečih povprečij. Črnomelj je v vseh izdajah nad slovenskim povprečjem.

Na nacionalni ravni je policija do konca novembra 2024 zabeležila 1.365 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci. V njih je umrlo 17 ljudi. [65] Agencija za varnost prometa navaja, da se pri 0,5 promila tveganje za povzročitev nesreče podvoji, pri 1,1 promila pa poveča za osemkrat. [65]

Ključna dejstva

KAZALNIK NIJZ	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA	OBDOBJE IN ZNAČILNOST
Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji	12,9 %	9,5 %	8,2 %	Povprečje 2020–2024; značilno slabše. [2]
Poškodovani v transportnih nezgodah (bolnišnične obravnave)	1,2 na 1.000	0,9	1,0	Povprečje 2020–2024, standardizirano; ni značilne razlike. [2]
Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15+, bolnišnične obravnave)	1,2 na 1.000	1,4	1,6	Povprečje 2020–2024, standardizirano; značilno boljše. [2]

Delež nezgod z alkoholom je razmerje: nanj vpliva tudi število vseh nezgod. Kazalnik ne pove, ali so povzročitelji prebivalci občine ali prehodni vozniki. Nižja stopnja bolnišničnih obravnav zaradi bolezni,

pripisljivih alkoholu, ne izključuje tveganega pitja pred vožnjo.

Kaj kažejo dokazi o ukrepih

UKREP	DOKAZ	OMEJITVE
Oglaševane točke nadzora alkoholiziranosti	Sistematični pregled: mediana −8,9 % smrtnih nezgod z alkoholom (10 vrednotenj, interkvartilni razpon −16,5 % do −3,5 %); razmerje koristi in stroškov od 2 : 1 do 57 : 1. [64] Pri naključnem preverjanju vseh voznikov (kot v Sloveniji) je ena raziskava pokazala 22,1 % manj hudih in smrtnih nočnih nesreč. [66]	Večinoma raziskave iz ZDA. Community Guide opozarja, da rezultati morda ne veljajo za majhno število kratkotrajnih nadzorov; oglaševanje je bistveni del ukrepa. [66]
Nacionalne preventivne akcije	Policija in AVP izvajata akcije ob praznikih. [65]	Število zaznanih voznikov ne meri učinka akcije.

Viri

Kazalniki NIJZ imajo uradno metodologijo in oznake statistične značilnosti. Nacionalni podatki policije so iz sporočila za javnost. Sistematični pregled je prebran kot povzetek (celotni članek ni prosto dostopen), podrobnosti dokazov pa iz uradnega povzetka Community Guide. Lokalnih podatkov policije po občini v pregledanih virih ni.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Višji delež nezgod z alkoholom	12,9 % proti 8,2 %, značilno. [2]
Dolgotrajno nad povprečjem	V vseh izdajah 2016–2026. [2]
Ni lokalnih javnih podatkov	Po metodologiji NIJZ podatki na ravni občin niso javno objavljeni. [61]
Slab javni prevoz ponoči	Na podeželju ni alternative za pot domov (za Črnomelj ni preverjeno).

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Policijska postaja Črnomelj	Koliko prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji je bilo v občini v letih 2022–2025 in kje? Agregirani podatki po letih in cestnih odsekih.
Policijska postaja Črnomelj	Koliko preizkusov alkoholiziranosti je bilo opravljenih in ob katerih urah? Letni podatki.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)	Kateri programi proti vožnji pod vplivom alkohola se izvajajo v občini? Program dela in poročilo.
Občinska uprava	Ali občina podpira nočni prevoz ali taksi ob prireditvah? Pogodbe in stroški.
Organizatorji prireditev	Kako preprečujejo vožnjo pod vplivom po prireditvah? Načrt varnosti prireditve.

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Gostinci	Ali sodelujejo v programih odgovorne strežbe alkohola? Seznam in usposabljanja.
Šole	Ali dijaki pred izpitom za voznika dobijo vsebine o alkoholu in drogah? Program.
CKZ	Ali izvaja programe za opuščanje tveganega pitja? Program in udeležba.
Agencija za varnost prometa	Ali lahko objavi podatke po občinah v agregirani obliki? Časovnica.
NIJZ	Ali je mogoče ločiti povzročitelje s stalnim prebivališčem v občini? Metodološko pojasnilo.

Tveganja

Kampanje, ki ljudi samo sramotijo, redko spremenijo vedenje. Pogostejši nadzor brez obveščanja ljudi manj odvrača. Objava podatkov po odsekih ne sme razkriti posameznih nesreč in udeležencev.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	Policija in SPV dogovorita redne, vnaprej javno napovedane nadzore ob vikendih in prireditvah, skozi vse leto in ne le v posamezni akciji. [66]	Obstoječi viri policije; 3.000–5.000 EUR za obveščanje (občina, SPV).	Manj vožnje pod vplivom; tveganje, da se nadzor izogiba. Število nadzorov in delež pozitivnih preizkusov.
0–12 mesecev	Občina objavi letni pregled prometne varnosti s podatki policije.	10–20 ur letno.	Preglednost; tveganje napačne razlage majhnih števil. Objavljeno letno poročilo.
1–3 leta	Nočni prevoz ali subvencioniran taksi ob večjih prireditvah.	Načrtovalna ocena 5.000–15.000 EUR letno; občina, organizatorji.	Alternativa vožnji; tveganje nizke uporabe. Število prepeljanih.
1–3 leta	CKZ in ZD razširita kratke intervencije pri tveganem pitju v ambulantah.	Obstoječi programi.	Manj tveganega pitja; tveganje nizke udeležbe. Število intervencij.
3–10 let	Ureditev nevarnih odsekov po analizi nesreč.	Investicije po projektu.	Manj hudih poškodb; tveganje visokih stroškov. Število hudih nesreč na odsekih.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	2: lokalni podatki policije niso javni.
Dostop in razpoložljivost	3: nacionalne akcije se izvajajo; lokalni programi niso dokumentirani.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Usklajenost s potrebami	2: visok delež brez vidnega lokalnega odziva.
Dokazna podlaga in spremljanje	3: kazalnik NIJZ je dober, a je drseče povprečje.
Pravičnost in doseg	3: posledice nosijo tudi nedolžni udeleženci.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	2: brez lokalnega programa ni trajnosti.
Izvedljivost	4: učinkoviti ukrepi so znani in poceni.

Izračun: (2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 4) / 7 = **2,71/5**; zaradi potrjeno in značilno slabšega kazalnika brez dokumentiranega lokalnega odziva ga spustimo na ❌.

Primerjave

Črnomelj (12,9 %) je nad JV Slovenijo (9,5 %) in Slovenijo (8,2 %). **[2]** Upravna enota Črnomelj ima enako vrednost kot občina.

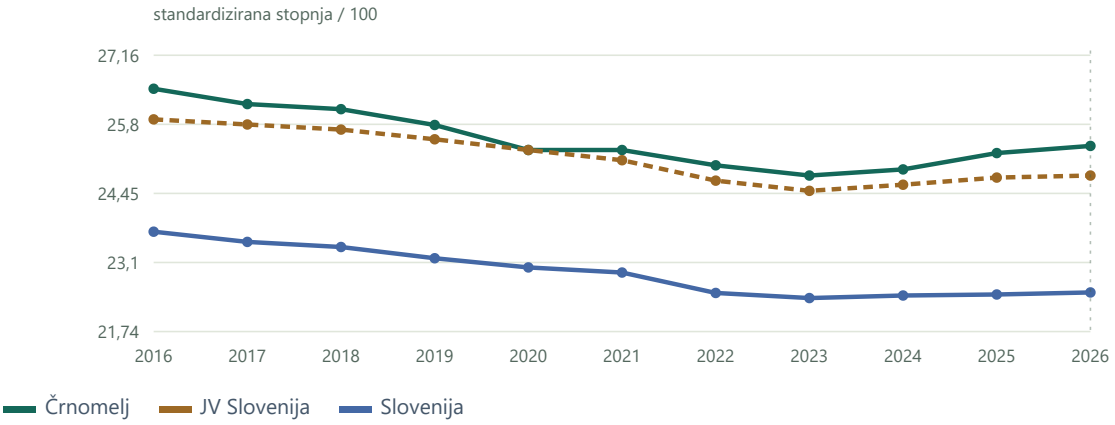
▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Lokalni podatki nesreč	Zahteva PP Črnomelj za agregirane podatke.
Vzroki razlike	Analiza po času, kraju in starosti povzročiteljev.

Kronične bolezni in umrljivost: trendi kazalnikov

Prejemniki zdravil za povišan tlak

K4.6 · leto objave podatkov



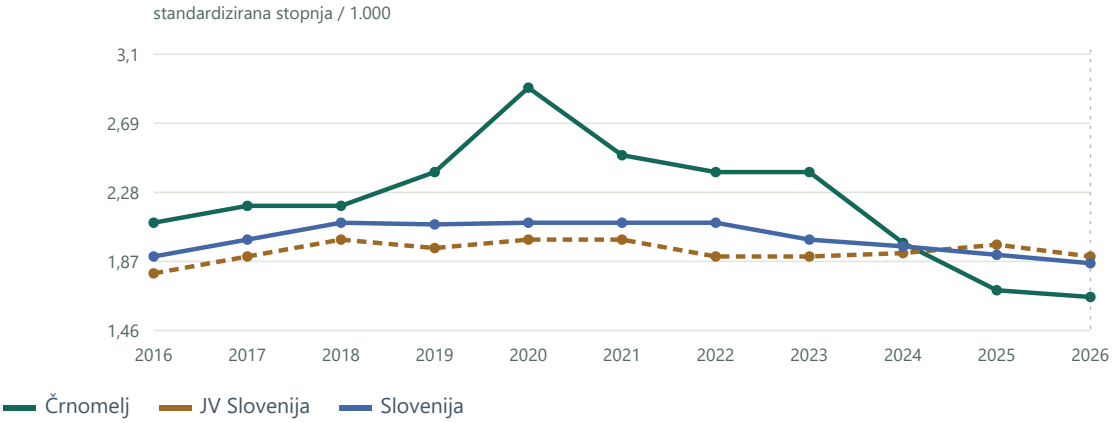
Izdaja 2026: leto 2024. Uporaba zdravil ni enaka razširjenosti bolezni. [3]

▼ Odpri podatkovno tabelo

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	26,5	25,9	23,7
2017	26,2	25,8	23,5
2018	26,1	25,7	23,4
2019	25,79	25,51	23,18
2020	25,3	25,3	23
2021	25,3	25,1	22,9
2022	25	24,7	22,5
2023	24,8	24,5	22,4
2024	24,92	24,62	22,45
2025	25,24	24,76	22,47
2026	25,38	24,8	22,51

Bolnišnične obravnave zaradi srčne kapi

K4.8 · leto objave podatkov



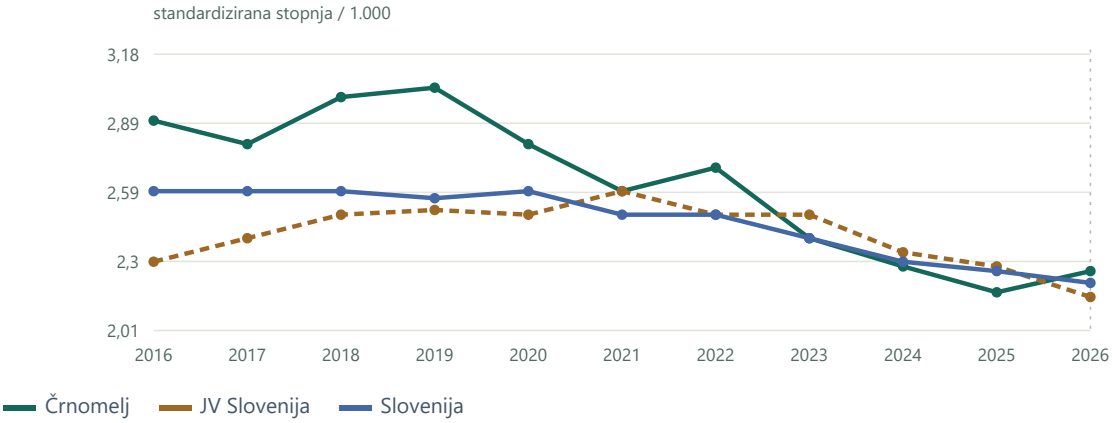
Starost 35–74 let; zadnja izdaja je povprečje 2020–2024. [3]

▼ Odpri podatkovno tabelo

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	2,1	1,8	1,9
2017	2,2	1,9	2
2018	2,2	2	2,1
2019	2,4	1,95	2,09
2020	2,9	2	2,1
2021	2,5	2	2,1
2022	2,4	1,9	2,1
2023	2,4	1,9	2
2024	1,98	1,92	1,96
2025	1,7	1,97	1,91
2026	1,66	1,9	1,86

Bolnišnične obravnave zaradi možganske kapi

K4.9 · leto objave podatkov



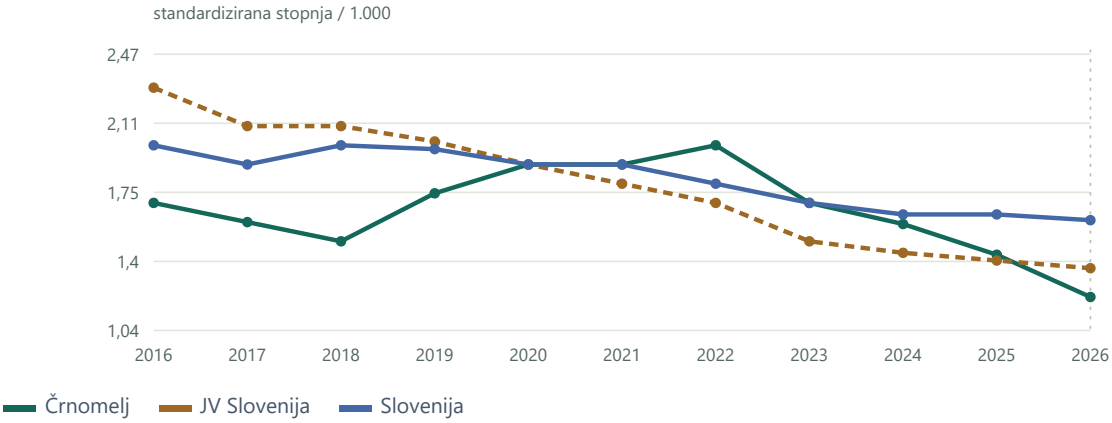
Starost 35–84 let; 2026: 2,26 proti 2,21. Razlika ni statistično značilna. **[3]**

▼ Odpri podatkovno tabelo

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	2,9	2,3	2,6
2017	2,8	2,4	2,6
2018	3	2,5	2,6
2019	3,04	2,52	2,57
2020	2,8	2,5	2,6
2021	2,6	2,6	2,5
2022	2,7	2,5	2,5
2023	2,4	2,5	2,4
2024	2,28	2,34	2,3
2025	2,17	2,28	2,26
2026	2,26	2,15	2,21

Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu

K4.4 · leto objave podatkov



Bolnišnične obravnave, starost 15+; zadnja izdaja je povprečje 2020–2024. [3]

▼ **Odpri podatkovno tabelo**

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	1,7	2,3	2
2017	1,6	2,1	1,9
2018	1,5	2,1	2
2019	1,75	2,02	1,98
2020	1,9	1,9	1,9
2021	1,9	1,8	1,9
2022	2	1,7	1,8
2023	1,7	1,5	1,7
2024	1,59	1,44	1,64
2025	1,43	1,4	1,64
2026	1,21	1,36	1,61

Stopnja prejemnikov zdravil za tlak ne meri vseh oseb s hipertenzijo in ne meri urejenosti njihovega tlaka. Del zdravil ima tudi druge indikacije. Znižanje uporabe zdravil zato ne sme postati samostojen cilj CKZ. [61] Pri bolnišničnih obravnavah zaradi alkoholu neposredno pripisljivih bolezni je zadnja vrednost ugodnejša od slovenske, vendar občina tudi na začetku niza ni bila nad povprečjem. [3]

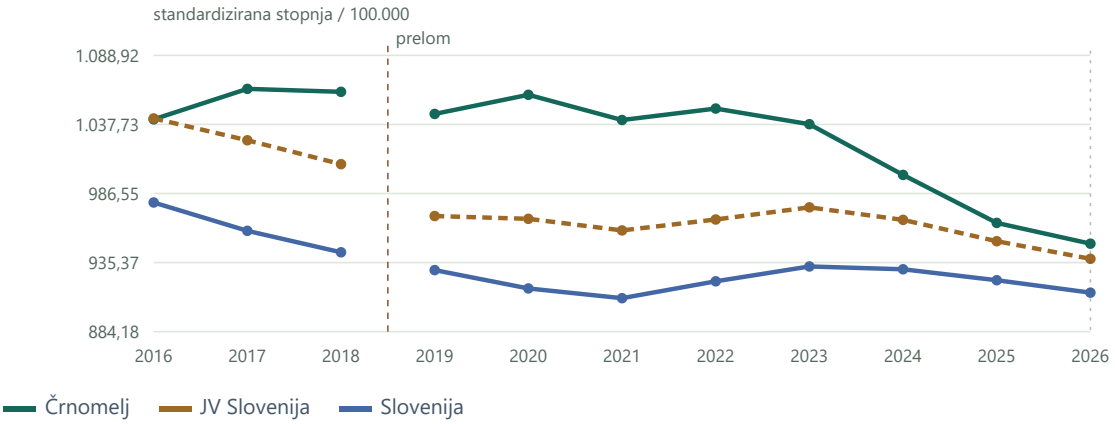
DRUGI PODATKI, IZDAJA 2026	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	POMEN
Zdravila za sladkorno bolezen	5,72	5,47	Standardizirana stopnja na 100; ne celotna razširjenost bolezni.

DRUGI PODATKI, IZDAJA 2026	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	POMEN
Zdravila zaradi duševnih motenj	15,64	14,47	Standardizirana stopnja na 100; ne pomeni enakega deleža oseb z depresijo.
Bolniška odsotnost	19,17 dneva	20,53 dneva	Občina je pod povprečjem, a višje kot v izdaji 2016 (11,6 dneva).

Vir: [3][61]

Splošna umrljivost

K5.1 · leto objave podatkov



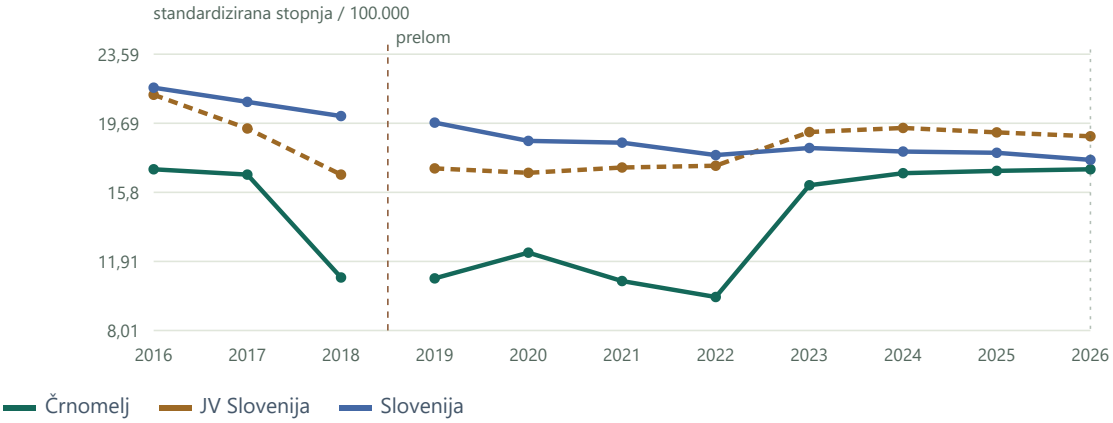
Prelom 2018/2019: običajno → stalno bivališče. Zadnja izdaja: povprečje 2020–2024. [3]

▼ Odpri podatkovno tabelo

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	1.041,5	1.042,2	979,9
2017	1.064,1	1.026	958,9
2018	1.061,9	1.008,3	943
2019	1.045,51	969,87	929,8
2020	1.059,7	967,8	916,2
2021	1.041	959,2	909
2022	1.049,5	967,3	921,5
2023	1.037,9	976,3	932,5
2024	1.000,33	967,02	930,41
2025	964,77	951,2	922,3
2026	949,38	938,17	913,09

Umrljivost zaradi samomora

K5.7 · leto objave podatkov



Večletna povprečja; prelom bivališča 2018/2019. Zadnje obdobje 2020–2024. [3]

▼ **Odpri podatkovno tabelo**

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	17,1	21,3	21,7
2017	16,8	19,4	20,9
2018	11	16,8	20,1
2019	10,95	17,15	19,73
2020	12,4	16,9	18,7
2021	10,8	17,2	18,6
2022	9,9	17,3	17,9
2023	16,2	19,2	18,3
2024	16,88	19,43	18,1
2025	17,01	19,18	18,03
2026	17,1	18,96	17,63

Splošna umrljivost je v izdaji 2026 številčno približno 4,0 % nad slovensko; NIJZ te razlike ne označuje kot statistično značilne. Primerjava od izdaje 2019 do 2026 kaže znižanje z 1.045,51 na 949,38 na 100.000. Pri samomoru zadnja stopnja znaša 17,1 proti 17,63; majhne razlike in nihanja večletnih povprečij niso podlaga za ocenjevanje posamezne ustanove. [3][2]

PREZGODNJA UMRLJIVOST, 0–74 LET	ČRNOMELJ / SLOVENIJA	OBDOBJE
Bolezni srca in ožilja	70,0 / 62,8 na 100.000	Povprečje 2020–2024; standardizirano.
Vse vrste raka	141,9 / 140,9 na 100.000	Povprečje 2020–2024; standardizirano.

Točkovne ocene iz nizov; obe razliki sta v zadnjem profilu statistično neznačilni. [3][2]

28 Slovenija in EU: primerjava zdravstvenih kazalnikov

Profil OECD/European Observatory 2025 zagotavlja primerjavo Slovenije in EU. Občinskih kazalnikov ne postavljamo v isto lestvico, kadar se razlikujejo definicija, starost, leto ali standardizacija. [67]

KAZALNIK	SLOVENIJA	EU	OPOMBA
Dnevno kajenje, odrasli	17 %	19 %	2019; to ni isti kazalnik kot lokalni delež vseh kadilcev.
Debelost odraslih	18 %	15 %	2022; ITM ≥ 30. Ne primerjati z lokalno prekomerno prehranjenostjo, ki vključuje preddebelost.
Zdravniki na 1.000 prebivalcev	3,5	4,3	2023; država kot celota, ne kadrovska zasedba ZD Črnomelj.
Pričakovana življenjska doba	82,3 leta	Slovenija je nad povprečjem EU.	2024; občinskega rezultata iz tega ni mogoče izpeljati.
Neizpolnjene zdravstvene potrebe	4,6 %	3,6 %	2024; med ljudmi, ki so imeli potrebo po oskrbi; pomemben razlog je čakanje.

Vir: profil 2025, poglavja Health in Slovenia, Risk factors, The health system in Accessibility. [67] Podatki niso dokaz velikosti lokalne vrzeli. Prejšnja trditev o »najvišji stopnji samomorov v EU« je umaknjena; neusklajene stopnje iz različnih virov niso uporabljene za lokalno evropsko razvrstitev.

PODROČJE 04 / ČRNOMELJ

Delovanje CKZ

Programi, dokumentirane dejavnosti in predlogi spremljanja. Objave, udeležba in zdravstveni izidi so različne enote; trend občine ni dokaz učinka CKZ.

21 CKZ: vidno delo, še ne celovito izmerjen učinek

Dopolnjeno 20. septembra 2026 · Kako izboljšati učinek: ukrepi in prvih 90 dni ↓ · Anketni list in predloge za spremljanje ↓

Center za krepitev zdravja je enota ZD Črnomelj. Uradna stran navaja vodjo **Tatjano Gregorič** in več strokovnih profilov: zdravstveno nego, fizioterapijo, prehrano, kineziologijo in psihologijo. Objavljena je telefonska številka 07 62 05 755 in naslov ckz@zd-crnomelj.si. Seznam oseb ne pove njihove zaposlitvene obremenitve. **[68][4]**

3,4 / 5
Javno dokumentirano delo
Ocena: dobro

Dejavnosti in strokovna sestava CKZ

Ocena priznava redno preventivno delo, terensko sodelovanje in javno dostopne kontakte. Znižujeta jo nepopoln pregled dosega in odsotnost celovite javne evalvacije rezultatov.

To je uredniška analitična ocena javnih dokazov, ne uradna akreditacija, klinična revizija ali lestvica slovenskih CKZ.

MERILO · ENAKA UTEŽ 20 %	OCENA	UTEMELJITEV
Kontinuiteta in raznolikost dejavnosti	4 / 5	Uradno poročilo navaja 100 % načrtovanih ur v osmih sklopih; dogodki in urniki potrjujejo raznovrstnost. Brez preglednice realizacije po delavnicah ni najvišje ocene. **[5][69][70]**
Ujemanje programa z zdravstvenimi potrebami	4 / 5	Prehrana, gibanje, duševno zdravje, kajenje in presnovna tveganja so vključeni. Ni dokazano, da intenzivnost in doseg zadoščata lokalnemu bremenu. **[71]**
Terensko delo in vključevanje	3 / 5	Dokumentirano delo v šolah, VDC ter zunaj mesta. Ni javnega imenovalca za delež doseženih ranljivih skupin, naselij ali novih uporabnikov. **[72][73][74]**
Javna komunikacija in kontakti	4 / 5	Vodja in strokovne osebe so navedene; objave segajo v 2026. Nekatera vabila so slikovna, zapisi razpršeni; potrebna sta enoten dostopen koledar in arhiv. **[4][69][70]**
Transparentnost dosega in izidov	2 / 5	Objavljena sta realizacija ur in rezultat manjše skupine. V pregledanih dokumentih ni celovitega prikaza različnih udeležencev, osipa, spremljanja po 6–12 mesecih in stroškov CKZ. **[5]**

Izračun: (4 + 4 + 3 + 4 + 2) / 5 = 3,4. Lestvica: 1 = v pregledanih virih ni uporabnih dokazov; 2 = posamični dokazi in velike vrzeli; 3 = dokumentirana izvedba z večjimi vrzelmi; 4 = več virov in dobro razvita izvedba, a nepopolno merjenje; 5 = celovita, sledljiva izvedba in spremljanje. Ocena ni primerjalna: za druge centre nismo zbrali primerljivih podatkov.

> **Česa pošteno še ne ocenimo:** klinične učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti in prispevka k spremembam občinske umrljivosti. Manjkajoči podatki niso dokaz slabega zdravljenja. Število člankov ali fotografij ni merilo zdravstvenega učinka.

Objavljeni rezultati skupine 17 udeležencev

KAZALNIK DRUŽINSKE OBRAVNAVE	OBJAVLJENI ŠTEVEC	PRERAČUN
Pridobljena mišična masa	14 / 17	82,4 %
Zmanjšana maščobna masa	13 / 17	**76,5 %**; v izvirniku je napačno zapisano 79 %.
Znižan ITM	11 / 17	64,7 %
Razmerje obseg pasu / višina	8 izboljšanj + 3 ohranitve / 17	47,1 % izboljšanj; 64,7 % izboljšanj ali ohranitev.

Gre za samoporočane rezultate izvajalca, brez primerjalne skupine, velikosti sprememb, podatkov o vseh začetno vključenih in dolgoročnega spremljanja. Rezultat je spodbuden signal, ne dokaz 79-odstotne uspešnosti CKZ. Povečanje mišične mase samo zase, posebej pri rastočih otrocih, ne dokazuje učinka programa. [5]

Popravek kadrovskega podatka: tabela na str. 6 letnega poročila prikazuje **time** po dejavnostih. Postavke 1,00 za integrirani CKZ in 1,00 za družinsko obravnavo niso avtomatično en ali dva zaposlena za polni delovni čas. Prejšnji seštevek »2–3 FTE« je zato umaknjen. [5]

Kako bi CKZ lahko izboljšal svoj učinek?

Več ljudi pripeljati od prvega priporočila do trajne spremembe navad. Smiselna nadgradnja poveže dostop do programa s podporo pri vztrajanju in nadaljevanju po zaključku. Spodaj je izvedbeni predlog; najprej je treba preveriti, katere postopke CKZ že izvaja in kakšne zmogljivosti ima.

Predlagane izboljšave: izvedba, odgovornost in merilo uspeha

IZBOLJŠAVA	KONKRETNA IZVEDBA IN NOSILEC	KAKO PREVERITI USPEH
Od napotitve do prvega obiska	CKZ in ambulanta ob primerni napotitvi ponudita konkreten termin; ob neudeležbi po dogovoru preverita razlog.	Delež napotenih, ki začnejo program, in čas do prvega obiska.
Odpraviti ovire za sodelovanje	CKZ preveri težave s prevozom, termini in skrbstvenimi obveznostmi. Z občino in KS glede na potrebe prilagodi urnik ali redno terensko izvedbo.	Doseg različnih oseb iz slabše doseženih skupin ter manj opuščanja zaradi ugotovljenih ovir.
Pomagati ljudem vztrajati	Strokovna ekipa z udeležencem določi izvedljiv osebni cilj, preverja napredek in ob težavah prilagodi podporo.	Dokončanje programa, razlogi osipa in napredek pri dogovorjenem cilju.

IZBOLJŠAVA	KONKRETNA IZVEDBA IN NOSILEC	KAKO PREVERITI USPEH
Podpora tudi po zaključku	CKZ dogovori nadaljnji stik ter po želji pomaga pri prvem obisku ustreznega društva ali redne vadbe. S partnerjem preveri sprejem, termin in stroške.	Dejanske vključitve in nadaljevanje dejavnosti po treh oziroma šestih mesecih.
Meriti trajnost izboljšanja	Ekipa za posamezni program izbere nekaj strokovno primernih kazalnikov ob začetku, zaključku ter po 6 in 12 mesecih.	Velikost spremembe in delež spremljanih; prikazati tudi neznane izide.
Prilagajati program rezultatom	Vodstvo in ekipa četrtletno pregledata ovire, rezultate in porabljene ure ter prilagodita izvedbo.	Boljši dostop, dokončanje in trajnost rezultatov pri primerljivih skupinah.

Boljše merjenje mora voditi v boljšo podporo. Če se izkaže, da ljudje odnehajo zaradi dopoldanskih terminov, je ukrep sprememba urnika. Če po zaključku opustijo vadbo, je ukrep lažji prehod v redno skupino. To sta primera možnega odziva, ne ugotovljena vzroka osipa v Črnomlju.

NIJZ že opisuje zbiranje podatkov o obravnavah CKZ in poročanje prek eSZBO. Najprej je zato treba preveriti uporabnost obstoječih evidenc. Polletni rok oddaje podatkov ni dokaz šestmesečnega spremljanja zdravja posameznika. **[75]** Za povezovanje s partnerji že obstaja imenik CKZ *Povezani za zdravje*; pregled podpore je tudi v poglavju o društvih. **[76]**

Začetek: 90-dnevni preizkus v dveh obstoječih programih

OBDOBJE	NALOGA	REZULTAT ZA ODLOČANJE
Prvi mesec	Pregled evidenc in poti od napotitve do zaključka; preverba ovir pri udeležencih in osebju.	Izhodišče dosega, čakanja in osipa; seznam podatkov, ki že obstajajo.
Drugi mesec	V dveh programih preizkus dogovorjenega prvega termina in nadaljnjega stika; prilagoditev ugotovljenim oviram.	Dokumentirana izvedba, odziv udeležencev in porabljene ure.
Tretji mesec	Pregled začetkov in osipa ter popravek izvedbe; dogovor nadaljnjega spremljanja.	Odločitev o nadaljevanju preizkusa. Izidi po 6/12 mesecih še niso na voljo.

Številčne cilje izboljšanja je treba določiti po izhodiščnem popisu. Klinične cilje in ustreznost meritev določi zdravstvena ekipa. Pri otrocih se uporabijo starosti primerni kazalniki; uspeha ni smiselno presojati samo po padcu telesne mase.

Kaj potrebuje izvedba?

NALOGA	OKVIRNA POTREBA	MOŽEN VIR IN OMEJITEV
Koordinacija napotitev	Pilotno 2–4 ure tedensko.	Obstoječi program ZD, če kadri in pogodbeni obseg dopuščajo.
Prehod v podporno skupino	Pilotno 1–2 uri koordinacije tedensko; izvedba partnerja posebej.	Redni programi izvajalcev in morebitna občinska podpora društvom.
Vzpostavitev spremljanja	Okvirno 10–20 delovnih dni vzpostavitve in 1–2 dneva mesečno; kontrolni stiki posebej.	Organizacijska sredstva ZD; obseg zmanjšati, če obstoječe evidence že zadoščajo.

NALOGA	OKVIRNA POTREBA	MOŽEN VIR IN OMEJITEV
Dostopnost na terenu	Prostor, prevoz in ure izvedbe po izbranih lokacijah.	Občina in KS za dopolnila dostopnosti; zdravstveni del v programu ZD.

To so avtorske planske predpostavke, ne izmerjene potrebe, potrjen proračun ali zagotovljeno financiranje. Naloge se lahko prekrivajo. Pred odločitvijo je treba preveriti kadre in stroške.

Rezultate prikazati za vse vključene

V javnem pregledu je treba različne osebe ločiti od obiskov in navesti, koliko udeležencev je iz Občine Črnomelj. Objavijo se agregati; majhne skupine se združijo, da posameznikov ni mogoče prepoznati.

Izmišljeni primer prikaza; to niso podatki CKZ Črnomelj

KORAK	ŠTEVILO LJUDI	RAZLAGA
Vključeni	100	Izhodiščna skupina.
Zaključili program	70	70 % vseh vključenih.
Spremljani po šestih mesecih	50	Pri polovici vključenih dolgoročni izid ostaja neznan.
Dokumentirano izboljšanje	35	70 % spremljanih oziroma 35 % vseh vključenih.

> **Ocena dokumentiranega dela ostaja 3,4/5.** Predlog še ni izveden ukrep. Manjkajoče meritve niso avtomatično neuspeh, izboljšanje pri udeležencih pa brez primerjave še ne dokazuje vzročnega učinka CKZ. Nadaljnja širitev naj temelji na preverjenem dostopu in trajnosti rezultatov.

---

22 Anketni list in spremljanje napredka CKZ

Pripravljeni sta dve prazni predlogi: mesečni list za ekipo CKZ in kratek vprašalnik za odrasle udeležence. Skupaj povežeta dostop do programa, izkušnjo udeleženca, spremembo dogovorjene navade in konkretne izboljšave dela.

Dodano 22. septembra 2026 · različica 1.0 · neodvisni predlog za preizkus v dveh programih; uvedba v CKZ ni potrjena.

> **Najprej pregled obstoječih evidenc.** NIJZ opisuje zbiranje podatkov med obravnavami in poročanje prek eSZBO. Polletna oddaja ni dokaz spremljanja posameznika po šestih mesecih. [75] Predloga dopolnjuje lokalni pregled; ni uradni obrazec NIJZ ali validirana zdravstvena lestvica. Spletna stran ne zbira odgovorov.

Kateri list uporabiti in kdaj

GRADIVO	VSEBINA	RITEM IN ODGOVORNOST

GRADIVO	VSEBINA	RITEM IN ODGOVORNOST
List za ekipo	Osem meril: preglednost, dostop, ujemanje s potrebami, dokazi in izidi, pravičnost, stroški, trajnost ter izvedljivost. Za vsako ocena 1–5 ali »ni podatka / ni uporabno«, dokazilo in vrzel; ob koncu ukrep, odgovorna vloga, rok in cilj.	Ekipa mesečno; vodja CKZ četrtletno preveri izvedbo ukrepov. Enake uteži 12,5 % pri vseh osmih ocenjenih merilih; pri delnem povprečju navesti n/8 in primerjati le ista merila.
Vprašalnik za udeleženca	Deset vprašanj o dogovorjeni navadi (dni v zadnjem tednu), zaupanju, ovirah, naslednjem koraku in podpori; razumljivost, zadovoljstvo in predlog izboljšave le ob zaključku. Možnost preskoka odgovora.	Pred začetkom, ob zaključku ter po 6 in 12 mesecih od referenčnega zaključka; predlagano okno ±30 dni. Tudi za udeležence, ki programa ne dokončajo, uporabiti predvideni zaključek njihove skupine.
Excelova predloga	Navodila, kazalniki s števci in imenovalci, obseg in parni izidi, samoocena ekipe ter dnevnik ukrepov. Prazna polja niso ničle. Odstotki se preračunajo ob odprtju v preglednici.	Pooblaščena vloga CKZ vnaša samo agregate; brez individualnih odgovorov. Pred objavo preveriti majhne skupine in možnost prepoznave iz kombinacij podatkov.

Kaj naj pokaže četrtletni pregled?

KAZALNIK	PRAVILO ZA POŠTEN PRIKAZ
Začetki, zaključki in različne osebe	Ločiti osebe, obiske in programe. Za začetek spremljati isto kohorto napotenih z vsaj 30 dnevi opazovanja; za zaključek samo kohorte z zapadlim predvidenim zaključkom. Letnih različnih oseb ne seštevati po mesecih.
Odziv po 6/12 mesecih	Odgovorili / vsi začetno vključeni, katerih kontrolno okno je že poteklo; prikazati tudi nezapadle, neodzivne in manjkajoče odgovore na posamezna vprašanja.
Sprememba navade in zadovoljstvo	Za isto osebo in isto navado parna razlika v dnevih na teden; število parov, mediana razlik in število brez para. Zadovoljstvo prikazati ločeno z odzivnostjo. Ni skupne »ocene zdravja« ali dokaza vzročnega učinka CKZ.
Dostop in stroški	Čakanje, ovire pri prevozu ali terminih in razlogi opustitve; porabljene ure ter pripisani stroški na začetnika oziroma zaključeni program iste kohorte. Navesti obračunsko metodo; to ni ocena stroškovne učinkovitosti.

Kaj še urediti

ROK IN UKREP	NOSILEC IN PLANSKI VIRI	PREVERJANJE KORISTI IN TVEGANJ
0–12 mesecev: slovar podatkov, koledar kontrol, preizkus razumljivosti ankete, papirna možnost in dnevnik ukrepov.	CKZ in skrbnik podatkov ZD; v okviru že predlaganih 10–20 dni vzpostavitve ter 1–2 dni mesečno, kontrolni stiki dodatno. Možna organizacijska sredstva ZD.	Po 3 mesecih čas izpolnjevanja in manjkajoči podatki; po 6/12 mesecih odziv in parne spremembe. Omejiti dvojni vnos in izključevanje oseb brez digitalnega dostopa.
1–3 leta: enoten koledar programov, zbirni prikaz rezultatov, preverjeni prehodi v podporne dejavnosti.	CKZ, ZD, občini in partnerji; plansko 60-minutni četrtletni pregled ekipe, ure izvoza in partnerjev posebej. Možni redni programi oziroma dogovorjena dopolnila.	Letno preveriti dostopnost, dejanske vključitve in izide po 12 mesecih. Javnost vidi agregate; majhne skupine združiti ali prikriti tudi tam, kjer bi jih razkrili seštevki.

ROK IN UKREP	NOSILEC IN PLANSKI VIRI	PREVERJANJE KORISTI IN TVEGANJ
3–10 let: trajno spremljanje, nadomeščanje skrbnika podatkov in zunanja metodološka presoja.	Vodstvo ZD, strokovna podpora po dogovoru; letni načrt ur, cena zunanje presoje po opredelitvi obsega. Možna sredstva ZD ali upravičeni razvojni viri; razpis ni predpostavljen.	Letni pregled kakovosti; po 4 letih presoja trajnosti, dostopa in stroškov. Primerjava z drugimi centri šele ob enakih definicijah, programih in obdobjih.

Priprava na uporabo: CKZ določi odgovorno vlogo, obvestilo udeležencem, način povezovanja odgovorov in varovano hrambo. Šifrirani list za spremljanje iste osebe ni anonimna anketa; ključ in kontakti ostanejo ločeno pri CKZ. Javna stran ponuja prazne predloge. Zdravstvene meritve izbere strokovna ekipa po obstoječih protokolih.

Ocena javno dokumentiranega dela ostaja 3,4/5. Nova samoocena je ločeno orodje z osmimi merili in še nima rezultatov. Priprava obrazcev ni dokaz izboljšanja storitev. Lokalnih primerjalnih podatkov za to anketo še ni; cilje naj ekipa določi po začetnem trimesečnem pregledu.

---

23 Dejavnosti CKZ v objavah Radia Odeon

Pregled vključuje lokalni arhiv ter notranje iskanje Radia Odeon z izrazi CKZ, krepitev, ZVC, zdravstvenovzgojni in imenom vodje. Uporabljena je domena **radio-odeon.com**. Članki so sekundarni dokazi o dejavnostih; vsebina organizatorjev, objavljena v mediju, ni neodvisna klinična evalvacija.

OBSEG PREGLEDA	REZULTAT
Pregledane lokalne Markdown datoteke	4945
Pregledane spletne objave	1068
Objave z izrecno povezavo s CKZ Črnomelj	396
Od tega: vabila	246
Od tega: poročila / novice	128
Od tega: obvestila in preklici	22
Neuspešni zajemi ob zaključku	0

Enota popisa je **objava z enoličnim URL-jem**, ne posamezna izvedena delavnica. Ponavljajoča se vabila lahko napovedujejo isti program; en festivalski članek lahko opisuje več dejavnosti. Zajem in začetna razvrstitev celotnega registra sta avtomatizirana po izrecnih besedilnih pravilih; spodnji izbrani primeri so vsebinsko preverjeni. Pri mejnih primerih je potreben pregled shranjenega besedila. Zaradi nepopolnih datumov in arhiva ni utemeljeno trditi, da gre za vse dogodke v zgodovini CKZ. Celoten najdeni nabor je na voljo za pregled, vključno z izločitvami in nejasnimi primeri.

DATUM / DOKAZ	DEJAVNOST	KAJ PRIZNAMO CKZ IN KAJ OSTAJA NEZNANO
8. 9. 2020 Poročilo o odprtju	Odprtje pod imenom Center za krepitev zdravja Bela krajina. [77]	Dokumentiran institucionalni razvoj. Investicijska sredstva ob odprtju niso letni strošek centra.

DATUM / DOKAZ	DEJAVNOST	KAJ PRIZNAMO CKZ IN KAJ OSTAJA NEZNANO
6. 4. 2022 Objava 9. 4.	Izobraževanje uporabnikov VDC; napoved nadaljnje priprave obroka. [72]	Prilagojeno delo z uporabniki VDC; brez merjenja dolgoročnih sprememb.
20. 2. 2024 Objava 4. 3.	Naravoslovni dan PŠ Adlešiči. [74]	Dejavnost tudi na podružnični šoli; objava ne navaja celotnega letnega dosega.
8.–10. 4. 2024 Poročilo o izvedbi	Festival zdravja za otroke, odrasle in starejše. [78]	Medgeneracijski program na več lokacijah; ni primerljivih meritev pred in po festivalu.
12. 10. 2024 Objava 15. 10.	Rožnati koraki v Dobličah, približno 50 udeležencev. [79]	Konkreten lokalni doseg in partnerstvo. Samopregledovanje ne nadomešča organiziranega presejanja.
20. 3. 2025 Objava 25. 3.	Zobkovadba na OŠ Milke Šobar – Nataše. [80]	Praktična ustna higiena in prilagojeno delo; manjkajo spremljani kazalniki ustnega zdravja.
Objava 9. 4. 2025	Festival zdravja v Radencih: vadba, medgeneracijsko sodelovanje in meritve. [73]	Terenski doseg ob Kolpi; meritev brez nadaljnje obravnave še ni zaključen preventivni proces.
Objava 14. 5. 2025	Vitaminski dan v 6. razredu OŠ Dragatuš. [81]	Prehranska pismenost v šoli; ni dokaz trajne spremembe prehrane.
Objava 25. 11. 2025	Brkati pohod na Mirno goro; CKZ sodeluje z meritvami in preventivnimi vsebinami. [82]	Doseganje moških in partnerstvo; natančno število udeležencev v besedilu ni navedeno.
Objava 19. 3. 2026	Dan za zdrav nasmeh in dobre navade na OŠ Semič. [83]	Dokaz nadaljevanja šolskega dela v 2026; šteje v območje izvajanja CKZ, ne izključno v Občino Črnomelj.

Sklep pregleda: očitek, da CKZ ne dela na terenu, ne zdrži. Prav tako ne zdrži sklep, da veliko objav že dokazuje uspešno zmanjševanje bolezni. V registru so objave CKZ Metlika izločene iz ocene Črnomlja; pri mešanih dogodkih je treba preveriti dejansko vlogo posameznega centra.

PODROČJE 05 / ČRNOMELJ

Spanje in digitalne navade

Kaj kažejo raziskave o večernih zaslonih, spanju in družbenih omrežjih? Mednarodne ugotovitve niso lokalna meritev Črnomlja.

Spanje in digitalne navade: ključna sporočila

Večerna uporaba zaslonov je povezana s krajšim in slabšim spanjem; majhen laboratorijski poskus potrjuje tudi vpliv svetlečega bralnika na čas uspavanja in cirkadiani ritem. To ni dokaz, da vsaka naprava ali kratka uporaba povzroči enak učinek. [84] [85]

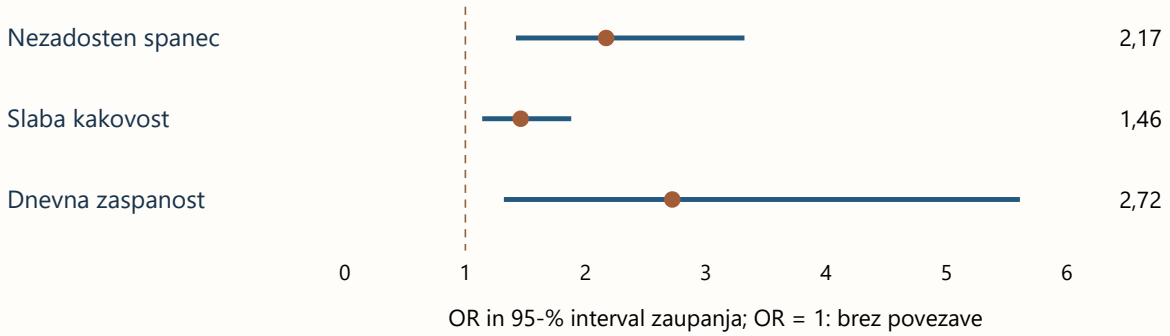
Pri družbenih omrežjih je pomembno, kaj uporabnik počne, kdaj jih uporablja in ali uporaba posega v spanje ali vsakodnevno delovanje. Povezave s stisko ne dokazujejo enosmernega vzroka. [86] Lokalna razširjenost teh težav v Črnomlju v pregledani zbirki ni izmerjena.

Trenutno stanje

To je usmerjeni raziskovalni pregled, opravljen 25. septembra 2026, ne izčrpna sistematična metaanaliza. Izbor vključuje laboratorijski poskus, sistematične preglede, novejšo longitudinalno raziskavo ter uradni objavi NIJZ. Iskanje je potekalo z izrazi »screen bedtime sleep systematic review«, »social media mental health sleep meta-analysis«, »sleep duration health umbrella review« in »social media abstinence 2025«. Za štiri članke je prebran le povzetek; to je označeno pri posamezni raziskavi. Celotna besedila dodatnih prilog niso pregledana.

NIJZ v objavi avgusta 2026 obravnava rednost spanja, večerne zaslone, šolske obveznosti, gibanje in stiske. Njegova priporočila so podlaga za lokalno izobraževanje, ne meritev učinka CKZ ali dokaz lokalne razširjenosti težav. [87] Stran s slovenskimi smernicami poudarja tako časovne omejitve kot način uporabe in kakovost vsebin. V tej dopolnitvi je prebrana uvodna spletna stran, ne celotna knjižica smernic. [88]

Kaj kažejo raziskave



Večerna uporaba naprav: raziskave do junija 2015, starost 6–19 let. OR ni relativno tveganje in ne pove deleža prizadetih v Črnomlju. [85]

Prenesi podatke grafa (CSV). Vrednosti in omejitve so tudi v preglednici raziskav spodaj.

Kaj lahko vpliva na spanec

MEHANIZEM	KAJ KAŽEJO DOKAZI	KAJ OSTAJA NEGOTOVO
Svetloba zaslona	V randomiziranem navzkrižnem poskusu je 12 zdravih mladih odraslih pet večerov po približno štiri ure bralo na svetlečem bralniku ali tiskano knjigo. Uspavanje je bilo pri bralniku povprečno 25,65 proti 15,75 minute; skupno trajanje spanja se ob osemurni priložnosti za spanje ni razlikovalo. [84]	Močna in dolga izpostavljenost v laboratoriju; rezultat ni ocena učinka kratkega pogleda na sodoben telefon. Poskus ne dokazuje preprečevanja bolezni z nočnim načinom zaslona.
Odlaganje spanja	Čas pred zaslonom lahko nadomesti čas za spanje. Pregled raziskav pri otrocih razlikuje predšolske otroke, šolarje in mladostnike. [89]	Časa za šolo in delo ne enačimo s prostočasnim časom. Različne starosti in naprave niso zamenljive.
Vznemirljiva vsebina in socialni pritisk	Psihološka stimulacija je verjetna razlaga; izidi so povezani tudi s problematično uporabo omrežij. [89] [86]	Posameznega mehanizma ni mogoče izolirati iz večine opazovalnih raziskav.
Prekinjanje večernega miru	Obvestila in pričakovanje odziva so smiselna tarča lokalnega dogovora o komunikaciji.	Učinek samega izklopa obvestil v izbranih virih ni ločeno kvantificiran; predlog je treba ovrednotiti.

Pregled ključnih raziskav

AVTORJI IN LETO; RAZISKAVA	ZASNOVA IN POPULACIJA	UGOTOVITEV	OMEJITVE, GOTOVOST IN OBSEG BRANJA
Chang in sod., 2015: *Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness*. DOI: 10.1073/pnas.1418490112. [84]	Navzkrižni randomizirani poskus, 12 zdravih mladih odraslih; po pet večerov na pogoj.	Uspavanje približno 10 minut pozneje; zamik začetka izločanja melatonina približno 1,5 ure.	Srednja gotovost za neposredni učinek v preučenih pogojih; omejena prenosljivost. Prebran PDF, str. 1–6.

AVTORJI IN LETO; RAZISKAVA	ZASNOVA IN POPULACIJA	UGOTOVITEV	OMEJITVE, GOTOVOST IN OBSEG BRANJA
Carter in sod., 2016: *Association Between Portable Screen-Based Media Device Access or Use and Sleep Outcomes*. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2016.2341. [85]	20 presečnih raziskav, 125.198 otrok in mladostnikov, vključitvena starost 6–19 let; iskanje do junija 2015.	Uporaba pred spanjem: OR za nezadosten spanec 2,17 (95-% IZ 1,42–3,32), slabo kakovost 1,46 (1,14–1,88), dnevno zaspanost 2,72 (1,32–5,61).	Nizka gotovost za vzročnost; velika heterogenost. OR pomeni razmerje obetov, ne povečanja verjetnosti ali lokalnega deleža. Prebran povzetek.
Lund in sod., 2021: *Electronic media use and sleep in children and adolescents in western countries*. DOI: 10.1186/s12889-021-11640-9. [89]	49 raziskav; starost 0–15 let, zahodne države; objave 2009–2019.	Najbolj dosledne povezave so s krajšim spanjem; drugi izidi se razlikujejo po starosti in načinu uporabe.	Prevladujejo opazovalne raziskave, samoocene in različne meritve; nizka do srednja gotovost povezav. Prebrano glavno besedilo in glavne tabele; priloge niso pregledane.
Gao in sod., 2022: *Sleep Duration/Quality With Health Outcomes*. DOI: 10.3389/fmed.2021.813943. [90]	Krovni pregled metaanaliz prospektivnih raziskav; različne populacije in opredelitve spanja.	85 metaanaliz, 36 izidov. Nobena povezava ni dosegla najvišje kategorije (»prepričljivo«); kot »zelo nakazana« je ocenjena le povezava dolgega spanja s celokupno umrljivostjo, kot »nakazane« pa med drugim kratek spanec s prekomerno težo/debelostjo ter slaba kakovost spanja s sladkorno boleznijo.	Statistična povezanost ne dokazuje, da podaljšanje spanja prepreči posamezno bolezen. Prebrano glavno besedilo; ni ponovnega preverjanja vsake izvorne študije.
Itani in sod., 2017: *Short sleep duration and health outcomes*. DOI: 10.1016/j.sleep.2016.08.006. [91]	153 prospektivnih raziskav, kumulativno 5.172.710 udeležencev; spremljanje najmanj eno leto.	Kratek spanec: RR umrljivosti 1,12 (1,08–1,16), sladkorne bolezni 1,37 (1,22–1,53), hipertenzije 1,17 (1,09–1,26).	Različni pragovi kratkega spanja, preostali moteči dejavniki; nizka gotovost za vzročni sklep. Povzetek ne omogoča zanesljive starostne razčlenitve. Prebran povzetek.
Ahmed in sod., 2024: *Social media use, mental health and sleep*. DOI: 10.1016/j.jad.2024.08.193. [86]	182 raziskav v pregledu; 98 v metaanalizah, skupaj 102.683 oseb v metaanalitičnem delu; mladi.	Majhne povezave splošne uporabe z depresivnostjo in anksioznostjo; problematična uporaba je povezana tudi s težavami s spanjem.	Visoka heterogenost; premalo študij za sklepe o posameznih platformah. Koeficienti v prebranem povzetku niso navedeni. Prebran povzetek.
Ahmed in sod., 2025: *Longitudinal associations between problematic social media use and mental health: Mediating role of sleep*. DOI: 10.1016/j.addbeh.2025.108446. [92]	437 mladih odraslih, povprečna starost 22,62 leta; štiri ankete v trimesečnih razmikih.	Problematična uporaba je napovedovala poznejše simptome; nespečnost in slabša kakovost spanja sta statistično delno posredovali povezavo.	Opazovalni model posredovanja ni dokaz vzročnega mehanizma; velikost učinka v povzetku ni podana. Nizka gotovost za vzročnost. Prebran povzetek.
Lemahieu in sod., 2025: *The effects of social media abstinence on affective well-being and life satisfaction*. DOI: 10.1038/s41598-025-90984-3. [93]	Metaanaliza 10 raziskav, 4.674 odraslih; odmor od omrežij 1–28 dni.	Za pozitivno počutje g = 0,03 (95-% IZ −0,11 do 0,16); statistično značilne skupne koristi niso potrjene niti za negativno počutje niti zadovoljstvo z življenjem.	Srednja gotovost za omejeni preučeni poseg; različno upoštevanje navodil, kratko spremljanje. Ne dokazuje odsotnosti vseh učinkov. Prebrano glavno besedilo.

Facebook, X, TikTok in Instagram

PLATFORMA ALI NAČIN UPORABE	KAJ LAHKO SKLEPAMO IZ TEGA PREGLEDA
Facebook	Pogost v raziskavah kratkotrajne abstinence; rezultati odraslih ne predstavljajo današnje uporabe otrok. [93]

PLATFORMA ALI NAČIN UPORABE	KAJ LAHKO SKLEPAMO IZ TEGA PREGLEDA
Instagram	V tem pregledu ni podlage za ločeno številčno oceno tveganja. Vsebina, primerjanje in način komunikacije zahtevajo ločeno merjenje. [86]
TikTok	Dokazi iz starejših raziskav bralnikov ali Facebooka niso neposredna ocena učinkov kratkih videov. Platformno specifična velikost učinka ni določena. [86]
X, prej Twitter	Iz združenih rezultatov ni mogoče oblikovati posebne ocene za X ali ga uvrstiti na lestvico »najškodljivejših«. [86]
Podporna uporaba	Omrežja omogočajo stike in izmenjavo informacij. Odklop lahko prekine tudi podporne vezi; kratkotrajna abstinenca zato ni univerzalna rešitev. [93]

Otroci, mladostniki in odrasli

SKUPINA	RAZISKOVALNI POUDAREK IN LOKALNI POMEN
Predšolski otroci	Dokazi o različnih napravah so neenakomerni. Potrebna je obravnava družinskih rutin in vsebine, ne prenos številk iz študij mladostnikov. [89]
Šolarji in mladostniki	Spanje obravnavati skupaj z začetkom pouka, obremenitvami, vrstniškimi odnosi in večerno uporabo. NIJZ-jeva priporočila omogočajo skupen okvir za šole in starše. [87]
Mladi odrasli	Longitudinalna raziskava kaže časovne povezave, vendar študentski oziroma mladi vzorci niso reprezentativni za vse odrasle. [92]
Starejši odrasli in ranljive skupine	Izbrani dokazi ne dajejo ločene lokalne ocene. Ukrepi naj ohranijo dostop do informacij in socialne podpore tudi za ljudi z omejeno mobilnostjo.

Lokalna vprašanja, ukrepi in omejitve

Viri

Bibliografija vsebuje trajne povezave, lokalne kopije in opis prebranega obsega. Ocena gotovosti zgoraj je obrazložena uredniška presoja, ne formalna ocena GRADE. Pregledi lahko vključujejo iste raziskave; njihovih udeležencev ne seštevamo. Različnih OR, RR in standardiziranih razlik ne prikazujemo na skupni lestvici.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Lokalno stanje ni izmerjeno	V pregledani projektni zbirki ni primerljive občinske meritve spanja in večerne uporabe omrežij. Status: Unverified za lokalno prevalenco.
Dejavnosti niso enako učinki	Število predavanj ali objav ne pokaže spremembe spanja. Potrebno je spremljanje pred programom in po njem z ustrezno primerjavo.

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Nevarnost poenostavljanja	Dokazi ne podpirajo ene številke za vse zaslone, starosti in platforme. [89] [86]
Izključevanje in stigmatizacija	Splošna prepoved lahko omeji podporne stike; nekatere družine nimajo mirne spalnice ali prilagodljivega delovnega časa. To so vprašanja za lokalno preverjanje, ne potrjena razširjenost.

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Vodja CKZ	Kateri programi dejansko obravnavajo spanje in digitalne navade? Predložiti vsebinski načrt, ciljne skupine, izvedene termine in uporabljene vire.
Vodstvo ZD	Kako je urejeno usmerjanje ob vztrajnih težavah s spanjem? Predložiti javno pot do obravnave in agregirane čakalne dobe.
Svet ZD	Katere rezultate programov spremljate po 6 in 12 mesecih? Predložiti anonimizirane agregate, osip in opis meril.
Šole	Ali pozna večerna sporočila ali naloge spodbujajo stalno dosegljivost? Predložiti pravila komunikacije in agregirano analizo časov objav.
Šolske svetovalne službe	Kako se obravnavajo spletno nasilje in stiske? Predložiti protokol podpore in agregirane podatke brez prepoznavnih primerov.
Pediatrija	Ali je spanje vključeno v preventivne obravnave? Predložiti uporabljena vprašanja, merila in način usmerjanja.
NIJZ	Kateri slovenski podatki so primerljivi za starostne skupine v Črnomlju? Predložiti definicije, vzorčenje, leta in intervale zaupanja.
Občina	Katere dostopne popoldanske možnosti imajo podeželski otroci brez lastnega prevoza? Predložiti pregled krajev, urnikov, stroškov in prevoza.
Športna društva	Ali so objavljeni urniki, cene in pogoji vključitve aktualni? Predložiti datiran register in način posodabljanja.
Socialni izvajalci	Katere ovire za miren spanec in sodelovanje je mogoče spremljati brez stigmatizacije? Predložiti prostovoljno, agregirano oceno potreb.
ZZZS in Ministrstvo za zdravje	Katere aktivnosti in spremljanje izidov so financirani? Predložiti veljavne programske podlage, obseg in odgovornosti.
Izvajalec evalvacije	Kako bo ločil spremembe zaradi programa od šolskega koledarja, sezone in osipa? Predložiti vnaprej določen protokol in primerjalni načrt.

Tveganja

Ne zbirati imen, uporabniških računov, vsebin zasebnih sporočil ali individualnih zdravstvenih podatkov za javno poročilo. Lokalna raziskava je predlog za pooblaščene izvajalce z ustreznim varovanjem podatkov, ne

opravilo tega projekta. Rezultate majhnih skupin je treba združiti ali zadržati, kadar bi omogočali prepoznavo. Ne enačiti časa na omrežjih z zasvojenostjo in ne obljubljati zdravstvenih učinkov posameznega predavanja.

▼ Možne rešitve

PROBLEM IN ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI TER MOŽNO FINANCIRANJE	PRIČAKOVANA KORIST, TVEGANJE IN MERILO
Neizmerjeno stanje; 0–12 mesecev	CKZ, šole in NIJZ pripravijo enoten načrt prostovoljne agregirane meritve.	Načrtovalna ocena: 40–80 ur strokovnega dela; možnost obstoječih preventivnih in občinskih sredstev, brez domneve odprtega razpisa.	Primerljiva izhodiščna slika; tveganje pristranskega odziva. V 6 mesecih protokol, v 12 mesecih odzivnost, definicije in objavljene omejitve.
Neizmerjeno stanje; 1–3 leta	NIJZ in občina ponovita enake meritve ter vključita podeželske skupine.	Načrtovalna ocena: 80–160 ur na merilni krog; dogovorjeno financiranje raziskovanja/preventive.	Spremljanje sprememb in dosega; tveganje nestalnega vzorca. Po 12 in 24 mesecih primerljivi agregati, ne vzročna ocena CKZ.
Neizmerjeno stanje; 3–10 let	Občina in ZD vključita spanje v večletno javno spremljanje potreb.	Načrtovalna ocena: 40–80 ur letno po vzpostavitvi; redni programski proračuni.	Vzdržnost; tveganje administrativnega bremena. Letno objavljen kazalnik popolnosti, vsaj triletna presoja uporabnosti.
Neizmerjeni učinki; 0–12 mesecev	CKZ izvede majhen pilot z izhodiščno in ponovljeno meritvijo ter evidentiranjem osipa.	Načrtovalna ocena: 60–120 ur; obstoječi programi, če dopuščajo tak obseg.	Preverba izvedljivosti; samoizbor udeležencev. Po 6 mesecih delež spremljanih, po 12 mesecih sprememba spanja z negotovostjo.
Neizmerjeni učinki; 1–3 leta	ZD in neodvisni evalvator uvedeta primerjalno skupino ali postopno uvajanje.	Načrtovalna ocena: 150–300 ur; raziskovalno partnerstvo ali sredstva preventive.	Boljša presoja učinkov; osip in kontaminacija skupin. Predhodni protokol, merjenje po 6/12 mesecih in strošek na spremljanega udeleženca.
Neizmerjeni učinki; 3–10 let	Svet ZD redno prilagaja programe glede na neodvisno evalvacijo.	Načrtovalna ocena: 40–80 ur letno; redno financiranje upravljanja kakovosti.	Trajna kakovost; tveganje izbire samo ugodnih rezultatov. Javna objava tudi ničelnih izidov in osipa, pregled vsaka tri leta.
Poenostavljanje; 0–12 mesecev	CKZ in šole uskladijo kratko gradivo z NIJZ ter ločijo starosti in načine uporabe.	Načrtovalna ocena: 20–40 ur; obstoječa strokovna sredstva.	Razumljivejša sporočila; tveganje moraliziranja. V 6 mesecih recenzirano gradivo, v 12 mesecih preverba razumevanja.
Poenostavljanje; 1–3 leta	Šole z družinami preizkusijo dogovore o večerni komunikaciji, brez splošne obljube učinka prepovedi.	Načrtovalna ocena: 20–40 ur na šolo/leto; šolski program in sredstva preventive.	Manj nepotrebnih večernih zahtev; neenako upoštevanje. Po 6/12 mesecih čas objav in prostovoljni agregati počutja.
Poenostavljanje; 3–10 let	NIJZ/CKZ letno posodobita vsebino in usposabljanje izvajalcev.	Načrtovalna ocena: 20–40 ur letno; redno strokovno izobraževanje.	Aktualnost; kadrovske menjave. Datum revizije, delež usposobljenih in merjenje razumevanja ob vsaki reviziji.

PROBLEM IN ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI TER MOŽNO FINANCIRANJE	PRIČAKOVANA KORIST, TVEGANJE IN MERILO
Izključevanje; 0–12 mesecev	Občina, društva in socialni izvajalci popišejo cenovne, prevozne in prostorske ovire.	Načrtovalna ocena: 40–80 ur; občinski in socialni programi.	Boljši doseg; tveganje označevanja posameznih skupin. V 6/12 mesecih agregiran zemljevid ovir in dostopne tiskane informacije.
Izključevanje; 1–3 leta	Občina in društva pilotno zagotovijo dostopne termine, prevoz ali subvencijo po ugotovljenih potrebah.	Načrtovalna ocena: proračun šele po popisu; občina, društva, potencialni nacionalni/EU programi, če so razpoložljivi.	Širša udeležba; nepravična merila in premajhen doseg. Po 6/12 mesecih udeležba po krajih, strošek, odpovedi in izkušnje uporabnikov.
Izključevanje; 3–10 let	Občina poveže dostopne javne prostore, poti in prevoz v večletni program.	Načrtovalna ocena: investicijski obseg ni določljiv brez projektov; občinski, državni in morebitni evropski viri.	Dolgoročno manj ovir; vzdrževanje in neenaka porazdelitev koristi. Vsaka tri leta pregled dostopnosti, uporabe in stroškov.

▼ Uredniška ocena dokumentiranosti

Ocenjen je novi raziskovalni pregled in pripravljenost predlaganega spremljanja, ne dejanska kakovost spanja prebivalcev ali klinična učinkovitost CKZ. Lestvica: 1 = skoraj nič dokumentirano; 2 = večje vrzeli; 3 = delna podlaga; 4 = dobra sledljiva podlaga; 5 = celovita neodvisno preverjena izvedba. Sedem ocenjenih meril ima enako utež 1/7. Stroškovne učinkovitosti ne ocenjujemo brez podatkov.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	4: sledljivi viri in odkrito označen obseg branja; štirje povzetki omejujejo presojo.
Dostop in razpoložljivost	2: lokalna pot do podpore in aktualni termini niso na novo preverjeni.
Usklajenost s potrebami	3: mednarodna podlaga je jasna, lokalne potrebe niso izmerjene.
Dokazna podlaga in spremljanje	3: kakovostni pregledi z omejitvami; lokalnih izidov ni.
Pravičnost in doseg	2: predlagani ukrepi vključujejo ovire, dokumentirane izvedbe ni.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene: samo načrtovalne ocene ur, brez dejanskih stroškov in primerljivih izidov.
Vzdržnost	3: predlagano periodično spremljanje, financiranje še ni potrjeno.
Izvedljivost	4: postopni ukrepi z določenimi odgovornostmi; potreben dogovor izvajalcev.

Izračun: (4 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 4) / 7 = **3,00/5,** ⚠️. Izredni prehod na ❌ ni uporabljen: odsotnost lokalnih podatkov ni sama po sebi dokaz potrjenega trenutnega zdravstvenega tveganja.

Primerjave

Za Črnomelj, JV Slovenijo, Slovenijo in EU v tej zbirki ni usklajene meritve spanja ali platformno specifične uporabe z enakimi starostmi, instrumenti in obdobjem. Lestvice občin zato ni. Pridobiti bi bilo treba primerljivo nacionalno/regijsko anketo z intervali zaupanja in ustrezen lokalni vzorec. Tuji rezultati raziskav so dokazna podlaga za načrtovanje, ne nadomestek lokalnih meritev.

Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Štirje članki so prebrani le kot povzetki	Pridobiti zakonito dostopna celotna besedila Carter 2016, Itani 2017 in Ahmed 2024/2025 ter ponovno preveriti metodo in rezultate.
Učinki posameznih platform	Dopolniti pregled s primerljivimi novejšimi longitudinalnimi ali eksperimentalnimi študijami; ne razvrščati platform brez dokazov.
Ciljno izklapljanje obvestil in večerna uporaba	Pridobiti neposredne preizkuse teh posegov; splošna abstinenca meri drug ukrep.
Lokalne storitve in stanje	Pridobiti aktualni program CKZ in agregirane podatke pristojnih; ta projekt ni kontaktiral organizacij.

PODROČJE 06 / ČRNOMELJ

Peš in kolesarske poti

Izberite pešpoti ali kolesarske sledi in si oglejte izračune GPX. Zemljevid opisuje trase; prehodnost, prometna varnost in primernost niso samodejno potrjene.

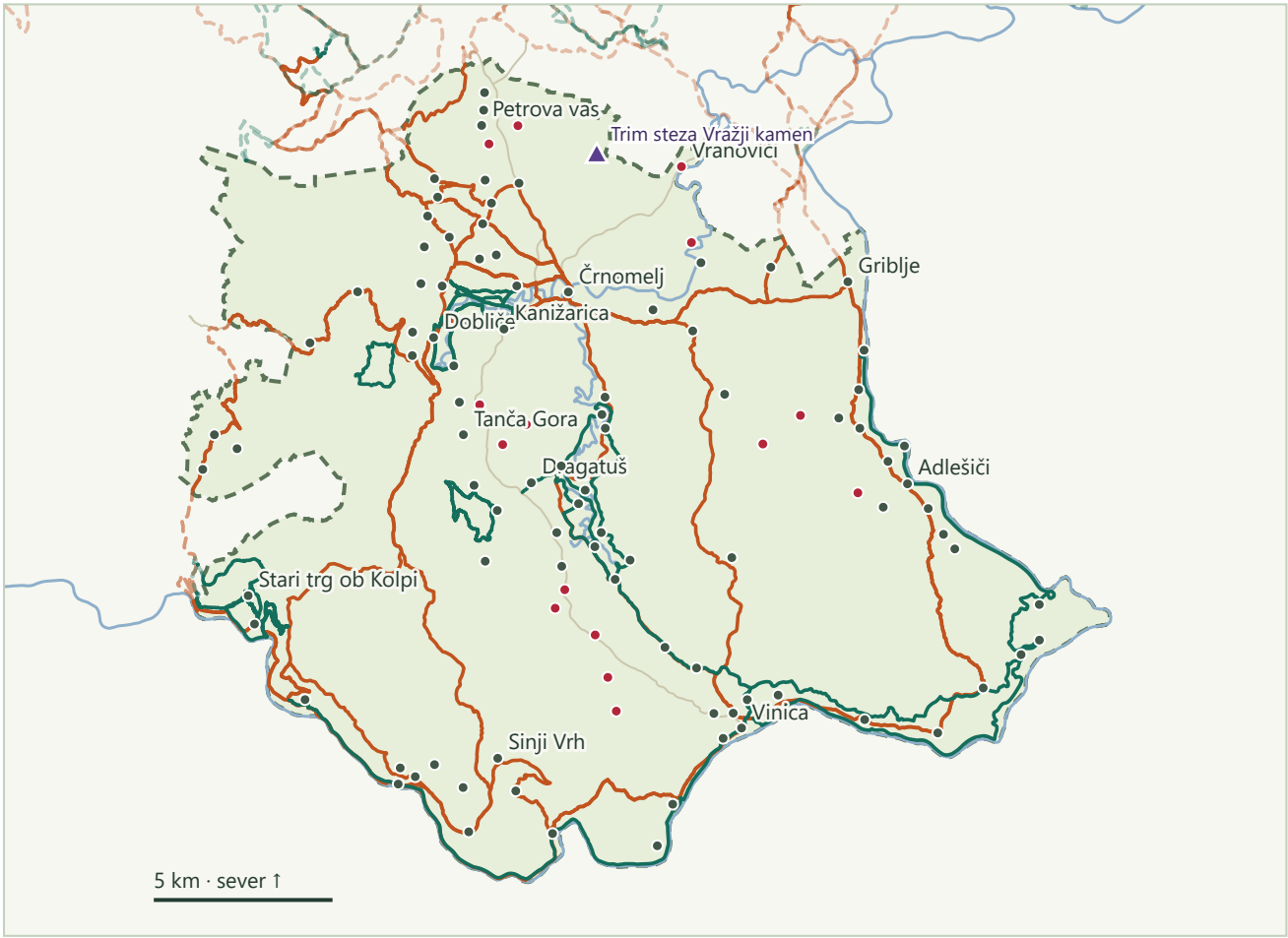
11 Pohodne in kolesarske trase: zemljevid in prostorska bližina

Pregled 21. 9. 2026: obdelanih je **43 datotek GPX: 26 pohodnih in 17 kolesarskih**. Znotraj meje Črnomlja ima merljiv odsek **22 tras (14 pohodnih in 8 kolesarskih)**; **21 tras je v celoti zunaj te meje**. To je regionalna zbirka, ne 43 poti v celoti znotraj občine. Pri Poti Gozdna železnica gre le za približno **40 m obmejnega odseka**, zato je treba pripadnost te poti preveriti tudi na uradni meji. [94][95]

Najmočnejša ugotovitev je razlika med vrstama aktivnosti: do pohodniške trase je znotraj **1 km zračne razdalje 62 od 111 točk krajev (55,9 %)**, do kolesarske pa **89 (80,2 %)**. Točke krajev niso gospodinjstva ali urejeni vstopi na pot; deleža **nista deleža prebivalcev**. [94][95]

Sloj AED uporablja iste podatke kot zavihek AED-ji. Točke ne potrjujejo časovne dostopnosti, varnosti poti ali odzivnega časa. Izberite točko za podatke o napravi.

Pohodne Kolesarske Meja občine Kraj več kot 1 km od katerekoli trase



Podlaga: © sodelavci OpenStreetMap, ODbL, zajem 20. 9. 2026; [95]. GPX: datoteke naročnika; [94]. Zemljevid deluje brez omrežja. Črtkane, blede trase so zunaj občine; v kazalnikih niso upoštevane.

▼ Seznam vseh 43 tras z dolžinami in prenosi

TRASA	VRSTA	CELOTNA (KM)	V OBČINI (KM)	DELEŽ V OBČINI	IZVIRNIK
Belokranjska kolesarska proga	Kolesarska	187,66	81,14	43,2 %	GPX
Kolesarska krožna pot Črnomelj	Kolesarska	10,39	10,39	100,0 %	GPX
Kolesarska krožna pot Metlika	Kolesarska	18,22	0,00	0,0 %	GPX
Kolesarska pot Damelj	Kolesarska	68,01	68,01	100,0 %	GPX
Kolesarska pot Gače	Kolesarska	37,45	0,00	0,0 %	GPX
Kolesarska pot Gradnik	Kolesarska	26,52	0,00	0,0 %	GPX
Kolesarska pot Krašnji vrh	Kolesarska	19,34	0,00	0,0 %	GPX
Kolesarska pot Krupa	Kolesarska	16,51	0,00	0,0 %	GPX
Kolesarska pot Kučar	Kolesarska	33,68	0,00	0,0 %	GPX
Kolesarska pot Mirna gora	Kolesarska	37,23	17,61	47,3 %	GPX
Kolesarska pot Mirna gora – Semič	Kolesarska	35,08	3,43	9,8 %	GPX
Kolesarska pot Ravnače	Kolesarska	24,18	0,00	0,0 %	GPX
Kolesarska pot Vidošiči	Kolesarska	18,30	0,00	0,0 %	GPX
Poljanska kolesarska pot	Kolesarska	55,79	46,31	83,0 %	GPX
STKP etapa 22: Mirna gora–Gospodična	Kolesarska	63,37	17,17	27,1 %	GPX
STKP etapa 21: Jelenov studenec–Mirna gora	Kolesarska	51,55	0,00	0,0 %	GPX
Županičeva kolesarska pot	Kolesarska	48,40	48,40	100,0 %	GPX
Čredniška pot	Pohodna	14,97	12,87	86,0 %	GPX
Grajska gozdna učna pot Obrh	Pohodna	7,04	7,04	100,0 %	GPX
Jožefov pohod	Pohodna	13,78	13,78	100,0 %	GPX

TRASA	VRSTA	CELOTNA (KM)	V OBČINI (KM)	DELEŽ V OBČINI	IZVIRNIK
Kraška učna pot od Lebice do Krupe	Pohodna	12,51	0,00	0,0 %	GPX
Krupa–Moverna vas	Pohodna	2,88	0,00	0,0 %	GPX
Martinov pohod	Pohodna	18,53	0,00	0,0 %	GPX
Mlinarska pot	Pohodna	8,73	8,73	100,0 %	GPX
Najjužnejša slovenska pešpot Radenci–Damelj	Pohodna	10,90	10,90	100,0 %	GPX
Obkolpska grajska pot	Pohodna	13,89	13,89	100,0 %	GPX
Pastirska pot	Pohodna	10,12	0,00	0,0 %	GPX
Planinska krožna pot	Pohodna	18,87	0,00	0,0 %	GPX
Pot Gozdna železnica	Pohodna	4,09	0,04	0,9 %	GPX
Pot na Smuk – Gornje Laze	Pohodna	6,35	0,00	0,0 %	GPX
Ribja pot – srčna pot Svibnik	Pohodna	4,64	4,64	100,0 %	GPX
Sejemska pešpot Vinica–Žuniči	Pohodna	23,97	23,97	100,0 %	GPX
Trdinova pot	Pohodna	31,26	0,00	0,0 %	GPX
Trška pešpot	Pohodna	7,69	7,69	100,0 %	GPX
Učna pot – srčna pot Svibnik	Pohodna	12,28	12,28	100,0 %	GPX
Učna pot Divji potok	Pohodna	1,59	0,00	0,0 %	GPX
Učna pot Grički kal	Pohodna	4,61	4,61	100,0 %	GPX
Učna pot Kučar–Kolpa	Pohodna	2,91	0,00	0,0 %	GPX
Učna pot Mirna gora	Pohodna	2,73	0,00	0,0 %	GPX
Učna pot Zdenc–Vidovec	Pohodna	2,12	0,00	0,0 %	GPX
Učno-rekreacijska pot Dobličica	Pohodna	10,73	10,73	100,0 %	GPX
Urbanova pot	Pohodna	5,75	0,00	0,0 %	GPX
Župančičeva pot	Pohodna	12,73	12,73	100,0 %	GPX

Predložene trase in dolžine odsekov v občini

VRSTA	DATOTEKE	Z ODSEKOM V OBČINI	CELOTNE TRASE (KM)	ODSEKI V OBČINI (KM)
Pohodništvo	26	14	265,7	143,9
Kolesarstvo	17	8	751,7	292,5
Skupaj	43	22	1.017,3	436,4

To so vsote dolžin posameznih tras. Ponovni prehodi po odseku in skupni odseki več tras so šteti večkrat; 436,4 km ni dolžina edinstvenega omrežja ali zgrajenih ločenih poti. Kolesarski GPX lahko poteka po navadni cesti, pohodni po kolovozu. Oblike infrastrukture iz same sledi ne ugotovimo. Dolžine so dvodimenzionalne in ne vključujejo višinske komponente. [94][95]

Bližina tras krajem in občinskemu ozemlju

BLIŽINA TRASE	POHODNE: KRAJI	KOLESARSKE: KRAJI	KATERAKOLI: KRAJI	DELEŽ OZEMLJA: POHODNE / KOLESARSKE / KATERAKOLI
0,5 km	52/111 (46,8 %)	67/111 (60,4 %)	80/111 (72,1 %)	20,9 % / 38,4 % / 46,6 %
1 km	62/111 (55,9 %)	89/111 (80,2 %)	96/111 (86,5 %)	35,4 % / 62,9 % / 70,9 %
2 km	84/111 (75,7 %)	109/111 (98,2 %)	110/111 (99,1 %)	61,5 % / 91,4 % / 94,4 %

Razdalje 0,5 / 1 / 2 km so **analitični pragovi**, ne zdravstveni, evropski ali prometni standard. Delež ozemlja meri geometrijsko bližino, vključno z gozdovi in neposeljenimi območji. Pasovi so unija, prekrivanje se pri površini ne podvaja. Skupna bližina obeh vrst ne pomeni, da je kolesarska trasa primerna za pešce. [94][95]

Prednostna območja za preverbo dostopa

KRAJ (TOČKA OSM)	DO POHODNE TRASE	DO KOLESARSKE TRASE
Vranoviči	5,6 km	3,5 km
Ručetna vas	5,4 km	0,6 km
Zastava	5,0 km	1,4 km
Mihelja vas	4,9 km	0,7 km
Pavičiči	4,8 km	0,8 km
Petrova vas	4,4 km	1,0 km
Gorenja Paka	4,4 km	1,7 km
Rožanec	4,0 km	1,2 km

Prednostna preverba za hojo: Vranoviči, Ručetna vas, Zastava, Mihelja vas in Pavičiči. Razvrstitev je po oddaljenosti od predloženih pohodnih GPX, ne po številu prebivalcev, starosti ali prometni nevarnosti. Obstoječe lokalne poti, ki jih v zbirki ni, lahko sliko bistveno spremenijo. [94][95]

Pri kolesarjenju sta najdlje Vranoviči (3,49 km) in Miliči (2,44 km). Vranoviči so edina od 111 zajetih točk več kot 2 km od katerekoli obravnavane trase znotraj občine. Za ukrepanje najprej preveriti, ali manjka GPX, označena povezava ali dejansko varna infrastruktura. [94][95]

Možnosti za vsakodnevno gibanje in omejitve podatkov

V celoti oziroma vsaj 95-odstotno znotraj občine sta v zbirki **le dve celotni pohodniški trasi dolgi največ 5 km**: Ribja pot – srčna pot Svibnik (4,64 km) in Učna pot Grički kal (4,61 km). Prag 5 km je raziskovalni izbor krajših tras, **ne priporočena razdalja za vsakega uporabnika**. Podatki ne potrjujejo zahtevnosti, prehodnosti z vozičkom, klopi, sence, dostopa brez avtomobila ali dovoljenosti prehoda. [94][95]

Kolesarska krožna pot Črnomelj meri 10,39 km, od tega 10,39 km v občini. Druge lokalno prisotne kolesarske trase so daljše regionalne ture ali njihovi odseki. Za vsakodnevno preventivno vadbo je smiselno **preveriti in opisati krajše uporabne odseke**, ne vsake celotne ture predstavljati kot primerne za začetnike. Pot Dobličica je v mapi pohodnih poti, njeno interno ime GPX pa je »Morning Ride«; vrsta dejavnosti zato zahteva potrditev. [94][95]

Metoda izračuna in omejitve

KORAK	POSTOPEK IN OMEJITEV
Vhod	Vseh 43 predloženih GPX, 67.518 trasnih točk; razvrstitev po mapah. Izračun ni dopolnjeval manjkajočih poti.
Razmejitev	OpenStreetMap, relacija 1685747, zajem 20. 9. 2026; izračunana površina približno 339,4 km². OSM ni uradna geodetska meja.
Dolžine	Vsak segment ločeno, brez povezovanja konca enega z začetkom naslednjega. Za lokalno dolžino je posebej obrezan vsak zaporedni par točk: ponovni prehodi so ohranjeni. WGS84 geodetska dolžina; preseki s poligonom občine v UTM 33N.
Kraji	111 točk tipa town/village iz obstoječega OSM zajema. Brez zaselkov tipa hamlet, brez uteži prebivalstva in brez trditve, da gre za vsa uradna naselja.
Razdalja	Najkrajša zračna razdalja do črte **znotraj občine** v metrih, ne samo do najbližje shranjene točke. Zunajobčinski odseki niso uporabljeni za ta kazalnik.
Pasovi	Polmer 500 / 1.000 / 2.000 m, unija in presek z občino. Za površino so trase poenostavljene največ 5 m; loki imajo 16 odsekov na kvadrant. Zemljevid dodatno poenostavi pasove za 20 m, kar ne spremeni že izračunanih tabel.
Kakovost	0 neveljavnih koordinat, 0 povsem enakih geometrij datotek. Največji razmik zaporednih točk je 537 m: GPX med točkami predpostavlja ravno povezavo. Brez terenske potrditve.
Česa ne merimo	Prebivalcev v dosegu, časa hoje/vožnje, prometa, podlage, naklona, zapor, lastništva, oznak, stroškov, vzdrževanja in zdravstvenega učinka. Datumi v GPS posnetku niso datum terenske preverbe.

Predlagani naslednji koraki

Ukrepi so raziskovalni predlogi. Okvir ur je orientacijska organizacijska ocena, ne ponudba ali potrjen občinski strošek.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI / MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN KAZALNIK
0–3 mesece	RIC, občina in lokalna društva preverijo 43 vnosov, prvotni vir, upravljavca, označenost ter manjkajoče trase. Najprej razjasnijo 40 m mejnega stika Poti Gozdna železnica in vrsto poti Dobličica.	20–40 ur pisarniškega dela; obstoječa sredstva upravljavcev.	Uporaben register; tveganje neodzivnosti. Delež poti s potrjenim upravljavcem in datumom preverbe.
0–12 mesecev	Občina, KS in CKZ preverijo dostopne kratke odseke pri Vranovičih, Ručetni vasi in drugih oddaljenih krajih ter pri Svibniku/Griču opravijo ogled obstoječih krajših tras.	5–8 terenskih ogledov po 2 osebi, približno 40–80 človek-ur; občinski program športa/turizma in sredstva partnerjev.	Loči vrzel podatkov od vrzeli dostopa; tveganje neurejenih pravic ali cestnih prehodov. Število opisov z varnim dostopom, podlago, ovirami in dolžino.
1–3 leta	Na podlagi ogledov urediti prednostne manjkajoče povezave, označevanje in dogovorjeno vzdrževanje; odgovorni občina, upravljavci cest in lastniki.	Ločen popis del in projektantska ocena; možni občinski proračun, LAS ali namenski razpisi, upravičenost še ni preverjena.	Več uporabnih povezav; tveganje gradnje brez uporabnikov ali vzdrževanja. Število potrjenih dostopnih povezav in števci uporabe.
1–3 leta	CKZ in društva preizkusijo redno vodeno hojo na preverjenih odsekih; spremljajo vključitev, vztrajanje in ovire dostopa.	Najprej dve skupini, okvirno 2–4 ure vodenja/koordinacije tedensko skupaj; sredstva programov izvajalcev.	Povezava poti z dejansko dejavnostjo; tveganje osipa. Udeležba po treh in šestih mesecih, ne samo število dogodkov.
3–10 let	Vzpostaviti letno obnavljan register poti in dostopa iz naselij, povezan z uradnimi prostorskimi podatki, prebivalstvom in proračunom.	Letni načrt vzdrževanja in podatkov; obseg naložb šele po prioritetah.	Trajnejša dostopnost; tveganje zastarelih podatkov. Delež prebivalcev z dejansko varnim dostopom po mreži in pravočasno izvedeno vzdrževanje.

Trim steza Vražji kamen in Srčna pot Svibnik

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Blizu mesta sta dve urejeni možnosti za gibanje, ki ju CKZ in društva povezujejo z zdravjem. **Trim steza Vražji kamen** ima vadbene postaje, ki jih je Krajevna skupnost Črnomelj obnovila poleti 2020. CKZ ZD Črnomelj je zanje pripravil brošuro s 57 vajami za moč in ravnotežje na sedmih postajah. [17] [96] **Srčna pot Svibnik** je 4,6 km dolga krožna Ribja pot z začetkom pri Baru Panda v Svibniku, z daljšo 12,3 km Učno potjo. Pripravili so jo Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine, Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Občina Črnomelj, KS Črnomelj ter ZD Črnomelj s CKZ. [97]

Obe poti Srčne poti sta že vključeni v prostorsko analizo tras. GPX Ribje poti s spletne strani Srčne poti je enak datoteki v tem poročilu. [97] Za trim stezo GPX še ni, zato njena dolžina, vzpon in trasa v poročilu niso prikazani. Na zemljevidu poti je označen le vrh Vražji kamen. [98]

Trenutno stanje

Leta 2021 je KS Črnomelj po poročanju Radia Odeon urejala parkirišče ob vstopu na trim stezo ter načrtovala table, koše in klopi. Namestili so tudi 25 novih ptičjih gnezdilnic. [99] Novejšega vira o stanju steze in postaj v tem pregledu ni. Srčna pot ima oznake s srcem, tablice z ribo, »kotičke za sproščanje« in točke za razgibavanje s slikovno brošuro vaj. [97]

Ključna dejstva

PODATEK	TRIM STEZA VRAŽJI KAMEN	SRČNA POT SVIBNIK (RIBJA POT)
Namen	Vadba moči in ravnotežja na postajah [96]	Hoja in razgibavanje, posebej za koronarne bolnike [97]
Dolžina	ni znana (GPX v pripravi)	4,6 km krožno, daljša različica 12,3 km [97]
Zahtevnost	Vaje od lažjih k težjim, prilagodljive posamezniku [96]	Lahka, okoli 1 h 15 min, vzpon 125 m in spust 133 m [97]
Vadbene točke	7 postaj, 57 vaj [96]	Točke za razgibavanje, brošura 4 strani [97]
Upravljavec, sodelujoči	KS Črnomelj; brošura CKZ [17]	Društvo koronarnih bolnikov, zveza, občina, KS, ZD, CKZ [97]
Zračna razdalja od ZD Črnomelj	približno 3,4 km (do vrha)	približno 1,1 km (do začetka)
Najbližji AED v registru (zračno)	2,9 km (TGH Črnomelj)	1,4 km (OŠ Loka, telovadnica)

Razdalje so izračunane iz koordinat OSM in lokacij AED v poročilu. [98] Zračna razdalja do AED ni čas do uporabe. Pri Vražjem kamnu je izmerjen vrh, ne vhod na stezo.

Viri

Brošura CKZ in spletna stran CKZ sta uradni viri ZD. Spletna stran Srčne poti je predstavitvena stran, ki navaja sodelujoče. Članek Radia Odeon je sekundarni vir in povzema KS. Nobeden od virov ne meri, koliko ljudi stezi uporablja in s kakšnim učinkom.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Trasa trim steze ni dokumentirana	GPX še ni; v OSM trase ni. [98]
Stanje postaj po letu 2021 ni znano	Zadnji vir o ureditvi je iz aprila 2021. [99]
Ni podatkov o uporabi	Število obiskovalcev in udeležencev vadb ni objavljeno.
AED ni ob začetku poti	Najbližji AED v registru je 1,4 km oziroma 2,9 km zračno.

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
KS Črnomelj	Kdaj bo GPX trim steze na voljo in kako dolga je steza? Datoteka GPX in opis.
KS Črnomelj	Kdaj so bile vadbene postaje zadnjič pregledane za varnost? Zapisnik pregleda.
CKZ	Ali CKZ izvaja vodene vadbe na trim stezi in kako pogosto? Urnik in število udeležencev.
CKZ	Ali brošura temelji na testiranju s starejšimi uporabniki? Opis priprave.
Društvo koronarnih bolnikov	Koliko članov uporablja Srčno pot in ali organizira skupinske pohode? Letni podatki.
ZD Črnomelj	Ali zdravniki koronarnim bolnikom po rehabilitaciji priporočajo Srčno pot? Opis poti napotitve.
Občina	Ali je ob začetku poti ali stezi načrtovan javno dostopen AED? Načrt in lokacija.
Občina	Kdo vzdržuje oznake, klopi in kotičke za sproščanje na Srčni poti? Dogovor o vzdrževanju in sredstva.
Turistične in informacijske službe	Ali so poti vključene v javne zemljevide (npr. Slovenia Outdoor, OSM)? Seznam objav.
Šole	Ali šole uporabljajo stezo za pouk športa ali naravoslovne dneve? Število obiskov.

Tveganja

Vaje na postajah brez nadzora so lahko zahtevne za ljudi s srčnimi boleznimi ali težavami z ravnotežjem. Brošura in spletna stran ne nadomeščata posveta z zdravnikom. Oznaka »srčna pot« ne pomeni, da je pot medicinsko nadzorovana.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	KS objavi GPX trim steze; poročilo ga vključi v analizo tras.	Do 5 ur dela.	Popolnejši pregled; brez tveganja. GPX objavljen.
0–12 mesecev	CKZ in Društvo koronarnih bolnikov organizirata mesečne vodene pohode po Srčni poti.	Obstoječi programi CKZ in društva.	Več varne vadbe; tveganje nizke udeležbe. Število udeležencev po 6 in 12 mesecih.
1–3 leta	Javno dostopen AED ob začetku Srčne poti ali trim steze, vključen v evidenco dispečerske službe.	Načrtovalna ocena 1.500–2.500 EUR z omarico; občina, KS ali donatorji.	Hitrejša pomoč; tveganje nevzdrževane naprave. AED v evidenci DSZ, letni pregled.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
3–10 let	Redno vzdrževanje in dostopnost poti za ljudi z omejeno gibljivostjo, kjer je mogoče.	Po projektu.	Dostop za več ljudi; tveganje stroškov. Dolžina dostopnih odsekov.

Uredniške ocene za ta dodatek ne podajamo. Gre za dopolnitev poglavja o poteh, ne za samostojno temo s podatki o izidih.

Primerjave

Srčne poti koronarnih društev obstajajo tudi drugod po Sloveniji, vendar v tem pregledu niso primerjane.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
GPX trim steze	Ko prispe, ga dodati v `viri/gpx/pohodnistvo/` in v analizo tras.
Uporaba poti	Podatki KS, CKZ in društva.

PODROČJE 07 / ČRNOMELJ

Športne dejavnosti

Poiščite vrsto dejavnosti in izvajalca. Ohranjeni pregled objav ni potrjen tekoči urnik; cene, prosta mesta in dostopnost ostajajo neznani, kjer ni dokaza.

09 Športi in vadba v občini

> Pregled je ohranjen iz izdaje 21. 9. 2026 in vključuje tudi objave iz 2025. Tekoči urniki, cene in prosta mesta niso na novo potrjeni.

Spodaj je **dokazljiv nabor, ne zagotovljeno izčrpen register vseh treningov 2026/27**. OŠ Loka je septembra 2025 poimensko dokumentirala deset izvajalcev popoldanske vadbe za otroke. To je dokaz lokalne ponudbe v 2025; aktualne starostne skupine, urnike, cene in prosta mesta je treba preveriti pri izvajalcu. **[100]**

Prikazano: 16 od 16 vrst dejavnosti. Objave ne potrjujejo današnjega urnika ali prostih mest.

Cena, prosti termini in gibalna dostopnost niso sistematično dokumentirani. Ponudbe zato ne filtriramo po domnevnih vrednostih.

ŠPORT / VADBA	IZVAJALEC	KAJ POTRJUJE VIR
Nogomet	Nogometna šola Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba za otroke, šolski pregled 2025. **[100]**
Rokomet	RK Črnomelj	Lokalna vadba 2025 in lastna klubska stran. **[100][101]**
Odbojka	Odbojkarski klub Črnomelj	Lokalna popoldanska vadba, šolski pregled 2025. **[100]**
Košarka	KK Kolpa Črnomelj; ŽKK Črnomelj	KK Kolpa je septembra 2025 objavil vpis in treninge v OŠ Mirana Jarca. ŽKK je v občinskem imeniku; njegov tekoči urnik ni preverjen. **[102][103]**
Atletika	Atletski klub Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba 2025. **[100]**
Tenis	TK Loka	Lastna stran ponuja rekreacijo, rezervacijo igrišč in belokranjsko ligo; termina šole tenisa za novo sezono ne potrjuje. **[104]**
Ju-jitsu	ŠD Ninja Črnomelj	Vadba za otroke 2025; lastna stran opredeli borilno veščino. **[100][105]**
Športno plezanje	Športno-plezalni odsek PD Črnomelj	Lokalna popoldanska vadba 2025. **[100]**
Lokostrelstvo	Lokostrelski klub Paradoks	Lokalna popoldanska vadba 2025. **[100]**
Kegljanje	Kegljaški klub Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba 2025. **[100]**
Twirling	Twirling klub Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba 2025. **[100]**

ŠPORT / VADBA	IZVAJALEC	KAJ POTRJUJE VIR
Ples	Plesni studio Novo mesto – lokalne vadbe	Šola ga izrecno navaja med izvajalci vadbe v Črnomlju; ime Novo mesto ne pomeni, da vadba poteka samo tam. [100]
Jahanje	Horse Resort Stariha, Vražji kamen	Šola jahanja za otroke in odrasle, začetni in nadaljevalni tečaji. [106]
Praktično streljanje	Klub praktičnega streljanja Črnomelj	Lastna stran opisuje klub in strelišče v TRIS Kanižarica. Pogoje vključitve preveriti pri klubu. [107]
Fitnes, osebna in funkcionalna vadba, pilates	RC Simon, Don Vito Gym, Sportas	Objavljene lokalne ponudbe; posamezno vrsto in termin preveriti pri konkretnem izvajalcu. [108][109][110][111]
Nordijska hoja in vadba za zdravje	CKZ	Programi gibanja, testiranja in nordijske hoje; to niso vsi tekmovalni športni programi. [112]

DODATNA DEJAVNOST	STOPNJA POTRDITVE
Namizni tenis, tajski boks, šah, kolesarstvo, planinstvo, windsurfing in kasaštvo	Občinski imenik vsebuje ustrezna društva oziroma klube, vendar **tekoči lokalni treningi niso preverjeni**. Ne vključujemo jih v potrjeno ponudbo rednih treningov 2026/27. [103]
Kolesarski izleti, pohodi in tek v naravi	Občina napoveduje dogodke septembra–novembra 2026. Posamezna napoved dokazuje priložnost za udeležbo, ne celoletne šole oziroma treninga. [113]
Plavanje, veslanje / kajak / kanu / SUP, badminton, joga in drugi programi	Ta pregled nima dovolj aktualnih podatkov o **redni strokovno vodeni lokalni vadbi**. Možnost rekreacije ali obstoj igrišča/reke ne zadoščata za trditev, da poteka šola ali trening. Status: Unverified.

Priložnost za neposredno preverbo ponudbe je občinska napoved **»Športaj v mestu 2026«, 23. 9. ob 16.00 v Športnem parku Loka**. Ob preseku raziskave je to prihodnji dogodek, ne že izvedena predstavitev. [113]

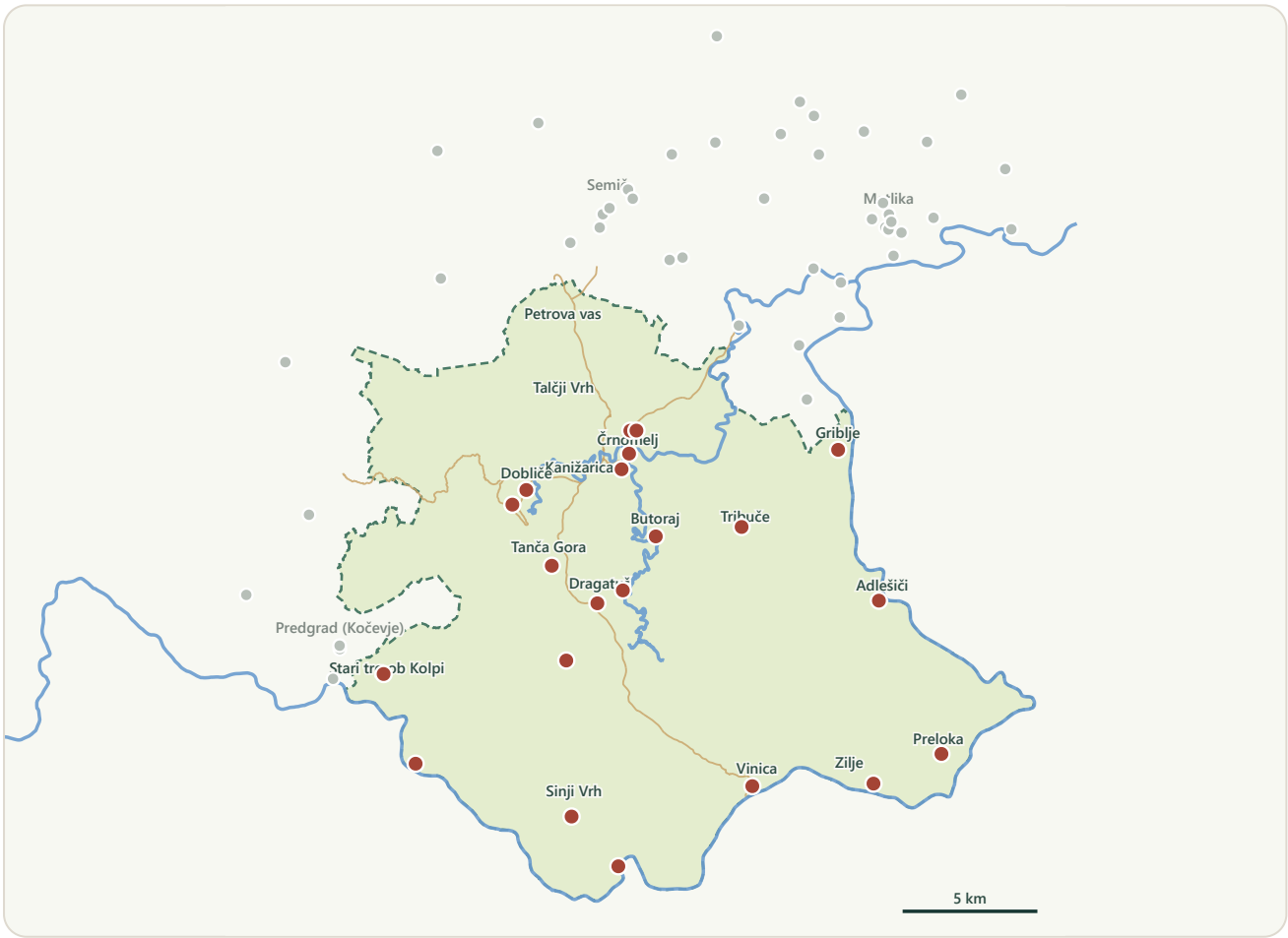
AED-ji

Lokacije iz ohranjenega registra. Javno navedena lokacija ne pomeni potrjene dostopnosti 24 ur na dan ali znanega odzivnega časa.

25 Lokacije defibrilatorjev (AED) in dostopnost

> Namestitev znotraj ali zunaj objekta ter urnik dostopnosti nista dokumentirano preverjena za posamezne naprave. Obnova iz ohranjenega poročila: 25. 9. 2026; to ni datum terenskega preverjanja.

Zemljevid prikazuje 67 lokacij avtomatskih zunanjih defibrilatorjev iz datoteke, ki jo je dodal naročnik poročila. Znotraj meje Občine Črnomelj jih je **21**; ostale so v sosednjih občinah in so prikazane zbledelo. **V ohranjenem uporabniškem popisu so AED-ji v občini Črnomelj označeni kot javno dostopni; urnik ni preverjen.** Podatek o javni dostopnosti je dopolnjen po sporočilu naročnika z dne 23. 9. 2026. [114]



Meja občine, Kolpa, glavne ceste in naselja: OpenStreetMap (ODbL), lokalna kopija viri/osm-crnomelj.json. Lokacije defibrilatorjev: viri/AEDs.xlsx. Zemljevid deluje brez omrežja.

Kako dobra je pokritost?

KAZALNIK	VREDNOST	POMEN
Defibrilatorji v datoteki	67	Datoteka zajema tudi sosednje občine (Metlika, Semič, Predgrad).
Znotraj meje Občine Črnomelj	**21**	Razvrščeno po meji občine iz OpenStreetMap, ne po naslovu.
Od tega v gasilskih domovih ali gasilskih vozilih	14 od 21	Tudi ti AED so javno dostopni; popravek naročnika z dne 23. 9. 2026.
Naselja (OSM) v občini z defibrilatorjem znotraj 1 / 3 / 5 km zračne črte	30 % / 85 % / 100 %	Od 111 naselij v občini, upoštevani so vsi defibrilatorji iz datoteke, tudi v sosednjih občinah; zračna razdalja, ne čas vožnje ali odzivnost reševalcev.
Naselja najdlje od najbližjega defibrilatorja	Bojanci (4.8 km); Rodine (4.4 km); Naklo (3.9 km); Nova Lipa (3.8 km); Rožanec (3.8 km); Stara Lipa (3.6 km)	Kandidati za preverjanje potrebe, ne dokaz vrzeli.

> **Omejitve.** Javna dostopnost AED v občini Črnomelj je navedena po popravku naročnika. Pregled ne vključuje terenske preverbe delovanja naprav ali datumov servisa. Podatek o javni dostopnosti ne opredeljuje dostopa 24 ur na dan. Za AED v sosednjih občinah s tem popravkom dostopnost ni določena. Razdalje so zračne in ne upoštevajo terena ali cest. Ob srčnem zastoju najprej pokličite 112; reševalec lahko usmeri do najbližjega defibrilatorja.

▼ Seznam vseh 67 lokacij (iskanje in prenos)

LOKACIJA	NASLOV	VRSTA	OBČINA	JAVNA DOSTOPNOST	KOORDINATE
Damelj	Damelj 30	Druga lokacija	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.43309, 15.18778
Gasilski dom Adlešiči	Adlešiči 13 B	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.52183, 15.31204
Gasilski dom Butoraj	Butoraj 29	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.54331, 15.20563
Gasilski dom Dobliče	Dobliče 22	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.55881, 15.14389
Gasilski dom Dragatuš	Dragatuš 19	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.52095, 15.17779

LOKACIJA	NASLOV	VRSTA	OBČINA	JAVNA DOSTOPNOST	KOORDINATE
Gasilski dom Griblje	Griblje 35 B	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.57223, 15.29261
Gasilski dom Preloka	Preloka 17	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.47064, 15.34188
Gasilski dom Radenci	Srednji Radenci 6	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.46739, 15.09112
Gasilski dom Sinji vrh	Sinji vrh 1	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.44971, 15.16547
Gasilski dom Tanča Gora	Tanča Gora 17 B	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.53350, 15.15606
Gasilski dom Tribuče	Tribuče 34a	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.54646, 15.24654
Gasilski dom Vinica	Vinica 44	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.45986, 15.25170
Gasilski dom Zapudje	Zapudje 4	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.50184, 15.16297
Gasilski dom Zilje	Zilje 37	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.46072, 15.30947
Gasilski dom Črnomelj	Belokranjska cesta 10 (intervencijsko vozilo)	Gasilski dom ali vozilo	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.57859, 15.19351
Grič pri dobličah	Na privat stavbi	Druga lokacija	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.55389, 15.13723
Občina Črnomelj	Trg svobode 3	Druga lokacija	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.57096, 15.19290

LOKACIJA	NASLOV	VRSTA	OBČINA	JAVNA DOSTOPNOST	KOORDINATE
Osnovna šola Loka telovadnica	Kidričeva ulica 18a	Druga lokacija	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.56570, 15.18933
TGH Črnomelj	Zadružna cesta 14a	Druga lokacija	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.57865, 15.19643
Turizem Malerič	Podlog 3c	Druga lokacija	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.52525, 15.18992
UNIOR d.d. obrat Stari trg ob Kolpi	Deskova vas 1A	Druga lokacija	Občina Črnomelj	V starem registru označen kot javno dostopen; urnik ni preverjen	45.49732, 15.07584
AVTO BUKOVEC avtokleparstvo in Avtoličarstvo d.o.o.	Vavpča vas 48	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64646, 15.17891
Beti Metlika	Tovarniška 2	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64474, 15.32282
Brezovica pri Predgradu 1	Zunaj v omarici na privatni hiši	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.55051, 15.04025
CŠOD-dom Lipa	Črmošnjice 27	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.67206, 15.10146
Gasilskega doma Predgrad	Predgrad 41	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.50679, 15.05486
Gasilski dom Božakovo	Božakovo 24	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64588, 15.37522
Gasilski dom Dobravice	Krivoglavice 10	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.63276, 15.28083
Gasilski dom Dragomlja vas	Dragomlja vas 15a	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.67769, 15.26524
Gasilski dom Drašiči	Drašiči 35	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.66600, 15.37233
Gasilski dom Grabrovec	Grabrovec 3B	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.67851, 15.30493
Gasilski dom Gradnik	Praproče 2	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.67486, 15.23407

LOKACIJA	NASLOV	VRSTA	OBČINA	JAVNA DOSTOPNOST	KOORDINATE
Gasilski dom Jugorje	Jugorje pri Metliki 5A	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.71037, 15.23477
Gasilski dom Koprivnik	Koprivnik 31	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.60147, 15.02895
Gasilski dom Kot-Brezje	Spodnje Gorenjce 32	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64138, 15.16490
Gasilski dom Krasinec	Krasinec 3B	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.58901, 15.27774
Gasilski dom Križevska vas	Križevska vas 2A	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.63703, 15.31901
Gasilski dom Krvavčji vrh	Krvavčji Vrh 11	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.65612, 15.25732
Gasilski dom Lokvica	Dolnja Lokvica 2A	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.67084, 15.28343
Gasilski dom Otok	Otok 1A	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.61646, 15.29340
Gasilski dom Podzemelj	Podzemelj 16B	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.60709, 15.27397
Gasilski dom Primostek	Primostek 1	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.62809, 15.29394
Gasilski dom ROŽNI DOL	ROŽNI DOL 5A	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.68138, 15.14959
Gasilski dom Radovica	Radovica 24B	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.69085, 15.35136
Gasilski dom Rosalnice	Rosalnice 45	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64973, 15.33810
Gasilski dom Slamna vas	SLAMNA VAS 8A	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.67506, 15.33499
Gasilski dom Stranska vas	Praprot 15	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.63563, 15.21226
Gasilski dom Štrekljevec	Štrekljevec 1c	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.67091, 15.21330

LOKACIJA	NASLOV	VRSTA	OBČINA	JAVNA DOSTOPNOST	KOORDINATE
Gasilsko vozilo PV1 – PGD Metlika	Črnomaljska cesta 3	Gasilski dom ali vozilo	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64649, 15.31511
Gradac 117	—	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.61373, 15.24523
Iskra	Vajdova ulica 71	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.65913, 15.19242
Jeklostil d.o.o.	Krupa 7	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.63645, 15.21837
Kulturni center Semič	Prosvetna ulica 4	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.65090, 15.18038
Lovski dom Predgrad	Predgrad 29	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.50565, 15.05495
Planinski dom na Mirni gori	Planina 6	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.62944, 15.10311
Podružnična šola Suhor	Šolska ulica 7	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.68844, 15.27434
Prva dolenjska hranilnica	TRG SVOBODE 7	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.65083, 15.31682
Spar Metlika	Cesta XV. brigade 27	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64925, 15.30876
Spodnji Log 7	Privat hiša	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.52376, 15.01034
TPC Gala SKB banka	Naselje Borisa Kidriča 9	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64554, 15.31678
TPV d.o.o.	PE Suhor	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.68377, 15.28109
Tilija	Naselje Borisa Kidriča 4	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64580, 15.31659
Turistična kmetija Majerle	Dol 7	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.49572, 15.05168
Unitplast D.O.O.	Obrtna cona 16	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.65610, 15.19465

LOKACIJA	NASLOV	VRSTA	OBČINA	JAVNA DOSTOPNOST	KOORDINATE
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ	Vajdova Ulica 9	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.65296, 15.18354
Zdravstveni dom Metlika	Cesta bratstva in enotnosti 71	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.64838, 15.31797
Športna dvorana Osnovne šole Metlika	V športni dvorani v omarici	Druga lokacija	Sosednja občina	Ni potrjenega podatka o časovni dostopnosti	45.65468, 15.31403

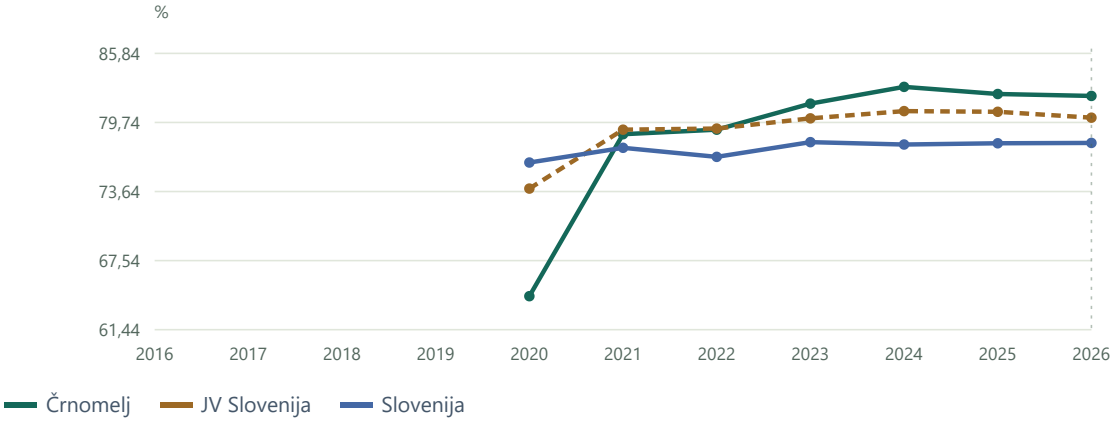
Preventiva in podpora

Presejanje, zdravstvene storitve in podporne mreže. Kontakti in ponudba so navedeni po objavljenih virih, brez telefonske potrditve.

19 Presejanje in dostopnost preventive

Presejanost v programu DORA

K3.4 · leto objave podatkov



Izdaja 2026: januar 2024–oktober 2025; manjkajoče vrednosti niso ničle. [3]

▼ Odpri podatkovno tabelo

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	—	—	—
2017	—	—	—
2018	—	—	—
2019	—	—	—
2020	64,4	73,9	76,2
2021	78,7	79,1	77,5
2022	79,1	79,2	76,7
2023	81,4	80,1	78
2024	82,88	80,74	77,79
2025	82,25	80,68	77,9
2026	82,08	80,16	77,93

DORA je od izdaje 2021 nad slovenskim povprečjem; tudi Svit v zadnji izdaji dosega višjo odzivnost. To je uspeh širšega sistema vabljenja, izvajalcev in prebivalcev. Iz teh podatkov ni mogoče izločiti samostojnega prispevka CKZ. [3]

KAZALNIK, IZDAJA 2026	ČRNOMELJ / SLOVENIJA	DOKAZ IN PREDNOSTNI ODZIV
Svit	68,14 / 64,94 %	NIJZ označuje ugodno razliko. Ohraniti podporo pri odzivu in preveriti skupine z nižjo udeležbo.
ZORA	71,96 / 72,48 %	Majhna, statistično neznačilna razlika. Ugotoviti razloge za neodziv posameznih skupin.
HPV	40,7 / 46,3 %	Šestošolska kohorta; statistično neznačilna razlika. Preveriti informiranje staršev in dostop do cepljenja.
Pnevmokok	44,4 / 55,2 %	Otroci, rojeni 2022; NIJZ označuje neugodno razliko. Pediatrija naj preveri zamujene odmerke in razloge.
OMR / DTP-Hib-IPV-hepB	88,10 / 86,94 % 83,33 / 85,61 %	Pri obeh razlika ni statistično značilna; rezultat nad povprečjem še ne pomeni zadostne zaščite.
Umivanje zob	63,0 / 68,7 %	Anketni kazalnik 2024; razlika ni statistično značilna. Nadaljevati praktično podporo ustni higieni.
Zlomi kolka, 65+	6,5 / 6,0 na 1.000	Standardizirane bolnišnične obravnave 2020–2024; razlika ni statistično značilna. Preveriti padce in dostop do vadbe ravnotežja.
Pomoč na domu, 65+	1,0 / 1,8 %	NIJZ označuje neugodno razliko. Občina in izvajalec naj preverita potrebe, čakalni seznam in ovire.

Natančne decimalke so iz Excelovih nizov; za dodatne kazalnike so prikazane zaokrožene vrednosti iz uradnega profila, str. 4. Statistične oznake so preverjene tudi vizualno. [3][2]

Profil 2026 posebej izpostavlja demenci prijazno skupnost. Smiselna lokalna dopolnitev so usposobljeni javni uslužbenci in podpora svojcem; iz profila ni mogoče izračunati števila oseb z demenco v Črnomlju. [2]

Referenčne ambulante: kaj odkrijejo preventivni pregledi

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Diplomirane medicinske sestre v ambulantah družinske medicine ZD Črnomelj so v letu 2025 povabile 1.645 oseb in opravile preventivni pregled pri 1.366 (odziv 83 %). Pri 923 so odkrile dejavnike tveganja, na novo pa 236 primerov povišanega krvnega tlaka, 165 depresije, 144 sladkorne bolezni, 67 osteoporoze in 20 kronične obstruktivne pljučne bolezni. Brez dejavnikov tveganja je bilo le 37 pregledanih (2,7 %). [5]

To je eden redkih lokalnih podatkov o tem, kako zdravi so odrasli v Črnomlju. A to ni vzorec prebivalstva, temveč povabljeni in pregledani, zato odstotkov ne smemo prenesti na vse prebivalce. Obenem Cochranov pregled 17 raziskav kaže, da sistematični splošni pregledi odraslih ne zmanjšajo umrljivosti, povečajo pa število novih diagnoz. [115] Vrednost pregledov je torej odvisna od tega, kaj sledi po odkritju.

Trenutno stanje

Do preventivnega pregleda so upravičeni vsi odrasli od 30. leta starosti, vsakih pet let. Ljudje s sladkorno boleznijo, debelostjo, družinsko obremenjenostjo za bolezni srca ali povišanim holesterolom lahko pridejo prej. Pregled vključuje krvne preiskave, meritve, pogovor o navadah in vprašalnik o depresiji; po potrebi napotitev v CKZ. [15] Projekt referenčnih ambulant je trajal od 2011 do 2018, od 2019 se ambulante imenujejo ambulante družinske medicine. [116]

ZD Črnomelj na spletni strani navaja referenčne ambulante z urniki, ki vključujejo popoldanske termine. [16]

Ključna dejstva

Rezultati preventivnih pregledov ZD Črnomelj, 2025

PODATEK	ŠTEVILO	DELEŽ PREGLEDANIH
Povabljeni	1.645	–
Pregledani	1.366	83,0 % povabljenih
Z dejavniki tveganja	923	67,6 %
Na novo odkrit povišan krvni tlak	236	17,3 %
Na novo odkrita depresija	165	12,1 %
Na novo odkrita sladkorna bolezen	144	10,5 %
Na novo odkrita osteoporoza	67	4,9 %
Na novo odkrita KOPB	20	1,5 %
Brez dejavnikov tveganja	37	2,7 %

Vir: letno poročilo ZD 2025, str. 31 (natisnjena). [5] Deleži so naš izračun. Poročilo ne navaja, ali so »novoodkrite« bolezni potrjene diagnoze ali sum, koliko pregledanih je iz Semiča, niti kaj se je z njimi zgodilo po pregledu.

Ali je obseg pregledov zadosten?

V Občini Črnomelj živi 10.265 prebivalcev, starih 30 let ali več (1. 1. 2026). [58] Da bi vsak prišel na pregled vsakih pet let, bi bilo potrebnih okoli 2.050 pregledov na leto samo za Črnomelj. ZD je leta 2025 opravil 1.366 pregledov za Črnomelj in Semič skupaj. [5] Pregledi v ambulantah koncesionarjev niso vključeni, zato je to le načrtovalna ocena, ne izmerjena pokritost.

Kaj kažejo raziskave

RAZISKAVA	UGOTOVITEV	POMEN ZA ČRNOMELJ
Krogsbøll in sod., 2019 (Cochrane, 17 RCT, 251.891 udeležencev) [115]	Splošni pregledi imajo malo ali nič učinka na celokupno umrljivost in umrljivost zaradi raka (visoka gotovost) ter verjetno na srčno-žilno umrljivost; povečajo pa število novih diagnoz in so lahko vzrok nepotrebnih preiskav.	Pregledi niso cilj sami po sebi. Pomembni so nadaljnja obravnava, zdravljenje odkritega krvnega tlaka in depresije ter spremljanje izidov.

Slovenski preventivni pregledi niso povsem enaki raziskovanim »splošnim pregledom«, saj so povezani z obravnavo kroničnih bolezni in CKZ. Zato izsledka ne smemo razumeti kot dokaza, da so nepotrebni, temveč kot opozorilo, da je treba meriti, kaj se zgodi po pregledu.

Viri

Letno poročilo ZD je uradni samoporočani vir. NIJZ je vir za pravila programa. Cochrane je prebran kot povzetek v preprostem jeziku.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Veliko novo odkritih bolezni	236 povišanega tlaka, 165 depresije, 144 sladkorne bolezni v enem letu. [5]
Nadaljnja obravnava ni opisana	Ni podatkov, koliko novo odkritih je začelo zdravljenje ali se vključilo v CKZ.
Obseg verjetno ne zadošča za petletni cikel	Okoli 1.366 pregledov proti okvirno 2.050 potrebnim samo v Črnomlju.
Depresija ob pomanjkanju psihologov	165 novih primerov ob omejeni psihološki pomoči za odrasle.

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Vodstvo ZD	Koliko novo odkritih bolnikov s povišanim tlakom, sladkorno boleznijo in depresijo je v 6 mesecih začelo zdravljenje? Agregirani podatki.
Vodstvo ZD	Ali so »novoodkrite« bolezni potrjene diagnoze ali sum? Opis meril.
Vodstvo ZD	Kakšen delež prebivalcev, starih 30 let ali več, je imel pregled v zadnjih petih letih? Pokritost po ambulantah.
Vodstvo ZD	Kako je razdeljeno delo med ambulantami za neopredeljene in preventivnimi pregledi? Kadrovski podatki.
CKZ	Koliko pregledanih je bilo napotenih v CKZ in koliko jih je prišlo? Napotitve in udeležba.
Psihološka služba	Kam se napotijo odrasli z novo odkrito depresijo in kako dolgo čakajo? Pot in čakalna doba.
Koncesionarji	Koliko preventivnih pregledov opravijo in kakšni so rezultati? Letni podatki.

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
NIJZ	Kakšni so primerljivi deleži novo odkritih bolezni v Sloveniji in regiji? Podatki PZVO.
Občina	Ali občina podpira vabila na pregled v oddaljenih krajih (prevoz, terenski dnevi)? Programi.
Svet zavoda	Ali bo ZD v letnem poročilu objavljal tudi izide po pregledih? Sklep.

Tveganja

Novo odkrite bolezni povečajo potrebe po obravnavi v že preobremenjenih ambulantah. Pregledi lahko vodijo v nepotrebne preiskave in skrb. Odstotkov iz pregledov ne smemo predstaviti kot razširjenosti bolezni med prebivalci.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	ZD v letnem poročilu doda izide: delež novo odkritih, ki so začeli zdravljenje ali se vključili v CKZ.	10–20 ur; obstoječi podatki.	Pregled nad koristjo; tveganje dodatnega administrativnega dela. Objava v letnem poročilu 2026.
0–12 mesecev	Jasna pot za odrasle z depresijo (psiholog, CKZ, psihiatrija).	Obstoječe službe.	Manj izgubljenih bolnikov; tveganje čakalnih vrst. Čas do prve obravnave.
1–3 leta	Prednostno vabljenje ljudi z večjim tveganjem in tistih, ki pregleda še niso imeli.	Obstoječi program.	Več koristi na pregled; tveganje izključitve. Delež prvič pregledanih.
3–10 let	Kadrovska krepitev ambulant z diplomiranimi medicinskimi sestrami, kot predvideva NIJZ.	Državni program.	Petletni cikel za vse; tveganje kadrov. Pokritost 30+ v 5 letih.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	4: ZD objavlja število pregledov in odkritih bolezni.
Dostop in razpoložljivost	3: dober odziv, popoldanski termini; obseg verjetno ne zadošča za petletni cikel.
Usklajenost s potrebami	4: pregledi odkrivajo bolezni, ki so v občini pogoste.
Dokazna podlaga in spremljanje	2: ni podatkov o izidih po pregledu; raziskave dvomijo o koristi splošnih pregledov brez nadaljnje obravnave.
Pravičnost in doseg	3: vabila dosežejo mnoge, oddaljeni kraji niso posebej obravnavani.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	3: program je sistemski, kadri so omejeni.
Izvedljivost	4: dodajanje izidov v poročilo je preprosto.

Izračun: (4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 3 + 4) / 7 = **3,29/5,** ⚠️.

Primerjave

Primerljivi podatki za Slovenijo so v zbirki NIJZ PZVO, a v tem pregledu niso bili pridobljeni. **[116]**

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Nacionalna primerjava	Podatki NIJZ PZVO za Slovenijo in JV regijo.
Izidi po pregledu	Uradni podatki ZD.

03 Zdravstveni dom Črnomelj: zdravljenje in preventiva

ZD Črnomelj je javni zavod z ustanoviteljico Občino Črnomelj; izvaja dejavnost tudi za Semič in deluje v Črnomlju, Semiču ter Vinici. Spodaj so podatki za zaključeno leto 2025, ne nepotrjena ocena poslovanja v 2026. **[5]**

PODATEK ZA 2025	VREDNOST	RAZLAGA
Prihodki / odhodki	9.753.579 € / 9.457.216 €	Prihodki so glede na 2024 višji za 17,94 %, odhodki za 18,67 %. Prejšnja navedba 15,8 % rasti prihodkov je popravljena.
Presežek	296.363 € pred davkom 294.256 € po davku	Poslovni izid celega zavoda ne pove, koliko stane CKZ.
Zadovoljstvo pacientov	4,57 / 5; 143 anket	Prostovoljni odziv uporabnikov, brez dokaza reprezentativnosti za vse paciente; ni ocena CKZ.
Kadrovska težava	Pomanjkanje zdravnikov, posebej v dodatni ambulanti	Zavod poroča o težavah pri izvajanju programov. Potrebujemo podatke o čakanju, neopredeljenih osebah in obremenitvah po lokacijah.
Načrt programa CKZ	Plan 2025 vključuje prehrano, gibanje, stres, kajenje, sladkorno bolezen in družinsko obravnavo.	Načrtovane delavnice so cilji, ne avtomatično dokaz dejanske izvedbe vsake skupine. **[71]**

Viri: letno poročilo 2025, natisnjene str. 24–26 in 31; finančni načrt 2025, str. 17. [5][71]

Vodenje zavoda in razpoložljivost ambulant: posnetek 25. 9. 2026

Po medijskem poročanju je svet zavoda aprila 2026 začel postopek predčasne razrešitve dotedanjega direktorja, ker Zakon o zdravstveni dejavnosti za direktorja zdravstvenega doma zahteva najmanj drugostopenjsko izobrazbo; ministrstvo je februarja od ZD in občine zahtevalo tudi pojasnila o tržni dejavnosti in vnosu podatkov v zbirko NIJZ. [117] Uradna stran ZD 25. 9. 2026 navaja v. d. direktorja, ki je hkrati strokovna vodja zavoda. [118] Po *neuradnem* medijskem poročilu z 23. 9. 2026 je svet zavoda po razpisu z dne 13. 8. 2026 (štiri prijave) izbral novega direktorja; imenovanje po navedbi članka postane dokončno s soglasjem ustanoviteljice ali po poteku 60-dnevnega roka. [119] Uradne objave izbire ob zajemu nismo našli, zato je ne štejemo za potrjeno.

PODROČJE	OBJAVA ZD 25. 9. 2026	KAKO RAZUMETI
Družinska medicina	Tri ambulante za neopredeljene (SA 2 in SA 3 v Črnomlju, SA Semič 2): »nadomeščanje po razporedu«.	Ambulante so namenjene ljudem brez izbranega zdravnika. To je skladno z vrzeljo 2,00 tima iz programa 2026, ne pove pa števila neopredeljenih oseb ali čakalnih dob.
Otroci in mladi	Otroška ambulanta z nekdanjo nosilko in zobna ambulanta za mlade 1: nadomeščanje po razporedu.	Stalni nosilec ni objavljen; obseg nadomeščanja v urah ni znan.
Zobozdravstvo	Ambulanta za odrasle 4 in ortodontija: nadomeščanje po razporedu; Vinica: odsotnost 22. 9.–30. 10.	Za Vinico to pomeni daljšo prekinitev lokalne zobozdravstvene ambulante; nadomestna lokacija ni navedena.
Duševno zdravje	Ena od treh navedenih psihologinj: »odsotna do nadaljnjega«.	Zmanjšana zmogljivost psihološke obravnave; čakalna doba ni objavljena.
Medicina dela	»Do nadaljnjega ne dela«.	Delodajalci in delavci morajo preventivne preglede opraviti drugje; vpliv na dostop ni izmerjen.

Vir za preglednico: [120] Omejitve: stran je tekoči razpored in ne kadrovska evidenca. Enkratni posnetek ni trend; za primerjavo ga je treba ponavljati (npr. mesečno) in dopolniti s podatki ZZZS o neopredeljenih osebah ter čakalnih dobah.

---

04 Zdravstveni kader: obseg in metoda popisa

Presek javnih virov: 21. september 2026. Najbolj oprijemljiv primanjkljaj je v družinski medicini: ZD v programu 2026 navaja **7,53 priznanega in 5,53 zagotovljenega tima**, torej vrzel **2,00 tima** za območje njegovega delovanja, ki vključuje tudi Semič. To ni izračun iz evropskega povprečja. [121]

Za psihološko pomoč so v ZD imenovane tri psihologinje, vendar ima ena objavljeno dolgotrajnejšo odsotnost. Dve imata objavljen urnik, kar še ne pomeni dveh polnih zaposlitev, namenjenih eni ambulanti. [122] Popolnega občinskega seznama vseh trenutno dejavnih zasebnikov, njihovih ur in prostih mest iz pregledanih virov ni mogoče sestaviti. Spodnje številke zato ločujejo potrjen podatek, dokumentirani minimum in neznano skupno število.

Pravila štetja oseb, timov in izvajalcev

ENOTA	POMEN IN OMEJITEV
Oseba	Posameznik se šteje enkrat, tudi če dela v CKZ in dispanzerju ali javno in zasebno.
Zaposleni	Zadnji zaključeni kadrovski stanji sta na 31. 12. 2025. Nista seznam prisotnih septembra 2026.
Tim / obseg dela	Financirani oziroma izvajani program. Ni isto kot število zaposlenih ali delež polnega delovnega časa posameznika.
Lokacija	Štejemo kraj obravnave, ne zgolj registriranega sedeža podjetja. Ambulanto v Semiču izločimo iz občine Črnomelj.
Aktivna ponudba	Objavljen urnik oziroma ponudba ob preverbi; telefonska potrditev izvajanja in prostih mest ni bila opravljena.
Šport	Ločimo dokumentirano vadbo, klub iz imenika in posamezen rekreativni dogodek. Vpis društva ni dokaz tekočih treningov.

05 Psihologi, psihiatri in psihoterapija

PROFIL	JAVNI ZAVODI / JAVNA MREŽA	ZASEBNO IN OMEJITVE ŠTETJA
Psihologinje	**3 zaposlene v ZD konec 2025**. Imenovane so Marina Strahinić, Lea Štravs in dr. Sabina Prah; slednja je po obvestilu odsotna do nadaljnjega. Marina in Lea imata objavljen urnik. [5][122]	Celotno število zasebnih psihologov ni potrjeno. Lea Štravs je navedena tudi v CKZ in se ne šteje še enkrat. [112]
Psihiater / nevropsihiater	V pregledanem seznamu ambulant ZD ni ločene psihiatrične ambulante. **DSO objavlja obiske specialista nevropsihiatra vsaka dva tedna po štiri ure**, namenjene stanovalcem doma; ne gre za polno občinsko ambulanto. Ime in aktualna pogodba nista objavljena v uporabljenem viru. [123][124]	Število zasebnih lokalnih psihiatričnih ambulant ni potrjeno. Nezmožnost potrditve ni dokaz, da jih je nič. ZD Metlika ima imenovano psihiatrinjo, vendar je to druga občina. [125]
Psihoterapija	ZD psihologov ne preimenujemo avtomatično v psihoterapevte. Starejši imenik iz 2023 navaja samoplačniško kognitivno-vedenjsko terapijo dr. Sabine Prah; to ni dokaz njene razpoložljivosti v 2026. [126][127]	**Najmanj ena aktualno objavljena lokalna ponudba:** Darinka Jerčinovič, Griblje, ki se predstavlja kot **specializantka logoterapije**, z obravnavami v živo ali na daljavo. To ni potrjen popis vseh dokončno usposobljenih psihoterapevtov. [128]

Pomembna razlika pri besedi »aktivni«: objavljeni septembrski seznam odsotnosti za Marino Strahinić in Leo Štravs navaja tudi 21. in 22. september; dveh rednih urnikov zato ne smemo razlagati kot dveh prisotnih psihologinj na dan te raziskave. Ni preverjeno, kdo ju takrat nadomešča. [127]

POT DO POMOČI	KONTAKT IN OBSEG
Otroci in mladostniki do 21. leta	Psihološka ambulanta ZD Črnomelj: **07 62 05 756**, **psiholog@zd-crnomelj.si**. Objavljen je poseben septembrski urnik naročanja. [122]

POT DO POMOČI	KONTAKT IN OBSEG
Odrasli – preventivna podpora	CKZ: **07 30 61 723** ali **07 62 05 755**, **ckz@zd-crnomelj.si**. Navedeni so programi spoprijemanja s stresom, tesnobo in depresijo ter psihologinja Lea Štravs. Ob naročanju preveriti ustrezen program in možnost individualne obravnave; preventivne delavnice niso enake specialističnemu zdravljenju. [112]
Specialistična psihiatrija v bližini	**ZD Metlika**, Daliborka Radivojević Vučković, dr. med., spec. psih.; **07 369 14 21**, **psihiatrija@zd-metlika.si**. Stran navaja torek 15.00–22.00. Nedatirane navedbe čakalne dobe ne uporabljamo kot potrjenega aktualnega termina. [125]
Zasebna ponudba v Gribljah	Darinka Jerčinovič, specializantka logoterapije; naročanje prek profila Mojpsihoterapevt.si. Objavljena cena je 60 EUR na srečanje; pred naročilom preveriti termin, status usposabljanja in pogoje. [128]

Duševno zdravje mladih

Dopolnitev 25. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Nacionalna raziskava HBSC 2022 kaže poslabšanje duševnega zdravja mladostnikov. Povišano verjetnost depresije je imelo 22 % mladostnikov, starih 11, 13, 15 in 17 let (leta 2018 13 %). Več kot tretjina (35,7 %) je redno, vsak teden, doživljala vsaj dva psihosomatska simptoma. [129] Za Črnomelj primerljive meritve ni, zato nacionalnih odstotkov ne prenašamo na lokalno raven.

Lokalno pomoč nudi psihološka ambulanta ZD Črnomelj za otroke in mlade do 21. leta. Po uradni strani so navedene tri psihologinje, ena je bila 25. 9. 2026 odsotna do nadaljnjega. [19] [120] Za zahtevnejšo obravnavo je pristojen Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) v Novem mestu. [20]

Trenutno stanje

V programu dela za leto 2026 ima ZD v dispanzerju za mentalno zdravje priznana 2 tima: 1,6 tima po točkah ZZZS in 0,4 tima v pavšalu na podlagi sodelovanja s CDZOM. [121] Po letnem poročilu 2025 je bil del programa dispanzerja (1,33 tima po točkah in 0,33 tima pavšala) od 1. 4. do 31. 12. 2025 začasno prenesen na ZD Trebnje. [5] Poročilo razloga ne navaja. ZD med deficitarnimi kadri navaja tudi psihologe in ima specializantko klinične psihologije. [121]

Ključna dejstva

Nacionalni kazalniki HBSC 2022 (11–17 let)

KAZALNIK	VREDNOST	OPOMBA
Občutki osamljenosti v zadnjem letu	vsak šesti mladostnik	Več pri dekletih ter 15- in 17-letnikih. [129]
Redno vsaj dva psihosomatska simptoma	35,7 %	Najpogosteje nervoza, nespečnost, razdražljivost. [129]
Visoka stopnja simptomov anksioznosti	skoraj 7 %	Več pri dekletih in starejših. [129]

KAZALNIK	VREDNOST	OPOMBA
Povišana verjetnost depresije (WHO-5)	22 % (2018: 13 %)	Presejalni indeks, ne diagnoza. [129]

Lokalni kazalniki NIJZ (vse starosti)

KAZALNIK	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	OBDOBJE IN ZNAČILNOST
Umrljivost zaradi samomora	17 na 100.000	18 na 100.000	Povprečje 2020–2024, standardizirano; ni statistično značilne razlike. [2]
Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj	15,6 na 100	14,5 na 100	Leto 2024, standardizirano; značilno različno, želene smeri ni mogoče enoznačno določiti. [2]

Kazalnika veljata za vse starosti in nista meri duševnega zdravja mladih. Delež prejemnikov zdravil ni delež obolelih.

Kam po pomoč

SLUŽBA	ZA KOGA	VIR
Psihološka ambulanta ZD Črnomelj	Otroci in mladi do 21. leta; naročanje po telefonu ali e-pošti	[19]
CDZOM Novo mesto	Otroci, mladostniki in starši; timska obravnava	[20]
Psihiatrična obravnava, SB Novo mesto	Prvi pregled: 145 čakajočih, 56 nad dopustno dobo (16. 9. 2026)	[130]

Povezava s spanjem in digitalnimi navadami je opisana v posebnem zavihku (nespečnost je med najpogostejšimi psihosomatskimi simptomi).

Viri

HBSC je nacionalna raziskava z reprezentativnim vzorcem, prebrana v objavi NIJZ. Podatki o ZD so iz uradne strani, letnega poročila in programa dela. Lokalne meritve počutja mladih v pregledanih virih ni.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Nacionalno poslabšanje	Povišana verjetnost depresije 13 % → 22 % (2018–2022). [129]
Omejena lokalna zmogljivost	Ena od treh psihologinj odsotna; program 2025 delno prenesen v Trebnje. [120] [5]
Specializirana pomoč je oddaljena	CDZOM je v Novem mestu. [20]
Ni lokalnih podatkov	Čakalne dobe psihološke ambulante in število obravnav niso objavljeni.

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Vodstvo ZD	Kolikšna je čakalna doba na prvi pregled pri psihologu za otroke in mlade? Mesečni podatki 2025–2026.
Vodstvo ZD	Zakaj je bil program dispanzerja v letu 2025 prenesen v ZD Trebnje in kako so bili obravnavani otroci iz Črnomlja? Pojasnilo in število obravnav.
Vodstvo ZD	Kako je nadomeščena psihologinja, ki je odsotna do nadaljnjega? Urnik in obseg dela.
CDZOM Novo mesto	Koliko otrok iz Bele krajine obravnavate in kako dolgo čakajo? Agregirani podatki po občinah.
Šole	Ali imate šolskega psihologa in kakšen je dogovorjen postopek napotitve? Opis postopka in število napotitev.
Šolske svetovalne službe	Kako se odziva na medvrstniško nasilje in spletno nadlegovanje? Protokol in agregirani podatki.
Občina	Ali financira preventivne programe za mlade (mladinski centri, svetovalnice)? Seznam programov in sredstev.
CKZ	Ali izvaja delavnice o duševnem zdravju za mladostnike in starše? Program in udeležba.
Mladinske organizacije	Kje se mladi v Črnomlju zbirajo zunaj šole in ali imajo dostop do svetovanja? Opis prostorov in urnikov.
NIJZ	Ali je mogoče pridobiti regionalne rezultate HBSC za JV Slovenijo? Podatki in intervali zaupanja.
Ministrstvo za zdravje	Kdaj bo mreža centrov za duševno zdravje dosegla Belo krajino z lokalno enoto? Načrt mreže.

Tveganja

Etiketiranje mladih kot »bolnih« lahko poveča stigmo. Samoocene v anketah niso diagnoze. Programi v šolah lahko izpustijo mlade, ki šolo opuščajo. Zbiranje podatkov o duševnem zdravju mora biti anonimno in agregirano.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	ZD objavi čakalno dobo psihološke ambulante in jasno pot napotitve (šola → ZD → CDZOM).	10–20 ur; obstoječi kadri.	Preglednost; tveganje večjega povpraševanja. Objavljena pot in mesečna čakalna doba.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	Šole, CKZ in ZD pripravijo skupen kratek program za starše o spanju, zaslonih in stiski.	20–40 ur; programi CKZ in šol.	Zgodnje prepoznavanje; tveganje moraliziranja. Število udeleženih staršev po šolah.
1–3 leta	Občina podpre dostopno svetovalnico za mlade v Črnomlju (npr. dan na teden z zunanjim strokovnjakom).	Načrtovalna ocena 15.000–30.000 EUR letno; občina, razpisi za mlade, če so na voljo.	Nizkopražna pomoč; tveganje kratkotrajnega financiranja. Število obiskov in čas do prvega pogovora.
3–10 let	Dogovor o lokalni enoti CDZOM ali redni prisotnosti tima v Črnomlju.	Državna mreža centrov.	Krajše poti; tveganje pomanjkanja kadra. Čas čakanja in delež obravnavanih v Črnomlju.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	2: kontakti so javni, čakalne dobe in obseg obravnav niso.
Dostop in razpoložljivost	2: zmanjšana zmogljivost in oddaljen CDZOM.
Usklajenost s potrebami	3: lokalna ambulanta obstaja, nacionalni trend pa kaže rast potreb.
Dokazna podlaga in spremljanje	2: brez lokalnih meritev.
Pravičnost in doseg	2: mladi brez prevoza težje pridejo do Novega mesta.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	3: 2 tima sta priznana za 2026.
Izvedljivost	3: potrebno je sodelovanje šol, ZD in CDZOM.

Izračun: (2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3) / 7 = **2,43/5,** ❌ po pravilu povprečja pod 2,5. Ocena velja za dokumentiranost in dostopnost, ne za kakovost dela psihologov.

Primerjave

Nacionalne vrednosti HBSC niso lokalne. Kazalnik samomora v Črnomlju se statistično ne razlikuje od slovenskega. [2] Za primerjavo z JV Slovenijo bi potrebovali regionalne rezultate HBSC.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Lokalno počutje mladih	Regionalni podatki HBSC ali anonimna šolska anketa z NIJZ.

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Čakalne dobe	Uradni podatki ZD in CDZOM.

06 Fizioterapija, prehrana, kineziologija in trenerji

PROFIL	KAJ LAHKO PREŠTEJEMO	KAJ OSTAJA NEZNANO
Fizioterapevti	**6 zaposlenih v ZD** konec 2025. Spletna stran fizioterapije imenuje Matejo Turk, Marto Judnič, Marto Rade, Mojco Šuštarič in Metko Štravs; CKZ dodatno Tjašo Klemenčič. **DSO poroča še o eni zaposleni fizioterapevtki** konec 2025, za stanovalce. [5][131][112][132]	To sta kadrovska podatka dveh zavodov, ne izmerjeni obseg sedmih splošno dostopnih ambulant. Skupno število aktivnih zasebnih fizioterapevtov v občini ni potrjeno.
Dietetiki in strokovnjaki za prehrano	ZD združuje **4 zaposlene v skupino »dietetiki, kineziologi«**. CKZ javno imenuje **Tino Resman, univ. dipl. inž. živil. teh.**, in **Katjo Hudelja, mag. inž. prehrane**. DSO ima v tabeli še **eno pripravnico dietetiko**. [5][112][132]	Skupine štirih zaposlenih ni mogoče zanesljivo razdeliti na poklice. Dveh objavljenih prehranskih profilov ne enačimo z dvema diplomiranima dietetikoma. Pripravnica ni samostojni specialistični izvajalec.
Nutricionisti / prehranski svetovalci	Ločene kadrovske kategorije »nutricionist« ni. Sportas imenuje dve prehranski svetovalki: **Sanelo Zukanović in Leo Berkopec**; slednja navaja tudi izobrazbo diplomirane medicinske sestre. [133]	To je ponudba prehranskega svetovanja, ne dokaz dveh zaposlitev dietetika. Enotnega skupnega števila nutricionistov ni mogoče potrditi.
Kineziologi	V CKZ je poimensko potrjena **Laura Muhič, dipl. kinez.**; celotna skupina dietetikov in kineziologov ima štiri zaposlene. [112][5]	Ena imenovana oseba je dokumentirani minimum, ne zanesljiv skupni seštevek ZD ali občine. Pripravniki in pogodbeni sodelavci se vodijo ločeno.
Osebni in fitnes trenerji	Na lokalnih straneh so poimensko navedeni **Simon Tomec (RC Simon), Sanela Zukanović in Danijela Mržljak (Sportas)**: najmanj **3**. Z inštruktorico jahanja **Ano Stariha** so potrjeni najmanj **4 imenovani izvajalci vadbe ljudi** iz tega vzorca. [111][133][106]	To ni število vseh trenerjev v občini ali zaposlenih za polni čas. Trenerji nogometa, rokometa in drugih klubov v ta minimalni vzorec niso sistematično vključeni.
Fitnes centri in studii	Potrjeni sta **2 ponudbi fitnes centra: RC Simon in Don Vito Gym Črnomelj**; dodatno **1 studio vodene vadbe Sportas**. [108][109][110]	Tri vadbene lokacije niso tri enakovredno opremljene fitnes dvorane. Popis ni dokaz, da drugih izvajalcev ni.

IZVAJALEC VADBE	LOKALNA LOKACIJA	OBJAVLJENA PONUDBA
RC Simon	Čopova ulica 14, Črnomelj	Fitnes, osebno trenerstvo, skupinske vadbe, pilates in prehransko svetovanje. [108][134][111]
Don Vito Gym	Belokranjska cesta 36, Črnomelj	Fitnes in dostop 24/7. Napovedanega dodatnega prostora HYROX ne obravnavamo kot že odprtega. [109]

IZVAJALEC VADBE	LOKALNA LOKACIJA	OBJAVLJENA PONUDBA
Sportas	Kanižarica 14B	Osebna in skupinska funkcionalna vadba ter prehransko svetovanje. Objavljeni kadrovski profili niso bili potrjeni po telefonu. [110][133]

Zakaj nekaterih zadetkov ne prištejemo: MD Rehab Lab predstavlja Davorina Matkoviča in Matica Muhiča ter naslov izvajanja v Novem mestu; Klinika Optimum za Roka Žagarja navaja Ljubljano; Rehab Studio za Dina Šunjergo in Najo Rebec navaja Ljubljano. Ti viri ne potrjujejo redne lokalne obravnave v Črnomlju, tudi če drug imenik pokaže lokalni poslovni sedež. To ni trditev, da občasno delo v Črnomlju ni mogoče. [135][136][137]

---

07 Zdravniki v lokalni osnovni zdravstveni mreži

ZZZS, stanje 1. 9. 2026: po izločitvi ambulante Gabrijele Plut v Semiču je v občini Črnomelj v seznamu splošnih ter otroških in šolskih ambulant **6 različnih družinskih zdravnikov in 2 pediatrinji**, skupaj **8 izbranih zdravnikov teh dejavnosti**. To ni celotno število vseh zdravnikov: izključuje zobozdravnike, druge specialistične ambulante, zdravnike urgence in nadomeščanja, ki v tem seznamu nimajo lastnega opredeljenega seznama. [138][127][139]

ZDRAVNIK	DEJAVNOST IN LOKACIJA	IZVAJALEC	OPREDELJENI 1. 9. 2026	SPREJEM NOVIH PO ZZZS
Ljiljana Špec	Družinska medicina, Črnomelj	ZD	1.198	NE
Jožica Fortun Tomažič	Družinska medicina, Črnomelj	ZD	1.503	NE
Mirela Mićić Despotović	Družinska medicina, Črnomelj	ZD	1.830	NE
Valerija Šimec	Družinska medicina, Vinica / del urnika Črnomelj	ZD	1.436	NE
Suzana Milenković	Družinska medicina, Zadružna cesta 33	Medicina MS, zasebnik v javni mreži	1.706	**DA**
Miro Vuković	Splošna ambulanta, Ulica 21. oktobra 19C	Zasebnik v javni mreži	772	NE
Eva Cimerman Jakša	Otroški in šolski dispanzer, Črnomelj	ZD	1.188	NE
Mateja Predalič	Otroški in šolski dispanzer, Črnomelj	ZD	1.527	NE

Vir celotne preglednice je ZZZS; lokacija Vinica in izločitev Semiča sta navzkrižno preverjeni pri ZD. **»DA« velja za datum seznama, ne zagotavlja sprejema danes.** Medicina MS objavlja kontakt **07 30 53 930**. [138][139][127][140]

Vseh osem vrstic skupaj predstavlja **11.160 opredelitev**. To ni število občanov s svojim zdravnikom: pacienti lahko prihajajo iz drugih občin, občani Črnomlja pa so lahko opredeljeni drugje. Zato iz razlike do števila prebivalcev ni dopustno izračunati števila oseb brez zdravnika. Pri Vukoviću vrstica zajema 0,45 tima splošne

ambulante; njegovega dela za DSO ne prištevamo kot druge osebe. Njegova spletna stran navaja drugačno delitev programa, zato za datirani obseg te ambulante uporabimo novejšo preglednico ZZZS. [138][141]

Letno poročilo **ZD kot celote** za konec 2025 vsebuje **9 zaposlenih zdravnikov in 5 zdravnikov specializantov/sekundarijev**, torej 14 zaposlenih oseb v teh dveh kategorijah; zobozdravstvo je ločeno (**7 zobozdravnikov in 1 oseba v kategoriji zobozdravniki pripravniki/specializanti**). Teh števil ne seštevamo z osmimi iz zgornje preglednice, saj se osebe prekrivajo, datuma in območji pa se razlikujejo. Načrt za 2026 predvideva 10 zdravnikov in 5 specializantov/sekundarijev, vendar načrt ni dokaz realizirane zaposlitve. [5][121]

---

08 Razpoložljivost zdravnikov in kadrovske vrzeli

> Posnetek objavljenega razporeda ambulant in stanje vodenja zavoda 25. 9. 2026: Zdravstveni dom Črnomelj.

MERILO	UGOTOVITEV	PRAVILNA RAZLAGA
Pokritost priznanega programa ZD	7,53 priznanega − 5,53 zagotovljenega = **2,00 manjkajočega tima**, približno **26,6 %** priznanega programa. [121]	Konkretno dokumentiran primanjkljaj družinske medicine za območje ZD, tudi Semič. Smiselni prvi cilj je zapolnitev teh dveh timov z zdravniškim in podpornim kadrom. To ni nujno natanko dve novi osebi.
Stalni osebni zdravnik	ZD navaja **3.142 pacientov v ambulantah za neopredeljene na 1. 8. 2026**. [142]	Dokaz potrebe po nadomestni organizaciji, ne 3.142 občanov brez vsake oskrbe. Občinsko prebivališče in morebitno poznejše opredeljevanje nista razčlenjena.
Dejanska dostopnost za nove paciente	Med osmimi navedenimi zdravniki ima v preglednici 1. 9. 2026 samo Suzana Milenković oznako DA. [138]	Pokritost vseh občanov s stalno izbranim zdravnikom ni izkazana. Oznake je treba preverjati sproti.
Evropsko priporočilo	Poročilo Evropske komisije 2026 opisuje različne nacionalne pristope in potrebo po upoštevanju lokalnih razmer; ne določa enotnega občinskega števila zdravnikov. Model JRC SANDEM izrecno ni namenjen postavitvi univerzalnega razmerja zdravniki/prebivalci. [143][144]	Na podlagi teh virov ni pošteno podati »evropsko predpisanega« občinskega primanjkljaja.
Primerjava z EU	Profil OECD za 2025 navaja za leto 2023 **3,5 zdravnika na 1.000 prebivalcev v Sloveniji in 4,3 v EU**. [67]	Vključeni so zdravniki različnih ravni, tudi bolnišnični specialisti. Povprečje EU ni norma za družinsko medicino v vsaki občini. Iz njega ne odštevamo zaposlenih v ZD.

Za natančno oceno dodatnih potreb nad tema dvema timoma potrebujemo ure dela po specialnostih, starost in zdravstvene potrebe prebivalstva, število oseb brez izbranega zdravnika po občini prebivališča, čakalne dobe, upokojitve ter tokove pacientov med občinami. Za psihiatrijo, psihologijo, fizioterapijo in prehrano pregledani viri ne omogočajo verodostojnega izračuna, koliko novih polnih zaposlitev bi zadoščalo.

24

Društva in podporna pomoč zunaj ambulante

Pregled 15 društev, združenj oziroma njihovih lokalnih enot in povezanih točk, preverjen 20. septembra 2026. Vključuje redno gibanje, podporo pri kroničnih boleznih, duševnem zdravju, demenci in življenjskih stiskah.

> **Koristna obstoječa osnova:** CKZ Črnomelj je že septembra 2025 izdal zbirnik *Povezani za zdravje* z lokalnimi kontakti. Smiselno ga je redno posodabljati in povezati z aktualnimi stranmi društev. To je dodatno potrjeno delo centra pri obveščanju; ocena dokumentiranega dela 3,4/5 ostaja, saj novi imenik ne meri zdravstvenih izidov. [76]

Šola zdravja: deset skupin v občini

Uradni občinski seznam društva navaja Črnomelj, Dragatuš, Kanižarico, Tančo goro, Vinico, Špeharje, Zilje, Svibnik, Adlešiče in Majer. Zadnje tri skupine so navedene z letom ustanovitve 2025. Urnik na Gričku ne velja samodejno za ostale skupine. [145]

»Objavljeno« pomeni navedbo v javnem viru, ne telefonske potrditve naslednjega termina. Pri organizacijah iz imenika 2025 je starost podatka posebej označena. Podporni programi dopolnjujejo zdravstveno obravnavo. Pogojev članstva, prispevkov in proste zmogljivosti ne domnevamo.

ORGANIZACIJA / POMOČ	KJE IN KAKO DO KONTAKTA	DOSTOPNOST IN VKLJUČITEV
Društvo Šola zdravja — Črnomelj in vaške skupine Redno skupinsko gibanje in druženje; možen partner za vzdrževanje gibalnih navad po obravnavi CKZ. [146][145]	Črnomelj: vzpetina v parku Gričeк; ponedeljek–sobota ob 7.30, razen praznikov. **Lidija: 040 784 400; malesic.lidija@gmail.com**	Lokalna skupina objavljena Termin je objavljen na strani skupine. Aktualno članarino, prilagoditve in možnost prvega obiska preveriti pri vodji; zneska iz 2024 ne prikazujemo kot veljavnega.
Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine Strokovno vodena vseživljenjska rehabilitacijska vadba in podpora koronarnim bolnikom. [147][148]	Zveza izrecno navaja Črnomelj med kraji vadbe; starejša objava društva potrjuje sodelovanje s CKZ v ZD. **info@koronarnodrustvo-dbk.si; za povezavo s skupino tudi CKZ Črnomelj.**	Vadba v Črnomlju navedena Pred vključitvijo preveriti ustrezno skupino, aktualni termin in prispevek. Starega urnika ponedeljek/sreda ne potrjujemo za 2026.
Društvo diabetikov Metlika Izobraževanje o sladkorni bolezni, vrstniška podpora, pohodi in izmenjava izkušenj. [149][150]	Objavljeno vpisno mesto: Društvo upokojencev Črnomelj, Ulica 21. oktobra 15; pisarna društva v Metliki. **slavo.prevalsek@siol.net**	Dostopno tudi iz Črnomlja Vključuje tudi prebivalce širšega območja; dogovoriti se o članstvu, aktualnih srečanjih in stroških. Vpisno mesto ni diabetološka ambulanta.
Europa Donna Slovenija — skupina Bela krajina Podpora članicam ob zdravljenju raka dojk, skupnost, prilagojeni pohodi in druge aktivnosti. [151]	Prvi torek v mesecu ob 18.00, Ljudska univerza Črnomelj, Kolodvorska cesta 32c. Objavljena je tudi sezonska joga. **Damjana Štefanič: 040 219 661; belakrajina@europadonna.si**	Lokalna skupina objavljena Sprejemajo nove članice. Pred obiskom preveriti termin in pogoje posamezne aktivnosti; joga je navedena od oktobra do maja.

ORGANIZACIJA / POMOČ	KJE IN KAKO DO KONTAKTA	DOSTOPNOST IN VKLJUČITEV
Metuljčica — skupina Črnomelj Samopomoč in izmenjava izkušenj ljudi z obolenji ščitnice. [152]	Drugi torek v mesecu ob 18.00, sejna soba Občine Črnomelj. **Darinka Klemenčič: 040 251 649**	Lokalna skupina objavljena Objavljen razpored nima datuma posodobitve. Termin preveriti; medsebojna podpora ne nadomešča zdravniškega spremljanja.
Klub Zeleni Jurij — Združenje bolnikov s CVB Povezovanje in podporna skupnost bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, tudi po možganski kapi. [153]	Zadnji četrtek v mesecu ob 17.00, Dom starejših občanov Črnomelj. **Sonja Imširović: 031 692 574; sonja.imsirovic@gmail.com**	Lokalna skupina objavljena Pred prvim srečanjem potrditi termin, dostopnost in način vključitve; klub ni nadomestilo za predpisano rehabilitacijo.
OZARA Črnomelj Pisarna za informiranje in svetovanje na področju duševnega zdravja. Lokalno sodelovanje potrjuje Knjižnica Črnomelj. [154][76]	Črnomelj; aktualni naslov in urnik dogovoriti ob naročanju. **07 306 18 60; karmen.zunic@ozara.org**	Lokalno delo potrjeno; kontakt iz 2025 Kontakt je iz imenika CKZ 2025; neposredna podstran OZARE ni bila dostopna. Obseg sedanje ponudbe preveriti.
Slovenska filantropija — Hiša Sadeži družbe Črnomelj Brezplačne medgeneracijske dejavnosti, zdravo staranje, druženje in vključevanje prostovoljcev. [155]	Železničarska cesta 5, Črnomelj; dejavnosti po mesečnem programu. **040 696 100; hisa-crnomelj@filantropija.org**	Lokalni center z objavami 2026 Uradna stran navaja brezplačne aktivnosti; za nekatere je potrebna prijava. Gre za socialno in preventivno podporo.
RKS — Območno združenje Črnomelj Krvodajalstvo, prva pomoč in humanitarna podpora. [76]	Območje občin Črnomelj in Semič. **07 305 14 51; crnomelj.ozrk@siol.net**	Lokalni izvajalec v imeniku CKZ Podatki iz zbirnika CKZ, september 2025. Preveriti posamezni program; stroški tečajev niso preverjeni.
Združenje multiple skleroze Slovenije — Dolenjska podružnica Povezava bolnikov z MS z regionalno podružnico in podporno mrežo. [156]	Podružnica izrecno vključuje Črnomelj, Metliko in Semič ter navaja poverjenico za Belo krajino. **Darinka Filipčič: 041 391 762; podružnica: 041 212 863**	Regionalno pokriva Črnomelj Pri poverjenici preveriti lokalna srečanja, programe in pogoje vključitve; spletna navedba območja ni potrdilo stalne ambulante.
Spominčica – Alzheimer Slovenija in lokalna demenci prijazna točka Informacije in podpora ob demenci; usposabljanje svojcev in lokalnih organizacij. [157][158]	Ljudska univerza Črnomelj javno potrjuje demenci prijazno točko. LU je javni zavod, Spominčica pa združenje. **Spominčica: 01 256 51 11; info@spomincica.si**	Nacionalno združenje z lokalno povezavo Za informacije se je mogoče obrniti na lokalno točko; za skupino svojcev ali novo usposabljanje dogovor s Spominčico. Točka ni diagnostična ambulanta ali stalna oskrba.
Slovensko društvo Hospic — Dolenjska, Posavje in Bela krajina Spremljanje hudo bolnih in podpora svojcem ter žalujočim. [159][160]	Regionalni odbor v Novem mestu; pomoč v konkretnem okolju se dogovori individualno. **051 454 845; dolenjska@hospic.si**	Regionalni odbor za območje Ob klicu preveriti možnost obiska in razpoložljivost podpore. Iz imenika ni mogoče obljubiti takojšnje ali 24-urne zdravstvene nege.

ORGANIZACIJA / POMOČ	KJE IN KAKO DO KONTAKTA	DOSTOPNOST IN VKLJUČITEV
ŠENT — Dnevni center Novo mesto Individualni razgovori, pomoč pri urejanju zadev in dejavnosti dnevnega centra za duševno zdravje. [161]	Smrečnikova ulica 60, Novo mesto; uradno objavljen center, lokalna enota v Črnomlju ni potrjena. **030 767 702; amina.nur@sent.si**	Možen regionalni partner Individualni razgovori po predhodni najavi. Sprejem prebivalcev Črnomlja, prevoz in morebitne terenske dejavnosti je treba posebej dogovoriti.
Sožitje Bela krajina Kontakt za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam. [76]	Bela krajina; aktualni programi v Črnomlju niso dodatno potrjeni. **031 515 412; drustvo_sozitje@t-2.net**	Navedeno v lokalnem imeniku 2025 Predlagan partner za prilagojene programe; podrobni pogoji in zmogljivosti zahtevajo neposredno potrditev.
Društvo invalidov Črnomelj Kontakt invalidske organizacije; možen partner pri dostopnosti in prilagojenem vključevanju. [76]	Črnomelj; konkretnih zdravstvenih storitev s tem pregledom ne potrjujemo. **07 305 32 40; di.crnomelj@a1mail.si**	Navedeno v lokalnem imeniku 2025 Najprej preveriti sedanji program, dostopnost in članstvo. Vpis v imenik sam ne dokazuje izvajanja rehabilitacije.

Prenesi imenik CSV

Kako bi lahko sodelovali s CKZ in občino?

PREDLOG / ROK	NOSILCI IN SREDSTVA	KORIST IN PREVERJANJE
0–12 mesecev: preveriti kontakte ter uvesti pomoč pri prvem stiku po koncu obravnave CKZ; uporabnik sam izbere dejavnost.	CKZ in imenovani predstavniki društev. Planska ocena: 1–2 delovna dneva za prvi krog preverbe, nato mesečno vzdrževanje; obstoječe organizacijske ure.	Manj izgubljenih kontaktov. Merilo: aktualnost imenika in delež uporabnikov, ki so uspeli vzpostaviti stik; brez prenosa diagnoz društvom brez ustrezne podlage.
1–3 leta: poskusno povezati redno gibanje, podporne skupine in dostopne prevoze v odročnejših krajih.	Občina, CKZ, Šola zdravja in druga zainteresirana društva. Obseg določiti s popisom potreb; možni občinski razpisi in redni viri izvajalcev, brez zagotovljenega financiranja.	Kontinuiteta in doseg zunaj mesta. Tveganje: preobremenitev prostovoljcev. Merilo: vztrajanje po 3/6 mesecih in geografski doseg.
3–10 let: redno načrtovanje mreže skupaj z zdravstvenimi in socialnimi izvajalci.	Občina in izvajalci; večletni program po evalvaciji, z ločenim financiranjem strokovnih storitev in prostovoljskih dejavnosti.	Trajnost ob staranju prebivalstva. Merilo: nezadovoljene potrebe in uporabniška izkušnja; ne samo število dogodkov.

To so predlogi sodelovanja, ne že sklenjeni dogovori. Za oceno uspešnosti posameznega društva potrebujemo doseg, obseg dela, vire in rezultate; sam seznam kontaktov ne zadošča za pošteno številčno oceno.

PODROČJE 10 / ČRNOMELJ

Dostop do oskrbe

Kako hitro pride nujna pomoč, kdo nima osebnega zdravnika, koliko se čaka, kdo zmore digitalne poti in kako je poskrbljeno za starejše in osebe z demenco doma. Modelski časi vožnje niso izmerjeni dostopni časi NMP.

Dostop do nujne pomoči in prvi posredovalci

Dopolnitev 25. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Od 3. junija 2026 velja nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (NMP). Povprečni dostopni čas prve ekipe za intervencije I. prioritete sme na letni ravni znašati največ 15 minut. Prvi posredovalci so po novem izrecna naloga izvajalcev NMP, sredstva za njihovo usposabljanje pa zagotavlja državni proračun. [26] ZD Črnomelj v letnem poročilu 2025 cilj »dokončna vzpostavitev prvih posredovalcev v občini Črnomelj« označuje kot realiziran, v programu 2026 pa napoveduje nadaljevanje izobraževanj. [5] [121] Števila usposobljenih prvih posredovalcev, njihove razporeditve po krajih, aktivacij in dejanskih dostopnih časov NMP zavod ne objavlja.

Modelska ocena pokaže okvir problema. Ko je ekipa ZD Črnomelj prosta, ima po srednji predpostavki ocenjen dostopni čas nad 15 minut 25 % prebivalcev (razpon 20–34 % glede na hitrost vožnje). Največ takih ljudi živi v Poljanski dolini, ob Kolpi in v okolici Vinice. Ko je ekipa zasedena in mora priti druga iz Metlike ali Novega mesta, je nad 15 minut skoraj vsa občina (99 %, povprečno 26,5 minute). [162] [163] [164] Za takšna območja raziskave podpirajo sistem aktiviranih prvih posredovalcev: v metaanalizi je bilo preživetje srčnega zastoja zunaj bolnišnice ob njihovi aktivaciji višje (9,1 % proti 8,3 %). [165]

Trenutno stanje

ZD Črnomelj navaja, da je NMP organizirana 24 ur na dan. Na spletni strani piše, da zdravnik ob delu v ambulanti opravlja tudi nujne obiske na terenu, medicinska sestra pa je stalno prisotna in sprejema nujne klice. [11] Letno poročilo 2025 in program 2026 navajata dežurno službo, triažo satelitskega urgentnega centra (SUC), nujno reševalno vozilo (NRV) in vozilo urgentnega zdravnika (VUZ). V letu 2025 je zavod dobil dodatnih 0,5 tima NRV. [5] [121] Zavod piše tudi, da zdravniki poleg ambulante sodelujejo v SUC, urgentni in dežurni službi. Od 1. 2. 2023 delajo še v ambulantah za neopredeljene. [121] Koliko intervencij se prekriva in koliko časa je ekipa odsotna iz ambulante, ni objavljeno.

Prvi posredovalci: ZD cilj vzpostavitve mreže v letnem poročilu 2025 označuje kot »realiziran« z opisnim kazalnikom. [5] To je samoocena zavoda. Število evidentiranih prvih posredovalcev, sodelujoča društva, pokritost odmaknjenih krajev in način aktivacije niso objavljeni. Status: Unverified.

Ključna dejstva

Kaj določa pravilnik iz leta 2026

DOLOČBA	VSEBINA	POMEN ZA ČRNOMELJ
Dostopni čas	Čas od dviga slušalke v dispečerski službi do prihoda ekipe na kraj. Letno povprečje prve prispele ekipe za I. prioriteto ne sme presegati 15 minut; izvozni čas največ 1 minuta. [26]	Povprečje lahko prikrije daljše čase za oddaljena naselja. Potreben je prikaz po naseljih oz. razdaljah.
Prvi posredovalec	Polnoletna, usposobljena in evidentirana oseba, ki jo aktivira dispečerska služba in začne temeljne ukrepe pred prihodom NMP. Znanje obnavlja vsaj enkrat na leto. [26]	Najbolj smiseln je v naseljih, kamor ekipa NMP potrebuje največ časa.
Naloge izvajalca NMP	Ugotavlja potrebe po prvih posredovalcih, usposablja kandidate, vodi evidenco in poroča ministrstvu; lahko sklene dogovor z organiziranimi skupinami (npr. gasilci). [26]	ZD Črnomelj kot izvajalec NMP je zadolžen za oceno potreb na svojem območju.
Financiranje	Sredstva za naloge izvajalcev pri prvih posredovalcih zagotavlja proračun RS. [26]	Uvedba ni odvisna samo od občinskega proračuna.
AED	Javno dostopni AED se vključijo v evidenco dispečerske službe; nevzdrževane naprave se iz nje izključijo. [26]	Povezuje se z zavihkom AED: lokacija sama ni dovolj, pomembni sta vzdrževanje in vključenost v evidenco.
Poročanje	Letno poročilo vključuje aktivacije prvih posredovalcev, njihov odzivni čas, oživljanja, defibrilacije in povprečni čas do prihoda ekipe. [26]	Podatki bodo obstajali in jih je mogoče javno zahtevati v agregirani obliki.

Modelska dostopnost naselij

Metoda: 111 naselij iz OpenStreetMap smo povezali s prebivalstvom SURS 1. 1. 2026 po imenu (109 ujemanj, 13.943 od 14.170 prebivalcev). Za vsako naselje smo s strežnikom OSRM izračunali čas običajne vožnje po cestah od ZD Črnomelj (Delavska pot 4), ZD Metlika in Splošne bolnišnice Novo mesto z urgentnim centrom. [163] [162] Dostopni čas po pravilniku teče od dviga slušalke v dispečerski službi do prihoda ekipe. [26] Ocenili smo ga kot vsoto treh delov: obdelava klica (predpostavka 1–2 min), izvoz (največ 1 min po pravilniku) in vožnja, pomnožena s faktorjem. Faktor 0,8 predstavlja hitrejšo nujno vožnjo, 1,0 običajno vožnjo in 1,2 slabše razmere; vse tri vrednosti so predpostavke. Model ne pozna dejanske zasedenosti ekip, vremena, iskanja naslova ali poti od vozila do bolnika. To ni izmerjeni dostopni čas.

SCENARIJ	OCENJEN DOSTOPNI ČAS NAD 15 MIN: PREBIVALCI	DELEŽ	OD TEGA 65+	UTEŽENO POVPREČJE
A: ekipa ZD Črnomelj prosta, srednja predpostavka (1,5 + 1 + vožnja × 1,0)	3.512	25,2 %	943	11,4 min
A: hitrejša nujna vožnja (1 + 1 + vožnja × 0,8)	2.801	20,1 %	758	9,2 min
A: počasnejša vožnja (2 + 1 + vožnja × 1,2)	4.784	34,3 %	1.266	13,7 min
B: ekipa ZD Črnomelj zasedena, pride najbližja druga ekipa (ZD Metlika ali UC Novo mesto), srednja predpostavka	13.842	99,3 %	3.518	26,5 min

Opozorilo o natančnosti (26. 9. 2026): preverjanje naročnika z Google Maps je pokazalo, da se modelski časi ne ujemajo z Googlovimi. Drug odprtokodni model (Valhalla) na istih cestah pogosto vrne daljše čase; pri Gribljah OSRM izbere ozko lokalno cesto z vpisano omejitvijo 90 km/h. Zgornji deleži so zato okvirni, dokler časi niso umerjeni na Googlove vrednosti. Zemljevid spodaj že kaže razpon obeh modelov. **[166]**

Scenarij B pokaže, kako pomembni sta druga ekipa v Črnomlju in mreža prvih posredovalcev. Kolikokrat na leto pride do sočasnih intervencij, ni objavljeno. ZD Metlika ima NMP organizirano 24 ur na dan. **[164]**

SAMO ČAS VOŽNJE OD ZD ČRNOMELJ (BREZ KLICA IN IZVOZA)	NASELJA	PREBIVALCI	DELEŽ ZAJETIH PREBIVALCEV	OD TEGA 65+
do 10 minut	34	9.159	65,7 %	2.274
10–15 minut	20	1.790	12,8 %	454
15–20 minut	19	1.142	8,2 %	288
20–30 minut	19	1.221	8,8 %	336
nad 30 minut	17	631	4,5 %	188

PRIMER NASELJA	PREBIVALCI 2026	MODELSKA VOŽNJA OD ZD	ZRAČNA RAZDALJA DO NAJBLIŽJEGA AED V REGISTRU
Vinica	245	27,0 min	0,18 km
Zilje	139	30,2 min	0,91 km
Preloka	103	33,0 min	0,13 km
Učakovci	105	33,9 min	2,73 km
Vukovci	33	36,8 min	2,82 km
Dalnje Njive	16	36,8 min	1,87 km

Celotna preglednica 111 naselij je v podatkih o dostopnosti (CSV). Poti in čase za vsako naselje prikazuje interaktivni zemljevid. Razdalja do AED je zračna in ne pove, ali je naprava dosegljiva ponoči, ali je zaklenjena in kdo jo lahko prinese. Točka naselja v OSM je ena koordinata, ne naslov posameznega doma.

Kaj kažejo raziskave o prvih posredovalcih

RAZISKAVA	ZASNOVA	UGOTOVITEV	OMEJITVE
Scquizzato in sod., 2022 **[165]**	Sistematični pregled in metaanaliza, 10 raziskav, 23.351 bolnikov s srčnim zastojem zunaj bolnišnice; aktivacija državljanov prek mobilnih aplikacij proti običajnemu odzivu.	Preživetje do odpusta ali 30 dni 9,1 % proti 8,3 % (OR 1,45; 95-% IZ 1,21–1,74); oživljanje očividcev 65 % proti 53 %; uporaba AED pred prihodom ekipe 7,2 % proti 4,2 %. Nevrološko ugoden izid se ni statistično razlikoval.	Opazovalne raziskave, različni sistemi in države; prebran povzetek. Učinek je povezava, ne zagotovljen lokalni rezultat.

Viri

Pravilnik je prebran v primarnem besedilu Uradnega lista (1.–20. člen in prilogi 7 in 8). Organizacija NMP ZD je iz uradne strani zavoda. Časi vožnje so modelski izračun in imajo nižjo zanesljivost kot izmerjeni dostopni časi. Metaanaliza je prebrana kot povzetek.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Dejanski dostopni časi NMP za Črnomelj niso javni	Pravilnik zahteva letno poročanje, podatki za občino v pregledanih virih niso objavljeni.
Četrtina prebivalcev ima ocenjen dostopni čas nad 15 minut	Model OSRM, SURS 2026 in predpostavke (razpon 20–34 %); zahteva preverjanje z dejanskimi časi.
Ranljivost ob sočasnih intervencijah	Če je ekipa Črnomelj zasedena, je po modelu nad 15 minut 99 % prebivalcev.
Mreža prvih posredovalcev ni javno opisana	ZD jo označuje kot vzpostavljeno, podatkov o obsegu in pokritosti ni. [5]
Zdravniki hkrati pokrivajo več služb	Ambulanta, SUC, urgentna in dežurna služba ter ambulante za neopredeljene. [121]
Odmaknjena naselja so starejša	V naseljih z ocenjenim dostopnim časom nad 15 minut živi 943 oseb, starih 65 let ali več (srednji scenarij).

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Vodstvo ZD Črnomelj	Kolikšen je bil povprečni in 90. percentilni dostopni čas za I. prioriteto v letih 2024–2026? Agregirani podatki po letih in po krajevnih skupnostih.
Vodstvo ZD Črnomelj	Koliko prvih posredovalcev je evidentiranih, v katerih krajih in koliko aktivacij je bilo v letih 2025–2026? Na čem temelji oznaka »realizirano« v letnem poročilu 2025? Agregirana evidenca in ocena potreb po 19. členu pravilnika.
Vodstvo ZD Črnomelj	Koliko intervencij na leto se zgodi, ko je ekipa NMP že na terenu? Število sočasnih klicev in čas čakanja na drugo ekipo.
Dispečerska služba zdravstva	Koliko AED z območja Črnomlja je v evidenci DSZ in koliko jih je izključenih zaradi vzdrževanja? Izpis evidence.
Gasilska zveza Črnomelj	Katera društva bi bila pripravljena sodelovati kot organizirana skupina prvih posredovalcev? Seznam društev, članov in opreme.
Občinska uprava	Ali bo občina sofinancirala opremo prvih posredovalcev, ki je državna sredstva ne pokrijejo? Proračunska postavka in merila.
Občinski svet	Ali bo občina zahtevala letno javno poročilo o dostopnih časih in aktivacijah? Sklep sveta in oblika poročila.
Ministrstvo za zdravje	Kdaj bodo objavljeni podatki iz letnih poročil izvajalcev NMP po Prilogi 7? Terminski načrt in raven razčlenitve.

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Svet zavoda ZD	Kako bo pomanjkanje zdravnikov vplivalo na razpoložljivost NMP ponoči in ob koncih tedna? Razpored dežurstev 2026.
Šole in športna društva	Koliko zaposlenih in trenerjev je v zadnjih dveh letih opravilo tečaj temeljnih postopkov oživljanja? Agregirano število in leto usposabljanja.
Policija	Ali lahko policijske patrulje na odmaknjenih območjih nosijo AED? Opis opreme in dogovor z ZD.

Tveganja

Prvi posredovalci ne nadomeščajo ekipe NMP. Brez rednega usposabljanja, zavarovanja in psihološke podpore se lahko hitro izčrpajo. Prostovoljci na podeželju so pogosto isti ljudje v gasilstvu, civilni zaščiti in društvih. Objava podatkov po naseljih ne sme omogočiti prepoznave posameznih bolnikov, zato je treba majhne številke združevati. Modelski čas ne sme služiti kot dokaz za ali proti posamezni lokaciji ekipe.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	ZD objavi agregiran pregled obstoječe mreže prvih posredovalcev in jo dopolni tam, kjer je modelski čas nad 15 minut; dogovor z gasilsko zvezo.	30–60 ur strokovnega dela; usposabljanje iz proračuna RS po 19. členu pravilnika.	Hitrejša prva pomoč; tveganje neenakomerne pokritosti. Po 6 mesecih: zemljevid pokritosti po krajevnih skupnostih; po 12 mesecih: delež odmaknjenih KS z vsaj dvema aktivnima prvima posredovalcema.
0–12 mesecev	Občina in ZD preverita AED v evidenci DSZ, dostopnost ponoči in vzdrževanje.	20–40 ur; stroški vzdrževanja nosi lastnik naprave.	Manj »mrtvih« naprav; tveganje nejasnega lastništva. Po 12 mesecih: delež AED z dokumentiranim pregledom in 24-urnim dostopom.
1–3 leta	ZD letno javno objavi agregirane dostopne čase in aktivacije prvih posredovalcev.	10–20 ur letno; obstoječi podatki iz Priloge 7.	Pregled nad dostopnostjo; tveganje napačne razlage povprečij. Letno poročilo z mediano, 90. percentilom in razčlenitvijo po območjih.
1–3 leta	Tečaji temeljnih postopkov oživljanja v šolah, društvih in podjetjih, najprej v odmaknjenih krajih.	Načrtovalna ocena 3.000–8.000 EUR letno; občina, ZZZS preventiva ali donatorji, če so na voljo.	Več usposobljenih očividcev; tveganje enkratnih akcij brez obnove. Število usposobljenih na 1.000 prebivalcev po krajevnih skupnostih.
3–10 let	Občina, ZD in ministrstvo presodijo, ali je za jug občine potrebna dodatna mobilna enota ali drugačna razporeditev.	Investicija in kadri po presoji; državna mreža NMP.	Krajši dostopni časi; tveganje, da ni kadra. Merilo: 90. percentil dostopnega časa za I. prioriteto v odmaknjenih KS.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Ocenjujemo javno dokumentiranost in pripravljenost sistema, ne kakovosti dela ekip NMP. Lestvica je 1–5 (1 = skoraj nič dokumentirano, 5 = celovito in neodvisno preverjeno), sedem meril ima enako utež.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	2: organizacija in cilj glede prvih posredovalcev sta opisana, dostopni časi, obseg mreže in aktivacije niso objavljeni.
Dostop in razpoložljivost	3: NMP deluje 24 ur; odmaknjena naselja so po modelu daleč, ena ekipa pokriva ambulanto in teren.
Usklajenost s potrebami	3: starejše prebivalstvo in razpršena poselitev zahtevata dodatne rešitve, ki niso dokumentirane.
Dokazna podlaga in spremljanje	2: pravilnik uvaja poročanje, lokalni podatki niso javni.
Pravičnost in doseg	2: prebivalci jugovzhoda so v slabšem položaju, ciljni ukrepi niso dokumentirani.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene: ni podatkov.
Vzdržnost	3: državno financiranje prvih posredovalcev je predpisano, ZD načrtuje nadaljnja izobraževanja; obseg ni javen.
Izvedljivost	4: gasilska mreža in AED že obstajata, pravni okvir je jasen.

Izračun: (2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 4) / 7 = **2,71/5,** ⚠️. Izredni prehod na ❌ ni uporabljen, ker za Črnomelj ni dokaza o preseženih dostopnih časih. To bi preverili dejanski podatki.

Primerjave

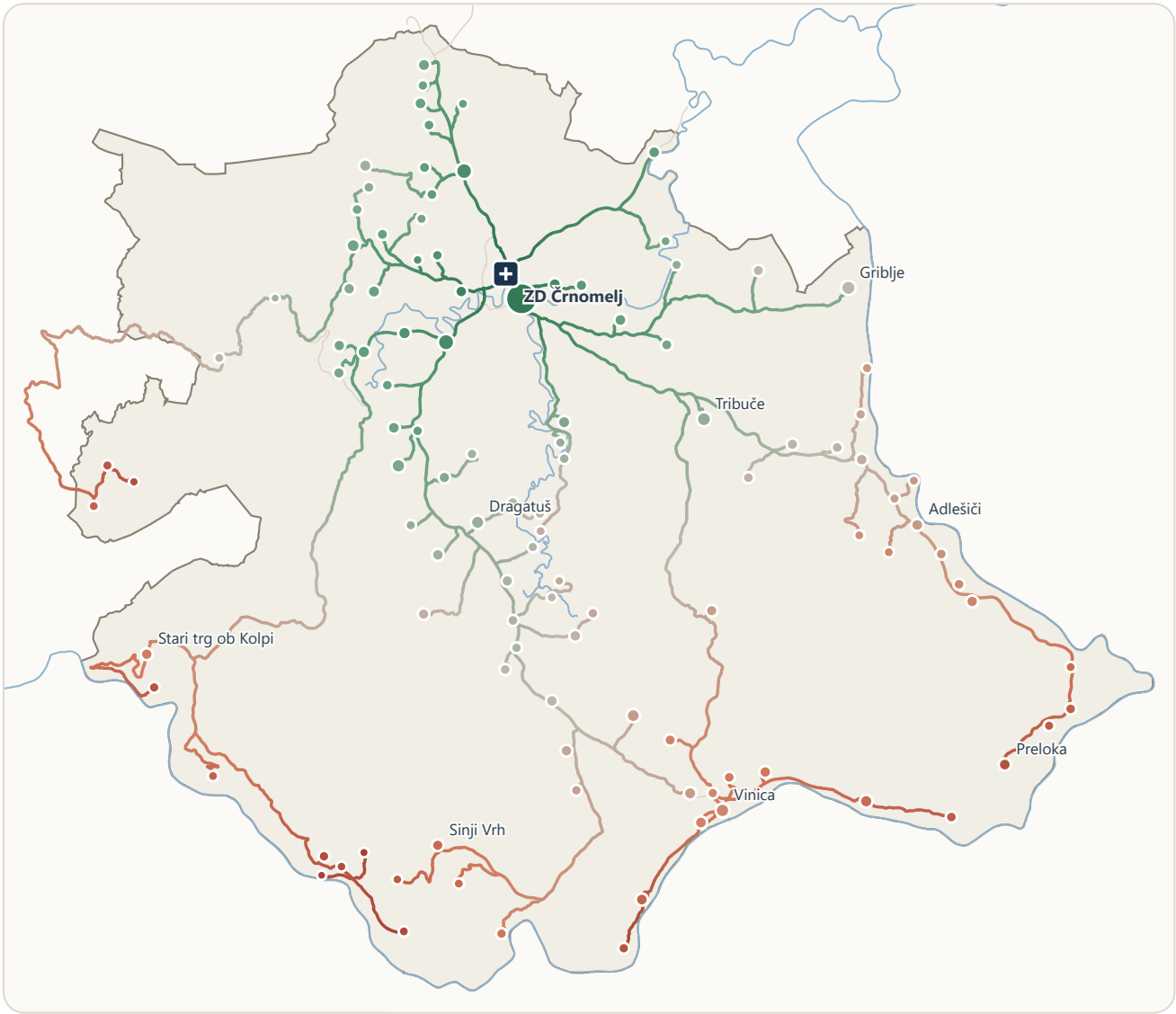
Pravilnik določa enoten nacionalni cilj (15 minut povprečno). Primerljivih objavljenih dostopnih časov po občinah v pregledanih virih ni. Ko bodo objavljeni, je treba primerjati enako opredelitev (dostopni čas od dviga slušalke do prihoda, I. prioriteta, prva prispela ekipa) in enako obdobje. Primerjava z drugimi ZD s sistemi prvih posredovalcev je smiselna šele z enakimi kazalniki iz Priloge 7.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Dejanski dostopni časi	Zahteva po informacijah javnega značaja za agregirane podatke 2024–2026.
Obseg in pokritost prvih posredovalcev	Uradni odgovor ZD in gasilske zveze (število, kraji, aktivacije).
Natančnost modela	Ko ZD posreduje agregirane dostopne čase po krajevnih skupnostih, jih primerjati s scenariji A; če odstopajo, popraviti predpostavke (obdelava klica, faktor vožnje). Zahteva je pripravljena v `dokumentacija/zahteve-ijz/`.

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Pogostost sočasnih intervencij	Podatek ZD o številu intervencij, ko je bila ekipa že na terenu (potrebno za oceno scenarija B).

Zemljevid: pot do zdravstvenega doma in čas nujne pomoči



Minute (ocenjeni dostopni čas nujne pomoči)

0 5 10 15 20 30 40+

Siva ≈ 15 minut: cilj povprečnega dostopnega časa po pravilniku NMP. Pika = naselje (velikost po številu prebivalcev), kvadrat = ZD Črnomelj.

Vir časov: razpon dveh odprtokodnih modelov (OSRM in Valhalla), še neumerjeno na Google Maps. Po osrednji oceni ima 24,2 % prebivalcev povezanih naselij dostopni čas nad 15 minut. Oba modela računata z isto cestno mrežo OpenStreetMap, a z različnimi hitrostmi, zato se razlikujeta. Primer so Griblje: OSRM izbere enopasovno lokalno cesto z vpisano omejitvijo 90 km/h (10 min), Valhalla pa drugo pot (22 min). Primerjava z

Google Maps je pokazala, da se modela od njega razlikujeta. Zato vozne čase umerjamo na Googlove vrednosti za izbrana naselja (predloga kalibracija-google.csv). Vožnja prebivalca je čas običajne vožnje od naselja do ZD. Nujna vožnja reševalcev je **predpostavka**: 0,8 × modelski čas, ker se vozilo z modrimi lučmi ne drži omejitev. Ocenjeni dostopni čas prišteje 1 minuto obdelave klica in 1 minuto izvoza (pravilnik dovoljuje največ 1 minuto). Zgornja meja razpona je 1,5 + 1 minuti in vožnja brez pospeška. To ni izmerjeni dostopni čas: model ne pozna zasedenosti ekipe, vremena in iskanja naslova, točka naselja pa je ena koordinata. **[167][166] [163][26]** Prenesi podatke (CSV).

▼ Preglednica: vsa naselja, razvrščena po oceni nujne pomoči

NASELJE	PREBIVALCI 2026	VOŽNJA PREBIVALCA DO ZD (MIN)	NUJNA VOŽNJA REŠEVALCEV, OCENA (MIN)	DOSTOPNI ČAS NMP, OCENA (MIN)
Črnomelj	5432	1,5–1,7	1,3–1,3	3,3–4,1
Svibnik	97	2,3–3,3	1,8–2,7	3,8–5,9
Vojna vas	110	3,2–4,3	2,6–3,4	4,6–6,7
Kanižarica	585	5,1–5,2	3,0–3,6	5,0–7,0
Lokve	544	4,3–4,8	3,5–3,8	5,5–7,3
Dolnja Paka	33	4,5–5,6	3,6–4,4	5,6–8,1
Blatnik pri Črnomlju	147	6,2–6,5	3,9–4,7	5,9–8,3
Zajčji Vrh	12	4,7–6,0	3,8–4,8	5,8–8,5
Dolenja vas pri Črnomlju	72	5,2–7,3	4,3–5,8	6,3–9,8
Dobliče	141	7,5–8,2	5,0–6,0	7,0–10,0
Otovec	50	6,6–7,2	5,3–5,8	7,3–9,7
Kvasica	42	7,8–8,4	5,2–6,2	7,2–10,3
Sela pri Otovcu	64	6,9–7,4	5,5–6,0	7,5–9,9
Vranoviči	101	6,8–7,4	5,5–6,0	7,5–10,0
Čudno selo	100	6,0–9,1	4,8–7,2	6,8–11,5
Gorenja Paka	ni podatka	7,1–8,2	5,7–6,5	7,7–10,7
Rožanec	50	6,8–7,9	5,8–6,4	7,8–10,5
Tušev Dol	66	6,8–8,4	5,4–6,7	7,4–10,9
Jerneja vas	51	8,7–8,9	5,9–6,5	7,9–10,7
Jelševnik	133	7,1–8,7	5,7–7,0	7,7–11,3
Petrova vas	100	7,2–8,5	5,8–6,9	7,8–11,1
Dragovanja vas	104	8,9–9,8	6,1–7,2	8,1–11,6
Mihelja vas	41	7,5–9,2	6,1–7,4	8,1–11,8
Ručetna vas	137	7,7–10,0	6,2–8,0	8,2–12,5

NASELJE	PREBIVALCI 2026	VOŽNJA PREBIVALCA DO ZD (MIN)	NUJNA VOŽNJA REŠEVALCEV, OCENA (MIN)	DOSTOPNI ČAS NMP, OCENA (MIN)
Stražnji Vrh	198	8,0–10,1	6,3–8,0	8,3–12,5
Doblička Gora	83	9,6–10,6	6,6–7,9	8,6–12,3
Talčji Vrh	29	8,5–9,1	7,3–7,3	9,3–11,7
Desinec	61	7,2–11,7	5,8–9,2	7,8–14,0
Rožič Vrh	52	8,6–10,6	6,8–8,4	8,8–13,0
Zastava	21	9,2–9,8	7,3–7,8	9,3–12,2
Grič pri Dobličah	82	10,2–11,4	7,1–8,5	9,1–13,1
Butoraj	127	10,2–10,6	8,1–8,3	10,1–12,9
Tanča Gora	241	10,3–12,1	7,3–9,2	9,3–14,0
Sela pri Dragatušu	72	11,1–11,6	7,9–8,8	9,9–13,5
Mavrlen	85	9,4–12,8	7,5–10,4	9,5–15,4
Naklo	52	10,6–12,9	8,4–10,3	10,4–15,3
Pavičiči	23	8,9–14,8	7,2–11,8	9,2–17,3
Breznik	24	12,8–13,8	9,2–10,4	11,2–15,5
Tribuče	314	11,2–13,4	9,0–10,6	11,0–15,8
Zorenci	23	11,6–13,2	9,3–10,5	11,3–15,6
Dragatuš	209	12,8–14,2	9,3–10,9	11,3–16,1
Rodine	137	12,3–13,9	9,8–11,2	11,8–16,4
Velika Lahinja	37	13,2–13,5	10,4–10,8	12,4–16,0
Obrh pri Dragatušu	87	14,2–14,6	10,3–11,1	12,3–16,4
Golek	35	14,1–14,7	10,3–11,3	12,3–16,6
Bistrica	1	12,8–15,6	10,2–11,9	12,2–17,4
Veliki Nerajec	75	14,0–15,8	10,2–12,2	12,2–17,8
Mali Nerajec	46	14,3–16,2	10,4–12,7	12,4–18,4
Dolenji Suhor pri Vinici	34	14,7–16,7	10,7–12,8	12,7–18,6
Pusti Gradec	26	15,1–16,3	11,1–12,6	13,1–18,2
Podlog	57	15,1–17,4	11,1–13,4	13,1–19,3
Cerkvišče	57	10,8–20,9	8,6–16,6	10,6–23,3
Bedenj	70	14,3–17,4	11,5–13,8	13,5–19,8
Griblje	329	10,4–22,2	8,4–17,7	10,4–24,7
Gornji Suhor pri Vinici	50	16,2–18,8	12,0–14,5	14,0–20,6

NASELJE	PREBIVALCI 2026	VOŽNJA PREBIVALCA DO ZD (MIN)	NUJNA VOŽNJA REŠEVALCEV, OCENA (MIN)	DOSTOPNI ČAS NMP, OCENA (MIN)
Brdarci	33	18,1–18,5	12,6–14,4	14,6–20,4
Mala Lahinja	21	17,0–18,8	12,6–14,6	14,6–20,7
Miklarji	0	15,7–19,2	12,5–14,7	14,5–20,9
Stara Lipa	88	16,4–19,4	12,2–15,0	14,2–21,3
Belčji Vrh	99	17,6–19,7	13,1–15,3	15,1–21,6
Pribinci	51	16,3–19,4	13,0–15,5	15,0–21,8
Jankoviči	51	16,3–20,0	13,1–15,9	15,1–22,4
Zapudje	76	18,7–19,8	14,0–15,3	16,0–21,6
Šipek	22	18,3–18,7	14,5–14,8	16,5–21,1
Dolenjci	87	16,7–20,6	13,4–16,4	15,4–23,0
Nova Lipa	85	18,7–22,1	13,9–17,1	15,9–23,9
Črešnjevec pri Dragatušu	6	19,4–21,3	14,6–16,6	16,6–23,3
Knežina	34	19,6–21,9	14,7–17,1	16,7–23,8
Fučkovci	37	18,1–22,2	14,5–17,7	16,5–24,6
Purga	25	18,6–22,9	14,9–18,3	16,9–25,3
Drežnik	35	20,2–24,0	15,1–18,6	17,1–25,8
Bojanci	77	19,1–23,9	15,3–19,1	17,3–26,3
Hrast pri Vinici	182	19,8–25,3	14,9–19,8	16,9–27,2
Drenovec	133	24,8–27,3	15,5–19,4	17,5–26,8
Adlešiči	106	20,0–24,6	16,0–19,6	18,0–27,1
Dragoši	26	13,6–24,9	16,2–19,8	18,2–27,3
Podbrežje	ni podatka	20,3–24,7	16,3–19,7	18,3–27,2
Gorenjci pri Adlešičih	51	21,6–26,6	17,3–21,3	19,3–29,1
Velika sela	21	22,2–26,3	17,7–20,9	19,7–28,6
Vrhovci	54	22,8–28,3	18,3–22,6	20,3–30,7
Ogulin	37	25,7–26,1	20,1–20,9	22,1–28,6
Mala sela	18	23,3–29,2	18,6–23,2	20,6–31,5
Marindol	91	23,6–29,2	18,9–23,3	20,9–31,6
Vinica	245	26,4–26,9	20,6–21,6	22,6–29,5
Perudina	61	25,2–28,9	20,1–22,6	22,1–30,7
Sečje selo	100	27,6–27,9	21,6–22,4	23,6–30,5

NASELJE	PREBIVALCI 2026	VOŽNJA PREBIVALCA DO ZD (MIN)	NUJNA VOŽNJA REŠEVALCEV, OCENA (MIN)	DOSTOPNI ČAS NMP, OCENA (MIN)
Stari trg ob Kolpi	83	26,6–31,9	20,3–25,0	22,3–33,7
Golek pri Vinici	54	28,7–29,4	22,9–23,0	24,9–31,2
Podklanec	87	28,8–29,4	23,0–23,1	25,0–31,4
Damelj	33	27,1–33,3	20,6–26,0	22,6–35,0
Miliči	20	28,0–34,7	22,4–27,7	24,4–37,1
Zilje	139	30,3–33,5	24,2–26,3	26,2–35,4
Sinji Vrh	71	29,8–35,9	22,8–28,2	24,8–37,7
Draga pri Sinjem Vrhu	19	30,3–35,7	23,2–28,0	25,2–37,5
Učakovci	105	33,2–33,9	26,1–27,1	28,1–36,4
Dolenji Radenci	21	31,5–37,2	24,2–29,2	26,2–39,0
Zagozdac	20	30,3–37,2	24,2–29,2	26,2–39,0
Žuniči	44	29,8–37,0	23,9–29,6	25,9–39,6
Balkovci	44	32,0–37,2	25,6–29,3	27,6–39,1
Paunoviči	27	31,0–38,4	24,9–30,7	26,9–40,9
Gorica	11	33,0–39,4	25,3–30,9	27,3–41,1
Gorenja Podgora	25	32,4–39,3	25,9–30,9	27,9–41,1
Sodevci	33	33,6–40,1	25,9–31,6	27,9–42,0
Vukovci	33	36,2–36,8	28,5–29,4	30,5–39,3
Preloka	103	33,0–40,7	26,4–32,4	28,4–43,1
Dolenja Podgora	8	34,2–41,1	27,3–32,3	29,3–42,9
Hrib	32	34,5–42,0	26,7–33,2	28,7–43,9
Špeharji	11	34,9–42,3	26,8–33,4	28,8–44,3
Dalnje Njive	16	38,1–39,4	29,5–30,9	31,5–41,2
Breg pri Sinjem Vrhu	1	37,1–44,7	28,6–35,2	30,6–46,5
Selce pri Špeharjih	2	37,4–45,0	28,9–35,6	30,9–47,0

Neopredeljeni pacienti in čakalne dobe

Dopolnitev 25. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Po navedbi ZD Črnomelj je imela ambulanta za neopredeljene 1. 8. 2026 registriranih 3.142 pacientov. To so ljudje, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. [13] Po izpisu ZZZS s 1. 9. 2026 med devetimi ambulantami družinske medicine in pediatrije na območju ZD nove paciente sprejema le ena. [138] Ambulante za neopredeljene od 1. 2. 2023 pokrivajo zdravniki ZD poleg svojega rednega dela. [121]

Pri specialističnih pregledih je slika slabša od slovenskega povprečja. V Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je najbližja bolnišnica za prebivalce Bele krajine, je 16. 9. 2026 na prvi pregled čakalo 5.945 ljudi, od tega 47,3 % dlje od dopustne čakalne dobe. V Sloveniji je bil ta delež 32,9 %. [130] Podatek velja za vse paciente te bolnišnice, ne samo za prebivalce Črnomlja.

Trenutno stanje

Na spletni strani splošnih ambulant sta ambulanti št. 2 in 3 v Črnomlju označeni kot »ambulanti za neopredeljene paciente«, podobno SA Semič 2. [13] [120] ZD v programu dela 2026 navaja vrzel dveh timov družinske medicine in načrtuje dodatne zaposlitve zdravnikov družinske medicine, pediatrije in urgentnih zdravnikov. [121] Zdravnica v Vinici je imela 1. 8. 2026 registriranih 1.426 pacientov. [12]

ZD Črnomelj v tedenskem izpisu NIJZ z dne 16. 9. 2026 ni naveden kot izvajalec s čakajočimi na storitve iz sistema eNaročanje. ZD Metlika in ZD Novo mesto sta navedena. [130] Iz izpisa ne moremo sklepati, ali to pomeni, da čakalnih seznamov ni, da storitve niso vključene v sistem ali da podatki manjkajo. Na spletni strani ZD so čakalne dobe dostopne le s povezavo na nacionalni portal.

Ključna dejstva

Osebni zdravnik

PODATEK	VREDNOST	VIR IN OMEJITEV
Registrirani v ambulantah za neopredeljene, 1. 8. 2026	3.142	Stran ZD. [13] Ni navedeno, ali številka vključuje Semič. To ni število vseh ljudi brez zdravnika v občini, saj nekateri niso registrirani nikjer.
Ambulante, ki sprejemajo nove paciente, 1. 9. 2026	1 od 9 (zasebnik s koncesijo)	Izpis ZZZS. [138] Stanje se lahko spreminja iz meseca v mesec.
Vrzel družinske medicine po programu 2026	2,00 tima (7,53 priznanega, 5,53 zagotovljenega)	Program dela ZD 2026. [121]
Dodatno delo zdravnikov	Ambulante za neopredeljene od 1. 2. 2023, SUC, urgentna in dežurna služba	Program dela ZD 2026. [121]

Čakalne dobe na prvi specialistični pregled, 16. 9. 2026

IZVAJALEC	ČAKAJOČI NA PRVI PREGLED	OD TEGA NAD DOPUSTNO DOBO	DELEŽ NAD DOPUSTNO DOBO
SB Novo mesto	5.945	2.814	47,3 %
Slovenija, vsi izvajalci	142.791	47.018	32,9 %

PRVI PREGLED V SB NOVO MESTO	ČAKAJOČI	NAD DOPUSTNO DOBO	ČAKALNA DOBA NA PRVI PROSTI TERMIN, STOPNJA »REDNO«
Ortopedski	1.728	597	118 dni
Kardiološki	1.403	883	541 dni
Dermatološki	731	310	647 dni
Revmatološki	517	394	862 dni
Nevrološki	505	359	443 dni
Psihiatrična obravnava	145	56	92 dni

Vir: tedensko poročilo NIJZ, list Tb 02, izračun seštevkov za izvajalca. [130] Stopnje nujnosti imajo različne dopustne dobe. Pacienti se lahko naročijo tudi drugje, kjer je čakanje lahko krajše, a to zahteva prevoz. Podatki so posnetek enega dne.

Viri

Podatki ZD so uradne objave na spletni strani in v programu dela. Izpis ZZZS je iz septembra 2026. Čakalne dobe so iz nacionalnega sistema eNaročanje. Za zdaj ni javnega vira, ki bi čakanje prikazal po občini prebivališča pacienta.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Več tisoč ljudi brez izbranega zdravnika	3.142 registriranih v ambulantah za neopredeljene. [13]
Skoraj nobena ambulanta ne sprejema novih pacientov	1 od 9 po ZZZS. [138]
Preobremenjenost zdravnikov	Ambulante za neopredeljene pokrivajo zdravniki poleg rednega dela. [121]
Dolgo čakanje na specialiste v regiji	SB Novo mesto 47,3 % nad dopustno dobo pri prvih pregledih. [130]
Ni lokalnega prikaza čakanja	ZD ni v tedenskem izpisu; čakanje po občini prebivališča ni objavljeno.

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Vodstvo ZD	Koliko prebivalcev Črnomlja in Semiča je neopredeljenih, ločeno po starosti 65+ in kroničnih boleznih? Mesečni agregati 2024–2026.
Vodstvo ZD	Koliko ur tedensko delajo ambulante za neopredeljene in kako dolgo se čaka na termin? Urnik in povprečna čakalna doba.
Vodstvo ZD	Zakaj ZD ni v tedenskem izpisu čakalnih dob NIJZ? Seznam storitev, vključenih v eNaročanje, in stanje čakajočih.
ZZZS OE Novo mesto	Koliko zavarovancev s prebivališčem v Občini Črnomelj nima izbranega osebnega zdravnika? Podatek po mesecih.

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Občinska uprava	Katere spodbude občina ponuja za pridobitev zdravnikov (stanovanje, štipendije, pomoč družini)? Seznam ukrepov, stroški in število pridobljenih zdravnikov.
Občinski svet	Ali ima občina načrt za kadrovske štipendije za medicino in pediatrijo? Sklep, pogoji, število štipendistov in obveznost dela.
Svet zavoda ZD	Kakšen je načrt zapolnitve vrzeli 2,00 tima do leta 2028? Časovnica, kadrovski načrt in razlogi za neuspešne razpise.
Ministrstvo za zdravje	Ali se Črnomelj šteje za deficitarno območje in katere državne spodbude veljajo? Seznam spodbud in meril.
SB Novo mesto	Kakšna je čakalna doba za kardiološke in revmatološke preglede za paciente iz Bele krajine? Podatek po občini prebivališča.
NIJZ	Ali je mogoče objaviti čakajoče po občini prebivališča? Metodologija in časovnica.
Patronažna služba ZD	Kako se spremljajo kronični bolniki brez izbranega zdravnika? Opis poti in obseg obiskov.

Tveganja

Ljudje brez izbranega zdravnika težje dobijo napotnice, redne preglede in spremljanje kroničnih bolezni. Lahko se zatekajo v nujno službo, ki je namenjena drugim stanjem. Nove spodbude lahko pritegnejo zdravnike iz sosednjih občin in tam povečajo primanjkljaj. Primerjave med izvajalci so občutljive na različno kodiranje nujnosti.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	ZD mesečno objavi število registriranih v ambulantah za neopredeljene, urnik in čakanje na termin.	5–10 ur mesečno; obstoječi kadri.	Preglednost; tveganje napačne primerjave z drugimi ZD. Mesečna objava 12 mesecev zapored.
0–12 mesecev	Referenčne ambulante in patronaža prednostno spremljajo neopredeljene kronične bolnike.	Obstoječi programi ZZZS.	Manj prekinitev v spremljanju; tveganje dodatne obremenitve. Delež kroničnih bolnikov s pregledom v 12 mesecih.
1–3 leta	Občina in ZD skupaj pripravita paket za pridobitev zdravnikov (stanovanje, štipendija, pomoč pri zaposlitvi partnerja).	Načrtovalna ocena 30.000–80.000 EUR letno; občinski proračun.	Več zdravnikov; tveganje, da ostanejo le kratek čas. Število novih zdravnikov in njihovo trajanje zaposlitve.
1–3 leta	Organiziran prevoz ali skupinski termini za specialistične preglede v drugih bolnišnicah s krajšim čakanjem.	Načrtovalna ocena 10.000–25.000 EUR letno; občina, prostovoljni prevozi.	Krajše čakanje; tveganje slabše kontinuitete. Število prepeljanih in prihranjen čas čakanja.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
3–10 let	Dolgoročna kadrovska strategija z usposabljanjem specializantov v Črnomlju in sodelovanjem z medicinskimi fakultetami.	Državni program specializacij; občinske štipendije.	Trajna rešitev; tveganje odhodov po specializaciji. Število specialistov, ki ostanejo vsaj 5 let.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril; ocenjujemo dostopnost in dokumentiranost, ne kakovosti dela zdravnikov.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	3: ZD objavlja število registriranih v ambulantah za neopredeljene, ne pa čakanja in urnika.
Dostop in razpoložljivost	2: skoraj nobena ambulanta ne sprejema novih pacientov; regijsko čakanje nad povprečjem.
Usklajenost s potrebami	2: starajoče se prebivalstvo s kroničnimi boleznimi potrebuje stalnega zdravnika.
Dokazna podlaga in spremljanje	3: nacionalni podatki obstajajo, lokalni prikaz po prebivališču ne.
Pravičnost in doseg	2: ljudje brez prevoza težje iščejo krajše čakanje drugje.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	2: dodatno delo zdravnikov ni dolgoročna rešitev.
Izvedljivost	3: ukrepi so znani, odvisni pa od trga zdravnikov.

Izračun: (3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3) / 7 = **2,43/5,** ❌. Povprečje je pod 2,5, poleg tega gre za potrjeno nerešeno tveganje za dostop do zdravstvene oskrbe.

Primerjave

Nacionalni delež čakajočih na prve preglede nad dopustno dobo je bil 16. 9. 2026 32,9 %, v SB Novo mesto 47,3 %. **[130]** Za primerjavo števila neopredeljenih med občinami bi potrebovali enotne podatke ZZZS po prebivališču; v pregledanih virih jih ni.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Število neopredeljenih prebivalcev občine	Zahteva ZZZS OE Novo mesto.
Čakanje za prebivalce Bele krajine	Zahteva NIJZ ali SB Novo mesto za podatke po prebivališču.

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Časovni trend	Ponavljati posnetek tedenskega poročila NIJZ vsak mesec.

Digitalno zdravje: eNaročanje, zVEM in e-posvet

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Digitalne poti do zdravnika postajajo standard. 97 % receptov in napotnic je elektronskih, mesečno je opravljenih več kot 700.000 elektronskih naročil, portal zVEM pa ima več kot 700.000 registriranih uporabnikov. [168] [169] ZD Črnomelj je 17. 9. 2026 začel testno uvajati elektronsko komunikacijo prek zVEM v eni ambulanti, vse ambulante naj bi sledile do konca leta 2026. [170]

Za Črnomelj je ključno vprašanje, kdo bo ostal zunaj. Leta 2025 je interneta še nikoli ni uporabilo 56 % ljudi, starih 75–89 let, v skupini 65–74 let pa je bilo brez digitalnih veščin 35 %. [171] [172] Občina ima starejše in manj izobraženo prebivalstvo od slovenskega povprečja. [58] [3] NIJZ je maja in junija 2026 odprl točke za pomoč pri zVEM (»digitočke«) tudi v ZD Novo mesto in ZD Trebnje, v objavljenem seznamu pa ZD Črnomelj ni naveden. [173]

Trenutno stanje

Na spletni strani ZD Črnomelj je elektronsko naročanje navedeno kot zaželen način. Ostajajo tudi osebno, telefonsko in pisno naročanje. [174] Spletni obrazec za e-komunikacijo omogoča izbiro zdravnika in namen (obisk, recept, napotnica), odgovor pa ZD obljublja v 24 urah v času delovanja ambulante. [175] Prek zVEM bodo pacienti lahko pošiljali varna sporočila, videli izvide, recepte in napotnice ter dodelili pooblastila svojcem ali skrbnikom. [170]

Na nacionalni ravni je elektronsko komunikacijo prek zVEM uvedlo 180 izvajalcev. V prvi polovici leta 2026 je bilo izvedenih več kot 60 digitočk, NIJZ pa načrtuje, da se bo do konca leta 2026 priključila večina izvajalcev na primarni ravni. [169] Za pomoč je na voljo klicni center eZdravja vsak dan med 7. in 22. uro (080 72 99). [14]

Ključna dejstva

eZdravje v Sloveniji

PODATEK	VREDNOST	VIR
Delež elektronskih receptov / napotnic	97 % / okoli 97 %	[168]
Elektronska naročila na mesec	več kot 700.000	[168]
Registrirani uporabniki zVEM (september 2026)	več kot 700.000; s povezanimi osebami več kot 900.000	[169]
Izvajalci z e-komunikacijo prek zVEM	180	[169]

Digitalna vključenost po starosti (Slovenija, 2025)

SKUPINA	PODATEK	VIR
65–74 let	71 % uporablja internet (največ doslej); 35 % brez digitalnih veščin	[171] [172]
75–89 let	40 % uporablja internet, 56 % ga ni še nikoli; 21 % je na spletu iskalo zdravstvene informacije	[171]
Z največ osnovnošolsko izobrazbo	30 % ima vsaj osnovne digitalne veščine (visokošolsko izobraženi: 71 %)	[172]

Zakaj je to za Črnomelj pomembno

LOKALNI DEJAVNIK	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	VIR
Prebivalci, stari 65 let ali več (1. 1. 2026)	25,5 %	22,5 %	[58]
Odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo (izdaja 2026)	15,5 %	11,8 %	[3]
Najbližja digitočka zVEM (maj–junij 2026)	ZD Novo mesto ali ZD Trebnje	–	[173]

Iz nacionalnih deležev ne moremo izračunati, koliko prebivalcev Črnomlja ne uporablja interneta. Starejša in manj izobražena sestava pa pomeni, da je tveganje za digitalno izključenost verjetno večje od povprečja. To je sklep, ne meritev.

Viri

Podatki NIJZ so samoporočanje upravljavca sistema. SURS je uradna statistika za Slovenijo in nima občinskih podatkov. Strani ZD kažejo objavljeno ponudbo, ne dejanske uporabe v Črnomlju.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Nevarnost izključitve starejših	56 % ljudi, starih 75–89 let, interneta še ni uporabilo. [171]
Ni lokalne točke za pomoč	ZD Črnomelj ni na seznamu digitočk maj–junij 2026. [173]
Hkrati več poti	Spletni obrazec, zVEM in telefon; pacientom ni jasno, katero pot uporabiti. [175] [170]
Ni lokalnih podatkov o uporabi	Delež pacientov ZD, ki uporabljajo zVEM ali e-naročanje, ni objavljen.

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Vodstvo ZD	Kakšen je časovni načrt uvedbe zVEM komunikacije v vseh ambulantah? Seznam ambulant in datumi.
Vodstvo ZD	Koliko sporočil prek e-komunikacije ambulante prejmejo na teden in v kolikšnem času odgovorijo? Agregirani podatki.
Vodstvo ZD	Ali bo telefonsko naročanje ostalo enako dostopno in kako dolgo se čaka na zvezo? Meritve klicev.
Vodstvo ZD	Ali lahko ZD organizira zVEM digitočko v Črnomlju, Vinici in Semiču? Dogovor z NIJZ.
NIJZ	Koliko registriranih uporabnikov zVEM je v Občini Črnomelj po starostnih skupinah? Agregirani podatki.
Občinska uprava	Ali občina podpira tečaje digitalne pismenosti za starejše (knjižnica, ljudska univerza, društva)? Programi in udeležba.
Društva upokojencev	Ali člani potrebujejo pomoč pri zVEM in pooblastilih? Anketa ali evidenca prošenj.
Patronažna služba	Ali patronažne sestre pomagajo starejšim pri urejanju pooblastil? Opis in obseg.
Knjižnica Črnomelj	Ali lahko postane stalna točka za pomoč pri eZdravju? Urnik in usposobljeno osebje.
Šole in mladinske organizacije	Ali bi lahko mladi prostovoljci pomagali starejšim (medgeneracijsko)? Program.

Tveganja

Digitalizacija lahko skrajša pot tistim, ki že imajo dober dostop, drugim pa jo podaljša. Pooblastila olajšajo pomoč svojcev, a zahtevajo zaupanje in zaščito pred zlorabo. Sporočila niso primerna za nujna stanja; za to ostaja številka 112.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	ZD in NIJZ organizirata zVEM digitočko v Črnomlju, z izpostavami v Vinici in Semiču.	Program NIJZ; prostor ZD ali knjižnice.	Lažja registracija; tveganje nizkega obiska. Število obiskovalcev in novih registracij.
0–12 mesecev	ZD na enem mestu jasno opiše vse poti naročanja in zagotovi, da telefon ostane enakovreden.	5–10 ur.	Manj zmede; brez večjega tveganja. Čas čakanja na telefonsko zvezo.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
1–3 leta	Občina, knjižnica in društva izvajajo redne tečaje digitalnega zdravja za starejše, tudi o pooblastilih.	Načrtovalna ocena 3.000–6.000 EUR letno; občina, razpisi za digitalno vključenost, če so na voljo.	Večja samostojnost; tveganje, da dosežemo le že vešče. Udeleženci po starosti in krajih.
1–3 leta	Medgeneracijski prostovoljci (dijaki) pomagajo starejšim pri zVEM.	Šolski programi prostovoljstva.	Hitra pomoč; tveganje zasebnosti. Število pomoči in pritožb.
3–10 let	Redno spremljanje digitalne vključenosti in dostopnosti po krajih (z NIJZ).	10–20 ur letno.	Pravočasno ukrepanje; tveganje slabe kakovosti podatkov. Letni agregati po starosti.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	3: ZD objavlja poti naročanja in uvedbo zVEM; podatkov o uporabi ni.
Dostop in razpoložljivost	3: več poti, telefon ostaja; zVEM komunikacija šele v uvajanju.
Usklajenost s potrebami	2: starejše prebivalstvo, lokalne pomoči pri uporabi ni.
Dokazna podlaga in spremljanje	2: ni lokalnih podatkov o uporabi.
Pravičnost in doseg	2: nevarnost izključitve starejših in manj izobraženih.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	4: nacionalni sistem je trajen in se širi.
Izvedljivost	4: digitočke in pooblastila že obstajajo.

Izračun: (3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4) / 7 = **2,86/5,** ⚠️.

Primerjave

Nacionalno ima zVEM več kot 700.000 uporabnikov, kar je okoli tretjina prebivalcev. **[169]** Primerljivega podatka za Črnomelj ni.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Uporaba zVEM v občini	Zahteva NIJZ za agregirane podatke.

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Učinek na dostop starejših	Spremljanje telefonskega naročanja in pritožb po uvedbi zVEM.

Dolgotrajna oskrba in pomoč na domu

Dopolnitev 25. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Po profilu NIJZ je bilo leta 2024 v pomoč na domu vključenih 1,0 % prebivalcev Črnomlja, starih 65 let ali več. V Sloveniji je bil ta delež 1,8 %. Razlika je statistično značilna in za občino neugodna. [2] Po podatkih IRSSV je izvajalec DSO Črnomelj v letu 2024 oskrboval 67 uporabnikov, 31. 12. 2024 pa 37. Uporabnik je plačal 8,40 EUR na uro ob delavnikih. Slovensko povprečje je bilo 6,92 EUR. [176]

Nacionalni program socialnega varstva si je za cilj zastavil, da se v pomoč na domu vključi 3 % oseb, starih 65 let ali več. V Črnomlju bi to pomenilo približno 105 ljudi. Leta 2024 je bilo takih uporabnikov 64. [176] Od julija 2025 se po zakonu o dolgotrajni oskrbi izvaja oskrba na domu, vloge pa za prebivalce Črnomlja obravnava vstopna točka v Novem mestu. Center za socialno delo sam opozarja na večmesečne zamude. [23] [177]

Trenutno stanje

Dolgotrajno oskrbo ureja Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). Dolgotrajna oskrba na domu se izvaja od 1. 7. 2025, celodnevna oskrba v instituciji in dnevna oskrba od 1. 12. 2025. [23] Vstopna točka za Občino Črnomelj je CSD Dolenjska in Bela krajina v Novem mestu. Pristojne enote so Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje. [177] CSD na svoji strani navaja, da zaradi izjemno povečanega števila vlog in odsotnosti informacijskega sistema prihaja do večmesečnih zamud pri odločbah. [23]

Državni zbor je 18. 9. 2026 sprejel interventni zakon. Prinaša enako plačilo za enake potrebe v domovih, dobropis za tiste, ki so zaradi zamud plačevali več, in začasen dodatek 300 EUR bruto za zaposlene, ki neposredno izvajajo oskrbo. Obstoječi način financiranja izvajalcev podaljšuje do konca leta 2027. [178] To je medijski povzetek zakonodajnega postopka; besedilo zakona v tem pregledu ni prebrano.

Ključna dejstva

Pomoč na domu v Črnomlju, 2024

PODATEK	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	VIR
Delež oseb 65+ v pomoči na domu (NIJZ, 2024)	1,0 %	1,8 %	Značilno slabše od povprečja. [2]
Uporabniki v letu 2024 / na dan 31. 12. 2024	67 / 37	13.636 / 9.121	[176]
Uporabniki 65+ v letu 2024	64 (1,8 % oseb 65+)	–	Cilj ReNPSV: 3 % = 105 oseb. [176]
Novo vključeni / zaključili v letu	27 / 30	–	[176]

PODATEK	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	VIR
Povprečno ur storitve na uporabnika v letu	123,84	–	[176]
Cena za uporabnika ob delavniku	8,40 EUR/uro	6,92 EUR/uro	Nedelja 11,70, praznik 12,55 EUR. [176]
Ekonomska cena ob delavniku	27,19 EUR/uro	–	Občina krije 69,1 %, uporabnik 30,9 %. [176]
Čakajoči na pomoč na domu	ni podatka za občino	najmanj 1.441 (konec 2024)	[176]

Opozorilo: NIJZ in IRSSV uporabljata različna imenovalca. NIJZ navaja delež na dan 31. 12., IRSSV pa tudi letni obseg. Zato sta 1,0 % in 1,8 % lahko oba pravilna.

Obseg pravic po ZDOsk-1

PRAVICA	ZAČETEK IZVAJANJA	OBSEG
Dolgotrajna oskrba na domu	1. 7. 2025	20–110 ur mesečno glede na kategorijo 1–5 [23]
Dnevna oskrba pri izvajalcu	1. 12. 2025	7–37 ur mesečno [23]
Celodnevna oskrba v instituciji	1. 12. 2025	Po kategoriji [23]
Oskrbovalec družinskega člana	Za 4. in 5. kategorijo	[23]

Viri

IRSSV letno spremlja vse izvajalce pomoči na domu; prebrani so povzetek in priloge za Črnomelj. NIJZ je uradni profil občine. Podatki o zakonu so iz strani CSD in medijskega poročila. Podatkov o številu vlog in čakanju na odločbe za Črnomelj v pregledanih virih ni.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Nizka vključenost starejših	1,0 % proti 1,8 %, značilno slabše. [2]
Daleč od nacionalnega cilja	64 uporabnikov 65+ proti 105 pri cilju 3 %. [176]
Višja cena za uporabnika	8,40 EUR proti 6,92 EUR povprečno. [176]
Zamude pri odločbah	Večmesečne, po navedbi CSD. [23]
Oddaljena vstopna točka	Novo mesto, uradne ure trikrat na teden. [23]

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Občinska uprava	Zakaj je cena za uporabnika višja od slovenskega povprečja in ali občina razmišlja o večji subvenciji? Izračun cene in primerjava.
Občinska uprava	Koliko prebivalcev čaka na pomoč na domu in koliko je odklonjenih? Mesečni podatki.
DSO Črnomelj	Koliko oskrbovalk dela na terenu in koliko ur je nepokritih zaradi pomanjkanja kadra? Kadrovski podatki 2024–2026.
DSO Črnomelj	Koliko časa izgubijo oskrbovalke za vožnjo v oddaljene kraje? Ure vožnje in plačilo prevoza.
CSD Dolenjska in Bela krajina	Koliko vlog za dolgotrajno oskrbo je bilo vloženih iz Črnomlja in kako dolgo čakajo na odločbo? Agregirani podatki.
CSD enota Črnomelj	Ali lahko ljudje oddajo vlogo in dobijo pomoč v Črnomlju, ne le v Novem mestu? Opis postopka.
Ministrstvo za solidarno prihodnost	Kdaj bo informacijski sistem deloval in zamude odpravljene? Časovnica.
Patronažna služba ZD	Kako se usklajuje zdravstvena nega z oskrbo na domu? Protokol sodelovanja.
Občinski svet	Ali bo občina sprejela cilj vključenosti (npr. 3 %) in ga spremljala letno? Sklep in kazalnik.
Društva upokojencev	Ali prostovoljci pomagajo pri oddaji vlog in prevozih? Seznam in obseg pomoči.

Tveganja

Nizka vključenost je lahko znak neznanja, visoke cene, pomanjkanja kadra ali močne družinske pomoči. Ne vemo, kateri razlog prevladuje. Prenizka cena lahko ogrozi kakovost in plače oskrbovalk. Družinski oskrbovalci, pogosto ženske, lahko prevzamejo breme brez podpore.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	Občina, CSD enota Črnomelj in DSO organizirajo lokalno pomoč pri oddaji vlog (npr. enkrat tedensko v Črnomlju).	10–20 ur mesečno; obstoječi kadri.	Hitrejše vloge; tveganje dodatne obremenitve CSD. Število oddanih vlog in čas do odločbe.
0–12 mesecev	Obveščanje starejših o pomoči na domu in dolgotrajni oskrbi prek patronaže, CKZ in društev.	5.000 EUR za gradiva; občina.	Več vključenih; tveganje povpraševanja brez kadra. Število novih uporabnikov.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
1–3 leta	Občina preuči znižanje cene za uporabnika vsaj na slovensko povprečje.	Načrtovalna ocena: razlika 1,48 EUR/uro × obseg ur (ob 67 uporabnikih in 124 urah okoli 12.000 EUR letno).	Dostopnejša storitev; tveganje rasti stroškov. Delež 65+ v pomoči na domu.
1–3 leta	DSO in občina zagotovita plačilo potnih stroškov in časa vožnje za oskrbovalke na podeželju.	Po izračunu ur vožnje; občina.	Boljša dostopnost za oddaljene kraje; tveganje stroškov. Delež uporabnikov iz oddaljenih KS.
3–10 let	Razvoj dnevnih centrov in skupnostnih oblik oskrbe v večjih krajih (Vinica, Dragatuš).	Investicije po projektu; državni in evropski skladi, če so na voljo.	Manj institucionalizacije; tveganje nizke zasedenosti. Število vključenih in čas bivanja doma.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	3: IRSSV in NIJZ objavljata podatke, čakanje na lokalni ravni ni javno.
Dostop in razpoložljivost	2: nizka vključenost, oddaljena vstopna točka, zamude.
Usklajenost s potrebami	2: staro prebivalstvo, vključenost pod ciljem.
Dokazna podlaga in spremljanje	3: redno nacionalno spremljanje.
Pravičnost in doseg	2: višja cena in oddaljenost vplivata na ljudi z nižjimi dohodki.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene: ni podatkov o izidih.
Vzdržnost	2: kadrovski primanjkljaj in začasne rešitve do 2027.
Izvedljivost	3: ukrepi so znani, odvisni od kadra in države.

Izračun: (3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3) / 7 = **2,43/5,** ❌ zaradi povprečja pod 2,5 in potrjene statistično značilne nizke vključenosti.

Primerjave

Črnomelj je glede vključenosti v pomoč na domu pod slovenskim in regionalnim povprečjem (regija 1,7 %). **[2]** Cena za uporabnika je nad slovenskim povprečjem. **[176]** Primerjava s podobnimi podeželskimi občinami je mogoča s prilogami IRSSV, a tu ni izvedena.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Čakalni seznam za Črnomelj	Uradni podatek DSO Črnomelj ali občine.
Vloge za dolgotrajno oskrbo	Agregirani podatki CSD.

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Razlogi za nizko vključenost	Anketa med starejšimi in svojci v sodelovanju z društvi.

Demenca in demenci prijazna občina

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

NIJZ je v publikaciji »Zdravje v občini 2026« za osrednjo temo izbral demenco in občinam priporočil konkretne ukrepe. Po NIJZ bi bilo mogoče z vplivom na 14 spremenljivih dejavnikov tveganja pojav demence preprečiti ali zamakniti v 45 % primerov (povzeto po komisiji revije Lancet, 2024). [2] Nacionalna strategija ocenjuje, da v Sloveniji živi okoli 43.000 ljudi z demenco, leta 2050 pa naj bi jih bilo okoli 85.000. [179]

Za Črnomelj lokalne meritve ni. Okvirni preračun nacionalne ocene na prebivalce občine da **približno 290–380 oseb z demenco** (širši razpon 250–440). [179] [58] Demenci prijazne točke v Črnomlju v javnih virih nismo našli; najbližja dokumentirana je v DSO Metlika. [25] [180]

Trenutno stanje

Vlada je strategijo obvladovanja demence do leta 2030 sprejela julija 2023, prvi dvoletni akcijski načrt (2024–2025) pa 11. 1. 2024. [179] [181] Strategija sama navaja, da nacionalni register demence, epidemiološke študije in mreža spominskih centrov iz prejšnje strategije niso bili vzpostavljeni ter da večina oseb z demenco živi doma. [179]

Lokalno: DSO Črnomelj je junija 2018 gostil brezplačen tridnevni program »Več in še več o demenci« za poklicne in neformalne oskrbovalce, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. [182] Novejše lokalne dejavnosti (skupine za samopomoč svojcev, demenci prijazna točka, usposabljanje javnih uslužbencev) v pregledanih virih niso dokumentirane. Status: Unverified. DSO Metlika ima demenci prijazno točko od 4. 4. 2018, odprto od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. [25]

Ključna dejstva

Obseg in stroški

PODATEK	VREDNOST	VIR IN OMEJITEV
Ljudje z demenco v Sloveniji	~43.000 (36.800–50.200)	Ocena GBD za 2019 v strategiji. [179]
Napoved za leto 2050	~84.700 (69.300–101.500)	[179]
Okvirna ocena za Črnomelj	290–380 (250–440)	Nacionalna ocena, preračunana na prebivalce 2026 oziroma na starejše od 65 let (3.616). [58] Ni lokalna meritev; starejša sestava Črnomlja pomeni, da je zgornji del razpona verjetnejši.

PODATEK	VREDNOST	VIR IN OMEJITEV
Letni stroški demence v Sloveniji, 2019–2023	~546 mio EUR	Neformalna oskrba 46,2 %, socialno varstvo 42,2 %, zdravstvo 11,6 %. [2]

Dejavniki tveganja z lokalnim podatkom

DEJAVNIK (LANCET 2024 PO NIJZ)	LOKALNI PODATEK	VIR
Nižja izobrazba	Odrasli z največ osnovnošolsko izobrazbo: 15,5 % (Slovenija 11,8 %), izdaja 2026	[3]
Visok krvni tlak	Delež prejemnikov zdravil je po NIJZ višji od slovenskega povprečja (značilno različen)	[2]
Sladkorna bolezen	Po besedilu NIJZ višji delež prejemnikov zdravil (razlika ni statistično značilna)	[2]
Telesna nedejavnost, debelost, kajenje, alkohol, izguba sluha in vida, osamljenost	Primerljivih lokalnih podatkov ni ali so obravnavani v drugih poglavjih	–

Zdravila niso isto kot bolezen, dejavniki tveganja pa niso napoved demence pri posamezniku.

Kaj NIJZ priporoča občinam [2]

PODROČJE	PRIMER UKREPA
Ozaveščanje in komunikacija	Usposabljanje javnih uslužbencev: kratki in jasni stavki, mirno govorjenje, očesni stik.
Varnost v okolju	Boljša označenost, varne poti, klopi; usposabljanje policije za ravnanje z zmedeno osebo.
Podpora v skupnosti	Dnevni centri in druženja; skupine za samopomoč svojcev.
Preventiva	Zmanjševanje dejavnikov tveganja skozi vse življenje.

Viri

Strategija je prebrana v primarnem besedilu. Podatek o 45 % in 14 dejavnikih je povzet po NIJZ, ki navaja komisijo revije Lancet (2024); izvirnega članka v tem pregledu nismo brali. Lokalni preračun je naša ocena z jasno metodo, ne meritev.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Ni lokalnih podatkov o demenci	Ni registra; lokalno število je le ocena. [179]
Ni dokumentirane demenci prijazne točke v Črnomlju	Najbližja je v Metliki. [25]
Svojci nosijo največji del bremena	Neformalna oskrba je 46,2 % stroškov. [2]
Nizka vključenost v pomoč na domu	1,0 % starejših (Slovenija 1,8 %), glej poglavje o dolgotrajni oskrbi. [2]
Več dejavnikov tveganja nad povprečjem	Nižja izobrazba, zdravila za krvni tlak. [3] [2]

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Župan in občinska uprava	Ali ima občina načrt za demenci prijazno okolje, kot ga predlagata strategija in NIJZ? Dokument, odgovorna oseba, roki.
Občinska uprava	Ali bo občina vzpostavila demenci prijazno točko (npr. v knjižnici, DSO ali na občini)? Lokacija, urnik, usposobljeno osebje.
ZD Črnomelj	Kako poteka zgodnje odkrivanje kognitivnih motenj v ambulantah družinske medicine in referenčnih ambulantah? Uporabljeni presejalni testi in število testiranih.
ZD Črnomelj	Kam so napoteni bolniki za diagnostiko (spominska ambulanta, nevrolog) in kako dolgo čakajo? Pot napotitve in čakalne dobe.
CKZ	Ali delavnice vključujejo preventivo demence (gibanje, krvni tlak, sluh, socialni stiki)? Program in udeležba.
DSO Črnomelj	Koliko postelj ali prostorov je prilagojenih osebam z demenco in kakšna je čakalna vrsta? Podatki na dan 31. 12.
CSD in dolgotrajna oskrba	Koliko oseb z demenco je vključenih v dolgotrajno oskrbo na domu? Agregirani podatki.
Policijska postaja	Ali so policisti usposobljeni za ravnanje z izgubljeno osebo z demenco? Število usposobljenih.
Društva upokojencev, Rdeči križ, Karitas	Ali obstajajo skupine za samopomoč svojcev? Seznam in termini.
Knjižnica in ljudska univerza	Ali lahko izvajajo programe za ohranjanje kognitivnih sposobnosti? Programi in udeležba.
Ministrstvo za zdravje	Kdaj bo vzpostavljen nacionalni register in mreža spominskih centrov, ki bi pokrila Belo krajino? Časovnica.

Tveganja

Etiketiranje in stigma lahko ljudi odvrneta od iskanja pomoči. Seznami oseb z demenco na lokalni ravni bi bili občutljivi osebni podatki in niso primerni. Preventivni ukrepi delujejo dolgoročno in ne bodo vidni v kratkem času. Lokalna ocena števila ljudi z demenco ne sme biti uporabljena kot natančna številka za načrtovanje zmogljivosti brez dodatnih podatkov.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	Občina v sodelovanju s Spominčico odpre demenci prijazno točko v Črnomlju (npr. knjižnica, DSO ali občina).	Usposabljanje osebja; predvsem obstoječi kadri.	Dostopne informacije; tveganje le formalne točke. Točka odprta, število obiskov in usposobljenih v 12 mesecih.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	Usposabljanje zaposlenih na občini, pošti, v trgovinah, bankah in pri policiji.	10–20 ur za organizacijo; programi Spominčice.	Varnejše okolje; tveganje nizke udeležbe. Število usposobljenih po ustanovah.
1–3 leta	Skupina za samopomoč svojcev in razbremenitveni programi v sodelovanju z DSO in CSD.	Načrtovalna ocena 3.000–8.000 EUR letno; občina, razpisi, če so na voljo.	Manj izgorelosti svojcev; tveganje nestalnih izvajalcev. Število srečanj in udeležencev.
1–3 leta	ZD in CKZ uvedeta sistematično presejanje kognitivnih motenj pri starejših v referenčnih ambulantah.	Obstoječi programi; usposabljanje.	Zgodnejša diagnoza; tveganje brez poti za nadaljnjo obravnavo. Delež presejanih 65+ in čakalna doba na diagnostiko.
3–10 let	Dnevni center za osebe z demenco v Črnomlju ali dnevna oskrba po ZDOsk-1.	Investicija po projektu; dolgotrajna oskrba in morebitna evropska sredstva.	Daljše bivanje doma; tveganje nizke zasedenosti. Število vključenih in čas do institucionalizacije.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril; ocenjujemo dokumentiranost in pripravljenost lokalnega okolja, ne kakovosti oskrbe.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	2: nacionalni dokumenti so javni, lokalni načrt in podatki ne.
Dostop in razpoložljivost	2: ni lokalne demenci prijazne točke; nizka vključenost v pomoč na domu.
Usklajenost s potrebami	2: staro prebivalstvo, dejavniki tveganja nad povprečjem, malo lokalnih ukrepov.
Dokazna podlaga in spremljanje	2: ni registra in ni lokalnih podatkov.
Pravičnost in doseg	2: oddaljeni kraji in svojci brez podpore.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	3: nacionalna strategija in dolgotrajna oskrba dajeta okvir do 2030.
Izvedljivost	4: ukrepi so poceni in podprti s Spominčico ter NIJZ.

Izračun: (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4) / 7 = **2,43/5,** ❌ po pravilu povprečja pod 2,5.

Primerjave

NIJZ navaja, da se Slovenija po številu ljudi z demenco na prebivalca uvršča v vrh držav OECD. [2] Primerjava med občinami ni mogoča, ker ni lokalnih podatkov.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Lokalno število oseb z demenco	Agregirani podatki ZZZS o zdravilih za demenco ali diagnozah (brez osebnih podatkov).
Obstoj lokalnih programov	Uradni odgovor občine, DSO in CSD.

Okolje in življenjske razmere

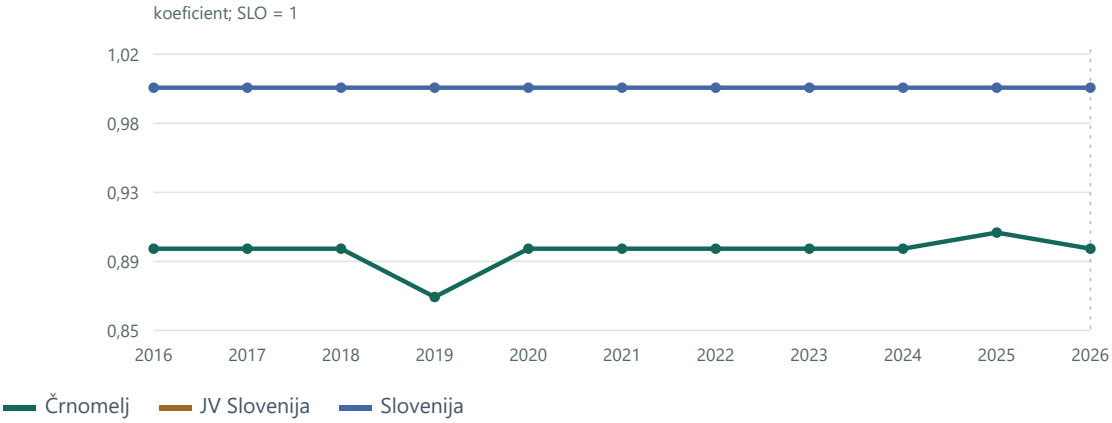
Dohodki, stres, domača hrana, pitna voda in kakovost zraka. Razlikujte obdobja meritev, lokacije in manjkajoče podatke.

12 Okolje in življenjske razmere

Koeficient razvitosti občine je sestavljen kazalnik za financiranje občin, katerega vir je Ministrstvo za finance. NIJZ ga objavlja, ne izračunava kot samostojno zdravstveno diagnozo. V prikazanih izdajah niha med 0,87 in 0,91; prvi in zadnji podatek sta 0,90. **[61][3]**

Razvitost občine

K1.1 · leto objave podatkov



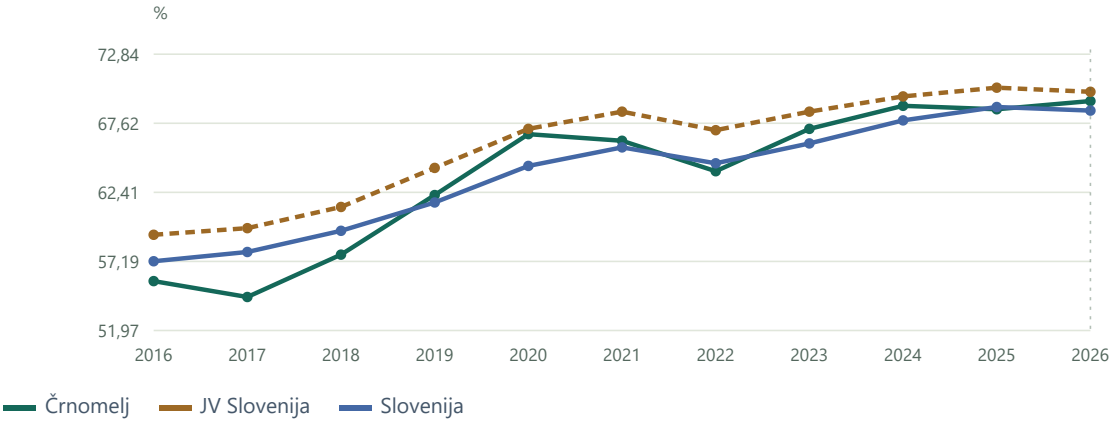
0,87–0,91; ponovitev iste vrednosti ni nova letna meritev. **[3]**

▼ Odpri podatkovno tabelo

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	0,9	—	1
2017	0,9	—	1
2018	0,9	—	1
2019	0,87	—	1
2020	0,9	—	1
2021	0,9	—	1
2022	0,9	—	1
2023	0,9	—	1
2024	0,9	—	1
2025	0,91	—	1
2026	0,9	—	1

Delovna aktivnost

K1.5 · leto objave podatkov



Zadnja izdaja 69,3 %; nad slovensko vrednostjo že v izdaji 2019. **[3]**

▼ **Odpri podatkovno tabelo**

IZDAJA	ČRNOMELJ	JV SLOVENIJA	SLOVENIJA
2016	55,7	59,2	57,2
2017	54,5	59,7	57,9
2018	57,7	61,3	59,5
2019	62,2	64,25	61,64
2020	66,8	67,2	64,4
2021	66,3	68,5	65,8
2022	64	67,1	64,6
2023	67,2	68,5	66,1
2024	68,94	69,65	67,84
2025	68,68	70,31	68,85
2026	69,3	70	68,58

Delovna aktivnost je od prve do zadnje izdaje zrasla za 13,6 odstotne točke. Slovensko vrednost je presegla že v izdaji 2019, zato leto 2026 ni prvi tak primer. Kazalnika opisujeta okoliščine, ne dokazujeta lokalnih vzrokov bolezni. **[3]** Poročilo WHO o zdravstvenih neenakostih poudarja pomen življenjskih in delovnih razmer ter dostopa do virov; za Črnomelj bi morali te povezave preveriti z lokalnimi podatki. **[183]**

Razlago povezav med razvitostjo in zdravjem dopolnjujejo naslednja poglavja z meritvami pitne vode, zraka in predlogi ukrepov.

13 Razvitost, dohodki, stres in domača hrana

Dopolnitev 24. septembra 2026 · obdobja meritev so navedena pri podatkih

Višji in varnejši dohodki, kakovostno bivanje, dostopne storitve ter manj dolgotrajnega stresa lahko izboljšajo zdravje. Podeželski značaj občine in domača pridelava hrane sama zase ne dokazujeta boljšega zdravja. Lokalna dokaza, ki zahtevata pozornost, sta pojav enteroparazitov na območju Adlešičev v letu 2025 in visoka izpostavljenost delcem ter benzo(a)pirenu na merilnem mestu Črnomelj v letu 2024. [184] [6] [7]

Presek raziskave je 24. september 2026. Pregled vode zajema vsako objavljeno letno poročilo 2011–2025 ter objavljene izvide VS Črnomelj za leto 2026. Za starejša leta obstajajo grafični prikazi, ne pa v tem pregledu preverjena izvorna letna števila. Pri zraku so lokalni podatki potrjeni za 2024, 2025 in del 2026. To ni popolna evidenca vseh meritev, vseh zasebnih vodnih virov ali vseh naselij v občini.

Kako življenjske razmere vplivajo na zdravje

DEJAVNIK	VERJETNA POT VPLIVA IN DOKAZNA PODLAGA	KAJ LAHKO SKLEPAMO ZA ČRNOMELJ
Razvitost in javne storitve	Stanovanjske razmere, izobrazba, delo, socialna varnost in dostop do kakovostne hrane pomembno oblikujejo zdravstvene razlike. [184]	Koeficient razvitosti občine ni zdravstvena diagnoza. Za presojo so potrebni tudi podatki o revščini, dostopu in porazdelitvi koristi razvoja.
Dohodki	Višji razpoložljivi dohodek lahko izboljša možnosti za primerno bivanje, ogrevanje, prehrano in prevoz. Povezanost dohodka z zdravjem ne pomeni, da je mogoče iz občinske povprečne plače izračunati zdravstveni učinek. [184]	SURS za 2024 navaja povprečno bruto plačo 2.016,60 EUR v občini in 2.394,92 EUR v Sloveniji; neto 1.306,78 in 1.526,02 EUR. To ni dohodek vseh gospodinjstev ali vseh prebivalcev. [185]
Manj dolgotrajnega stresa	Dolgotrajni stres lahko poslabša spanje, obstoječe zdravstvene težave in duševno zdravje ter spremljajoča vedenja. [186]	Trditev, da je življenje v Črnomlju manj stresno, ostaja hipoteza. Potrebna je primerljiva anketa; naravno okolje ne izključi stresa zaradi dela, finančnih težav ali prevozov.
Vrtnarjenje in samooskrba	Randomizirana raziskava 291 odraslih v ZDA je zaznala ugodnejše spremembe vnosa vlaknin, gibanja, stresa in tesnobe; ni dokazala sprememb BMI, obsega pasu ali skupnega vnosa sadja in zelenjave. To ni dokaz preprečenih bolezni. [187]	Prostor za vrt je možnost, ne meritev prehrane. Učinek je odvisen od dejanskega uživanja pridelkov, dostopa do zemlje, časa, vode in znanja. Raziskava skupnostnih vrtov ni neposredna ocena domače pridelave v Beli krajini.
Kakovost hrane	Zdravstvena vrednost je odvisna od sestave prehrane, raznovrstnosti in varnosti, ne samo od lokalnega izvora. [188]	Domače ne pomeni samodejno bolj zdravo ali brez onesnaževal. Potrebni so varna voda, primerna tla, pravilna uporaba sredstev ter varno ravnanje in shranjevanje. To so načrtovalna merila, ne ugotovitev onesnaženosti lokalnih pridelkov.
Varna voda	Mikrobiološko onesnažena voda lahko prenaša okužbe; pomembna sta tudi kemijska varnost in neprekinjena oskrba. [189]	Presojati moramo pripravljeno vodo pri uporabniku, surovi vir in stanje omrežja ločeno. Letna ocena ne zagotavlja ustreznosti vsake pipe vsak dan.
Čistejši zrak	Onesnažen zunanji zrak je dejavnik tveganja za srčno-žilne in dihalne bolezni ter pljučnega raka. [190]	Zeleno okolje ne zagotavlja nizkih zimskih koncentracij. Lokalna merilna postaja opisuje svojo lokacijo; iz nje ne moremo izračunati izpostavljenosti vseh prebivalcev.

14

Pitna voda: pregled letnih meritev

Dopolnitev 24. septembra 2026 · obdobja meritev so navedena pri podatkih

Vodovodni sistem Črnomelj uporablja vodni vir Dobličica oziroma zajetje Dobliče. Poročila ločujejo surovo vodo na zajetju, vodo po pripravi na Griču ter vzorce v vodohranih, omrežju in pri uporabnikih. V letu 2025 so bili vsi štirje običajni mikrobiološki vzorci na zajetju neustrezni, 108 vzorcev po pripravi in v omrežju pa ustreznih po parametrih tabele 2. Dodatne analize parazitov so kljub temu odkrile neskladnosti v Adlešičih. [6]

Kakovost reke Dobličice ni s tem v celoti ocenjena. Analize zajetja niso ocena ekološkega in kemijskega stanja celotnega vodotoka, meritve pretoka pa niso meritve pitnosti. V tem dopolnilu ni preverjene neprekinjene časovne vrste ARSO za stanje reke; te vrzeli ne nadomeščamo z oceno vodovoda.

LETO MERITEV	KAJ JE BILO MOGOČE PREVERITI	POMEMBNA OMEJITEV ALI ODSTOPANJE
1996–2010	Poročilo za 2021 vsebuje zgodovinski graf 1996–2021. [191]	Izvirnih letnih tabel za ta leta nismo pridobili. Deležev ne odčitavamo navidezno natančno iz slike; to so manjkajoči podatki, ne nič neskladnosti.
2011	VS Črnomelj: objavljenih 116 mikrobioloških, 36 kemijskih in 1 preiskava na parazite; upravljavec navaja zdravstveno ustreznost. [192]	Vinica je še imela težave z vonjem, okusom in motnostjo ter priporočilo prekuhavanja. Splošna letna ocena zato ne izbriše opisanih težav.
2012	VS Črnomelj: 116 mikrobioloških, 42 kemijskih in 1 preiskava na parazite; vsi objavljeni rezultati ocenjeni ustrezno. [193]	Še opisane težave na takrat ločenem sistemu Vinica in ob dežju na sistemu Semič.
2013	VS Črnomelj: 116 mikrobioloških, 44 kemijskih in 3 preiskave na parazite; ocena ustrezno. [194]	Povzetek še opisuje težave Vinice; ne enačimo ocene Črnomlja z neprekinjeno ustreznostjo vseh sistemov.
2014	VS Črnomelj: 116 mikrobioloških, 44 kemijskih in 3 preiskave na parazite; ocena ustrezno. [195]	V drugi polovici leta se je območje Vinice začelo oskrbovati iz Dobličice. Sprememba vira omejuje neposredno primerjavo.
2015	VS Črnomelj: 132 mikrobioloških, 54 kemijskih in 4 preiskave na parazite; po pripravi objavljena skladnost vseh vzorcev. [196]	Ne gre za dokaz, da je bila tudi surova izvirska voda pitna.
2016	VS Črnomelj: 129 mikrobioloških, 49 kemijskih in 3 preiskave na parazite; letna ocena ustrezno. [197]	Kratek povzetek, brez posameznih koncentracij in vseh imenovalcev po odvzemnih mestih.
2017	VS Črnomelj: 133 mikrobioloških, 51 kemijskih in 2 preiskavi na parazite; letna ocena ustrezno. [198]	Letna zdravstvena ocena ni isto kot objavljena tabela vseh posameznih rezultatov.
2018	VS Črnomelj: 122 mikrobioloških in 41 kemijskih vzorcev; 3 mikrobiološka in 1 kemijsko odstopanje, kontrolni vzorci po ukrepih skladni. [199]	V povzetku so odstopanja pretežno pripisana hišnim napeljavam. Opisano je tudi onesnaženje surove vode vrtine Damelj; ne mešamo ga z omrežjem Črnomelj.
2019	VS Črnomelj: 131 mikrobioloških in 47 kemijskih vzorcev; 3 mikrobiološka in 1 kemijsko odstopanje, kontrolni vzorci skladni. [200]	Letna ocena je ustrezno kljub posamičnim odstopanjem. Podobno besedilo poročil 2018 in 2019 ni dodatna neodvisna verifikacija vzrokov.
2020	VS Črnomelj: 122 mikrobioloških, 46 kemijskih in 2 preiskavi na parazite; objavljena skladnost vseh preskušanih vzorcev. [201]	Obseg povzetka ni enak podrobnejšim tabelam od 2021.

LETO MERITEV	KAJ JE BILO MOGOČE PREVERITI	POMEMBNA OMEJITEV ALI ODSTOPANJE
2021	Surovo zajetje: 7/7 rutinskih mikrobioloških vzorcev neustreznih; po pripravi in v omrežju 109/109 ustreznih. [191]	5. 10. zaznan Cryptosporidium na zajetju; kontrolna vzorca na Griču in v VVO Čardak 21. 10. brez zaznave. PDF vsebuje dvakrat istih osem strani; ne štejemo dvakrat.
2022	Surovo zajetje: 9/9 neustreznih; po pripravi in v omrežju 111/111 ustreznih. Pet preiskav na parazite brez zaznave. [202]	Na dolgih krakih Črnomelj–Dobliče je bilo približno 25 % meritev klordioksida pod priporočeno vrednostjo.
2023	Surovo zajetje: 5/5 neustreznih; po pripravi in v omrežju 94/94 ustreznih. Štiri preiskave na parazite brez zaznave. [203]	V poročilu je navedenih 27 % meritev klordioksida pod priporočeno vrednostjo. Podatek 5/5 E. coli je ob napačno izpisanih 89 % računsko 100 %.
2024	Surovo zajetje: 5/5 neustreznih; po pripravi in v omrežju 114/114 ustreznih. Štiri preiskave na parazite brez zaznave. [204]	Ena od treh kemijskih analiz surovega zajetja neustrezna zaradi motnosti; kemijski vzorci po pripravi skladni.
2025	Surovo zajetje: 4/4 neustreznih; po pripravi in v omrežju 108/108 rutinskih mikrobioloških vzorcev ustreznih. [6]	Dodatne analize v Adlešičih 6. in 16. oktobra pozitivne na enteroparazite. Letno poročilo izrecno izvzema območje Adlešičev iz splošne ocene ustreznosti.
2026 do 2. 9.	Pregledan seznam 88 povezav do izvidov VS Črnomelj: 86 različnih številk vzorcev, odvzemi 8. 1.–2. 9. 2026. [205]	Nepopolno leto in samo ta sistem; ne izračunavamo letnega deleža za občino. Izvid 26/89747, Griblje OŠ, 2. 9.: Giardia in Cryptosporidium 0 v 100 L. [206]

Števila od 2011 do 2020 so prepis objavljenega obsega preskušanja VS Črnomelj. Od 2021 ločeno seštevamo vrstice »po pripravi«, »VH in omrežje upravljavca« in »omrežje« v tabeli 2. Analize različnih parametrov lahko zadevajo isti odvzem: mikrobioloških, kemijskih in parazitoloških preiskav ne seštevamo v število različnih dogodkov. Delež 100 % pri rutinskih analizah ne vključuje samodejno dodatnih analiz na parazite.

Kaj se je zgodilo v Adlešičih leta 2025

DATUM ODVZEMA	MESTO	UGOTOVITEV POROČILA
6. 10. 2025	Adlešiči KZ	Giardia 1, Cryptosporidium 1; neskladno.
16. 10. 2025	Hidrant med OŠ in KZ	Giardia 1, Cryptosporidium 0; neskladno.
16. 10. 2025	VH Grič, VH Čudno Selo, VH Bedenj	Obe preiskavi brez zaznave.
28. 10. 2025	Isti hidrant v Adlešičih in VH Zilje	Obe preiskavi brez zaznave.
6. 11. 2025	VH Zilje	Obe preiskavi brez zaznave.

Vir je tabela 3 letnega poročila; v tej tabeli volumen vzorca ni naveden, zato navedenih števil ne pretvarjamo v koncentracijo. [6] Poznejši negativni vzorci so pomembni, vendar sami ne dokazujejo vzroka in trajne sanacije. Poročilo ne dokazuje izbruha bolezni med prebivalci. Brez evidence ukrepov tudi ne sklepamo, da omejitev uporabe velja še danes. Javni izvid za Adlešiči KZ s časom odvzema 31. 8. 2026 navaja skladne rutinske mikrobiološke parametre; ne vsebuje preiskave na enteroparazite. Datum ob povezavi je 7. 9., zato je odločilen datum v izvidu. [207]

Drugi sistemi in kakovost dokumentacije

V letu 2025 tabela notranjega nadzora za Semič–Črnomelj navaja en neustrezen mikrobiološki vzorec od 26 na omrežju, brez E. coli. Državni monitoring za Potoki–Rožni Dol navaja en neskladen od dveh vzorcev zaradi števila kolonij pri 22 °C. Zato niti ocena največjega sistema niti skupna uvodna ocena ne nadomesti branja vseh tabel. Kemijski rezultati in spremljani stranski produkti dezinfekcije so v poročilu za 2025 ocenjeni skladno. [6]

Za zajetje Rožni Dol tabela 2024 vsebuje medsebojno nezdružljive števce in odstotke; teh ne popravljamo z ugibanjem. Poročilo 2022 nadgradnjo priprave na Griču datira v 2022, poročili 2023 in 2024 pa v 2023. To je odprto dokumentacijsko neskladje, ki ga mora razjasniti upravljavec z zapisnikom o prevzemu. [202] [203] [204]

Podatkovne tabele: kazalo preglednic CSV. Na ozkem zaslonu preglednice pomaknite vodoravno.

---

15 Kakovost zraka: meritve in njihove omejitve

Dopolnitev 24. septembra 2026 · obdobja meritev so navedena pri podatkih

OBDOBJE	PM10: LETNO POVPREČJE (MG/M³)	DNEVI PM10 NAD 50 MG/M³	PM2,5: LETNO POVPREČJE (MG/M³)	RAZLAGA
Pred 2024	Ni potrjenega lokalnega niza	Ni podatka	Ni podatka	Poročilo ARSO 2024 opisuje na novo uvedene enoletne meritve pri ZD; pregledani letni poročili 2022 in 2023 ne dajeta primerljivega niza za Črnomelj. [7]
2024, Črnomelj ZD	24	39 izmerjenih; 34 po odštetju naravnega prispevka	19	ARSO: 99 % razpoložljivost podatkov za obe frakciji. Benzo(a)piren 2,6 ng/m³, nad letno ciljno vrednostjo 1 ng/m³. [7]
2025, Črnomelj; selitev februarja	19	10	15	Letni pregled v decembrskem biltenu. Podatkov ne razlagamo kot čisto meritev izboljšanja na istem mestu. [8]
2026, januar–julij	Letnega povprečja še ni	Objavljenih 10*, podatki niso dokončno potrjeni	Letnega povprečja še ni	Januar je označen z nezadostnim številom veljavnih meritev. Ne primerjamo delnega leta s celim letom. [208] [209]

Postaja ob ZD je bila ob začetku gradnje prizidka februarja 2025 ukinjena; meritve na Loki ob stadionu so se začele 21. februarja 2025. Spremenila sta se lokacija in izplen meritev. Razlika med 2024 in 2025 zato sama ne dokazuje učinka občinskih ukrepov ali trajnega trenda. [9]

Pravna presoja in zdravstvena presoja nista ista stvar. Pri PM10 je ARSO za Črnomelj v 2024 od 39 preseganj odštel pet zaradi puščavskega prahu; 34 je pod dovoljenimi 35 dnevi. Delci, ki jih prebivalci vdihujejo, s tem

niso izginili. Povprečji PM10 24 in PM2,5 19 µg/m³ sta bili pod tedanjima letnima zakonskima mejama 40 in 20, a nad priporočiloma WHO 2021 za letno povprečje 15 in 5 µg/m³. [7] [210]

MESEC	PM10 2024, ZD (MG/M³)	PM10 2025, LOKACIJA SE SPREMENI (MG/M³)	PM10 2026, LOKA (MG/M³)
Januar	45	31	50*
Februar	37	34*	23
Marec	28	18	20
April	16	14	14
Maj	13	9	9
Junij	15	12	12
Julij	15	10	12
Avgust	15	16	Ni podatka
September	14	14	Ni podatka
Oktober	22	18	Ni podatka
November	37	25	Ni podatka
December	41	36	Ni podatka

Mesečna povprečja niso primerljiva z letno mejno vrednostjo ali z dnevno mejo kot testom skladnosti. Zvezdica pomeni premalo veljavnih meritev, informativni podatek. Viri: tabela 7.4 poročila 2024 ter mesečni tabeli ARSO za december 2025 in julij 2026, objavljeni 3. 2. in 31. 8. 2026. [7] [211] [208]

Benzo(a)piren in kovine

Povprečni benzo(a)piren 2,6 ng/m³ v letu 2024 je posebej pomemben signal: ARSO ga povezuje predvsem z nepopolnim zgorevanjem, zlasti v malih kurilnih napravah, ter navaja rakotvornost. Visoke vrednosti v kurilni sezoni podpirajo prednostno obravnavo ogrevanja; ne dokazujejo prispevka vsakega lokalnega vira. Povprečne letne vrednosti kovin na isti postaji so bile arzen 0,26, nikelj 0,58, kadmij 0,18 in svinec 4,2 ng/m³; poročilo jih ocenjuje pod ustreznimi ciljnimi oziroma mejnimi vrednostmi. [7]

Za 2025 je arhivirana tudi dnevna tabela benzo(a)pirena. Vsebuje vrednosti pod mejo določanja, podvojeno vrstico za 6. 8. 2025 in še podatke januarja 2026. Brez določitve obravnave teh zapisov in potrditve reprezentativnosti iz nje ne objavljamo uradnega letnega povprečja. Odsotnost agregata ni dokaz odsotnosti tveganja. [212] Za ozon, NO_2 in druge pline ta pregled nima primerljive lokalne časovne vrste; podatkov iz Novega mesta ne predstavljamo kot meritev Črnomlja.

Vročinski valovi in zdravje

Dopolnitev 25. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Leta 2025 je imel Črnomelj (postaja Črnomelj/Dobliče) 39 vročih dni z najvišjo temperaturo vsaj 30 °C in 110 toplih dni nad 25 °C. To je več kot v Ljubljani (36 vročih dni) in Novem mestu (37). [8] Vročina najbolj ogroža starejše, kronične bolnike, osebe z oviranostmi in ljudi v slabših bivalnih razmerah. [213] V Črnomlju je četrtina prebivalcev starih 65 let ali več, zato je tema pomembna za javno zdravje.

Evropske modelske raziskave ocenjujejo, da je vročina poleti 2022 povzročila 61.672 smrti, v letu 2024 pa 62.775. Ocenjeno breme je bilo največje pri najstarejših in pri ženskah. [214] [215] Za Črnomelj teh ocen ni mogoče izračunati, ker je populacija premajhna za zanesljive lokalne ocene umrljivosti.

Trenutno stanje

NIJZ je avgusta 2026 posodobil napotke za ravnanje v vročih dneh. Poudarja hlajenje prostorov, zadrževanje v senci, pitje vode, omejitev telesne dejavnosti in skrb za ranljive. Priporoča tudi javno dostopne hlajene prostore, kjer lahko ljudje preživijo nekaj ur na dan. [213] V pregledanih virih nismo našli občinskega načrta ukrepov ob vročini ali seznama hlajenih javnih prostorov v Črnomlju. Status: Unverified.

Ključna dejstva

Vročina v Črnomlju, leto 2025

KRAJ	VROČI DNEVI (TMAX ≥ 30 °C)	TOPLI DNEVI (TMAX ≥ 25 °C)
Črnomelj/Dobliče	39	110
Novo mesto	37	103
Ljubljana	36	94
Kočevje	22	ni navedeno v istem besedilu

Vir: ARSO, letni pregled 2025, preglednica 1 in besedilo o toplih dneh. [8] V Ljubljani je bilo vročih dni leta 2024 kar 53, rekord pa ostaja leto 2003 s 54 dnevi. Za Črnomelj v tem viru ni daljše vrste, zato lokalnega trenda ne navajamo.

Kaj kažejo raziskave

RAZISKAVA	ZASNOVA	UGOTOVITEV	OMEJITVE
Ballester in sod., 2023 [214]	Eurostat, 823 regij v 35 državah, poletje 2022	61.672 smrti zaradi vročine (95-% IZ 37.643–86.807); relativno 56 % več pri ženskah; največ pri ženskah, starih 80 let ali več	Modelska ocena iz tedenskih podatkov, ki po navedbi avtorjev breme verjetno podcenjuje; brez podatkov o vzrokih smrti. Prebrano celotno besedilo.
Janoš in sod., 2025 [215]	654 regij v 32 državah, poletja 2022–2024	62.775 smrti leta 2024 (IZ 36.765–84.379); zdravstvena opozorila je mogoče napovedati vsaj teden dni vnaprej	Modelska ocena; prebran povzetek.

Ocena za Slovenijo, poletje 2022

SKUPINA	OCENJENE SMRTI ZARADI VROČINE (95-% IZ)	NA MILIJON PREBIVALCEV (95-% IZ)
Vsi prebivalci	154 (−24 do 307)	73 (−12 do 146)
Ženske	100 (−4 do 209)	96 (−4 do 200)
Moški	58 (−4 do 119)	55 (−3 do 112)
0–64 let	9 (−26 do 39)	5 (−15 do 23)
65–79 let	34 (−18 do 85)	105 (−54 do 260)
80 let ali več	94 (−11 do 186)	798 (−91 do 1.580)

Vir: Ballester in sod. 2023, preglednici 1 in 2. **[214]** Vsi intervali zaupanja za Slovenijo vključujejo ničlo, zato ocena za Slovenijo sama po sebi ni statistično zanesljiva. Vzorec pa je jasen: breme je skoncentrirano pri najstarejših. Preračun na Črnomelj ni primeren.

Kdo je najbolj ogrožen

SKUPINA PO NIJZ [213]	LOKALNI POMEN
Starejši, otroci, nosečnice	25,5 % prebivalcev je starih 65 let ali več.
Kronični bolniki in osebe z oviranostmi	Veliko prejemnikov zdravil za povišan krvni tlak in sladkorno bolezen po profilu NIJZ. **[2]**
Ljudje v slabših bivalnih razmerah, socialno izolirani	Podatki o hlajenju domov niso zbrani.
Delavci na prostem	Kmetijstvo, gradbeništvo in komunala.

Viri

ARSO je primarni vir za meritve. Raziskava za leto 2022 je prebrana v celoti (odprti dostop), raziskava za leto 2024 le kot povzetek, ker ni prosto dostopna. NIJZ je nacionalni vir priporočil. Lokalnih podatkov o obremenitvi ambulant ali NMP med vročinskimi valovi v pregledanih virih ni.

Identificirani problemi

PROBLEM	DOKAZ OZIROMA MEJA ZNANJA
Veliko vročih dni	39 vročih dni leta 2025. **[8]**
Staro prebivalstvo	Četrtina starih 65 let ali več.
Ni lokalnega načrta	V pregledanih virih ni najden.
Osamljeni starejši	Nizka vključenost v pomoč na domu (glej temo dolgotrajne oskrbe). **[2]**

▼ Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Župan in občinska uprava	Ali ima občina načrt ukrepov ob vročini? Dokument, odgovorne osebe in stopnje opozarjanja.
Občinska uprava	Kateri javni prostori so hlajeni in dostopni prebivalcem? Seznam in delovni čas.
Center za krepitev zdravja	Ali CKZ izvaja delavnice o vročini za starejše in kronične bolnike? Program in število udeležencev.
Patronažna služba ZD	Ali se ob opozorilih ARSO obiskujejo osamljeni starejši? Protokol in število obiskov.
DSO Črnomelj	Kako so prostori doma hlajeni in kakšen je načrt ob vročinskem valu? Opis ukrepov.
Šole in vrtci	Kako se prilagodi pouk in igra na prostem ob vročini? Pravila in senčenje igrišč.
Komunala Črnomelj	Kje so javni pitniki in ali delujejo vse poletje? Seznam lokacij.
Civilna zaščita	Ali so ob vročinskem valu vključeni prostovoljci za preverjanje ranljivih? Postopek.
ZD Črnomelj	Ali se v poletnih mesecih spremlja porast obiskov NMP zaradi vročine? Agregirani podatki.
Delodajalci	Kako se v vročini organizira delo na prostem? Pravilniki in ukrepi.

Tveganja

Pozivi »ostanite doma« lahko povečajo osamljenost. Hlajenje z energijo poveča stroške za ljudi z nizkimi dohodki. Brez seznama ranljivih lahko pomoč ne doseže tistih, ki jo najbolj potrebujejo, seznami pa morajo spoštovati varstvo osebnih podatkov.

▼ Možne rešitve

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev	Občina objavi kratek načrt ukrepov ob vročini: opozarjanje, hlajeni prostori, pitniki, telefonsko preverjanje ranljivih.	20–40 ur; občinski proračun.	Hitrejši odziv; tveganje, da ostane le na papirju. Načrt objavljen pred poletjem 2027.
0–12 mesecev	CKZ in patronaža pripravita gradivo in delavnice za starejše in svojce.	Obstoječi programi CKZ.	Boljše znanje; tveganje nizke udeležbe. Število udeležencev in razdeljenih gradiv.
1–3 leta	Senčenje igrišč, postajališč in poti (drevesa, nadstreški).	Načrtovalna ocena 20.000–60.000 EUR; občina, podnebni skladi, če so na voljo.	Manj pregrevanja; tveganje vzdrževanja. Število senčenih lokacij.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN FINANCIRANJE (NAČRTOVALNA OCENA)	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
3–10 let	Pri obnovi javnih stavb in DSO vključiti pasivno hlajenje in zunanja senčila.	Investicijski proračun in energetska sredstva.	Trajna zaščita; tveganje stroškov. Temperatura v prostorih med vročinskim valom.

Uredniška ocena dokumentiranosti

Lestvica 1–5, sedem enako uteženih meril.

MERILO	OCENA IN OBRAZLOŽITEV
Transparentnost	2: meritve ARSO so javne, lokalni načrt ni najden.
Dostop in razpoložljivost	2: hlajeni javni prostori niso dokumentirani.
Usklajenost s potrebami	2: staro prebivalstvo in veliko vročih dni, brez vidnega lokalnega odziva.
Dokazna podlaga in spremljanje	3: dobre meritve in raziskave, ni lokalnega spremljanja zdravstvenih posledic.
Pravičnost in doseg	2: ranljive skupine niso posebej obravnavane.
Stroški in učinkovitost	Ni ocene.
Vzdržnost	2: brez načrta ni ponavljajočega se ukrepanja.
Izvedljivost	4: ukrepi so poceni in znani.

Izračun: (2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 4) / 7 = **2,43/5,** ❌ po pravilu povprečja pod 2,5. Opozorilo: ocena velja za dokumentiranost lokalnega odziva. Ne pomeni, da je bilo zaradi vročine v Črnomlju dokazano več smrti.

Primerjave

Črnomelj je imel leta 2025 več vročih dni kot Ljubljana in Novo mesto. [8] Primerjava umrljivosti zaradi vročine po občinah ni mogoča s pregledanimi viri.

▼ Odprta vprašanja

VRZEL	NADALJNJI KORAK
Dolga vrsta vročih dni za Črnomelj	Pridobiti ARSO arhiv postaje Črnomelj/Dobliče.
Lokalni odziv	Uradni odgovor občine in ZD.

Ukrepi in odprta vprašanja

Predlogi za občino, ZD, CKZ, šole in partnerje. Načrtovane aktivnosti in sredstva še niso potrjena izvedba ali odobreno financiranje.

27 Načrt ukrepov za eno leto, mandat in desetletje

To je **predlog**, ne že sprejet program ali zagotovljeno financiranje. Obseg dela je planska ocena avtorja; pred proračunsko odločitvijo je treba preveriti zmogljivosti, cene in upravičenost financiranja. Financiranje rednega zdravstvenega programa je treba ločiti od občinskih dopolnil in investicij.

0–12 mesecev

Urediti poročanje, ugotoviti ovire in uvesti ciljne pilote.

1–3 leta

Razširiti redno obravnavo in preveriti izide udeležencev.

3–10 let

Vzdrževati šolske programe, dostopno oskrbo in zdravo okolje.

ROK IN UKREP	NOSILEC / OCENJENI VIRI / MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev: javni letni pregled CKZ. Po programih prikazati vključitve, različne uporabnike, zaključke, osip, spremljanje in stroške; objaviti enoten koledar.	Vodja CKZ, vodstvo in računovodstvo ZD. Ocena: 10–20 delovnih dni vzpostavitve ter 1–2 dneva mesečno. Možen vir: obstoječa organizacijska sredstva zavoda, ob preverbi pogodbenih obveznosti.	Preglednost in boljše usmerjanje. Tveganje: dvojno štetje, obremenitev osebja in razkritje majhnih skupin. **Merilo:** prva preglednica v 6 mesecih, četrtletne posodobitve; objava zgolj agregatov.
0–12 mesecev: pilot za otroke. Na dveh šolah povezati dodatno gibanje, prehransko okolje in družinsko obravnavo. [216][217]	Šoli in ustanoviteljica, CKZ kot strokovna podpora. Ocena: 2 dodatni šolski uri na skupino tedensko, koordinacija, jedilniki. Možno: šolski/občinski program in ustrezni nacionalni razpisi; brez domneve, da razpis že obstaja.	Redna izpostavljenost učinkovitejšemu okolju. Tveganje: izključitev otrok brez prevoza, stigmatizacija. **Merilo:** izvedene ure, udeležba in izhodiščni SLOfit; zdravstvenega učinka še ne pričakovati po enem mesecu.

ROK IN UKREP	NOSILEC / OCENJENI VIRI / MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev: dostop do cepljenja in podpore na domu. Preveriti nepopolno cepljene otroške kohorte ter čakalne sezname/ovire za oskrbo starejših. [2]	Pediatrija in patronaža; občina, CSD, izvajalec pomoči na domu. Ocena: 5–10 dni analize za vsak sklop, nato dogovorjen obseg dela. Možno: redni zdravstveni in socialni programi.	Odpraviti zamujene priložnosti. Tveganje: mešanje različnih storitev in upravičencev. **Merilo:** objavljena izhodišča ter vzroki neodziva; ločeno spremljanje cepljenja in oskrbe.
0–12 mesecev: alkohol in promet. Povezati kratke intervencije, usmerjanje v zdravljenje, preventivo na prireditvah in prometni nadzor. [218]	ZD/CKZ, občinski svet za preventivo v prometu, policija, organizatorji. Ocena: 4 usklajevalni sestanki letno in 1 ciljana akcija četrtletno. Možno: redni programi in občinska preventiva.	Manj škodljivega pitja in tveganih voženj. Tveganje: samo medijska akcija brez obravnave. **Merilo:** število obravnav z nadaljnjim stikom; policijska letna poročila, ne zgolj delež iz petletnega kazalnika.
1–3 leta: redne skupine za presnovno in duševno zdravje. Zdravstveno utemeljene napotitve, programi z več srečanji in spremljanje po 6/12 mesecih. [219][220][221][222]	CKZ, družinska medicina, psihološka in specialistična obravnava. Ocena: začetno 4 kohorte letno; dejansko velikost in ure določi strokovna ekipa. Možno: pogodbeni program ZZZS, dopolnitve po odobrenem načrtu.	Vzdrževanje sprememb in urejenost bolezni. Tveganje: osip, izbiranje lažjih primerov, neželeni učinki. **Merilo:** delež spremljanih od vseh vključenih; tlak po individualnem cilju, vzdrževanje sprememb, funkcionalnost in počutje.
1–3 leta: redne terenske točke in prevoz. Termine povezati s potrebami oddaljenih naselij, starejših in oseb z oviranostmi.	Občini Črnomelj in Semič, KS, CKZ, partnerji. Ocena: pilot 1 terenskega dne mesečno; prevoz in koordinacija posebej. Možno: redni terenski program in občinska dopolnila.	Lažji dostop in več novih uporabnikov. Tveganje: preusmerjanje omejenih kadrov brez dodatnega dosega. **Merilo:** različni uporabniki po območjih, razlogi neudeležbe, strošek na zaključen program.
3–10 let: trajno šolsko gibanje in varne poti. Po pilotu razširiti program ter izboljšati dostop do pešpoti, rekreacije in pitne vode. [216][217]	Občina, šole, upravljavci prostora in CKZ. Ocena: večletne pedagoške ure; investicije šele po popisu poti in projektantski oceni. Možno: občinski načrt razvojnih programov in ustrezni državni/EU razpisi.	Dolgoročno bolj zdrave navade in manj razlik v dostopu. Tveganje: vzdrževanje, prometna varnost, menjava prioritet. **Merilo:** trajnost programa po 4 letih; fitnes in prehranjenost otrok po primerljivi metodi, raba poti in varnost.
3–10 let: podpora staranju in stalnost kadrov. Povezati pomoč na domu, demenci prijazne točke ter načrt pridobivanja in ohranjanja zdravstvenih kadrov.	ZD, občina, socialni izvajalci, šole za zdravstvene poklice. Ocena: letni kadrovski in storitveni načrt; obseg financ po analizi potreb. Možno: redni viri zdravstva/sociale in občinska podpora v okviru pristojnosti.	Kontinuiteta oskrbe in razbremenitev svojcev. Tveganje: pomanjkanje kadra, nepovezane storitve. **Merilo:** čakanje, nezadovoljene potrebe, stabilnost ekip in kakovost življenja uporabnikov.

Kako vemo, da ukrep deluje?

Pred začetkom določiti izhodišče in glavne izide. Poročati o vseh vključenih, ne le o uspešnih zaključkih. Kadar je izvedljivo, primerjati podobne šole oziroma postopno uvajanje programa; preveriti razlike v izhodiščih in osip. Po 6–12 mesecih spremljati vedenje in zdravstvene kazalnike udeležencev, po 3–4 letih šolske trende, po daljšem obdobju širše zdravstvene izide. To je predlog evalvacije; vpliva CKZ na umrljivost s preprosto primerjavo »pred in po« ne moremo dokazati.

Vprašalnik o izkušnjah pacientov za letno poročilo

Dopolnitev 26. septembra 2026 · referenčna obdobja so navedena pri podatkih

Povzetek

Predlagamo kratek, anonimen vprašalnik (15 vprašanj, okoli 4 minute), ki ga pacienti izpolnijo po obisku v ambulanti. Rezultati bi se uporabili v letnem poročilu ZD in v tem poročilu. Vprašalnik se izpolnjuje **enkrat v posameznem letnem obdobju zbiranja** (na primer 4 tedne v oktobru): vsak pacient enkrat, ne ob vsakem obisku. Isti pacient ga lahko izpolni **tudi naslednje leto**, vendar se odgovori med leti ne povezujejo. Primerjamo skupine anketirancev iz leta v leto, ne posameznikov.

Za spremljanje istega pacienta skozi čas (na primer v programu CKZ) je primeren drug, že pripravljen vprašalnik s šifro in soglasjem, ne ta. Obrazec je predlog projekta, ZD ga ni potrdil ali uvedel.

Trenutno stanje

ZD Črnomelj od leta 2014 uporablja anketo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, zdaj tudi kot spletno anketo, dostopno vse leto. V letu 2025 jo je izpolnilo 143 pacientov (2024: 274); splošno zadovoljstvo je bilo 4,57 na lestvici 1–5. ZD sam poroča, da je vse več anket nepopolnih, da naročeni pacienti v čakalnici nimajo časa za izpolnjevanje in da načrtuje vabila po SMS. [5] Nacionalno anketo MZ in NIJZ na portalu eZdravje sta za ZD v letu 2025 izpolnila le dva pacienta. [5]

Sedanja anketa dobro pokriva prijaznost, zasebnost in čakanje v čakalnici. [223] Ne sprašuje pa, ali ima pacient izbranega osebnega zdravnika, koliko dni je čakal na termin, kako daleč je potoval, ali ve, kaj sledi po obisku, ali pozna zVEM, in iz katerega dela občine prihaja. To so podatki, ki jih to poročilo pogreša.

Zasnova

ODLOČITEV	PREDLOG	ZAKAJ
Kdo izpolni	Polnoletni pacienti po obisku; za otroke starš ali skrbnik	Izkušnja z današnjim obiskom.
Kdaj	Enkrat na leto, 4 tedne v istem mesecu (npr. oktober)	Primerljivost med leti; zajame tudi redke obiskovalce.
Kako	Vabilo po SMS s povezavo po prvem obisku v obdobju, papirni izvod na recepciji, pomoč pri izpolnjevanju za tiste, ki želijo	Višji in manj pristranski odziv kot pri stalni anketi; papir ohrani dostop za starejše.
Anonimnost	Brez imena, EMŠO, telefonske številke ali datuma rojstva; starost v skupinah; kraj v širših območjih	Iskrenejši odgovori; majhne skupine ne razkrijejo posameznika.
Dolžina	15 vprašanj, vsa razen enega zaprta; vsako je mogoče preskočiti	Manj nepopolnih anket.
Primerljivost	Pet vprašanj z enako lestvico »nikoli–vedno« in splošna ocena 1–5 kot v sedanji anketi	Niz od leta 2014 se ne prekine.

Enkratno ali večkratno izpolnjevanje?

NAČIN	PRIMEREN ZA	PRAVILO
Enkrat v letnem obdobju zbiranja, anonimno (ta vprašalnik)	Letno poročilo: deleži in trendi za vse paciente	Vsak pacient enkrat v obdobju; ponovno lahko naslednje leto. Odgovori se med leti ne povezujejo.

NAČIN	PRIMEREN ZA	PRAVILO
Ob vsakem obisku, vse leto (sedanji spletni način)	Sprotni odziv, pohvale in pritožbe	Ni primeren za letne deleže: pogosti obiskovalci in zelo zadovoljni ali nezadovoljni so nadpovprečno zastopani.
Večkrat pri istem pacientu, povezano s šifro	Spremljanje sprememb v programu (CKZ, kronični bolniki)	Samo s privolitvijo in varovanjem podatkov; tak vprašalnik že obstaja za CKZ. Ni za letno poročilo.

Kako preprečiti, da bi isti pacient v istem obdobju izpolnil vprašalnik dvakrat: sistem SMS pošlje vabilo le enkrat na telefonsko številko in številke ne shrani skupaj z odgovori. Na papirnem izvodu je prvo vprašanje »Ste ta vprašalnik v tem mesecu že izpolnili?«. Če je odgovor »da«, se izpolnjevanje konča.

Kazalniki za letno poročilo

KAZALNIK	VPRAŠANJE	KAKO POROČATI
Delež anketirancev brez izbranega osebnega zdravnika	2	%, 95-% interval zaupanja
Delež, ki je termin dobil v 7 dneh	5	% po ambulantah, kjer je n ≥ 30
Delež s potjo do ambulante nad 30 minut	6	% po območjih bivanja
Delež »vedno/pogosto« pri poslušanju, razlagi, vključevanju, času in zasebnosti	8–12	% za vsako vprašanje in povprečje
Delež, ki ve, kaj sledi po obisku	13	%
Uporaba zVEM po starosti	14	% v skupinah 65–79 in 80+
Splošna ocena	15	Povprečje 1–5 (primerljivo s serijo od 2014) in delež ocen 4–5
Odziv	–	Povabljeni, izpolnjeni, delno izpolnjeni; delež odziva

Pravila objave: skupine z manj kot 10 odgovori združimo ali ne objavimo. Nepopolnih anket ne zavržemo, ampak vsako vprašanje poročamo z lastnim n. Za oceno deleža na ravni ZD s natančnostjo ±5 odstotnih točk je potrebnih okoli 385 odgovorov (izračun za delež 50 % pri 95-% zaupanju). Ob 143 odgovorih, kolikor jih je ZD zbral v letu 2025, je negotovost približno ±8 odstotnih točk.

Vprašalnik

Natisljiva različica: vprašalnik (PDF) in HTML.

Vprašalnik o vašem obisku v Zdravstvenem domu Črnomelj

Vaše mnenje nam pomaga izboljšati dostop in obravnavo. Sodelovanje je prostovoljno in anonimno: ne pišite svojega imena. Vsako vprašanje lahko preskočite. Izpolnjevanje traja okoli 4 minute. Vprašalnik izpolnite **samo enkrat v tem mesecu**, tudi če pridete večkrat. Za otroke naj ga izpolni starš ali skrbnik.

ŠT.	VPRAŠANJE	ODGOVORI (OZNAČITE ENEGA, RAZEN ČE PIŠE DRUGAČE)
0	Ste ta vprašalnik v tem mesecu že izpolnili?	☐ Da (hvala, ne izpolnjujte ponovno) ☐ Ne
1	Katero ambulanto ali službo ste danes obiskali?	☐ Družinska medicina ☐ Ambulanta za neopredeljene ☐ Otroška ali šolska ambulanta ☐ Zobozdravnik ☐ Laboratorij ☐ Fizioterapija ☐ Psiholog ☐ Nujna medicinska pomoč ☐ Referenčna ambulanta ☐ Drugo
2	Ali imate izbranega osebnega zdravnika (družinskega ali pediatra)?	☐ Da, v ZD Črnomelj ☐ Da, drugje ☐ Ne ☐ Ne vem
3	Kako ste se naročili na današnji obisk?	☐ Po telefonu ☐ Prek zVEM ali eNaročanja ☐ Prek spletnega obrazca ZD ☐ Osebno ☐ Nisem se naročil
4	Kako enostavno je bilo dobiti termin?	☐ Zelo težko ☐ Težko ☐ Niti težko niti lahko ☐ Lahko ☐ Zelo lahko
5	Koliko dni je minilo od naročila do današnjega obiska?	☐ Isti dan ☐ 1–3 dni ☐ 4–7 dni ☐ 8–14 dni ☐ Več kot 14 dni ☐ Ne vem
6	Koliko časa ste danes potovali do ambulante in kako?	Čas: ☐ Do 15 min ☐ 15–30 min ☐ 30–60 min ☐ Več kot 60 min Način: ☐ Sam z avtom ☐ Me je nekdo peljal ☐ Javni prevoz ☐ Peš ali s kolesom ☐ Drugo
7	Koliko ste čakali v čakalnici po uri, za katero ste bili naročeni?	☐ Manj kot 20 min ☐ 20–60 min ☐ 1–2 uri ☐ Več kot 2 uri ☐ Nisem bil naročen
8	Ali so vas zdravnik ali medicinska sestra pozorno poslušali?	☐ Nikoli ☐ Redko ☐ Občasno ☐ Pogosto ☐ Vedno
9	Ali so vam razložili stvari tako, da ste jih razumeli?	☐ Nikoli ☐ Redko ☐ Občasno ☐ Pogosto ☐ Vedno
10	Ali ste bili vključeni v odločitve o svojem zdravljenju?	☐ Nikoli ☐ Redko ☐ Občasno ☐ Pogosto ☐ Vedno ☐ Ni bilo odločitev
11	Ali ste imeli dovolj časa za svoja vprašanja?	☐ Nikoli ☐ Redko ☐ Občasno ☐ Pogosto ☐ Vedno
12	Ali je bila spoštovana vaša zasebnost?	☐ Nikoli ☐ Redko ☐ Občasno ☐ Pogosto ☐ Vedno
13	Ali veste, kaj morate narediti po današnjem obisku (zdravila, izvidi, naslednji termin)?	☐ Da ☐ Delno ☐ Ne ☐ Ni potrebno nič
14	Ali uporabljate portal ali aplikacijo zVEM?	☐ Da, sam ☐ Da, s pomočjo svojca ali pooblastila ☐ Ne, a bi želel pomoč pri uporabi ☐ Ne, ne želim ☐ Ne vem, kaj je zVEM
15	Kako ste na splošno zadovoljni z današnjo obravnavo?	☐ 1 (zelo nezadovoljen) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (zelo zadovoljen)
–	Kaj bi morali izboljšati? (ne pišite imen)	

O vas (za primerjavo med skupinami; odgovori ostanejo anonimni)

VPRAŠANJE	ODGOVORI
Starost	☐ Do 17 (izpolni starš) ☐ 18–39 ☐ 40–64 ☐ 65–79 ☐ 80 ali več
Kje živite?	☐ Mesto Črnomelj ☐ Drugje v občini Črnomelj ☐ Občina Semič ☐ Drugje
Najvišja dokončana izobrazba	☐ Osnovna šola ali manj ☐ Poklicna ali srednja ☐ Višja ali več ☐ Ne želim odgovoriti
Kdo je izpolnil vprašalnik?	☐ Sam ☐ S pomočjo svojca ☐ S pomočjo osebja ☐ Starš ali skrbnik za otroka

Hvala. Vprašalnik oddajte v zaprto skrinjico na recepciji ali prek povezave v SMS.

Pred uvedbo

KORAK	ODGOVORNI
Uskladiti vprašanja z vodstvom ZD in preveriti razumljivost na 10–15 pacientih	ZD, CKZ
Preveriti vabila po SMS in hrambo s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov	ZD
Določiti obdobje zbiranja, cilj odziva in odgovorno osebo za analizo	Vodstvo ZD
Po prvem letu objaviti rezultate z n in intervali zaupanja ter en ukrep za izboljšanje	ZD, svet zavoda

---

10 Ukrepi za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev in vadbe

Naslednji ukrepi so **analitični predlogi**, ne sprejeti projekti ali potrjene finančne obveznosti. Ocene ur so okvir za organizacijo dela, ne ponudbene cene.

OBDOBJE	UKREP IN ODGOVORNI	OKVIR VIROV IN MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN KAZALNIK
0–12 mesecev	ZD s svetom zavoda pripravi izvedbeni načrt zapolnitve 2,00 tima; z občino razdeli potrebe po lokacijah.	40–80 ur za analizo in dogovore; nato stroškovnik kadra. Izvajanje iz pogodbeno urejenega programa ZZZS; občinski podporni ukrepi le po preverbi pristojnosti.	Stalnejša oskrba; tveganje neuspešnih zaposlitev. Meriti dejanske ure, zapolnjeni program, nove opredelitve in kontinuiteto, ne le števila razpisov.
0–12 mesecev	ZD in regionalne službe objavijo enotno pot do pomoči otrokom, odraslim in starejšim z nadomeščanji in datiranimi kontakti.	20–40 ur začetnega usklajevanja in 2–4 ure mesečnega vzdrževanja iz obstoječih organizacijskih sredstev.	Manj napačnih napotitev; tveganje zastarelih kontaktov. Meriti čas do prve ustrezne obravnave in neuspešne predaje.

OBDOBJE	UKREP IN ODGOVORNI	OKVIR VIROV IN MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN KAZALNIK
0–12 mesecev	Občina / CKZ s klubi in zasebniki vzpostavi prostovoljno potrjen imenik: kraj, poklic, ure, starost, cena, prosta mesta, datum preverbe.	40–80 ur začetnega popisa ter 4–8 ur mesečno; občinski program športa/preventive in lastna sredstva sodelujočih, po preverbi upravičenosti.	Preglednejša ponudba; tveganje neodzivnosti in dvojnega štetja. Delež vnosov potrjenih v zadnjih 90 dneh ter število uspešnih vključitev.
1–3 leta	ZD z regionalnimi izvajalci preveri razširitev kliničnopsiholoških in psihiatričnih obravnav za odrasle, po potrebi gostujoče termine.	Najprej analiza potreb in čakalnih vrst; obseg in cena dodatnega programa še nista ocenljiva. Dogovor z ZZZS in izvajalci, morebitni namenski razpisi.	Boljši dostop; tveganje prerazporejanja istega redkega kadra. Meriti dodatne dejanske ure in čas čakanja.
1–3 leta	CKZ in športni izvajalci preizkusijo prehod v cenovno dostopno prilagojeno vadbo ter pomoč pri prevozu.	Pilot dveh skupin; strošek vaditeljev, prostora, prevoza in koordinacije določiti s ponudbami. Možni občinski športni/socialni programi in lastni viri; brez avtomatične pravice do financiranja.	Vztrajanje pri gibanju; tveganje osipa in neustrezne vadbe. Spremljati začetek, redno udeležbo, osip in funkcionalne rezultate.
3–10 let	Občina, ZD, DSO in regija letno usklajujejo potrebe, upokojitve, izobraževanje in dostopne prostore.	Letna kadrovska projekcija; naložbe šele po analizi potreb. Sredstva zavodov, ustanoviteljice in ustreznih državnih razpisov.	Vzdržnejša oskrba; tveganje naložb brez kadra. Meriti nezapolnjeni program, zadržanje kadra ter geografsko in finančno dostopnost.

16

Okolje in zdravje: odgovornost, vprašanja in ukrepi

Dopolnitev 24. septembra 2026 · obdobja meritev so navedena pri podatkih

Dokazna podlaga

Prednost imajo uradna poročila NLZOH, objavljena pri Komunali, ARSO in SURS. Kratka obvestila Komunale 2011–2020 imajo srednjo zanesljivost za natančno rekonstrukcijo vzorčenj; podrobni laboratorijski izvidi in merilne tabele visoko za konkretne vzorce oziroma postaje. Viri WHO povzemajo širše dokaze; lokalnega učinka ne merijo. Randomizirana raziskava vrtov ima omejeno prenosljivost v Črnomelj. Celotne prenesene datoteke, izvlečki in SHA-256 so shranjeni lokalno. Arhiviranje ni sinonim za ročno validacijo vsake laboratorijske številke.

Identificirani problemi

PROBLEM	KAJ JE POTRJENO IN KAJ OSTAJA ODPRTO
Nepopolna zgodovina in neenaka kakovost zapisov	Kratki povzetki starejših let, grafi brez izvornih tabel, tipkarske napake ter podvojeni PDF in vzorci omejujejo letno primerjavo.
Varovanje virov in nadzor omrežja	Surovo zajetje je mikrobiološko obremenjeno; poročila navajajo težave z ostankom razkužila in priporočila obnov. Ustreznost pripravljene vode je treba dokazovati ločeno.
Dogodek Adlešiči	Pozitivni vzorci 2025 in poznejši negativni vzorci so dokumentirani; vzrok, obseg obveščanja in dokaz trajne odprave v tej raziskavi niso potrjeni.

PROBLEM	KAJ JE POTRJENO IN KAJ OSTAJA ODPRTO
Zimska izpostavljenost zraku	Lokalni signal PM in benzo(a)pirena je potrjen; sprememba merilne lokacije ovira trend, prostorska pokritost pa ne zadošča za vsa naselja.
Domneve o socialnih prednostih podeželja	Ni lokalne meritve manj stresa ali zdravstvenega učinka samooskrbe. Povprečna plača ne razkrije revščine in dostopa gospodinjstev.

Kritična vprašanja

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Komunala in NLZOH	Katere izvorne letne tabele obstajajo za 1996–2010? Predložiti števce, imenovalce, odvzemna mesta in metode.
Komunala	Kako so odpravljena neskladja odstotkov v tabelah 2023–2024? Objaviti popravljeno različico z revizijsko sledjo.
Komunala in NLZOH	Kaj je bil ugotovljeni vzrok parazitov v Adlešičih 2025? Predložiti zapisnik preiskave in rezultate kontrol.
Komunala	Kdaj in komu je bilo ob dogodku izdano obvestilo ter kdaj preklicano? Predložiti časovnico z besedili in območjem veljavnosti.
Komunala in zdravstveni inšpektorat	Katere zahteve za pripravo vode so bile preverjene po dogodku? Predložiti odločitve, izvedene ukrepe in meritve.
Komunala	Koliko meritev na končnih krakih ostaja pod priporočilom razkužila? Objaviti lokacije po območjih, število meritev in mesečni delež.
Občina in upravljavec	Kdaj je bila prevzeta nadgradnja Grič, 2022 ali 2023? Predložiti prevzemni zapisnik in opis faz.
Občina in pristojni organi za vode	Kako se nadzorujejo vodovarstvena območja? Predložiti načrt, izvedene preglede in ukrepe.
Komunala in občina	Kakšna je varnost gospodinjstev zunaj javnega sistema? Predložiti agregiran popis sistemov in režim nadzora brez osebnih podatkov.
ARSO	Katere meritve Dobličice so primerne za presojo reke, zajetja in podzemne vode? Predložiti šifre mest, obdobja, parametre in meje določanja.
ARSO	Ali obstajajo lokalne meritve zraka pred 2024? Predložiti arhiv postaj, trajanje meritev in validirane nize.
ARSO	Kako selitev ZD–Loka vpliva na primerljivost 2024–2025? Predložiti metapodatke, izplen in morebitne vzporedne meritve.
ARSO	Kakšen je potrjen letni benzo(a)piren 2025? Predložiti agregat, pravilo za LOQ in pojasnilo podvojene vrstice 6. avgusta.
ARSO	Kako je bilo določenih pet naravnih preseganj v 2024? Predložiti datume in izračun prispevka.
Občina in ARSO	Katera naselja so z merilno postajo slabo predstavljena? Predložiti načrt dodatnih zimskih meritev.
Občina	Kolikšen delež kurišč je zastarel in kateri ukrepi so izvedljivi? Predložiti anonimiziran popis in stroške variant.
Občina in Eko sklad	Kako bodo lahko ukrepali energetsko revni? Predložiti pogoje dostopa, pomoč pri prijavi in spremljanje zavrnjenih vlog; ne domnevamo odprtega razpisa.
Šole in ZD	Ali obstaja protokol aktivnosti ob epizodah delcev? Predložiti protokol, odgovorne osebe in evidenco obveščanja.

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
Občina in upravljavci cest	Kje se prekrivata prometna izpostavljenost in pot otrok? Predložiti prometne podatke in meritve, ne samo ocene.
NIJZ	Kako spremljati zdravstvene izide brez pripisovanja občinskih nihanj enemu viru? Predložiti načrt s primerjalnimi območji in starostno standardizacijo.
SURS in občina	Kateri podatki opisujejo dohodke prebivalcev in ne samo delovnih mest? Predložiti definicije, leta in agregate gospodinjstev.
Občina in CSD	Katere skupine imajo težave s prevozom, ogrevanjem in prehrano? Predložiti anonimizirano oceno potreb in pokritosti pomoči.
CKZ	Ali je stres lokalno izmerjen z veljavno lestvico? Predložiti vzorčenje, odzivnost in rezultate po skupinah brez razkrivanja oseb.
Delodajalci	Kako merijo delovne obremenitve in dostop do preventivnih ukrepov? Predložiti agregirane rezultate in načrt sprememb.
Občina in kmetijska svetovalna služba	Koliko gospodinjstev dejansko prideluje hrano zase? Predložiti način ocene, površine in deleže po naseljih.
Občina	Ali imajo do vrta dostop najemniki in gospodinjstva brez zemlje? Predložiti evidenco potreb ter pregleden način dodelitve.
CKZ in šole	Ali program vrtnarjenja spreminja prehrano in gibanje po 6 in 12 mesecih? Predložiti meritve pred in po ter podatke o osipu.
Kmetijska svetovalna služba in NIJZ	Kako zagotoviti varno vodo, tla in uporabo sredstev na vrtovih? Predložiti program podpore ter merila za ciljno vzorčenje.
Občina in društva	Kako vključiti starejše, gibalno ovirane in ljudi brez prevoza? Predložiti prilagoditve, dostopnost in strošek na udeleženca.
Občinski svet	Kako se bodo predlogi primerjali z drugimi naložbami? Predložiti stroške, koristi, tveganja in poročanje po 12 mesecih.

Tveganja

Največji interpretacijski tveganji sta enačenje ustreznih rutinskih vzorcev z odsotnostjo vseh nevarnosti ter razglasitev čistega zraka na podlagi podeželske pokrajine. Socialni programi lahko izključijo ljudi brez zemlje, časa, denarja ali prevoza. Ukrepi za kurišča brez finančne podpore lahko povečajo energetsko revščino. Pridelava hrane lahko doda obremenitev, če postane pričakovana obveznost. Zdravstvenih izidov ne pripisujemo samooskrbi, dohodku, CKZ ali eni naložbi brez ustrezne primerjave.

Možne rešitve

Vse ocene virov spodaj so **načrtovalne ocene**, ne ponudbe ali zagotovljeno financiranje. Za večje gradbene posege se znesek določi po projektiranju. Možni financerji pomenijo možnosti za preverbo, ne trditve o odprtih razpisih.

PROBLEM IN ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI IN MOŽNA SREDSTVA	KORIST, TVEGANJE IN KAZALNIK
Voda, 0–12 mesecev	Komunala in NLZOH: enoten javni register vzorcev, pojasnilo Adlešičev in popravki tabel.	15–30 delovnih dni; proračun upravljavca/občine.	Boljša sledljivost; tveganje napačnega štetja. V 6 mesecih vsak zapis z ID, datumom odvzema, mestom in ukrepom; v 12 mesecih izmerjen čas obveščanja.
Voda, 1–3 leta	Upravljavec in občina: na podlagi ocene tveganja izboljšati pripravo, nadzor dolgih krakov in obnovo.	20–50 strokovnih dni za oceno in načrt; investicije po projektu. Lastna sredstva, občina, preverba državnih/EU možnosti.	Manj obratovalnih tveganj; tveganje stroška za odjemalce. Letno spremljati izpade, delež nizkega ostanka razkužila in dodatne kontrole parazitov.
Voda, 3–10 let	Občina in pristojni organi: zaščita zaledja, sistematična obnova omrežja in varnost virov zunaj javnega sistema.	Večletni načrt na podlagi popisa; investicije po projektu.	Odpornost ob nalivih/suši; varovati dostopnost za oddaljene uporabnike. Letni pregled izvedbe, izgub vode, prekinitev in pokritosti nadzora.
Zrak, 0–12 mesecev	ARSO in občina: ohraniti meritve, objaviti metapodatke selitve, pripraviti zimski protokol in ciljni popis kurišč.	10–25 strokovnih dni; občina/ARSO v okviru dogovora.	Jasnejša izpostavljenost; tveganje stigmatizacije naselij. Po 6/12 mesecih poročati o izplenu, pokritosti in dosegu obvestil.
Zrak, 1–3 leta	Občina s svetovalnimi službami: ciljno pomagati pri učinkovitejšem ogrevanju in prenovah.	0,2–0,5 FTE koordinacije; subvencije in prenove po popisu. Preveriti Eko sklad, državo, lastna sredstva.	Znižanje izpustov; brez prisile v nevzdržne stroške. Spremljati zamenjave, strošek ogrevanja ranljivih in vremensko prilagojene koncentracije.
Zrak, 3–10 let	Občina: povezati energetski, prometni in prostorski načrt s cilji kakovosti zraka.	Investicijski program po variantah; občina ter možna državna/EU sredstva.	Trajnejše zmanjšanje izpostavljenosti; tveganje počasnega izvajanja. Letno spremljati PM in BaP, po 3–5 letih presoditi trend na primerljivih postajah.
Življenjske razmere, 0–12 mesecev	Občina, CSD, CKZ: ocena potreb, stresa in dostopa do zdrave hrane; prostovoljen pilot dostopnih vrtov.	15–30 strokovnih dni; pilot 5.000–15.000 EUR, občina in partnerji.	Identifikacija ovir; tveganje samoizbora. Po 6/12 mesecih izmeriti vključevanje, osip, stres in prehrano z vnaprej določenimi merili.
Življenjske razmere, 1–3 leta	Občina, šole, CKZ: dostopni vrtovi, znanje o varni pridelavi in povezava s prehransko/prevozno podporo.	0,2–0,5 FTE koordinacije; oprema in dostopnost po načrtu. Občina, partnerji, preverba javnih pozivov.	Koristi tudi brez lastništva zemlje; tveganje izključevanja in stigme. Letno poročati po območjih in o pokritosti ranljivih skupin, ne samo številu dogodkov.
Življenjske razmere, 3–10 let	Občina, delodajalci in država: kakovostna delovna mesta, dostopno bivanje, prevoz in socialna infrastruktura.	Večletni program z ločenimi stroški in odgovornostmi.	Manj strukturnih ovir; tveganje neenake porazdelitve koristi. Spremljati dohodke gospodinjstev, stanovanjsko breme, dostop in zdravstvene neenakosti; brez obljube učinka ene naložbe.

Uredniška ocena javno dokumentiranega stanja

Lestvica: 1 = velika nedokumentirana vrzel, 2 = večje vrzeli, 3 = delna pokritost, 4 = dobro dokumentirano, 5 = celovito in preverljivo spremljanje. Enake uteži: po 1/7 za sedem ocenjenih meril. Stroški in učinkovitost niso ocenjeni zaradi manjkajočih primerljivih podatkov; ne štejejo kot nič. Ocene so raziskovalna presoja dokumentacije in izvedljivosti predlaganih ukrepov, ne klinična, akreditacijska ali stroškovna ocena izvajalcev.

MERILO	VODA	ZRAK	ŽIVLJENJSKE RAZMERE
Preglednost rezultatov	4: letna poročila in izvidi, napake ostajajo	4: javni podatki, prelom lokacije	3: SURS obstaja, lokalna anketa manjka
Dostop in razpoložljivost	4: široka javna oskrba, zasebni viri odprti	3: ena lokalna lokacija	3: možnosti obstajajo, dostop do zemlje neizmerjen
Ujemanje s potrebami	4: konkretne nevarnosti in ukrepi	4: PM in BaP sta pomembna lokalna signala	3: utemeljene poti vpliva, potrebe niso popisane
Dokazi in spremljanje	3: kontrole so objavljene, vzrok dogodka ni potrjen	3: kratka in prekinjena lokalna serija	2: ni meritev lokalnega učinka
Pravičnost in doseg	3: oddaljeni kraki in zasebni viri zahtevajo pregled	2: prostorski in socialni doseg izpostavljenosti manjka	2: ni meritev dostopa ranljivih
Stroški in učinkovitost	Ni ocene	Ni ocene	Ni ocene
Trajnost	3: potrebne obnove in zaščita virov	3: potreben večletni program	3: odvisno od trajne podpore
Izvedljivost ukrepov	4: znani odgovorni in postopki	3: potreben dogovor več deležnikov	3: izvedljiv pilot, širitev zahteva oceno
Izračun in status	25/7 = 3,57; ⚠️	22/7 = 3,14; ⚠️	19/7 = 2,71; ⚠️

Status pri vodi ne pomeni potrjene današnje nevarnosti: dogodek 2025 je dokumentiran, poznejši kontrolni vzorci negativni, trajna odprava pa ni potrjena. Pri zraku je presežena ciljna vrednost BaP potrjena za 2024, tekoče letno stanje ni zaključeno. Pravila za samodejni status ❌ zaradi potrjenega trenutno nerešenega tveganja zato ne uporabljamo zgolj iz zgodovinskih meritev; odprto vprašanje jasno ohranimo.

Primerjave

Plače so primerjane s Slovenijo za isto leto in po isti objavi SURS. Pri zraku primerjava s priporočili uporablja isto frakcijo in letni čas povprečenja. Novo mesto v letnem pregledu 2025: PM10 14 in PM2,5 12 µg/m³; Črnomelj 19 in 15 µg/m³. To je primerjava merilnih mest mestnega ozadja, ne povprečij celotnih občin. **[185]** **[8]**

Za JV Slovenijo, EU/OECD in podobne občine potrebujemo primerljive podatke o izpostavljenosti, dohodkih gospodinjstev, stresu in samooskrbi ter pri vodi enak način vzorčenja. Brez njih ne izdelamo lestvice občin ali trditve, da podeželje izravna nižje dohodke. Raziskava vrtov je primer intervencije z evalvacijo, ne primerljiva občinska zdravstvena statistika. **[187]**

Odprta vprašanja

Manjkajo izvorne tabele vode pred 2011, popolna razlaga dogodka Adlešiči, primerljiva časovna vrsta stanja reke Dobličice, potrjen agregat BaP za 2025 ter meritve stresa, samooskrbe in dostopa do zemlje. Leto 2026

ostaja delno. Predlagana naslednja raziskava je povezava teh evidenc po enotnih definicijah, brez povezovanja osebnih zdravstvenih podatkov.

---

29 Dvanajst vprašanj za odgovorne

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
1 · Vodja CKZ	Koliko različnih ljudi je CKZ obravnaval v 2025 in koliko do presečnega datuma 2026, ločeno od števila obiskov?
2 · CKZ in ZD	Kakšna je realizacija po posameznih programih glede na načrtovane skupine, ure in udeležence?
3 · Vodstvo ZD	Koliko dejanskih zaposlenih in ekvivalentov polnega delovnega časa je namenjenih CKZ po poklicih?
4 · Računovodstvo ZD	Kakšni so letni neposredni in razporejeni stroški CKZ ter prihodki po virih financiranja?
5 · CKZ	Koliko ljudi je družinsko obravnavo začelo, zaključilo in opravilo kontrolno meritev; kako pojasnjujete 13/17 = 79 %?
6 · CKZ in NIJZ	Kateri standardizirani izidi se spremljajo po 6 in 12 mesecih in ali lahko objavite agregate brez osebnih podatkov?
7 · Občina in CKZ	Katera naselja in skupine imajo najslabši dostop ter s čim boste ocenili ovire pri prevozu in terminih?
8 · Šole in ustanoviteljica	Koliko dodatnih ur gibanja je na voljo vsem otrokom in ali prevoz oziroma strošek komu preprečujeta udeležbo?
9 · Pediatrija	Kateri razlogi pojasnjujejo 44,4-odstotno precepljenost proti pnevmokokom v prikazani kohorti in kako boste preverili zamujene odmerke?
10 · Občina in socialni izvajalec	Ali nizek delež pomoči na domu izhaja iz manjših potreb, cene, kadrov ali čakanja; kakšen je popis potreb?
11 · ZD in policija	Kako povezujete obravnavo tveganega pitja, prometno preventivo in spremljanje ponavljajočih se kršitev brez nedovoljenega povezovanja osebnih evidenc?
12 · Svet zavoda in občini	Kdaj boste obravnavali javni letni pregled CKZ in kdo bo neodvisno presodil doseganje ciljev po štirih letih?

Viri in metodologija

Kako beremo podatke, kaj je bilo popravljeno in na katerih dokazih temeljijo ugotovitve. Vsaka navedba vodi do bibliografskega zapisa in stanja lokalne kopije.

02 Kako brati in primerjati podatke

Preverjena je aktualna publikacija NIJZ za Črnomelj, izdana aprila 2026, in vseh 54 lokalnih Excelovih časovnih nizov. Grafi prikazujejo **leto objave**. Posamezna izdaja združuje meritve iz različnih preteklih obdobij. [2][3]

SKUPINA PODATKOV	REFERENČNO OBDOBJE V IZDAJI 2026	OMEJITEV
Prehranjenost otrok in odraslih, Svit, zdravila, bolniška odsotnost	2024	To niso meritve zdravstvenega stanja v septembru 2026.
DORA / ZORA	DORA: 1. 1. 2024–31. 10. 2025. ZORA: 1. 7. 2021–30. 6. 2024.	Različni programi, starostne skupine in obdobja.
Umrljivost, srčna in možganska kap, alkoholne bolezni, nesreče	Povprečje 2020–2024	Sosednje izdaje se časovno prekrivajo; to niso neodvisna letna opazovanja.
Novi primeri raka	Povprečje 2018–2022	Daljši zamik; ni primerno za oceno učinka dogodkov v 2025 ali 2026.
HPV / pnevmokok / OMR / DTP-Hib-IPV-hepB	HPV: kohorta šestošolcev 2023/24; preostali navedeni kazalniki: otroci, rojeni 2022.	Ne gre za precepljenost celotnega prebivalstva ali vseh starejših.

Obdobja so prepisana iz pojasnil pod tabelo NIJZ, str. 4 publikacije. [2]

> **Pomemben prelom pri umrljivosti.** Izdaje 2016–2018 uporabljajo običajno bivališče, poznejše stalno. NIJZ pri splošni umrljivosti izrecno opozori na neprimerljivost. Na grafih je prelom označen in črta prekinjena. Standardizirane stopnje že upoštevajo različno starostno strukturo, zato višje stopnje ne pojasnimo preprosto s »starejšim prebivalstvom«. [61]

Razlika med točkovnima ocenama sama po sebi ne dokazuje statistično značilne razlike. Rdeča oziroma zelena oznaka NIJZ označuje potrjeno neugodno oziroma ugodno razliko, rumena neznačilno razliko, modra pa razliko, pri kateri smer ni enoznačno dobra ali slaba. Tako je lahko več prejemnikov zdravil tudi posledica boljšega odkrivanja in zdravljenja. [2][61]

▼ Celoten pregled 54 kazalnikov in prenos podatkov

Prenesi podatke CSV · Manjkajoče vrednosti ostanejo manjkajoče; niso pretvorjene v ničle.

KAZALNIK	ZADNJA IZDAJA Z VREDNOSTJO	ČRNOMELJ	SLOVENIJA ISTE IZDAJE
K1.1 Razvitost občine	2026	0,9	1
K1.2 Prirast prebivalstva	2026	-1,19	3,25

KAZALNIK	ZADNJA IZDAJA Z VREDNOSTJO	ČRNOMELJ	SLOVENIJA ISTE IZDAJE
K1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)	2026	5,85	5,86
K1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)	2026	15,49	11,76
K1.5 Stopnja delovne aktivnosti	2026	69,3	68,58
K1.6 Delovne migracije	2019	68,79	100
K2.2 Prekomerna prehranjenost otrok	2026	28,3	24,18
K2.3 Kadilci	2021	23,7	23,2
K2.4 Visokotvegano opijanje	2021	46,2	42,8
K2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah	2026	1,23	0,96
K2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji	2026	12,94	8,22
K2.7 Sosedska povezanost	2017	62,5	64,9
K2.8 Umivanje zob	2026	62,96	68,74
K2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih	2026	61,64	59,78
K2.10 Hrupno okolje	2026	22,32	29,32
K2.11 Uporabniki marihuane	2026	14,04	21,96
K2.12 Dostop do površin za rekreacijo	2022	74,2	88,2
K2.13 Dostop do varnih kolesarskih in sprehajalnih poti	2023	97,8	97,5
K2.14 Sodelovanje pri odločitvah skupnosti	2023	53	50,8
K3.1 Odzivnost v Program Svit	2026	68,14	64,94
K3.2 Presejanost v Programu Zora	2026	71,96	72,48
K3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode	2018	96,7	90,6
K3.4 Presejanost v Programu DORA	2026	82,08	77,93
K3.5 Precepljenost proti okužbam s HPV	2026	40,67	46,27
K3.6 Precepljenost proti pnevmokokom	2026	44,44	55,15
K3.7 Precepljenost proti OMR	2026	88,1	86,94

KAZALNIK	ZADNJA IZDAJA Z VREDNOSTJO	ČRNOMELJ	SLOVENIJA ISTE IZDAJE
K3.8 Precepljenost proti DTP-Hib-IPV-hepB	2026	83,33	85,61
K4.1 Samoocena dobrega zdravja	2021	63,7	67,5
K4.2 Bolniška odsotnost	2026	19,17	20,53
K4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)	2026	0,31	0,39
K4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)	2026	1,21	1,61
K4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni	2026	5,72	5,47
K4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka	2026	25,38	22,51
K4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi	2026	12,03	12,06
K4.8 Srčna kap (35-74 let)	2026	1,66	1,86
K4.9 Možganska kap (35-84 let)	2026	2,26	2,21
K4.10 Novi primeri raka	2026	566,6	577,33
K4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)	2026	6,53	6,04
K4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj	2026	15,64	14,47
K4.13 Pomoč na domu	2026	1,02	1,84
K4.14 Klopni meningoencefalitis	2026	2,16	6,07
K4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke	2026	61,74	59,01
K4.16 Novi primeri pljučnega raka	2026	74,37	70,6
K4.17 Novi primeri raka dojke	2026	126,51	131,39
K4.18 Novi primeri malignega melanoma	2020	18,3	26,3
K4.19 Novi primeri raka želodca	2024	18,88	21,73
K4.20 Oviranost pri skrbi zase	2023	2,6	6,5
K5.1 Umrljivost po stalnem bivališču	2026	949,38	913,09
K5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)	2026	70,01	62,78
K5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)	2026	141,85	140,86

KAZALNIK	ZADNJA IZDAJA Z VREDNOSTJO	ČRNOMELJ	SLOVENIJA ISTE IZDAJE
K5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja	2017	19,3	14,3
K5.5 Umrljivost zaradi raka dojke	2017	15,5	20,3
K5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)	2026	24,37	33,54
K5.7 Umrljivost zaradi samomora	2026	17,1	17,63

Prenesi vrednosti ohranjenih grafov (CSV) (izpis iz prikaza). Celotna izvirna tabela kazalnikov je v kazalniki.csv, izvirnih 54 Excelov NIJZ pa v mapi viri/nijz in lokalni knjižnici virov (obnovljeni iz commita 0dc0bd4 25. 9. 2026 in preverjeni z izvirnim manifestom SHA-256).

---

26 Raziskave o dejavnikih zdravja in omejitve lokalnih sklepov

Znanstvena literatura pomaga izbrati ukrepe. Ne dokazuje, da je določen dejavnik glavni vzrok prav v Črnomlju. Lokalno vzročnost bi morali preveriti z dodatnimi podatki o prehrani, gibanju, dostopnosti in poteku obravnave.

PROBLEM IN MEHANIZEM	RAZISKAVA / MOČ DOKAZA	UPORABNA POSLEDICA IN OMEJITEV
Prekomerna prehranjenost otrok. Hrana, gibanje, spanje, psihosocialne okoliščine in biologija delujejo skupaj.	Slovenska nerandomizirana raziskava več kot 34.000 sodelujočih in primerjalne skupine: 2–3 dodatne šolske ure gibanja tedensko; največja razlika v ITM po 3–4 letih. [216]	Reden večletni šolski program ima boljšo dokazno podlago kot pričakovanje spremembe po enkratnem dogodku. Izbira udeležencev lahko vpliva na rezultat; konkretnega učinka v Črnomlju ne napovemo.
Prehransko okolje. Dostopna in hitro zaužita hrana lahko poveča energijski vnos.	Hall in sod.: randomizirana navzkrižna bolnišnična raziskava 20 odraslih, po dva tedna na vsaki prehrani; ob ultra predelani prehrani približno 508 kcal/dan več. [224]	Smiselna je sprememba ponudbe hrane. Majhna kratka raziskava odraslih ni neposredna ocena otroške prehrane v Beli krajini.
Tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Presežna masa in neaktivnost sta spremenljiva dejavnika.	DPP: randomiziranih 3.234 odraslih z visokim tveganjem; intenziven življenjski program je v povprečno 2,8 leta zmanjšal pojavnost bolezni za 58 % relativno proti placebu. [219]	Prednost imajo strukturirana obravnava, nadaljnji stiki in spremljanje. Rezultat ne pomeni 58-odstotnega zmanjšanja bolezni v celotni občini ali po eni delavnici.
Visok tlak in srčno-žilni zapleti. Zdravljenje urejenega tlaka zmanjšuje tveganje.	SPRINT: randomiziranih 9.361 oseb z večjim srčno-žilnim tveganjem brez diabetesa; intenzivna obravnava je zmanjšala primarni sestavljeni izid, a povečala nekatere neželene dogodke. [220]	CKZ lahko podpira merjenje in sodelovanje pri zdravljenju; cilje in terapijo določa zdravnik. Univerzalni cilj pod 120 mmHg iz te študije ni primeren za vse prebivalce.
Alkohol in promet. Vplivajo dostopnost, cena, družbene norme in vožnja po pitju.	WHO SAFER povezuje omejevanje dostopnosti, ukrepe proti vožnji pod vplivom, kratke intervencije/zdravljenje, omejitve oglaševanja in cenovne ukrepe. [218]	Lokalno povezati ZD, policijo, občino in organizatorje prireditev. Davki in večina regulacije so državni ukrepi; vinorodnost sama ni dokaz lokalnega vzroka.

PROBLEM IN MEHANIZEM	RAZISKAVA / MOČ DOKAZA	UPORABNA POSLEDICA IN OMEJITEV
Kajenje. Zasvojenost zahteva trajnejšo podporo kot informiranje.	Klinične smernice WHO 2024 obravnavajo vedenjsko podporo in zdravljenje opuščanja tobaka. [221]	Vzpostaviti prehod od svetovanja do obravnave ter preverjati abstinenco po 6 in 12 mesecih; izbiro zdravljenja vodi zdravstveni strokovnjak.
Duševne stiske in samomorilnost. Preplet socialnih stisk, bolezni in življenjskih dogodkov.	WHO LIVE LIFE: zgodnje prepoznavanje in spremljanje, življenjske veščine mladih, odgovorno medijsko poročanje ter varnejše okolje. [222]	Povezati CKZ, družinsko medicino, šole, CSD in specialistično pomoč. Delavnica sproščanja ne nadomesti zdravljenja težje duševne motnje.
Neenak dostop. Stroški, prevoz, delovni čas, izobrazba in bivanjske razmere omejujejo možnosti.	WHO, World report on social determinants of health equity, 2025. [183]	Meriti ovire po naseljih in uporabniških skupinah. Udeležbe ne razlagati samo kot »osebno motivacijo«; učinka posamezne ovire lokalno še ne poznamo.

Predavanja in strokovna gradiva za izvajalce

GRADIVO	KAJ JE BILO PREVERJENO	UPORABA
WHO / UNICEF / World Obesity Federation: *Accelerating childhood overweight reduction*, 21. 11. 2024. [225]	Prebrane spremljevalne prosojnice, zlasti str. 7–8 in 15–19: več vzrokov, preprečevanje stigme, šolsko okolje in financiranje. Video ni bil v celoti pregledan. [226]	Skupni strokovni sestanek CKZ, šol in občine; pripraviti lokalni načrt po odgovornostih. Globalni cilji za otroke pod 5 let niso isti kazalnik kot NIJZ za šolske otroke.
WHO: predstavitev smernic za zdravo šolsko prehransko okolje, 27. 1. 2026. [227]	Preverjena uradna objava z video povezavo in opisom smernic; uporabljena objavljena vsebina o ponudbi, pravilih in spodbudah pri izbiri hrane. [217]	Pregled šolskih jedilnikov, ponudbe pijač in dostopnosti vode; spremembo ponudbe povezati z izobraževanjem.

Predavanja so dopolnilna strokovna razlaga. Ocene učinkov v zgornji tabeli izhajajo iz raziskav, ne iz promocijskih opisov webinarjev.

---

30 Popravki, omejitve in sled sprememb

Prejšnja izdaja je shranjena v lokalnem arhivu. Prenova ohranja izvorne številčne nize, popravlja njihovo razlago in dodaja novo dokazno podlago.

PREJŠNJA NAVEDBA	POPRAVEK IN PODLAGA
AED pri gasilskih domovih, podjetjih in zasebnih lokacijah morda niso dosegljivi; dostop naj bi bil odvisen od gasilcev.	23. 9. 2026: vsi AED-ji v občini Črnomelj so javno dostopni, po popravku naročnika. Vrsta lokacije ni dokaz omejenega dostopa. Popravek ne določa ur dostopa ali stanja naprav in ne zajema sosednjih občin. [114]
Zaključna opomba je celoten pregled omejevala na 19. 9. 2026.	Datum velja za osnovni pregled in register; tematske dopolnitve so posebej datirane. Dne 22. 9. 2026 dodane prazne predloge spremljanja, brez novih rezultatov CKZ; ponovno preverjen opis NIJZ. [75]
Vodja CKZ ni javno znana; približno 2–3 FTE.	Vodja je javno imenovana. Pogodbeni tim ni zaposleni oziroma FTE. [4][5]
Otroška prehranjenost je edini dosleden zaostanek in se ni izboljšala.	31,1 → 28,3 %; napredek ob vztrajni vrzeli. Več drugih kazalnikov je prav tako dosledno nad povprečjem. [3]

PREJŠNJA NAVEDBA	POPRAVEK IN PODLAGA
Koeficient razvitosti je vedno 0,90; delovna aktivnost šele 2026 nad povprečjem.	Razpon 0,87–0,91; delovna aktivnost nad slovensko že 2019. [3]
Nesreče z alkoholom so se skoraj prepolovile.	18,9 → 12,94 %, približno −31,5 %. [3]
Tri bolezni so iz nadpovprečja trajno prešle pod povprečje.	Možganska kap v zadnji izdaji 2,26 proti 2,21; alkoholne bolezni že 2016 pod slovensko stopnjo. [3]
Umrljivost ima neposredno primerljiv desetletni trend; odstopanje pojasni staranje.	Prelom metodologije 2018/2019; stopnje so že starostno standardizirane. [61]
13/17 pomeni 79 % uspešnost.	Izvirni vir vsebuje računsko napako: 76,5 %. Poleg tega ni znan trajni učinek. [5]
Slovenija ima najvišjo stopnjo samomorov v EU.	Neuporabljena trditev; za razvrstitev potrebujemo usklajeno leto, definicijo in standardno populacijo.
Prejšnja izdaja še ni vsebovala letnega pregleda vode in lokalnih meritev zraka.	24. 9. 2026: dodani letni viri vode 2011–2025, delni izvidi 2026 in zrak 2024–2026. Manjkajoča leta so označena. [205]
Možna napačna razlaga: 100 % rutinskih vzorcev pomeni odsotnost vseh nevarnosti.	Rutinske analize 2025 ločene od dodatnih pozitivnih preiskav parazitov v Adlešičih. Ne gre za trditev o današnji prepovedi uporabe. [6]
Možna napačna razlaga: 39 dni PM10 samodejno pomeni neskladnost; 2025 dokazuje izboljšanje.	Za 2024 je ARSO po odštetju naravnega prispevka navedel 34 dni. Leta 2025 se je merilnik preselil. [7][9]
Poročilo ni vsebovalo aktualnega stanja vodenja ZD in objavljenega razporeda ambulant.	25. 9. 2026: dodan datiran posnetek. Izbira novega direktorja je označena kot neuradna, dokler je ne potrdi uradni vir. [118][119]
Poročilo ni obravnavalo dostopa do nujne pomoči, neopredeljenih pacientov, vročine, duševnega zdravja mladih, dolgotrajne oskrbe ter prometa in alkohola.	25. 9. 2026: dodanih šest poglavij z 20 novimi lokalno shranjenimi viri. Modelski časi vožnje (OSRM) so označeni kot ocena, ne kot dostopni čas NMP. Popravek med pripravo: prvotni osnutek je trdil, da mreža prvih posredovalcev ni dokumentirana; letno poročilo ZD 2025 jo navaja kot vzpostavljeno, zato je trditev popravljena pred objavo.
Poročilo ni omenjalo trim steze Vražji kamen, Ribje in Učne poti pa ni povezalo s Srčno potjo koronarnih bolnikov.	26. 9. 2026: dodano poglavje v zavihku poti in oznaka na zemljevidu. GPX Ribje poti s strani Srčne poti je enak že analiziranemu (SHA-256). Trasa trim steze bo dodana, ko bo GPX na voljo.
Zemljevid dostopnosti je prikazoval en sam modelski čas (OSRM) kot oceno vožnje.	26. 9. 2026: naročnik je s primerjavo z Google Maps ugotovil neujemanje. Dodan drug model (Valhalla), prikazan razpon obeh ter pripravljeno umerjanje na Googlove čase (predloga). Najdena napaka v podatkih: enopasovna lokalna cesta proti Gribljam ima v OSM vpisano omejitev 90 km/h.
Uvod je navajal »preverjeno oceno dela CKZ«; oznaka AED »javno dostopen« je lahko zvenela kot zagotovljen dostop.	25. 9. 2026: ocena CKZ ostaja uredniška presoja dokumentiranega dela. Dostopnost AED je ločena od nepreverjenega urnika in namestitve; ohranjeni zapis ni nova terenska potrditev. Dokaz: ohranjena izdaja v arhivu in njeni podatkovni zapisi.
Spanje in digitalne navade niso imeli samostojnega raziskovalnega pregleda.	25. 9. 2026: dodana ločena presoja populacij, vzročnosti in omejitev dostopa do člankov. [86][93]
Stari manifest je bil opisan kot potrjen za celoten obnovljeni obseg.	25. 9. 2026: pri 313 besedilnih datotekah je potrjena ekvivalentnost po pretvorbi koncev vrstic. Šest podedovanih HTML-kopij se še ne ujema; pričakovane in opažene vsote so ohranjene v registru neskladij. Izvirnih pričakovanih vsot nismo nadomestili z novimi.

PREJŠNJA NAVEDBA	POPRAVEK IN PODLAGA
Prenova 25. 9. 2026 je navajala, da je del starega arhiva izgubljen in da 77 prenosov ter izvirni GPX in Exceli NIJZ niso na voljo.	25. 9. 2026 (popoldne): 1.087 izpraznjenih datotek je obnovljenih iz prve git različice projekta (commit 0dc0bd4). 1.289 od 1.290 datotek izvirnega manifesta se ujema z zapisanimi SHA-256 (razlika le v koncih vrstic); izjema je `viri/AEDs.xlsx`, katere neskladje je bilo zabeleženo že 23. 9. Manjka le še zapis naročnika o dostopnosti AED z dne 23. 9. Postopek: seznam obnovljenih datotek.

Odprto: popolna evidenca dogodkov CKZ, nedvoumni datumi starejših koledarskih vabil, primerljivi podatki drugih centrov, stroški in dolgoročni izidi uporabnikov. Javni register beleži stanje spletnih strani ob dostopu in ne more nadomestiti izvajalčeve evidence. Osnovni pregled in register objav imata presek 19. 9. 2026; poznejše tematske dopolnitve imajo naveden svoj datum (kader in šport 21. 9., obrazci CKZ in ponovna preverba strani NIJZ o spremljanju 22. 9., javna dostopnost AED 23. 9. 2026).

Literatura (IEEE)

Številčenje sledi prvemu pojavu v poročilu. Novi viri o spanju imajo lokalne kopije in kontrolne vsote; obseg branja je naveden pri vsakem. Starejše lokalne kopije so bile 25. 9. 2026 obnovljene iz prve različice projekta in preverjene z izvirnim manifestom SHA-256 (1.289 od 1.290 ujemanj). Pri okoljskem arhivu ostaja šest neskladij HTML-kopij. Kontrolne vsote potrjujejo izvirnost kopij, ne aktualnosti starejših ugotovitev.

[1] »Črnomelj | Zdravje v občini | NIJZ,« NIJZ, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://obcine.nijz.si/obcine/crnomelj/17/2026/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[2] »Zdravje v občini 2026: Črnomelj,« NIJZ, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://obcine.nijz.si/api/files/c49f9ba8760c194efdfc379c907674b2edc51334/data. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[3] »Časovni nizi kazalnikov za Črnomelj, izdaje 2016–2026: 54 Excelovih datotek,« NIJZ, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://obcine.nijz.si/obcine/crnomelj/17/2026/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Lokalni izvirniki XLSX; izvoz v podatki/nijz/kazalniki.csv. Leto v nizu pomeni leto objave.

[4] »Kontakti Centra za krepitev zdravja Črnomelj,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/ckz/predstavitev/kontakti/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[5] »Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2025,« ZD Črnomelj, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2026/03/Letno-porocilo-ZD-Crnomelj-2025.pdf. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[6] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2025,« NLZOH / Komunala Črnomelj, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dokumenti/Vodovod/Letno%20poro%C4%8Dilo%20za%20vodo/Komunala%20%C4%8Crnomelj%20poro%C4%8Dilo%202025_compressed.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[7] »Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2024,« ARSO, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno_porocilo_2024_za_splet.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[8] »Naše okolje, december 2025: letni pregled kakovosti zraka, str. 142,« ARSO, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/Nase%20okolje%20-%20december%202025.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[9] »Naše okolje, februar 2025: selitev postaje Črnomelj,« ARSO, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/Nase%20okolje%20-%20februar%202025.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[10] Zdravstveni dom Črnomelj. »Kako do nas,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/kako-do-nas/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Kontakti iz strani in noge strani (izvirni HTML: zd-kako-do-nas.html). Zanesljivost: visoka za kontakte.

[11] Zdravstveni dom Črnomelj. »Nujna medicinska pomoč,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/nujna-medicinska-pomoc/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeno organizacijo.

[12] Zdravstveni dom Črnomelj. »Zdravstvena postaja Vinica,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d. (stanje 1. 8. 2026). [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/zdravstvena-postaja-vinica/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeni podatek.

[13] Zdravstveni dom Črnomelj. »Splošna ambulanta,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d. (stanje 1. 8. 2026). [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/splosna-medicina/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeni podatek.

[14] NIJZ. »Portal in mobilna aplikacija zVEM – vaše zdravje na dosegu roke,« NIJZ, 26. avgust 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/informatika-v-zdravstvu/ezdravje/portal-in-mobilna-aplikacija-zvem-vase-zdravje-na-dosegu-roke/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka.

[15] NIJZ. »Vzemite si čas za svoje zdravje – pojdite na preventivni pregled,« NIJZ, 27. februar 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/programii/vzemite-si-cas-za-svoje-zdravje-pojdite-na-preventivni-pregled/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka.

[16] Zdravstveni dom Črnomelj. »Referenčne ambulante,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/referencne-ambulante/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljene kontakte in urnike.

[17] CKZ ZD Črnomelj. »Vadba na trim stezi Vražji kamen,« Zdravstveni dom Črnomelj, Center za krepitev zdravja, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/ckz/vadbe/vadba-na-trim-stezi-vrazji-kamen/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeno vsebino.

[18] Zdravstveni dom Črnomelj. »Patronažna služba,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/patronazna-sluzba/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljene kontakte.

[19] Zdravstveni dom Črnomelj. »Dispanzer za mentalno zdravje,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/dispanzer-za-mentalno-zdravje/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeno organizacijo.

[20] NIJZ, Program MIRA. »Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Novo mesto,« Program MIRA (zadusevnozdravje.si), b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.zadusevnozdravje.si/center/center-za-dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov-novo-mesto/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Iz shranjenega HTML je odstranjen javni API ključ spletišča (redakcija 26. 9. 2026, glej viri/manifest.json). Zanesljivost: visoka za objavljene kontakte in območje.

[21] NIJZ, Program MIRA. »Kam po pomoč,« zadusevnozdravje.si, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Seznam telefonov za pomoč v duševni stiski. Zanesljivost: visoka za kontakte.

[22] Dom starejših občanov Črnomelj. »Informacije,« DSO Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.domcrnomelj.si/sl/informacije/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za kontakte.

[23] CSD Dolenjska in Bela krajina. »Dolgotrajna oskrba,« Centri za socialno delo Slovenije, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.csd-slovenije.si/csd-dolenjska-in-bela-krajina/dolgotrajna-oskrba/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljen postopek in kontakte.

[24] Skupnost centrov za socialno delo Slovenije. »Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj,« SCSD, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-csd/csd-crnomelj/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za kontakte.

[25] Dom starejših občanov Metlika. »Demenci prijazna točka,« DSO Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.dso-metlika.si/aktivnosti/demenci-prijazna-tocka/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeno ponudbo.

[26] Ministrstvo za zdravje. »Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 666/2026),« Uradni list Republike Slovenije, 19. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV15756. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Prebrani 1.–20. člen ter Prilogi 7 (poročanje) in 8 (usposabljanje prvih posredovalcev). Zanesljivost: visoka (predpis; velja od 3. 6. 2026).

[27] Svetovna zdravstvena organizacija. »Hypertension (fact sheet),« WHO, 25. 9. 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Ključna dejstva: 1,4 milijarde odraslih, starih 30–79 let, s hipertenzijo (2024), 44 % zanjo ne ve, 23 % ima urejen tlak. Zanesljivost: visoka (mednarodna agencija; ocene so modelirane).

[28] Združenje za arterijsko hipertenzijo. »Napotki za merjenje tlaka doma,« Združenje za arterijsko hipertenzijo (strokovno združenje SZD), b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://hipertenzija.org/napotki-za-merjenje-tlaka-doma/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran: priprava, položaj, manšeta, število meritev, pogostost, mejna vrednost 135/85, validirani merilniki. Zanesljivost: visoka za postopek merjenja (strokovno združenje).

[29] NIJZ. »Izmerite si obseg pasu! (zloženka),« NIJZ, 2018 (objavljeno 2022). [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/obseg_pasu_zlozenka.pdf. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna zloženka: merjenje v višini popka, meje 80/88 cm (ženske) in 94/102 cm (moški). Zanesljivost: visoka.

[30] NIJZ, Skupaj za zdravje. »Imate sladkorno bolezen tipa 2? Preverite,« NIJZ, 27. 2. 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://skupajzazdravje.si/izpostavljeno/imate-sladkorno-bolezen-tipa-2-preverite/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotni članek: sladkorna bolezen tipa 2 je pogosto brez znakov, vprašalnik FINDRISK, pri 15 točkah ali več k zdravniku. Zanesljivost: visoka.

[31] Onkološki inštitut Ljubljana, program ZORA. »Nadgradnja programa ZORA prinaša sodobnejše in zanesljivejše presejanje,« Onkološki inštitut Ljubljana, 20. 5. 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://zora.onko-i.si/novice/novica/nova-nadgradnja-programa-zora-prinasa-sodobnejse-in-zanesljivejse-presejanje. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Od 1. 1. 2027 ciljna skupina 25–64 let, postopna uvedba testa HPV v petih letih, interval 5 let po negativnem testu HPV. Zanesljivost: visoka.

[32] Onkološki inštitut Ljubljana, program DORA. »Vprašanja in odgovori,« Onkološki inštitut Ljubljana, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://dora.onko-i.si/vprasanja-in-odgovori. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Ciljna skupina 50–69 let, vabilo vsaki dve leti, mesečno samopregledovanje tudi med slikanji, ob spremembah takoj v center za bolezni dojk, telefon 080 27 28. Zanesljivost: visoka.

[33] Onkološki inštitut Ljubljana, program DORA. »OE Novo mesto,« Onkološki inštitut Ljubljana, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://dora.onko-i.si/presejalni-centri/oe-novo-mesto. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Presejalni center v ZD Novo mesto, Kandijska cesta 4; med vabljenimi občinami tudi Črnomelj, Metlika in Semič. Zanesljivost: visoka.

[34] NIJZ. »Program Svit,« NIJZ, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/programi/program-svit/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Ciljna skupina 50–74 let, vabilo vsaki dve leti, test na prikrito krvavitev doma, brezplačno. Zanesljivost: visoka.

[35] Onkološki inštitut Ljubljana. »Priporočila diagnostike in zdravljenja raka dojk,« Onkološki inštitut Ljubljana, december 2021. [Na spletu]. Dostopno: https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Strokovna_knjiznica/smernice/Priporocila_diagnostike_in_zdravljenja_raka_dojk_2021.pdf. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Poglavje »Presejanje in zgodnje odkrivanje raka dojk pri asimptomatskih ženskah« (str. 7–13): splošna populacija, zmerno in visoko povečana ogroženost; ostalo ni prebrano. Zanesljivost: visoka (nacionalna klinična priporočila).

[36] Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. »Samopregledovanje mod (kartonček),« DOBS, b.d. (objavljeno 2017). [Na spletu]. Dostopno: https://www.onkologija.org/wp-content/uploads/2017/04/kartoncek_pregledovanj_mod.pdf. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celoten kartonček z navodili. Zanesljivost: srednja (bolniško združenje).

[37] Onkološki inštitut Ljubljana. »Rak mod,« Onkološki inštitut Ljubljana, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.onko-i.si/o-raku/vrste-raka/rak-mod. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Najpogostejši rak mladih odraslih moških (20–40 let), 126 novih primerov v Sloveniji 2022, znaki, dejavniki tveganja. Zanesljivost: visoka.

[38] Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. »Kožni melanom,« DOBS, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.onkologija.org/o-raku/kozni-melanom/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Pogostost, dejavniki tveganja, pravilo ABCDE, mesečni samopregled, zaščita pred soncem. Zanesljivost: srednja (bolniško združenje).

[39] Onkološki inštitut Ljubljana. »Presejanje za raka prostate v raziskavi PRO-PETER,« Onkološki inštitut Ljubljana, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.onko-i.si/o-raku/presejanje-za-raka/raziskava-pro-peter. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Raziskava na naključno izbranih moških, starih 50–69 let (odvzem krvi na OI ali v UKC Ljubljana); kategorije PSA; kontakti. Regija vzorca na strani ni navedena. Zanesljivost: visoka.

[40] Onkološki inštitut Ljubljana (ur.). »Peta šola pljučnega raka (zbornik),« Onkološki inštitut Ljubljana, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Strokovna_knjiznica/strokovni_dogodki_OI_publikacije/sola_pljucnega_raka_2025.pdf. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Prispevek o presejanju (str. 10–12): projekt LUKA pripravlja strokovne podlage za morebitno presejanje z nizkodozno CT pri ljudeh z visokim tveganjem; program še ni uveden. Zanesljivost: visoka.

[41] Zdravstveni dom Črnomelj, CKZ. »Delavnice za odrasle,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/ckz/odrasli/krepitev-zdravja/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Seznam delavnic CKZ za odrasle. Zanesljivost: visoka za ponudbo (lastna objava izvajalca; izvedba ni potrjena).

[42] G. Parati, G. S. Stergiou, G. Bilo in sod.. »Home blood pressure monitoring: methodology, clinical relevance and practical application: a 2021 position paper by the Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability of the European Society of Hypertension,« Journal of Hypertension, 39(9), 1742–1767, 2021. [Na spletu]. Dostopno: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9904446/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Tabela praktičnih priporočil: validirani merilniki na nadlakti, 7 dni (vsaj 3) po dve meritvi zjutraj in zvečer, prag 135/85, dolgoročno enkrat do dvakrat tedensko ali mesečno; zapestni merilniki na splošno niso priporočeni. Zanesljivost: visoka (stališče delovne skupine ESH).

[43] G. S. Stergiou, R. Mukkamala, A. Avolio in sod.. »Cuffless blood pressure measuring devices: review and statement by the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability,« Journal of Hypertension, 40(8), avgust 2022. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003224. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Samo povzetek (Europe PMC); celotno besedilo ni prebrano. Zanesljivost: visoka (stališče delovne skupine ESH).

[44] Dolenjske lekarne. »Lekarna Črnomelj,« Dolenjske lekarne, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.dolenjske-lekarne.si/lekarne/lekarna-crnomelj. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Naslov, telefon, delovni čas, storitve (pregled uporabe zdravil; meritve na strani niso navedene). Zanesljivost: visoka za kontakte.

[45] NIJZ, Skupaj za zdravje. »Kolikšno je tveganje, da boste zboleli za sladkorno boleznijo? (vprašalnik FINDRISK),« NIJZ, februar 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://skupajzazdravje.si/wp-content/uploads/2026/02/Findrisk.pdf. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Obe strani: osem vprašanj s točkami in razlaga seštevka (10-letno tveganje). Zanesljivost: visoka.

[46] D. Pongrac Barlovič (ur.). »Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2,« Diabetološko združenje Slovenije, 2022. [Na spletu]. Dostopno: https://endodiab.si/wp-content/uploads/2022/10/Knjizica-Sladkorna-bolezen-tipa-2-100x160-mm-2022-06-13-v5-4-za-web-VSEBINA.pdf. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Poglavji o presejanju in diagnozi (preventivni pregledi od 30. leta, merila za diagnozo, odsvetovano merjenje glukoze za diagnozo zunaj zdravstvenega sistema) in o samokontroli; ostalo ni prebrano. Zanesljivost: visoka (nacionalne klinične smernice).

[47] J. P. Kösters, P. C. Gøtzsche. »Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer,« Cochrane Database of Systematic Reviews, CD003373, 2003. [Na spletu]. Dostopno: https://www.cochrane.org/evidence/CD003373_regular-self-examination-or-clinical-examination-early-detection-breast-cancer. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Povzetek v preprostem jeziku in sklepi avtorjev: 388.535 žensk, brez vpliva na umrljivost, skoraj dvakrat več biopsij. Zanesljivost: visoka (sistematični pregled; starejši).

[48] U.S. Preventive Services Task Force. »Testicular Cancer: Screening,« USPSTF, 15. 4. 2011. [Na spletu]. Dostopno: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/testicular-cancer-screening. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Priporočilo proti presejanju moških brez znakov (razred D) in pojasnilo, da to ne velja za moške z znaki. Zanesljivost: visoka (ameriški neodvisni strokovni odbor; drug zdravstveni sistem).

[49] U.S. Preventive Services Task Force. »Skin Cancer: Screening,« USPSTF, 18. 4. 2023. [Na spletu]. Dostopno: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/skin-cancer-screening. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Dokazi nezadostni za pregled kože pri ljudeh brez znakov in za svetovanje o samopregledu; ne velja za ljudi s spremembami znamenj. Zanesljivost: visoka (ameriški neodvisni strokovni odbor; drug zdravstveni sistem).

[50] Europa Donna Slovenija. »Samopregled,« Europa Donna Slovenija, združenje za boj proti raku dojk, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://europadonna.si/ostani-zdrav/samopregled/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran: kdaj, spremembe, na katere smo pozorni, koraki samopregleda (ogled, otip dojk, bradavic, pazduh, leže). Zanesljivost: srednja (bolniško združenje).

[51] Onkološki inštitut Ljubljana. »Presejanje za raka,« Onkološki inštitut Ljubljana, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.onko-i.si/o-raku/presejanje-za-raka. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Trije organizirani programi (ZORA, DORA, Svit) in raziskava PRO-PETER; opozorilo, da noben presejalni test ni 100-odstotno zanesljiv. Zanesljivost: visoka.

[52] E. Toes-Zoutendijk in sod.. »European Code Against Cancer, 5th edition – organised cancer screening programmes,« Molecular Oncology, 16. 1. 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12809467/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Priporočila za posameznike in odločevalce (debelo črevo, dojke, maternični vrat, pljuča) in stališče do presejanja raka prostate. Zanesljivost: visoka (IARC/WHO, sistematična presoja).

[53] Onkološki inštitut Ljubljana, program DORA. »Začetek raziskave programa DORA med ženskami, starimi od 45 do 49 ter od 70 do 74 let,« Onkološki inštitut Ljubljana, 1. 9. 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://dora.onko-i.si/novica/zacetek-raziskave-programa-dora-med-zenskami-starimi-od-45-do-49-ter-od-70-do-74-let. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Raziskava za načrtovano širitev na 45–74 let; vzorec 2.150 žensk iz sedmih občin ljubljanske enote, do konca 2026. Zanesljivost: visoka.

[54] Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije; Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. »GROM – prepoznaj znake možganske kapi,« grominute.si, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.grominute.si/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran: G, R, O, M, klic 112, dodatni znaki. Zanesljivost: srednja (združenji bolnikov in laikov; vsebinsko skladno z mednarodnim FAST).

[55] M. Noč, P. Radšel (UKC Ljubljana). »Bolnik po srčnem infarktu (knjižica V skrbi za vaše zdravje),« Krka (izdajatelj knjižice), b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.ambulanta-garmus.si/krkapdf/krka016.pdf. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Poglavji »Kako prepoznate srčni infarkt?« in »Kako je treba ravnati ob srčnem infarktu?« (str. 4–5). Zanesljivost: srednja (strokovna avtorja; izdaja farmacevtskega podjetja; datum ni naveden).

[56] Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. »Atrijska fibrilacija – bolezen razvitega sveta,« Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 6. 3. 2012. [Na spletu]. Dostopno: https://zasrce.si/clanek/atrijska_fibrilacija_bolezen_razvitega_sveta/. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Znaki atrijske fibrilacije in povezava z možgansko kapjo (do petkrat večje tveganje). Zanesljivost: srednja (starejši poljudni članek).

[57] Onkološki inštitut Ljubljana, program DORA. »Državni program DORA pričenja s slikanjem žensk v Zdravstvenem domu Novo mesto: presejalni program se širi v OE ZZZS Novo mesto in Krško,« Onkološki inštitut Ljubljana, 14. 12. 2016. [Na spletu]. Dostopno: https://dora.onko-i.si/novica/drzavni-program-dora-pricenja-s-slikanjem-zensk-v-zdravstvenem-domu-novo-mesto-presejalni-program-s. [Dostopano: 27. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Napoved mobilne presejalne enote v Beli krajini za ženske iz Črnomlja, Metlike in Semiča (predviden začetek 2018). Zanesljivost: visoka (uradna napoved; starejša).

[58] »Prebivalstvo po starosti, občine, Slovenija, polletno,« Statistični urad Republike Slovenije, 18. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4003S.px. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Poizvedba: Slovenija in Črnomelj, H1 2008–2026, oba spola skupaj. Podrobni izvoz ob poročilu.

[59] »Prebivalstvo — izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno,« Statistični urad Republike Slovenije, 18. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4008S.px. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Poizvedba: Slovenija in Črnomelj, H1 2008–2026, oba spola skupaj. Podrobni izvoz ob poročilu.

[60] »Prebivalstvo — izbrani kazalniki: metodološka pojasnila,« Statistični urad Republike Slovenije, 18. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4008S.px. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Poizvedba: Slovenija in Črnomelj, H1 2008–2026, oba spola skupaj. Podrobni izvoz ob poročilu.

[61] »Zdravje v občini 2026 — Opisi kazalnikov,« NIJZ, marec 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://obcine.nijz.si/vsebine/metodoloska-pojasnila/opisi-kazalnikov-2026-223/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran lokalni izvirnik: str. 8–9, 19–20, 66–67, 96–97 in 108–109 (natisnjene strani).

[62] G. Starc, M. Kovač, B. Leskošek, M. Sorić, G. Jurak. »ŠVK 2025 – Poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine v šolskem letu 2024/25,« Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.slofit.org/Portals/0/Porocilo_2025_1.pdf. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Poglavje o prehranjenosti (str. 19–23) in povzetek sprememb (str. 55–57). Zanesljivost: visoka (nacionalno spremljanje ~96 % šolarjev).

[63] T. Brown in sod.. »Interventions for preventing obesity in children (povzetek v preprostem jeziku),« Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1002/14651858.CD001871.pub4. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Povzetek v preprostem jeziku. Zanesljivost: visoka (sistematični pregled 153 RCT; prebran povzetek).

[64] G. Bergen in sod.. »Publicized sobriety checkpoint programs: a Community Guide systematic review,« American Journal of Preventive Medicine, 46(5), str. 529–539, 2014. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1016/j.amepre.2014.01.018. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Prebran povzetek (PubMed). Celotni članek ni prosto dostopen; podrobnosti dokazov so iz uradnega povzetka Community Guide. Zanesljivost: srednja do visoka (sistematični pregled; ZDA; prebran povzetek).

[65] Policija, GPU. »Alkohol in droge za volanom jemljejo življenja: od 16. decembra do konca leta poostreno preverjamo, ali vozite pod vplivom alkohola in drog,« Policija, december 2024. [Na spletu]. Dostopno: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/123617-alkohol-in-droge-za-volanom-jemljejo-zivljenja-od-16-decembra-do-konca-leta-poostreno-preverjamo-ali-vozite-pod-vplivom-alkohola-in-drog. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotno sporočilo. Zanesljivost: srednja (sporočilo za javnost; nacionalni podatki).

[66] Community Preventive Services Task Force. »Motor Vehicle Injury – Alcohol-Impaired Driving: Publicized Sobriety Checkpoint Programs (Task Force Finding and Rationale Statement),« The Community Guide (CDC), avgust 2012 (dopolnjeno). [Na spletu]. Dostopno: https://www.thecommunityguide.org/findings/motor-vehicle-injury-alcohol-impaired-driving-publicized-sobriety-checkpoint-programs.html. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran s povzetkom rezultatov, ekonomskimi dokazi, uporabnostjo in vrzelmi. Zanesljivost: visoka za povzetek dokazov; večinoma raziskave iz ZDA.

[67] »Slovenia: Country Health Profile 2025,« OECD / European Observatory, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/country-health-profile-2025-country-notes_7e72146d/slovenia_27d174ae/4765833c-en.pdf. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[68] »Center za krepitev zdravja Črnomelj,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/ckz/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[69] »Dogodki in aktivnosti CKZ Črnomelj,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/ckz/dogodki/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[70] »Urnik delavnic: april in maj 2025,« ZD Črnomelj, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/zvc/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Urnik-delavnic-APRIL-IN-MAJ-2025-5.pdf. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[71] »Finančni načrt in program dela za leto 2025,« ZD Črnomelj, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2025/04/FINANCNI-NACRTI-2025.pdf. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[72] »Izobraževanje o najpomembnejši vrednoti,« Radio Odeon, 2022-04-09. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/izobrazevanje-o-najpomembnejsi-vrednoti/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[73] »Festival zdravja v Radencih ob Kolpi,« Radio Odeon, 2025-04-09. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/festival-zdravja-v-radencih-ob-kolpi/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[74] »Naravoslovni dan na temo zdravja v PŠ Adlešiči,« Radio Odeon, 2024-03-04. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/naravoslovni-dan-zdravje-na-ps-adlesici/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[75] »Zdravstvenovzgojni centri / Centri za krepitev zdravja (ZVCT),« NIJZ, 14. april 2023, posodobljeno 7. april 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/podatki/podatkovne-zbirke-in-raziskave/zdravstvenovzgojni-centri-centri-za-krepitev-zdravja-zvct/. [Dostopano: 22. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebrano osrednje besedilo spletne strani. Metodološke priponke niso pregledane. Vir ne potrjuje lokalnega spremljanja izidov; anketni list je avtorski predlog.

[76] »Povezani za zdravje: zbirnik informacij za krepitev zdravja v lokalni skupnosti,« ZD Črnomelj, CKZ, september 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2025/10/zbirnik-informacij-CKZ-crnomelj_cistopis.pdf. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Izdaja september 2025; natisnjene str. 31, 33–34 in 39–40, kar ustreza stranem PDF 33, 35–36 in 41–42 (šteto od 1). Kontakti iz imenika zahtevajo preverbo aktualnosti.

[77] »Otvoritev Centra za krepitev zdravja Bela krajina,« Radio Odeon, 2020-09-08. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/otvoritev-centra-za-krepitev-zdravja-bela-krajina/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[78] »Letošnji festival zdravja uspešno zaključen,« Radio Odeon, 2024-04-12. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/letosnji-festival-zdravja-je-zakljucen/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[79] »Rožnati koraki v Dobličah,« Radio Odeon, 2024-10-15. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/roznati-koraki-v-doblicah/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[80] »Zobkovadba na OŠ Milke Šobar - Nataše,« Radio Odeon, 2025-03-25. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/zobkovadba-na-os-milke-sobar-natase/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[81] »Vitaminski dan,« Radio Odeon, 2025-05-14. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/vitaminski-dan/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[82] »Brkati pohod ozaveščal o zdravju moških,« Radio Odeon, 2025-11-25. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/brkati-pohod-ozavescal-o-zdravju-moskih/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[83] »Dan za zdrav nasmeh in dobre navade,« Radio Odeon, 2026-03-19. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/dan-za-zdrav-nasmeh-in-dobre-navade/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[84] Anne-Marie Chang; Daniel Aeschbach; Jeanne F. Duffy; Charles A. Czeisler. »Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness,« PNAS, 2015. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1073/pnas.1418490112. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: celotno glavno besedilo PDF, 6 strani; dodatne priloge niso vključene.

[85] Carter B, Rees P, Hale L, Bhattacharjee D, Paradkar MS.. »Association Between Portable Screen-Based Media Device Access or Use and Sleep Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis.,« JAMA pediatrics, 2016. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27802500/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: bibliografski zapis in povzetek; celotno besedilo ni prebrano.

[86] Ahmed O, Walsh EI, Dawel A, Alateeq K, Espinoza Oyarce DA, Cherbuin N.. »Social media use, mental health and sleep: A systematic review with meta-analyses.,« Journal of affective disorders, 2024. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39242043/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: bibliografski zapis in povzetek; celotno besedilo ni prebrano.

[87] . »Nazaj v šolski ritem – kako urediti spanje otrok in mladostnikov,« NIJZ, 26. 8. 2026; posodobitev 27. 8. 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/zivljenjski-slog/nazaj-v-solski-ritem-kako-urediti-spanje-otrok-in-mladostnikov/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: celotno glavno besedilo; dodatne priloge niso vključene.

[88] . »Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih,« NIJZ, 2021; posodobitev 17. 7. 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/zivljenjski-slog/nekemicne-zasvojenosti/zasloni/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: celotno glavno besedilo; dodatne priloge niso vključene.

[89] . »Electronic media use and sleep in children and adolescents in western countries: a systematic review,« BMC Public Health, 2021. [Na spletu]. Dostopno: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8482627/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: celotno glavno besedilo; dodatne priloge niso vključene.

[90] . »Sleep Duration/Quality With Health Outcomes: An Umbrella Review of Meta-Analyses of Prospective Studies,« Frontiers in Medicine, 2022. [Na spletu]. Dostopno: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8811149/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: celotno glavno besedilo; dodatne priloge niso vključene.

[91] Itani O, Jike M, Watanabe N, Kaneita Y.. »Short sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression.,« Sleep medicine, 2017. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27743803/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: bibliografski zapis in povzetek; celotno besedilo ni prebrano.

[92] Ahmed O, Dawel A, Walsh EI, Cherbuin N.. »Longitudinal associations between problematic social media use and mental health: Mediating role of sleep.,« Addictive behaviors, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40782602/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: bibliografski zapis in povzetek; celotno besedilo ni prebrano.

[93] . »The effects of social media abstinence on affective well-being and life satisfaction: a systematic review and meta-analysis | Scientific Reports,« Scientific Reports, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.nature.com/articles/s41598-025-90984-3. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni prenos. Obseg: celotno glavno besedilo; dodatne priloge niso vključene.

[94] »Predložena zbirka 43 poti GPX – manifest izvirnikov,« Naročnik poročila; izvirni avtorji niso potrjeni, obdelava 21. september 2026. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Izvirniki v viri/gpx; kontrolne vsote v manifestu. Popolnost in terensko stanje nista potrjena.

[95] »Meja Črnomlja, točke krajev in kartografska podlaga,« Sodelavci OpenStreetMap, 20. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.openstreetmap.org/relation/1685747. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Obstoječi zajem Overpass; © sodelavci OpenStreetMap, ODbL.

[96] CKZ ZD Črnomelj. »Vadba na vadbenih napravah – trim steza Vražji kamen,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d. (objavljeno na strani decembra 2023). [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/zvc/wp-content/uploads/sites/3/2023/12/VADBA-NA-VADBENIH-NAPRAVAH.pdf. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna brošura (28 strani, 7 vadbenih postaj, 57 vaj). Zanesljivost: visoka za vsebino brošure; ni meritev uporabe.

[97] Srčna pot Svibnik (spletna stran). »Srčna pot Svibnik · Korak za zdravje,« GitHub Pages (dejanban), b.d. (zajem 26. 9. 2026). [Na spletu]. Dostopno: https://dejanban.github.io/Srcna_pot_spletna_Stran/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran, podatki poti (routes.js), GPX Ribje poti (enak viri/gpx/pohodnistvo/ribja-pot.gpx, SHA-256 82117d8d…) in slikovna brošura vaj. Zanesljivost: srednja (predstavitvena stran; sodelujoči navedeni na strani).

[98] Sodelavci OpenStreetMap (ODbL). »Vražji kamen (vrh, 172 m), vozlišče 9272920042,« OpenStreetMap, 26. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.openstreetmap.org/node/9272920042. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Podatki vozlišča. Zanesljivost: srednja za lokacijo vrha; trase trim steze v OSM ni.

[99] Radio Odeon (vir: KS Črnomelj). »Trim steza na Vražjem kamnu dobiva lepšo podobo,« Radio Odeon, 21. april 2021. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/novice/trim-steza-na-vrazjem-kamnu-dobiva-lepso-podobo/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celoten članek (WebFetch; HTML shranjen v odeon-trim-steza.html). Zanesljivost: nizka do srednja (medij, povzema KS).

[100] »Športni dan 1. triade, 14. 9. 2025,« OŠ Loka Črnomelj, 14. september 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.os-loka-crnomelj.si/2025/09/14/sportni-dan-1-triade/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[101] »Rokometni klub Črnomelj,« RK Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.rkcrnomelj.si/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[102] »Lipkomanija in vpis na treninge,« KK Kolpa Črnomelj, objavljeno na Radiu Odeon, 24. september 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.radio-odeon.com/sport/lipkomanija-v-crnomlju-in-semicu/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[103] »Krajevna skupnost Črnomelj,« Občina Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://crnomelj.si/sl/o-obcini/krajevne-skupnosti/2021122908384865/crnomelj/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[104] »Teniški klub Loka,« TK Loka, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.tk-loka.si/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[105] »Ju-jitsu – o nas,« ŠD Ninja Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://ninjacrnomelj.wixsite.com/ju-jitsu/o-nas. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[106] »Jahalna šola in ekipa,« Horse Resort Stariha, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://horse-resort-stariha.si/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[107] »Klub praktičnega streljanja Črnomelj,« KPS Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://kpscrnomelj.si/klub. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[108] »Rekreativni center Simon,« RC Simon, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://rcsimon.si/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[109] »Don Vito Gym Črnomelj,« Don Vito Gym, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.donvitogym.si/crnomelj.html. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[110] »Sportas studio,« Sportas, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.yousportas.si/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[111] »Naše poslanstvo in ekipa,« RC Simon, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://rcsimon.si/nase-poslanstvo/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[112] »Kontakti CKZ,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/ckz/predstavitev/kontakti/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[113] »Napoved dogodkov, september 2026,« Občina Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://crnomelj.si/sl/za-obcane/dogodki/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[114] »Popravek javne dostopnosti AED v občini Črnomelj,« Naročnik poročila, neposredno sporočilo, 23. september 2026. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo [kopija manjka]. Vsebinski popravek naročnika; neodvisna terenska preverba ni opravljena. Navedba ne določa dostopa 24/7 ali servisnega stanja. Opomba: lokalna kopija manjka ali je prazna in je ni bilo mogoče obnoviti iz zgodovine projekta; potrebna je ponovna pridobitev izvirnika.

[115] L. T. Krogsbøll, K. J. Jørgensen, P. C. Gøtzsche. »General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease (povzetek v preprostem jeziku),« Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1002/14651858.CD009009.pub3. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Povzetek v preprostem jeziku. Zanesljivost: visoka (17 RCT; prebran povzetek).

[116] NIJZ. »Preventivno zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne in družinske medicine (PZVO),« NIJZ, 13. februar 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/podatki/podatkovne-zbirke-in-raziskave/preventivno-zdravstveno-varstvo-odraslih-v-dejavnosti-splosne-in-druzinske-medicine-pzvo/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka.

[117] »Direktor Zdravstvenega doma Črnomelj Andrej Matkovič odhaja. Zakaj?,« Svet24 (M. Glavonjić), 23. april 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://svet24.si/lokalno/dolenjska/novice/direktor-zdravstveni-dom-crnomelj-andrej-matkovic-razresitev-1894643. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni HTML. Zanesljivost: nizka do srednja (medij; sekundarni vir).

[118] »Upravljanje in vodenje,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/upravljanje-in-vodenje/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni HTML. Zanesljivost: visoka (uradna stran zavoda; stanje na dan zajema).

[119] »Neuradno: Novi direktor Zdravstvenega doma Črnomelj iz Medvod,« Moja Dolenjska (A. L.), 23. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://moja-dolenjska.si/neuradno-novi-direktor-zdravstvenega-doma-crnomelj-iz-medvod/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni HTML. Zanesljivost: nizka (medij, »neuradno«, po lastnih virih; ni uradne objave ZD ali občine).

[120] »Odsotnost zdravnikov,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d. (tekoče posodabljana; zajem 25. 9. 2026). [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/odsotnost-zdravnikov/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: zajeto besedilo; izvirni HTML. Zanesljivost: visoka za objavljeni razpored; ne pove števila neopredeljenih oseb ali čakalnih dob.

[121] »Finančni načrt in program dela ZD Črnomelj za leto 2026,« ZD Črnomelj, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2026/06/FINANCNI-NACRTI-2026-ZD-Crnomelj.pdf. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[122] »Dispanzer za mentalno zdravje,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/dispanzer-za-mentalno-zdravje/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[123] »Ambulante,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/?services=ambulante. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[124] »Zdravljenje v domu,« DSO Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.domcrnomelj.si/sl/zdravljenje/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[125] »Psihiatrična ambulanta,« ZD Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.zd-metlika.si/ambulante/psihiatricna-ambulanta/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[126] »V stiski nismo sami – starejši imenik,« OŠ Podzemelj / Zavod Metlika, 2023. [Na spletu]. Dostopno: https://www.ospodzemelj.si/files/2023/03/Zlozenka-ZAVODA-METLIKA-na-koga-se-lahko-obrnemo.pdf. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[127] »Odsotnost zdravnikov – september 2026,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/odsotnost-zdravnikov/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[128] »Darinka Jerčinovič,« Mojpsihoterapevt.si – profil izvajalke, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.mojpsihoterapevt.si/psihoterapevt/Darinka-Jercinovic-185. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[129] NIJZ. »Podatki raziskave HBSC opozarjajo na poslabšanje duševnega zdravja mladostnikov v Sloveniji,« NIJZ, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/zivljenjski-slog/podatki-raziskave-hbsc-opozarjajo-na-poslabsanje-dusevnega-zdravja-mladostnikov-v-sloveniji/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za nacionalne podatke; ni občinskega vzorca.

[130] NIJZ, Zdravstveno podatkovni center. »Izpis stanja čakalnih dob in števila čakajočih na ravni VZS na dan 16. 9. 2026,« NIJZ, 16. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/podatki/cakalne-dobe/tedenska-porocila-o-cakalnih-dobah/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Listi Vsebina, Tb 02 (po izvajalcih) in Tb 04 (skupaj). Zanesljivost: visoka (nacionalni sistem eNaročanje).

[131] »Fizioterapija,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/fizioterapija/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[132] »DSO Črnomelj 2025: kadrovska tabela, str. 43–44,« DSO Črnomelj, 2026 (poročilo za 2025). [Na spletu]. Dostopno: https://www.domcrnomelj.si/docs/porocanje/Letno_porocilo_z_obrazlozitvami_2025.pdf. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[133] »Trenerji Sportas,« Sportas, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.yousportas.si/trenerji/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[134] »Osebno trenerstvo,« RC Simon, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://rcsimon.si/osebno-trenerstvo/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[135] »MD Rehab Lab,« MD Rehab, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://mdrehablab.com/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[136] »Rok Žagar – lokacija izvajanja,« Klinika Optimum, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.klinikaoptimum.si/o-nas/rok-zagar. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[137] »Ekipa in lokacija Rehab Studio,« Rehab Studio, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://rehabstudio.si/o-nas/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[138] »Aktivni zdravniki ZZZS: preverjeni izvleček za Črnomelj in Semič,« ZZZS, 1. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://partner.zzzs.si/zzzs-api/prenesi-datoteko?stdatoteke=14295&tx_agzzzsapi_izvajalcidownloadfile%5Baction%5D=downloadfile&tx_agzzzsapi_izvajalcidownloadfile%5Bcontroller%5D=Izvajalci&type=1249058992&cHash=4c02aa16fb75ac78f33edb132adf897e. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[139] »Zdravstvena postaja Vinica,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/zdravstvena-postaja-vinica/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[140] »Ambulanta Suzane Milenković,« Medicina MS, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://medicina-ms.si/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[141] »Ordinacija dr. Vuković,« Ordinacija dr. Vuković, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://vukovic.pro/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[142] »Splošna medicina,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/splosna-medicina/. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[143] »Staffing levels for European healthcare – poročilo 2026,« Evropska komisija, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://health.ec.europa.eu/document/download/b76a01d9-a2e9-4a59-aca7-9476ed908746_en?filename=hspa_eg-staffing-levels_rep_en.pdf. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[144] »Health at a Glance: Europe 2024,« Evropska komisija in OECD, 2024. [Na spletu]. Dostopno: https://health.ec.europa.eu/document/download/1e23af78-d146-4c84-be77-690fc6044655_en?filename=2024_healthatglance_rep_en.pdf&prefLang=es. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[145] »Črnomelj - Šola Zdravja,« Društvo Šola zdravja, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://solazdravja.com/obcina/crnomelj/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[146] »Črnomelj - Šola Zdravja,« Društvo Šola zdravja, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://solazdravja.com/skupina/crnomelj/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[147] »Kontakt – ZKDKS,« Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zkdks.si/kontakt/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[148] »Rehabilitacijska vadba koronarnih bolnikov odslej tudi v Črnomlju | Koronarno društvo DBK,« Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://koronarnodrustvo-dbk.si/rehabilitacijska-vadba-koronarnih-bolnikov-poslej-tudi-v-crnomlju/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[149] »Domov - Diabetiki Metlika,« Društvo diabetikov Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://diabetiki-metlika.org/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[150] »Kontakt - Diabetiki Metlika,« Društvo diabetikov Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://diabetiki-metlika.org/kontakt/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[151] »Skupina Bela krajina | Europa Donna Slovenija,« Europa Donna Slovenija, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://europadonna.si/skupnost-europa-donna/skupine/podruznica-bela-krajina/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[152] »Srečanja — Metuljčica,« Društvo Metuljčica, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.metuljcica.si/srecanja/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Uporabljen spletni izvleček; neposredni prenos vrne 403.

[153] »Klubi,« Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.zdruzenjecvb.com/klubi.html. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[154] »Skupaj za duševno zdravje - Knjižnica Črnomelj,« Knjižnica Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://knjiznica-crnomelj.si/zgodilo-se-je/skupaj-za-dusevno-zdravje/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[155] »Hiša sadeži družbe Črnomelj – Slovenska filantropija,« Slovenska filantropija, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-crnomelj/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[156] »Dolenjska - Združenje multiple skleroze Slovenije,« Združenje multiple skleroze Slovenije, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.zdruzenje-ms.si/podruznice/dolenjska/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[157] »Demenci prijazne točke | Spominčica,« Spominčica – Alzheimer Slovenija, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.spomincica.si/demenci-prijazne-tocke/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[158] »Demenci prijazna točka (DPT) - Ljudska univerza Črnomelj,« Ljudska univerza Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.zik-crnomelj.eu/en/projekti/demenci-prijazna-tocka-dpt/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[159] »KONTAKTI – Hospic,« Slovensko društvo Hospic, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://hospic.si/kontakti/. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[160] »Seznam območnih odborov s kontakti,« Slovensko društvo Hospic, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://hospic.si/wp-content/uploads/2023/01/Seznam-vseh-obmocnih-odborov-s-kontakti.pdf. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[161] »Šent - Dnevni center ŠENT Novo mesto,« ŠENT, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.sent.si/index.php?m_id=dnevni_center_enota_sent_novo_mesto. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[162] Project OSRM; cestni podatki © sodelavci OpenStreetMap (ODbL). »Modelski časi in razdalje vožnje: ZD Črnomelj, ZD Metlika in SB Novo mesto (UC) do 111 naselij,« OSRM demo strežnik, 26. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://project-osrm.org/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna tabela (3 izhodišča × 111 naselij); izračun scenarijev v orodja/analiziraj_dostopnost_nmp.py. Zanesljivost: nizka do srednja (model običajne vožnje, ne nujne vožnje).

[163] Statistični urad RS. »Prebivalstvo po spolu in po starosti, občine in naselja, Slovenija, letno (05C5003S), Občina Črnomelj, 2026,« SURS, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5003S.px. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Poizvedba za 122 naselij: skupaj in 65+ (podatki/teme/surs-05C5003S-poizvedba.json). Zanesljivost: visoka.

[164] Zdravstveni dom Metlika. »Ambulanta za nujno medicinsko pomoč,« Zdravstveni dom Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.zd-metlika.si/ambulante/ambulanta-za-nujno-medicinsko-pomoc/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeno organizacijo.

[165] T. Scquizzato in sod.. »Dispatching citizens as first responders to out-of-hospital cardiac arrests: a systematic review and meta-analysis,« European Journal of Emergency Medicine, 29(3), str. 163–172, 2022. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1097/MEJ.0000000000000915. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Prebran povzetek. Celotno besedilo ni prosto dostopno (Europe PMC, Unpaywall 26. 9. 2026: zaprt dostop). Zanesljivost: srednja (metaanaliza opazovalnih raziskav; prebran povzetek).

[166] Valhalla (FOSSGIS); cestni podatki © sodelavci OpenStreetMap (ODbL). »Modelski časi in razdalje vožnje med ZD Črnomelj in 111 naselji (obe smeri),« Javni strežnik Valhalla, costing auto, 26. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://valhalla1.openstreetmap.de/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: 222 poizvedb; primerjava z OSRM v orodja/kalibracija_casov.py. Zanesljivost: nizka do srednja (drug model običajne vožnje; služi za oceno negotovosti).

[167] Project OSRM; cestni podatki © sodelavci OpenStreetMap (ODbL). »Cestne poti in modelski časi vožnje med ZD Črnomelj in 111 naselji (obe smeri, čas po odsekih),« OSRM demo strežnik, 26. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://project-osrm.org/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: 222 poti; zajem z orodja/zajemi_poti_nmp.py, zemljevid z orodja/zemljevid_nmp.py. Zanesljivost: nizka do srednja (model običajne vožnje, ne nujne vožnje).

[168] NIJZ, Center za informatiko v zdravstvu. »10 let eZdravja v Sloveniji: digitalne storitve, ki vsak dan povezujejo paciente in zdravstvene strokovnjake,« NIJZ, 1. december 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/informatika-v-zdravstvu/ezdravje/10-let-ezdravja-v-sloveniji-digitalne-storitve-ki-vsak-dan-povezujejo-paciente-in-zdravstvene-strokovnjake/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna objava. Zanesljivost: visoka (upravljavec sistema; samoporočanje).

[169] NIJZ. »zVEM presegel 700.000 uporabnikov, skupaj s povezanimi osebami že nad 900.000,« NIJZ, 23. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/informatika-v-zdravstvu/ezdravje/zvem-presegel-700-000-uporabnikov/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna objava. Zanesljivost: visoka (upravljavec sistema).

[170] Zdravstveni dom Črnomelj. »Komunikacijska platforma zVEM,« Zdravstveni dom Črnomelj, 17. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/blog/2026/09/17/komunikacijska-platforma-zvem/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotno obvestilo. Zanesljivost: visoka za objavljeno uvajanje.

[171] Statistični urad RS (T. Mlakar). »Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, 2025,« SURS, 9. oktober 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/13908. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna objava. Zanesljivost: visoka (uradna statistika, 1. četrtletje 2025).

[172] Statistični urad RS (T. Mlakar). »Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, 2025,« SURS, 4. december 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/14007. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna objava. Zanesljivost: visoka (uradna statistika).

[173] NIJZ. »Odprtje novih zVEM digitočk v maju in juniju 2026,« NIJZ, 4. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/informatika-v-zdravstvu/ezdravje/odprtje-novih-zvem-digitock-v-maju-in-juniju-2026/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna objava. Zanesljivost: visoka.

[174] Zdravstveni dom Črnomelj. »Možnosti naročanja,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/moznosti-narocanja/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeno ponudbo.

[175] Zdravstveni dom Črnomelj. »E-komunikacija,« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/e-komunikacija/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka za objavljeno ponudbo.

[176] Inštitut RS za socialno varstvo. »Spremljanje storitve pomoči za družino: pomoč na domu – analiza stanja v letu 2024 (končno poročilo),« IRSSV, 30. september 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://irssv.si/analiza-izvajanja-pomoci-na-domu-2024/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Povzetek (str. 1–10), cene (pogl. o cenah) in Priloge A, B, C, D za Črnomelj. Zanesljivost: visoka (letno spremljanje vseh izvajalcev).

[177] Ministrstvo za solidarno prihodnost. »Seznam pristojnih območnih enot centrov za socialno delo (vstopne točke) za dolgotrajno oskrbo,« gov.si, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MSP/Dolgotrajna-oskrba/Seznam-pristojnih-obmocnih-enot-CSD_vstopne-tocke.pdf. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celoten dokument. Zanesljivost: visoka.

[178] RTV SLO. »Poslanci brez glasu proti potrdili intervencijski zakon o dolgotrajni oskrbi,« RTV SLO, 18. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.rtvslo.si/slovenija/poslanci-brez-glasu-proti-potrdili-intervencijski-zakon-o-dolgotrajni-oskrbi/794108. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celoten članek. Iz shranjenega HTML je odstranjen javni API ključ spletišča (redakcija 26. 9. 2026, glej viri/manifest.json). Zanesljivost: srednja (medij; povzema zakonodajni postopek).

[179] Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje. »Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030,« gov.si, julij 2023. [Na spletu]. Dostopno: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/NOVICE/Strategija-obvladovanja-demence-v-Sloveniji-do-leta-2030.pdf. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Prebrani uvod, cilji, kazalniki in poglavja o lokalnem okolju ter oskrbi v skupnosti. Zanesljivost: visoka (nacionalni strateški dokument).

[180] Spominčica – Alzheimer Slovenija. »Demenci prijazne točke,« Spominčica, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.spomincica.si/demenci-prijazne-tocke. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran; iskanje zapisov za Črnomelj, Metliko, Semič in Belo krajino. Zanesljivost: srednja (seznam na spletni strani; lahko nepopoln).

[181] Spominčica – Alzheimer Slovenija (vir: Ministrstvo za zdravje). »Vlada Republike Slovenije sprejela Akcijski načrt za izvajanje Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030,« Spominčica, 11. januar 2024. [Na spletu]. Dostopno: https://www.spomincica.si/novice/vlade-republike-slovenije-sprejela-akcijski-nacrt-za-izvajanje-strategije-obvladovanja-demence-v-sloveniji-do-leta-2030. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna novica. Zanesljivost: srednja do visoka (povzema sporočilo MZ).

[182] Socialna zbornica Slovenije. »Več in še več o demenci – DSO Črnomelj,« Socialna zbornica Slovenije, 2018. [Na spletu]. Dostopno: https://www.szslo.si/3-dso-crnomelj. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran (WebFetch). Zanesljivost: srednja (napoved programa; izvedba in udeležba nista navedeni).

[183] »World report on social determinants of health equity,« WHO, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/publications/i/item/9789240107588. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[184] »Social determinants of health,« WHO, 6. maj 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/social-determinants-of-health. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[185] »Črnomelj: Slovenske regije in občine v številkah, podatki za 2024,« SURS, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/GroupedAll/24. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[186] »Stress,« WHO, 30. marec 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/stress. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[187] »Effects of a community gardening intervention on diet, physical activity, and anthropometry outcomes in the USA (CAPS): an observer-blind, randomised controlled trial,« J. S. Litt in sod., The Lancet Planetary Health, 2023. [Na spletu]. Dostopno: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9936951/. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[188] »Healthy diet,« WHO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[189] »Drinking-water,« WHO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[190] »Ambient (outdoor) air pollution,« WHO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[191] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2021,« NLZOH / Komunala Črnomelj, 2022. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dejavnosti/vodovod/KAKOVOST%20PITNE%20VODE/PV-Crnomelj-2021.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[192] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2011,« Komunala Črnomelj, 2012. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne%20vode_v_letu_2011.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[193] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2012,« Komunala Črnomelj, 2013. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2012.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[194] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2013,« Komunala Črnomelj, 2014. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2013.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[195] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2014,« Komunala Črnomelj, 2015. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2014.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[196] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2015,« Komunala Črnomelj, 2016. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2015.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[197] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2016,« Komunala Črnomelj, 2017. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2016.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[198] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2017,« Komunala Črnomelj, 2018. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2017.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[199] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2018,« Komunala Črnomelj, 2019. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2018.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[200] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2019,« Komunala Črnomelj, 2020. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dejavnosti/vodovod/KAKOVOST%20PITNE%20VODE/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2019.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[201] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2020,« Komunala Črnomelj, 2021. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dejavnosti/vodovod/KAKOVOST%20PITNE%20VODE/Kakovost_pitne_vode_v_letu_2020.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[202] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2022,« NLZOH / Komunala Črnomelj, 2023. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dejavnosti/vodovod/KAKOVOST%20PITNE%20VODE/PV-Crnomelj-2022.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[203] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2023,« NLZOH / Komunala Črnomelj, 2024. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/_prehod/dokumenti/Komunala%20%C4%8Crnomelj_poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202023.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[204] »Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2024,« NLZOH / Komunala Črnomelj, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dokumenti/Vodovod/Letno%20poro%C4%8Dilo%20za%20vodo/Komunala%20%C4%8Crnomelj_%20poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202024_compressed.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[205] »Rezultati vzorčenj VS Črnomelj,« Komunala Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/novica/rezultati-vzorcenj-vs-crnomelj. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[206] »Poročilo o izvedeni nalogi: vzorec 26/89747, Griblje OŠ, odvzem 2. 9. 2026,« NLZOH / Komunala Črnomelj, 8. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dokumenti/Vodovod/Rezultati%20vzor%C4%8Denj%20po%20VS/VS%20%C4%8Crnomelj/15.09.2026/26-89747_Pitna-voda---Griblje-OS.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[207] »Poročilo o izvedeni nalogi: vzorec 26/88801, Adlešiči KZ, odvzem 31. 8. 2026,« NLZOH / Komunala Črnomelj, 7. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.komunala-crnomelj.si/storage/app/media/dokumenti/Vodovod/Rezultati%20vzor%C4%8Denj%20po%20VS/VS%20%C4%8Crnomelj/15.09.2026/26-88801_Pitna-voda---Adlesici-bife-KZ.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[208] »Povprečna mesečna raven delcev PM10 v letu 2026, januar–julij,« ARSO, 31. avgust 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_jul26.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[209] »Preseganje delcev PM10 v letu 2026, januar–julij,« ARSO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/preseganja_pm10.html. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[210] »WHO global air quality guidelines,« WHO, 2021. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/who-global-air-quality-guidelines. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[211] »Povprečna mesečna raven delcev PM10 v letu 2025,« ARSO, 3. februar 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_dec25.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[212] »Dnevne ravni policikličnih aromatskih ogljikovodikov v delcih PM10 na merilnem mestu Črnomelj v letu 2025,« ARSO, 15. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PAH_D_PM10_%c4%8cRNOMELJ_2025.pdf. [Dostopano: 24. september 2026]. Lokalni vir: celotni izvirnik; shranjeni izvleček.

[213] NIJZ. »Napotki za ravnanje v vročih dneh,« NIJZ, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://nijz.si/moje-okolje/podnebne-spremembe/napotki-za-ravnanje-v-vrocih-dneh/. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotna stran. Zanesljivost: visoka (nacionalna priporočila).

[214] J. Ballester in sod.. »Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022,« Nature Medicine, 29, str. 1857–1866, 2023. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02419-z. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celotno besedilo (23 strani), vključno s preglednicama 1 in 2 (Slovenija) in omejitvami; XML iz Europe PMC v ballester-2023-celotno.xml. Zanesljivost: srednja do visoka (modelska ocena, odprti dostop; celotno besedilo).

[215] T. Janoš in sod.. »Heat-related mortality in Europe during 2024 and health emergency forecasting to reduce preventable deaths,« Nature Medicine, 31, str. 4065–4074, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://doi.org/10.1038/s41591-025-03954-7. [Dostopano: 25. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Prebran povzetek. Celotno besedilo ni prosto dostopno (Europe PMC, Unpaywall 26. 9. 2026: zaprt dostop). Zanesljivost: srednja do visoka (modelska ocena; prebran povzetek).

[216] P. Jurić, G. Jurak, S. A. Morrison, G. Starc in M. Sorić, »Effectiveness of a population-scaled, school-based physical activity intervention for the prevention of childhood obesity,« Obesity, zv. 31, št. 3, str. 811–822, 2023. doi: 10.1002/oby.23695. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36811242/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[217] »Policies and interventions to create healthy school food environments: WHO guideline,« WHO, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/publications/i/item/9789240118324. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[218] »The SAFER initiative,« WHO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/initiatives/SAFER. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[219] W. C. Knowler in sod., »Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin,« New England Journal of Medicine, zv. 346, št. 6, str. 393–403, 2002. doi: 10.1056/NEJMoa012512. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11832527/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[220] SPRINT Research Group, »A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control,« New England Journal of Medicine, zv. 373, št. 22, str. 2103–2116, 2015. doi: 10.1056/NEJMoa1511939. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26551272/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[221] »WHO clinical treatment guideline for tobacco cessation in adults,« WHO, 2024. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/publications/i/item/9789240096431. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[222] »LIVE LIFE Initiative for Suicide Prevention,« WHO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/initiatives/live-life-initiative-for-suicide-prevention. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[223] Zdravstveni dom Črnomelj. »Anketa o zadovoljstvu pacientov (spletni vprašalnik),« Zdravstveni dom Črnomelj, b.d. (zajem 26. 9. 2026). [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/anketa/. [Dostopano: 26. september 2026]. Lokalna kopija: izvleček; izvirnik. Obseg: Celoten vprašalnik (izvleček iz HTML z obrazcem; izvirnik zd-anketa.html). Zanesljivost: visoka za vsebino vprašalnika.

[224] K. D. Hall in sod., »Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake,« Cell Metabolism, zv. 30, št. 1, str. 67–77.e3, 2019. doi: 10.1016/j.cmet.2019.05.008. [Na spletu]. Dostopno: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31105044/. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[225] »Accelerating childhood overweight reduction: lessons learned and the path towards 2030,« WHO, 2024-11-21. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/11/21/default-calendar/accelerating-childhood-overweight-reduction-lessons-learned-and-the-path-towards-2030. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[226] »Accelerating childhood overweight reduction: lessons learned and the path towards 2030 — prosojnice,« WHO, 2024-11-21. [Na spletu]. Dostopno: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutrition-and-food-safety/events/2024/webinar---accelerating-childhood-overweight-reduction---lessons-learned-and-the-path-towards-2030-presentation.pdf?sfvrsn=a331db34_5. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[227] »Launch of the WHO guideline on policies and interventions to create healthy school food environments,« WHO, 2026-01-27. [Na spletu]. Dostopno: https://www.who.int/news-room/events/detail/2026/01/27/default-calendar/launch-of-the-who-guideline-on-policies-and-interventions-to-create-healthy-school-food-environments. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.